INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

-- Medicina livre, contra os preços abusivos na medicina.

-- Venda proibida

-- @Livremedicina - twitter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343780)

Enunciado: A partir dos 6 meses de idade da criança, recomenda-se a introdução de alimentos complementares, uma vez que após esse período o leite materno sozinho não é mais capaz de suprir as necessidades nutricionais do lactente. A respeito da alimentação complementar marque a resposta correta.

A) A papa principal deve ser oferecida após o 4º mês de vida.

B) É comum a criança rejeitar alimentos que não lhe são familiares, portanto, são necessárias em média oito a dez exposições para uma plena aceitação.

C) Os lipídeos devem assegurar 55% da energia total da alimentação do lactente após 6 meses de vida.

D) Inicialmente os alimentos devem ser ofertados batidos no liquidificador para que não haja risco de engasgos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343786)

Enunciado: Lactente de 3 meses de idade, nascido a termo com 3.100g, em aleitamento materno exclusivo, previamente hígido deve receber qual das opções abaixo para suplementação de vitaminas:

A) Vitamina D em dose diária de 600UI para prevenção de raquitismo.

B) Vitamina C em dose diária de 200mg/dia para prevenção de escorbuto.

C) Vitamina A em dose de 100.000 UI/mês para prevenção de xerofaltamia.

D) Vitamina D em dose diária de 400UI para prevenção de raquitismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343791)

Enunciado: Lactente nascido de parto a termo, pesando 3.500g, medindo 49cm e com perímetro cefálico de 34cm, deverá ter quais medidas antropométricas aos 4 meses de idade?

A) 6.300g; 60cm; 41cm.

B) 5.500g; 53cm; 36cm.

C) 8.000g; 70cm; 45cm.

D) 5.900g; 53cm; 41cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343792)

Enunciado: Lactente de 6 meses de idade, comparece a Unidade Básica da Saúde para realizar consulta de puericultura. Quais devem ser os marcos do desenvolvimento que surgem nessa idade?

A) Sorriso social, acompanhar objetos com o olhar e sustentação da cabeça.

B) Levar as mãos na linha média, sorriso social, sentar com apoio.

C) Transferir objetos de uma mão para outra, levantar a cabeça em decúbito ventral e acompanhar os objetos com o olhar.

D) Sentar com apoio, levantar a cabeça em decúbito ventral e balbuciar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345495)

Enunciado: Sobre puberdade precoce, é CORRETO afirmar que:

A) Ocorre quando há aparecimento de pelos pubianos antes dos 7 anos no sexo feminino.

B) Pode ocorrer devido a tumor de células de Leydig ou a gonadoblastoma.

C) Pode ocorrer se houver ativação do eixo hipotalâmico hipofisário.

D) É caracterizada no sexo masculino por aumento do volume testicular abaixo de 10 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283290)

Enunciado: Considerando a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, com relação à alimentação da criança no primeiro ano de vida, assinale a alternativa CORRETA:

A) Devemos oferecer suco de fruta natural, sem adição de açucares ou adoçantes.

B) O aleitamento materno deve ser exclusivo ate o 4º mês de vida, sem necessidade de oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.

C) Na transição alimentar a papa principal pode ser liquidificada ou processada devendo-se evitar o sal e utilizando a gordura, sob a forma de óleo vegetal.

D) Em média, a criança precisa ser exposta a um novo alimento de 8 a 10 vezes para que o aceite bem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283297)

Enunciado: Com relação às características da adolescência normal, marque a alternativa CORRETA:

A) O crescimento dos membros inferiores e do tronco é responsável pelo aumento da estatura do adolescente, sendo esse processo uniforme nessa fase.

B) A primeira manifestação de puberdade no sexo feminino é a telarca, que pode ser unilateral, inicialmente, ocorrendo entre 8 a 13 anos.

C) O estirão puberal ocorre primeiramente nos meninos, em torno de 9,5 anos de idade e 2 anos mais tarde nas meninas.

D) O ganho de peso no sexo masculino é resultante da deposição de gordura, devido a ação de testosterona, esse hormônio também é responsável pelo aumento da capacidade física nessa fase da vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283301)

Enunciado: A síndrome de Down é a anomalia cromossômica mais comum em recém-nascidos vivos e a forma mais frequente de deficiência intelectual causada por alteração cromossômica.

Quais das alterações dismórficas NÂO são caraterísticas desta síndrome:

A) Braquicefalia.

B) Frouxidão ligamentar.

C) Mãos largas e curtas e vínculo palmar transverso (prega simiesca).

D) Luxação de cristalino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291790)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando o parâmetro ?escore z?, adotado pela OMS, indique a classificação correta para o peso e a estatura dessa lactente.

A) Ganho de peso e de estatura adequados.

B) Ganho de peso e crescimento inadequados.

C) Ganho de peso adequado e crescimento inadequado.

D) Ganho de peso inadequado e crescimento adequado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291791)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando a velocidade de crescimento esperada para o Perímetro Cefálico, especifique qual deve ser, aproximadamente, o valor atual, nessa criança.

A) 40 cm

B) 42 cm

C) 44 cm

D) 46 cm

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291792)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando que essa criança apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado à idade, identifique entre as capacidades listadas a que mostra aquela que ela já deve ser capaz de executar atualmente.

A) Empilhar cubos.

B) Levantar-se sozinha com apoio.

C) Transferir objetos de uma mão para outra.

D) Pegar objetos em pinça com o polegar e o indicador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283355)

Enunciado: Lactente de 6 meses de vida, sexo feminino, é trazida pelos genitores para consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde. O Médico de Família e Comunidade, supervisiona o atendimento dos residentes, lançando a seguinte pergunta "qual o marco do desenvolvimento motor, espera-se encontrar?"

A) Sentar sem apoio.

B) Mostrar o que quer.

C) Usar colher para comer.

D) Pegar um objeto com movimento de pinça.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247189)

Enunciado: Com relação ao estadiamento puberal e crescimento em adolescentes, pode-se afirmar que

A) Meninas e meninos iniciam o estirão em idades cronológicas semelhantes.

B) A identificação do estágio M2 de mama pelos critérios de Tanner pode ser usado como indicador de que o estirão está se iniciando no sexo feminino.

C) O primeiro sinal de amadurecimento sexual no menino é o aumento do comprimento peniano.

D) Em estágio M3 de mamas, as meninas encontram-se em fase de desaceleração de crescimento.

E) A muda vocal é evento que ocorre em fases precoces do desenvolvimento pubertário no sexo masculino, geralmente em estágio G (genital) 2, pelos critérios de Tanner.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251912)

Enunciado: Durante consulta de puericultura da criança, ela é capaz de se sentar sem suporte do tronco, consegue apanhar objetos e transferi-los de uma mão para a outra, mas ainda não é capaz de fazer o movimento de pinça com os dedos polegar e o indicador. Estes marcos do desenvolvimento são típicos de um bebê de:

A) 10 meses.

B) 6 meses.

C) 5 meses.

D) 4 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247197)

Enunciado: Uma adolescente de 15 anos de idade procura o ginecologista para orientação contraceptiva. Refere que seus pais desconhecem que tem atividade sexual e que não pretende contar a eles. Durante o exame ginecológico, são encontradas verrugas genitais suspeitas de HPV. Após esclarecer as dúvidas da jovem quanto à vida sexual com segurança, o ginecologista deve

A) Prescrever contraceptivo, biopsiar e tratar as lesões suspeitas com autorização da paciente.

B) Solicitar a presença de um familiar responsável para prescrever o contraceptivo e tratar as lesões.

C) Prescrever o contraceptivo, mas solicitar a um responsável que autorize a realização da biópsia.

D) Orientar o uso de preservativo, cauterizar as lesões verrucosas e esclarecer sobre a necessidade da presença de um adulto responsável para prescrição de medicamentos.

E) Avisar os responsáveis a respeito da suspeita de HPV por se tratar de doença sexualmente transmissível antes de instituir qualquer tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251918)

Enunciado: Com relação ao aleitamento materno, marque a alternativa CORRETA:

A) A recomendação internacional quanto à duração da amamentação é de 6 meses para a amamentação exclusiva e de 1 ano ou mais para a amamentação com outros alimentos.

B) A técnica incorreta de amamentação é a principal causa de pouco ganho ponderal na criança e de traumas mamilares.

C) O bebê que mama exclusivamente ao seio materno deve ter horários regulares para se alimentar, sendo recomendado de 3 em 3 horas.

D) Nos dias mais quentes, podemos oferecer água para as crianças que mamam exclusivamente ao seio materno, pois a quantidade existente desse elemento é mínima na composição do leite materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251930)

Enunciado: A avaliação do desenvolvimento infantil é extremamente importante na consulta pediátrica, pois identifica precocemente um déficit neuromotor ou sensorial, alertando para patologias. Qual das abaixo NÃO descreve um padrão de desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida?

A) Aos três meses o bebê já sustenta a cabeça e segura o pescoço.

B) No terceiro trimestre de vida a criança já senta sem apoio.

C) No primeiro trimestre o bebê ganha, aproximadamente, 700g/mês.

D) No ultimo trimestre a criança quer explorar, iniciando o processo de autoconsciência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251933)

Enunciado: Com relação a prevenção da anemia ferropriva, qual é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria?

A) 1mg/kg/dia de sulfato ferroso.

B) 2mg/kg/dia de sulfato ferroso.

C) 1mg/kg/dia de ferro elementar.

D) 3mg/kg/dia de ferro elementar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217645)

Enunciado: Com relação ao crescimento e desenvolvimento na infância, analise os itens abaixo: I. Anda sem apoio; II. Agarra objetos fazendo pinça com o polegar; III. Sustentar a cabeça; IV. Sentar em tripé.V. Junta as mãos na linha média. A alternativa CORRETA e SEQUENCIAL no que se refere à aquisição cronológica dos marcos de desenvolvimento é:

A) III, V, IV, II e I.

B) III, V, II, IV, e I.

C) V, III, II, IV e I.

D) III, IV, V, II, e I.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217726)

Enunciado: Com relação à adolescência normal, qual das alternativas abaixo está CORRETA?

A) A primeira manifestação de puberdade no sexo feminino é o aparecimento dos pelos pubianos.

B) A menarca ocorre cerca de 1 ano após aparecimento da primeira manifestação de puberdade nas meninas.

C) No gênero masculino, após o início da puberdade, pode ocorrer ginecomastia puberal uni/bilateral, que tem caráter transitório e regride espontaneamente em cerca de 2 a 3 anos.

D) A primeira manifestação de puberdade no sexo masculino é o aumento do tamanho peniano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217695)

Enunciado: Mãe de primeiro filho, chega à consulta queixando-se que seu "peito" direito está endurecido em uma área do quadrante superior externo, e que a região está muito dolorida. Ela mostra o problema e acha que foi o leite que "empedrou". O médico confirma o problema. Assinale a alternativa que apresenta a recomendação CORRETA que pode ser dada a ela.

A) Aplicação de gelo, antes das mamadas.

B) Ordenha manual da aréola, antes das mamadas.

C) Compressas mornas ou banho quente, após as mamadas.

D) Massagens delicadas, com movimentos retilíneos sobre a região afetada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217708)

Enunciado: Sobre o desenvolvimento da linguagem na infância, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir: ( ) As queixas dos familiares devem sempre ser valorizadas; ( ) O uso excessivo de televisão, tablet e smartphone nos dois primeiros anos de vida da criança está associado à dificuldade de aprendizagem. ( ) O atraso na aquisição de linguagem oral é extremamente raro na infância e, na maioria das vezes, costuma ser grave. ( ) Durante a consulta, observar o comportamento da criança é muito importante, pois dá informações dos aspectos emocionais: se fixa o olhar, se corresponde ao sorriso e à brincadeiras. A sequência CORRETA é:

A) V-V-F-V.

B) F-V-V-F.

C) V-V-F-F.

D) F-V-F-V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182701)

Enunciado: Considerando o desenvolvimento neuropsicomotor normal da infância, qual dos marcos abaixo NÃO é esperado para uma criança de 6 meses?

A) Preensão cubital voluntária.

B) Sustentar a cabeça.

C) Sentar sozinho (sem apoio).

D) Lalação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182621)

Enunciado: Segundo a OMS/MS quando se fala que lactente recebe, além de leite materno, água e bebidas à base de água, como suco de frutas ou chás, mas não recebe outro leite, estamos usando qual dos conceitos de aleitamento materno abaixo?

A) Exclusivo.

B) Complementado.

C) Misto ou parcial.

D) Predominante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183135)

Enunciado: Com relação à composição do leite humano, é correto afirmar:

A) O leite humano apresenta uma quantidade de ferro superior a do leite de vaca, e na forma de maior biodisponibilidade para o ser humano.

B) A lisozima é uma molécula carreadora do ferro do leite humano, impedindo que bactérias patogênicas façam a utilização do ferro para proliferação no meio intestinal.

C) A relação Ca: P, no leite humano, é de 1:2, o que favorece a absorção do cálcio em detrimento do fósforo na muscosa intestinal.

D) A taurina é um aminoácido assencial, importante na formação da retina e está presenta em menor quantidade no leite humano, quando comparado ao leite de vaca.

E) IgA secretória é a principal imunoglobulina do leite humano, tendo sua especificidade determinada pelos antígenos entéricos e respiratórios da mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183140)

Enunciado: Uma causa não rara de desmame é a ocorrência da doença na nutriz. Das situações abaixo relacionadas na nutriz, qual contraindica a amamentação:

A) Tuberculose, puérpera bacilífera no final da gestação.

B) Hepatite C diagnosticada no terceiro trimestre de gestação.

C) Dengue na fase aguda com plaquetopenia e hipovolemia.

D) Varicela manifestada clinicamente três dias antes do parto.

E) Hepatite B com HbsAg reagente no primeiro trimestre.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182688)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA sobre as medidas antropométricas:

A) A aferição do comprimento em crianças até 2 anos de idade com até 16 kg deve ser realizada segundo o protocolo com antropômetro horizontal.

B) Algumas deficiências nutricionais específicas podem ocorrer sem comprometimento antropométrico imediato, e sua detecção depende da realização de cuidadosa anamnese nutricional.

C) Recomenda-se que as medidas antropométricas sejam realizadas ao nascimento, com 7 a 10 dias de vida, e, se não forem identificados problemas, nova medida ao final de 12 meses e ao completar 24 meses de vida.

D) A aferição de circunferência craniana em crianças até 2 anos de idade deve ser realizada, segundo o protocolo, com fita métrica inextensível (precisão: cm).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159049)

Enunciado: Puberdade precoce pode ser encontrada em ambos os sexos, mas, o feminino é o mais afetado, com uma proporção 23:1. Define-se puberdade precoce quando ocorre em idade inferior a:

A) 14 anos.

B) 12 anos.

C) 10 anos.

D) 08 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159073)

Enunciado: Após a saída do RN da maternidade, quando o pediatra deve realizar a primeira consulta?

A) Nos primeiros cinco dias de vida.

B) Nos primeiros 15 dias de vida.

C) Dentro do primeiro mês de vida.

D) Diariamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159039)

Enunciado: Ana Júlia, 10 meses de vida, nascida de parto normal a termo, sem intercorrências, é levada à consulta de puericultura onde a mãe relata que está muito preocupada pois a filha ainda não engatinha. A conduta mais adequada é:

A) Encaminhar para o neuropediatra para investigação.

B) Encaminhar para o fisioterapeuta para estimulação motora.

C) Tranquilizar a mãe, pois muitas crianças não engatinham sem ter significado patológico.

D) Solicitar tomografia computadorizada de crânio com urgência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159044)

Enunciado: Em relação à puberdade podemos afirmar que a:

A) Primeira manifestação da puberdade no sexo masculino é o aumento do volume testicular.

B) Primeira manifestação da puberdade no sexo masculino é a espermatogênese.

C) Mudança de voz no menino ocorre devido à ação estrogênica.

D) Aceleração do crescimento ocorre 2 anos após o início do desenvolvimento puberal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159058)

Enunciado: Criança de 5 anos de idade chega a Unidade Básica de Saúde acompanhada da avó, com queixa principal de cefaleia e vômitos. Qual(is) o(s) sinal/sintoma(s) que sugerem a hipótese diagnóstica de tumor cerebral?

A) Febre e dor em membros.

B) Melhora da cefaleia com analgésico.

C) Marcha claudicante e estrabismo.

D) Sonolência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159105)

Enunciado: Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Após a leitura dos itens abaixo sobre aleitamento materno, marque a resposta correta: I. Durante a amamentação, a produção do leite é iniciada por meio da sucção do recém-nascido, o que irá estimular a hipófise posterior e secretar prolactina, e esta, por sua vez, estimulará a produção de leite pelas células secretoras dos alvéolos da glândula mamária; II. O reflexo de descida do leite também se inicia com o estímulo da sucção, responsável por ativar a secreção de ocitocina pela hipófise anterior, que atinge os alvéolos, promove a contração das células mioepiteliais e leva o leite para dentro dos ductos e então ao recém-nascido; III. Entre os benefícios do aleitamento materno, estão: o melhor desenvolvimento da cavidade bucal, promoção do vínculo mãe-filho e o efeito protetor contra o câncer de mama para mulher.

A) Apenas o item I está correto.

B) Apenas o item II está correto.

C) Todos estão incorretos.

D) Apenas o item III está correto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135968)

Enunciado: Lactente de 2 meses e meio de idade, em aleitamento materno exclusivo é avaliado em unidade de pronto atendimento devido estrófulos em membros inferiores. Mãe nega febre ou outros sintomas, mas acha o bebê pálido. Exame físico sem alterações, exceto 2 lesões papulares na perna D. O pediatra solicita hemograma com o seguinte resultado: Leucócitos 10 500 - hematócrito 32% - plaquetas 360.000; Bastões 0% - hemoglobina 9,9; Segmentados 32% - VCM 94; Linfócitos 64% - HCM 30; Monócitos 4% - CHCM 32. Qual o diagnóstico hematológico e qual a conduta?

A) Anemia carencial; tratar com sulfato ferroso;

B) Anemia fisiológica; esclarecer a mãe;

C) Anemia carencial; iniciar leite de vaca;

D) Anemia fisiológica; iniciar leite de vaca;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135914)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA em relação a amamentação:

A) A hepatite B não é uma doença potencialmente transmissível pelo leite materno;

B) A toxoplasmose é transmitida via leite humano;

C) A tuberculose não é transmitida pelo leite humano;

D) Mães com lesões herpéticas nas mamas devem ser orientadas a suspender a amamentação temporariamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135939)

Enunciado: Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa correta com relação as seguintes afirmações: I - A deficiência de tiamina provoca anemia megaloblástica; II - A deficiência de vitamina D está relacionada a raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos; III - A deficiência de vitamina B12 pode causar Beribéri; IV - A deficiência de vitamina C crônica leva ao escorbuto.

A) F,F,F,F;

B) V,V,F,V;

C) F,V,F,V;

D) F,V,V,V;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108647)

Enunciado: Mãe primípara está com dificuldades na técnica de amamentação e pede ajuda ao pediatra. O profissional solicita a colocação do bebê ao seio e observa o sinal de possível dificuldade. Assinale o sinal que indica a possível dificuldade:

A) A cabeça e o tronco do bebê estão alinhados.

B) O corpo do bebê está muito perto do corpo da mãe.

C) A mama está apoiada com dedos da mãe na aréola.

D) O bebê está todo voltado para a mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108656)

Enunciado: Lactente de cinco meses de idade em aleitamento materno exclusivo é levado ao ambulatório para atendimento de Puericultura. A mãe quer saber se está na época de iniciar outro leite. O bebê está com peso adequado e curva de crescimento ascendente. Qual a conduta indicada?

A) Manter o leite materno e prescrever complementação;

B) Manter leite materno e prescrever papa de legumes;

C) Orientar a mãe sobre a importância do aleitamento exclusivo ao seio até o sexto mês;

D) Recomendar suco de fruta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84499)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta a provável sequência cronológica do desenvolvimento motor de Silvana, que hoje tem 1 ano e 6 meses:

A) Sentou-se com apoio, sustentou a cabeça, andou com apoio.

B) Sustentou a cabeça, andou com apoio, sentou-se com apoio.

C) Sentou-se com apoio, andou com apoio, sustentou a cabeça.

D) Andou com apoio, sentou-se com apoio, sustentou a cabeça.

E) Sustentou a cabeça, sentou-se com apoio, andou com apoio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84467)

Enunciado: Acerca do papel das fibras alimentares na dieta do lactante, assinale a opção CORRETA:

A) Na redução da absorção de gorduras, utilizam-se fibras solúveis.

B) Para o tratamento da diarreia aguda, é muito importante o uso de fibras insolúveis.

C) O leite materno é rico em fibras insolúveis.

D) Fibras solúveis são importantes na redução do colesterol.

E) Fibras insolúveis são aquelas ricas em gorduras.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84483)

Enunciado: A mãe de Jonas (4 meses) quer saber quando o pediatra prescreverá sulfato ferroso profilático. O Cartão da Criança de Jonas mostra que ele nasceu a termo e com peso adequado para a idade gestacional. Considerando que Jonas receberá exclusivamente leite materno até os 6 meses, assinale a alternativa que apresenta a provável resposta do pediatra.

A) Do primeiro até o segundo ano de vida.

B) Somente quando a criança apresentar anemia ferropriva.

C) Quando a criança apresentar anemia perniciosa.

D) A partir da introdução da alimentação complementar (dos 6 meses aos 2 anos).

E) Dos 6 meses até 1 ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84503)

Enunciado: Em relação a distúrbios do desenvolvimento puberal, é correto afirmar que:

A) O brotamento das mamas costuma ser a primeira alteração puberal reconhecida.

B) A menarca é a segunda alteração puberal que normalmente ocorre no desenvolvimento da puberdade.

C) Durante o estirão de crescimento associado à puberdade, os ossos longos de corpo se alongam, e as epífises não se fecham.

D) A secreção de hormônio do crescimento diminui juntamente com o aumento de gonadotropina no início da puberdade.

E) O surgimento dos pelos pubianos ocorre após a menarca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66956)

Enunciado: Considere as assertivas abaixo: I - Malformação congênita é todo defeito na constituição de algum órgão ou conjunto de órgãos que determine uma anomalia morfológica estrutural presente ao nascimento; II - Toda malformação congênita é de origem genética; III - Doença genética é todo e qualquer distúrbio que afete o material genético; IV - Toda doença genética é hereditária. Marque a alternativa em que as assertivas estão CORRETAS.

A) I e II.

B) II e III.

C) I e III.

D) II e IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66962)

Enunciado: Menina, 14 anos procurou atendimento por não apresentar desenvolvimento puberal. Mas nega atraso no desenvolvimento neuropiscicomotor ou dificuldade de leitura na escola. Ao exame: corada, hidratada, afebril, peso adequado, baixa estatura (abaixo do percentil 3), pescoço curto e alado, hipertelorismo mamário, cúbito valgo. Qual o diagnóstico sindrômico mais provável?

A) Síndrome de Turner;

B) Síndrome de Down;

C) Síndrome de Klinefelter;

D) Síndrome de Laron.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343181)

Enunciado: Com quais idades considera-se puberdade precoce em meninos e meninas?

A) Entre 8 e 13 anos nas meninas e entre 9 e 14 anos nos meninos.

B) Entre 6 e 8 anos nas meninas e entre 7 e 9 anos nos meninos.

C) Antes dos 8 anos em meninas e 9 anos em meninos.

D) Antes de 9 anos em meninas e 11 anos em meninos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343182)

Enunciado: Em relação à puberdade em meninos e meninas assinale a alternativa correta.

A) Em meninas, o início da puberdade é marcado pela menarca.

B) A puberdade inicia-se entre 8 e 13 anos nas meninas e entre 9 e 14 anos nos meninos.

C) Em meninos, o início da puberdade é marcado por pelos corporais generalizados.

D) A puberdade precoce sempre vai ser central.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343183)

Enunciado: Um adolescente de 13 anos de idade, sexo masculino, relata o aumento da mama direita há 6 meses. Ao exame físico apresenta tecido mamário subareolar palpável bilateralmente, testículos com 10ml e pelos axilares, com pelos pubianos e genitália no estágio 3 de Tanner. Qual a conduta mais indicada nesse momento?

A) Acompanhamento clínico.

B) Cirurgia para remoção das mamas.

C) Tratamento com inibidores de aromatase.

D) Tratamento com antagonistas de estrogênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343184)

Enunciado: Um dado do exame físico que levanta a suspeita de puberdade precoce periférica em um menino de 4 anos com virilização é a presença de:

A) Pubarca

B) Ginecomastia

C) Quadro neurológico

D) Testículos de volume infantil

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343185)

Enunciado: Um menino apresenta aumento de pênis em seu comprimento, testículos com 10cc, pelos escuros, grossos e crespos no saco escrotal e na linha média acima de pênis, bem como pelos finos acima do lábio superior, acne, mudança da voz e início do estirão puberal. Qual é a classificação de Tanner para seu estágio puberal?

A) G3P3

B) G2P2

C) G4P3

D) G3P2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341071)

Enunciado: Menino, 13 meses, em aleitamento materno exclusivo, pesa 11,0Kg e a curva de crescimento acompanha o mesmo percentil desde o nascimento. Sua mãe o leva à Unidade Básica de Saúde para orientação pois precisará complementar a alimentação para trabalhar fora de casa. A família é vegetariana e pretende manter essa prática na dieta da criança. Indique a partir de qual período de vida a introdução de novos alimentos deve ser incentivada:

A) 5 meses.

B) 6 meses.

C) 12 meses.

D) 24 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341072)

Enunciado: Menino, 13 meses, em aleitamento materno exclusivo, pesa 11,0Kg e a curva de crescimento acompanha o mesmo percentil desde o nascimento. Sua mãe o leva à Unidade Básica de Saúde para orientação pois precisará complementar a alimentação para trabalhar fora de casa. A família é vegetariana e pretende manter essa prática na dieta da criança. Indique os dois nutrientes, oligoelementos, que devem ser oferecidos como complementação na dieta dessa criança:

A) Ferro e Zinco.

B) Zinco e Cálcio.

C) Ferro e Magnésio.

D) Cálcio e Magnésio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341073)

Enunciado: Menino, 13 meses, em aleitamento materno exclusivo, pesa 11,0Kg e a curva de crescimento acompanha o mesmo percentil desde o nascimento. Sua mãe o leva à Unidade Básica de Saúde para orientação pois precisará complementar a alimentação para trabalhar fora de casa. A família é vegetariana e pretende manter essa prática na dieta da criança. Quanto à presença de aminoácidos essenciais na alimentação vegetariana, é correto afirmar:

A) Histidina, Leucina e Isoleucina não são encontrados na alimentação vegetariana.

B) Metionina, Cisteína e Histidina não são encontrados na alimentação vegetariana.

C) Triptófano, Valina e Metionina não são encontrados na alimentação vegetariana.

D) Todos os aminoácidos essenciais necessários à dieta são encontrados na alimentação vegetariana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341074)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, é levada ao Ambulatório de Pediatria com relato de ausência de menarca. Sua mãe apresentou a menarca aos 13 anos. Posiciona-se adequadamente nos gráficos ponderal e estatural. Verifica-se que apresenta caracteres sexuais secundários compatíveis com os critérios de Tanner M5P4 e não há alterações ao exame segmentar.

Considerando o caso clínico, indique a que parâmetros os critérios de Tanner se referem:

A) Axilarca, telarca e pubarca.

B) Axilarca e pubarca.

C) Axilarca e telarca.

D) Telarca e pubarca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341075)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, é levada ao Ambulatório de Pediatria com relato de ausência de menarca. Sua mãe apresentou a menarca aos 13 anos. Posiciona-se adequadamente nos gráficos ponderal e estatural. Verifica-se que apresenta caracteres sexuais secundários compatíveis com os critérios de Tanner M5P4 e não há alterações ao exame segmentar. Indique o diagnóstico provável para esse caso:

A) Menarca tardia.

B) Puberdade fisiológica.

C) Atraso puberal a esclarecer.

D) Atraso puberal constitucional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341076)

Enunciado: Menina, 14 anos de idade, é levada ao Ambulatório de Pediatria com relato de ausência de menarca. Sua mãe apresentou a menarca aos 13 anos. Posiciona-se adequadamente nos gráficos ponderal e estatural. Verifica-se que apresenta caracteres sexuais secundários compatíveis com os critérios de Tanner M5P4 e não há alterações ao exame segmentar. Indique a conduta adequada a ser adotada no caso:

A) Orientar aos pais e expectar.

B) Prescrever medroxiprogesterona.

C) Solicitar dosagem de TSH e FSH.

D) Solicitar ultrassonografia de útero e de ovários.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315174)

Enunciado: Um bebê primogênito de 1 mês de vida, amamentação exclusivamente ao peito, não ganhou peso adequadamente. A mãe se queixa de que a criança ?mama a toda hora?. Fez pré-natal completo, sem intercorrências e seu parto foi normal. O bebê nasceu a termo, pesando 3.400 g. Apresenta-se normal ao exame físico. Este quadro requer a seguinte conduta:

A) Avaliar técnica correta de amamentação.

B) Introduzir complemento de fórmula láctea.

C) Explicar à mãe a importância do leite materno.

D) Pesar o lactente antes e depois da mamada ao seio.

E) Nenhuma das afirmativas acima.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315175)

Enunciado: Quanto ao leite materno, pode-se afirmar que:

A) A proteção anti-infecciosa conferida à criança se refere apenas à doença diarreica viral.

B) A manutenção do aleitamento materno exclusivo até quatro meses é desejável pois a partir dessa idade as crianças necessitam alimentação rica em ferro.

C) A proteção anti-infecciosa decorrente do aleitamento materno é decorrente da presença de IgA secretora e vários fatores inespecíficos, como lisozima, fatores de maturação para o epitélio intestinal e lactoferrina.

D) Crianças com baixo peso devem receber leite de vaca como complemento até atingir o peso ideal para a idade.

E) O aleitamento materno não deve ser exclusivo até seis meses, pois a criança necessita de frutas para suplementar sua necessidade de vitaminas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315176)

Enunciado: Qual das opções abaixo é a mais eficaz para garantir um adequado volume de leite na nutriz?

A) Sucção frequente.

B) Nível plasmático de ocitocina.

C) Uso de spray de ocitocina

D) Uso regular de metoclopramida

E) Uso de bomba que garanta o esvaziamento do seio materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314206)

Enunciado: Todas as crianças necessitam fazer acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, principalmente, nos primeiros anos de vida. São competências do pediatra na puericultura todas as abaixo, exceto:

A) Obrigar viagem anual da criança com a família.

B) Orientar atividade física.

C) Orientar imunizações.

D) Avaliação do quadril coluna e marcha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313444)

Enunciado: Para oferecer um cuidado de qualidade e alcançar resultados positivos no controle de sintomas alguns pontos são muito relevantes. Dentre os abaixo, assinale a incorreta.

A) Avaliação das queixas utilizando instrumentos validados para a faixa etária pediátrica e o idioma.

B) Controle dos sintomas utilizando apenas a terapêutica farmacológica, excluindo-se as práticas não farmacológicas.

C) Comunicação dos achados de estudos e pesquisas, de hipóteses diagnósticas e do plano terapêutico de forma honesta e realista.

D) Reavaliação e monitoramento, a fim de ter certeza de que o tratamento está adequado e, caso contrário, proceder com nova avaliação e ajuste da terapêutica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313445)

Enunciado: Durante o plantão no Pronto Socorro Infantil você atende um paciente de 5 anos. Os pais referem que a criança apresenta febre, dor abdominal e vômitos. Ao exame apresenta-se descorado, hidratado, acianótico, ictérico, taquipnéico, febril, taquicárdico e edemaciado; o abdome é doloroso à palpação difusamente, com RHA diminuídos, restante do exame sem alterações importantes. Das alternativas abaixo são sinais apresentados pelo paciente todas as descritas, exceto:

A) Icterícia.

B) Edema.

C) Taquipneia.

D) Dor abdominal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307062)

Enunciado: Jovem, primípara, acaba de evoluir com parto normal e recebe notícia, durante internação, que está com sorologia positiva para HIV, motivo pelo qual não poderá amamentar. A paciente ainda não começou a produzir colostro. Identifique o mecanismo de ação da cabergolina:

A) Agonista da dopamina.

B) Antagonista da dopamina.

C) Antagonista de GnRH.

D) Inibidor da produção de ocitocina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280410)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta uma síndrome genética que não tem correlação clínica com ginecomastia.

A) Síndrome de Down.

B) Síndrome de Klinefelter.

C) Síndrome de Kallmann.

D) Síndrome de Peutz-Jeghers.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278094)

Enunciado: Sobre a Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) e musculoesquelético, assinale a alternativa correta.

A) As crianças com alterações do DNPM, do tônus muscular e da função neuromusculoesquelética apresentam maior risco de desenvolver atelectasias pulmonares.

B) Diferentemente da escala de Bayley, a Alberta identifica se a idade cronológica e o DNPM esperado da criança são correspondentes.

C) Existem diversos instrumentos determinados para avaliar o DNPM de acoro com a faixa etária da criança, em pediatria é recomendada, exclusivamente, a escala de Alberta.

D) O sistema neuromusculoesquelético não sofre alterações indiretas durante a internação hospitalar, principalmente e UTI.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275994)

Enunciado: Marcelo, 1 ano, termo, hígido, nasceu pesando 3400 g, medindo 50 cm de estatura e 35 cm de perímetro cefálico. Ao ser avaliado na UBS, quais seriam as medições esperadas para Marcelo?

A) Peso: 10 kg; estatura: 75 cm; perímetro cefálico: 47 cm.

B) Peso: 12 kg; estatura: 65 cm; perímetro cefálico: 41 cm.

C) Peso: 9,2 kg; estatura: 50 cm; perímetro cefálico: 39 cm.

D) Peso: 7,2 kg; estatura: 60 cm; perímetro cefálico: 44 cm.

E) Peso: 8,3 kg; estatura: 75 cm; perímetro cefálico: 37 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275995)

Enunciado: Júlia, 11 anos, hígida, vai à consulta com pediatra acompanhada de sua mãe Gabriela e de seu pai João. A mãe questiona o médico a respeito do início da puberdade de sua filha, querendo saber se há algum atraso, uma vez que aos 11 anos afirma já ter menstruado. O pediatra relata que Júlia ainda está dentro da faixa etária de início de desenvolvimento puberal e que a conduta, por hora, é acompanhar. João, atento, pergunta ao médico quais seriam os sinais, em sequência, que Júlia apresentaria e quando a menstruação de Júlia provavelmente irá acontecer. Em relação ao caso anteriormente descrito, quais seria a resposta do médico à pergunta de João, sabendo que o primeiro sinal puberal de Júlia irá aparecer ainda aos 11 anos?

A) Menarca, pubarca e telarca. A menstruação de Júlia irá acontecer, provavelmente, aos 13 anos.

B) Telarca, menarca e pubarca. A menstruação de Júlia irá acontecer, provavelmente, aos 11 anos.

C) Telarca, pubarca e menarca. A menstruação de Júlia irá acontecer, provavelmente, aos 13 anos.

D) Apenas telarca e menarca. A menstruação de Júlia irá acontecer, provavelmente, aos 12 anos.

E) Apenas telarca e pubarca. A menstruação de Júlia irá acontecer, provavelmente, aos 11 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283746)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando a velocidade de crescimento esperada para o perímetro cefálico, especifique qual deve ser, aproximadamente, o valor atual nesta criança:

A) 40 cm.

B) 42 cm.

C) 44 cm.

D) 46 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283747)

Enunciado: Menina, 8 meses de idade, é levada à Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta de rotina. Nasceu de parto natural a termo, pesando 3.300g; medindo 49cm e com Perímetro Cefálico medindo 34cm. Atualmente pesa 8.000g e mede 67,5cm (escore z: em ambos, entre -1 e +1). Está em aleitamento materno exclusivo. Considerando que essa criança apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado à idade, identifique entre as capacidades listadas a que mostra aquela que ela já deve ser capaz de executar atualmente.

A) Empilhar cubos.

B) Levantar-se sozinha com apoio.

C) Transferir objetos de uma mão para outra.

D) Pegar objetos em pinça com o polegar e o indicador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249289)

Enunciado: Qual é o objetivo do acompanhamento ambulatorial do prematuro?

A) Realizar o diagnóstico precoce das alterações de crescimento.

B) Identificar as alterações de peso no recém-nascido.

C) Detectar os possíveis desvios do crescimento normal, principalmente quanto ao peso, ao comprimento e ao perímetro cefálico.

D) Detectar os possíveis desvios do crescimento do perímetro cefálico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249291)

Enunciado: Assinale a alternativa correta quanto ao perímetro cefálico.

A) Deve ser medido apenas em crianças suspeitas.

B) Deve ser medido em todas as crianças até os 2 anos de idade.

C) Deve ser medido em todas as crianças até os 7 anos.

D) Deve se medido apenas nos primeiros 6 meses, após esse período só se houver suspeita de hidrocefalia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249905)

Enunciado: Sobre nutrição materna e infantil assinale a alternativa correta:

A) A nutrição materna deficiente afeta principalmente o sistema motor da criança.

B) A inadequada nutrição materna e infantil pode limitar o desenvolvimento de aspectos importantes da arquitetura do cérebro.

C) A anemia materna no primeiro trimestre gestacional é um dos fatores impeditivos para o crescimento infantil.

D) O estado nutricional adequado da gestante é importante, mas não é fator de risco para maiores problemas comportamentais na idade escolar, mesmo na ausência de déficits neurológicos evidentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249303)

Enunciado: A ginecomastia é a proliferação benigna mais comum do tecido glandular da mama masculina, causada pela alteração do equilíbrio entre as concentrações de estrógeno e androgênios. Pela Classificação de Simon, a mama que apresenta aumento mamário moderado com redundância de pele definida, similar a mama feminina corresponde ao grau:

A) I

B) II

C) III

D) IV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249404)

Enunciado: Assinale a alternativa incorreta em relação à palpação do abdome em pediatria:

A) Devemos aprofundar a palpação no tempo expiratório.

B) Sempre deixar as regiões dolorosas para serem palpadas por último.

C) Utilizar sempre a ponta dos dedos para pressionar os órgãos durante a palpação.

D) A princípio palpar toda a extensão do abdome, depois os órgãos específicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231388)

Enunciado: A anemia ocorre principalmente pela deficiência de ferro é a carência nutricional de maior magnitude no mundo. Atinge, principalmente, crianças menores de dois anos e gestantes e, no pré-natal, relaciona-se com o baixo peso ao nascer e à mortalidade materna. Em relação às estratégias criadas no Brasil para o controle e redução da anemia por deficiência de ferro, assinale a alternativa correta.

A) Suplementação preventiva diária de 60 mg de sulfato ferroso e 5mg de ácido fólico para crianças de 6 a 18 meses de idade e suplementação semanal de 25 mg de sulfato ferroso para gestantes a partir da 20ª semana.

B) Suplementação preventiva semanal de 25 mg de sulfato ferroso para crianças de 6 a 18 meses de idade e suplementação diária de 60 mg de sulfato ferroso e 5mg de ácido fólico para gestantes a partir da 20ª semana.

C) Suplementação medicamentosa diária de 60 mg de sulfato ferroso e 5mg de ácido fólico somente para gestantes com diagnóstico de anemia falciforme.

D) Fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e vitamina A: cada 100g de farinha de trigo e de milho deverá conter 10,0 mg de ferro e 200.000 UI de vitamina A.

E) fortificação das farinhas de mandioca e arroz com ferro e tiamina: cada 100g de farinha de mandioca e arroz deverão conter 10,0 mg de ferro e 150 mg de vitamina B1.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201763)

Enunciado: Qual das opções abaixo é a mais eficaz para garantir um adequado volume de leite na nutriz?

A) Sucção frequente.

B) Nível plasmático de ocitocina.

C) Uso de spray de ocitocina.

D) Uso regular de metoclopramida.

E) Uso de bomba que garanta o esvaziamento do seio materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201764)

Enunciado: O retardo na purberdade é definido como a ausência de características sexuais secundárias na idade de:

A) 10 anos.

B) 12 anos.

C) 14 anos.

D) 16 anos.

E) 18 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215513)

Enunciado: Você está atendendo em uma UBS e a mãe traz seu filho de 1 ano e 3 meses para consulta de rotina; refere que a criança começou a andar faz 1 mês e está falando algumas palavras, usa fralda durante o dia e à noite. Come bem, mas mama apenas leite materno. Ao exame apresenta PC no percentil 50, peso no percentil 25 e estatura no percentil 25 do gráfico de crescimento. Qual é a orientação para a mãe?

A) Solicitar TC de crânio, pois a criança está com PC desproporcional ao tamanho e peso.

B) Orientar suspender o leite materno e iniciar leite de vaca engrossado, pois a criança está desnutrida.

C) Orientar apenas retorno na consulta de rotina.

D) Solicitar hemograma, urina 1, glicemia, ureia e creatinina para investigar a causa da desnutrição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219915)

Enunciado: Adolescente feminino, 17 anos, apesar de ter feito acompanhamento nutricional com sucesso, optara por realizar cirurgia de redução de estômago em serviço privado. Evoluiu com complicações pós-cirúrgicas e foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva onde veio a falecer cinco dias após a admissão. Um jornal local quer fazer reportagem sobre os riscos de procedimentos cirúrgicos na adolescência e procura você. Frente aos dados deste caso e baseando-se no capítulo XI - Sigilo Profissional - do Código de Ética Médica brasileiro (2010), assinale a opção CORRETA:

A) Você pode revelar fato de que tenha conhecimento em vista do exercício de sua profissão, quando este já é de conhecimento público.

B) Você poderá prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.

C) Você poderá utilizar retratos de sua paciente em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, com a autorização do paciente/familiares.

D) Você tem o dever de preservar o sigilo profissional em paciente com menos de 18 anos de idade, mesmo após o óbito da adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219896)

Enunciado: Na unidade básica de saúde, você está acompanhando um lactente de seis meses de idade que está em aleitamento materno exclusivo e a mãe está com dúvidas quanto a introdução de alimentos. Segundo orientações para alimentação saudável do Ministério de Saúde, você deverá orientar a mãe que:

A) Aos oito meses, a criança poderá receber a alimentação básica da família desde que não seja muito temperada.

B) Há crianças que se adaptam facilmente às novas etapas e aceitam bem os novos alimentos permitindo a retirada do leite materno.

C) Outros alimentos podem ser introduzidos de forma lenta e gradual até a retirada do leite materno ao final do primeiro ano de vida.

D) Se a criança rejeitar as primeiras ofertas pode indicar intolerância ao alimento devendo-se oferecer outros em substituição.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212202)

Enunciado: As evidências científicas acerca da prevenção de doenças crônicas e degenerativas do adulto através da alimentação saudável na primeira infância têm levado o governo brasileiro a investir em treinamentos para intervenções nutricionais em aleitamento materno. Aplicando a Bioética às boas práticas de aconselhamento, podemos dizer:

A) a escuta é mais importante que qualquer outro instrumento de intervenção em aleitamento materno.

B) nos casos de contraindicações do leite materno, o preparo de fórmula não deve ser orientado na maternidade, pelo risco de outras mães se desestimularem a amamentar.

C) deve-se observar e intervir nas mães inseguras quanto às vantagens do aleitamento materno, e a liberação para alta depende da alimentação do bebê com leite materno exclusivo.

D) deve ser realizado aconselhamento sempre que se observar relutância em não amamentar, com técnicas verbais e todas as informações possíveis, empatia e julgando o aleitamento materno a melhor escolha para o binômio mãe-bebê.

E) o aconselhamento em saúde não significa necessariamente que o profissional de saúde fale das vantagens e alerte sobre os riscos da não amamentação, mas tenha argumentação para que a mãe opte pela decisão de amamentar com autonomia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212177)

Enunciado: Na avaliação da puberdade, costuma-se avaliar as mamas e os pelos púbicos nas meninas e as características dos genitais e os pelos púbicos nos meninos. Nesse contexto, dadas as afirmativas, considerando-se sua evolução natural, I. Nas mamas, no estágio 4, a aréola e a papila formam um contorno secundário, destacando-se do resto da mama. II. Nos genitais, no estágio 2, o escroto apresenta-se levemente aumentado, com pele mais escura e mudança de textura, enquanto no estágio 1, permanece de tamanho e formas infantis. III. No estágio 3, tanto em meninos quanto em meninas, os pelos são finos, longos, lisos ou curvos, com localização exclusiva em base do pênis ou a longo dos lábios. verifica-se que está(ão) correta(s)

A) II, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

180119)

Enunciado: Um bebê primogênito de 1 mês de vida, amamentação exclusivamente ao peito, não ganhou peso adequadamente. A mãe se queixa de que a criança ?mama a toda hora?. Fez pré-natal completo, sem intercorrências e seu parto foi normal. O bebê nasceu a termo, pesando 3.400 g. Apresenta-se normal ao exame físico. Este quadro requer a seguinte conduta:

A) Avaliar técnica correta de amamentação

B) Introduzir complemento de fórmula láctea

C) Explicar à mãe a importância do leite materno

D) Pesar o lactente antes e depois da mamada ao seio

E) Nenhuma das afirmativas acima

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

180129)

Enunciado: Quanto ao leite materno, pode-se afirmar que:

A) A proteção anti-infecciosa conferida à criança se refere apenas à doença diarreica viral

B) A manutenção do aleitamento materno exclusivo até quatro meses é desejável pois a partir dessa idade as crianças necessitam alimentação rica em ferro.

C) A proteção anti-infecciosa decorrente do aleitamento materno é decorrente da presença de IgA secretora e vários fatores inespecíficos, como lisozima, fatores de maturação para o epitélio intestinal e lactoferrina

D) Crianças com baixo peso devem receber leite de vaca como complemento até atingir o peso ideal para a idade

E) O aleitamento materno não deve ser exclusivo até seis meses, pois a criança necessita de frutas para suplementar sua necessidade de vitaminas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

180132)

Enunciado: Qual das opções abaixo é a mais eficaz para garantir um adequado volume de leite na nutriz?

A) Sucção frequente

B) Nível plasmático de ocitocina

C) Uso de spray de ocitocina

D) Uso regular de metoclopramida

E) Uso de bomba que garanta o esvaziamento do seio materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187762)

Enunciado: Qual alternativa é CORRETA em relação às peculiaridades próprias da relação médico-paciente em Pediatria?

A) Aquele que se chama paciente muitas vezes não é a criança, mas sim a mãe ou o pai

B) Dirigir-se às mães, chamando-as de "mãe" e não pelo seu nome reforça o caráter pessoal da relação

C) Na clientela particular de consultório, o pagamento direto pelos serviços médicos diminiu a aquisição de direitos sobre o pediatra

D) Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico, a satisfação com os pediatras vem crescendo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187811)

Enunciado: Qual alternativa está CORRETA em relação aos alimentos e à medicação na prevenção de anemia por deficiência de ferro?

A) Lactente nascido a termo, com peso adequado e recebendo pelo menos 500ml/dia de fórmula alimentar não necessita de reposição de ferro

B) O espinafre contém alto teor de ferro, porém tem baixa disponibilidade

C) O feijão tem alto teor de ferro e alta disponibilidade

D) Prematuros acima de 2kg ao nascimento não necessitam receber reposição de ferro

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182759)

Enunciado: Cognição é uma rede complexa de funções mentais comandadas pelo cérebro que inclui todas as alternativas abaixo, EXCETO:

A) Atenção

B) Memória

C) Aprendizado

D) Audição

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182764)

Enunciado: São fatores que podem influenciar o desenvolvimento cognitivo da criança, EXCETO:

A) Prematuridade.

B) Recém-nascidos com Crescimento Intra-Útero Acelerado (GIG).

C) Nível socioeconômico.

D) Estimulação no primeiro ano de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182776)

Enunciado: Em relação ao Desenvolvimento Cognitivo, assinale a alternativa CORRETA:

A) Durante os períodos fetal e neonatal precoce, o cérebro está em uma fase de desenvolvimento e amadurecimento rápidos, sendo um período que o torna vulnerável a desequilíbrios nutricionais.

B) O desenvolvimento cognitivo depende apenas do desenvolvimento e do amadurecimento estrutural das várias regiões do cérebro, e não sofre influências externas.

C) Após um período de deficiência nutricional, depois da reposição do nutriente em quantidades adequadas, o cérebro tem capacidade de recuperar-se totalmente, sem sofrer interferências.

D) Algumas áreas específicas do cérebro, associadas à linguagem, leitura e memória não sofrem influências de agravos nutricionais durante a infância.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182785)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA:

A) A desnutrição nos primeiros dois anos de vida pode estar associada a alterações do desenvolvimento da linguagem e do aprendizado.

B) Existe uma relação entre deficiência de ferro e pior desenvolvimento cognitivo durante a infância.

C) A dieta materna influencia as variações no conteúdo de gordura do leite materno.

D) O número de partos anteriores é um importante fator de influência na variação do conteúdo de gordura do leite materno, quanto maior o número de gestações, maiores as concentrações de gordura no leite materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181413)

Enunciado: A puberdade feminina caracteriza-se pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários (mamas, pelos pubianos e menstruação) paralelamente à aceleração ou estirão do crescimento, dentre outros eventos biológicos e psicossociais. Sobre a puberdade precoce feminina, é correto afirmar:

A) um dos principais exames complementares é a radiografia de mãos e punhos, avaliada comumente pelo método de Tanner, para determinação da idade óssea.

B) no exame físico ginecológico, é importante realizar avaliação cuidadosa e se utilizar dos critérios de Greulich-Pyle para determinar o desenvolvimento mamário e dos pelos pubianos.

C) a puberdade precoce central é causada por maturação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, sendo na maioria dos casos por ativação idiopática dos pulsos de GnRH.

D) a puberdade precoce periférica pode ser causada por excesso de hormônios esteroides sexuais de fonte exógena, secretados pelas gônadas ou nas glândulas suprarrenais, com ativação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

E) cistos foliculares de ovário são a causa mais rara de puberdade precoce periférica, sendo as neoplasias ovarianas, como as das células da granulosa, tumores de células de Leydig e gonadoblastomas, as mais frequentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181401)

Enunciado: Constitui contraindicação absoluta ao aleitamento materno:

A) galactosemia.

B) mastite lactacional.

C) fissura labiopalatal.

D) ingurgitamento mamário.

E) doença da urina de xarope de bordo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152625)

Enunciado: O aleitamento materno está contraindicado quando a mãe apresenta:

A) HTLV-1.

B) Sífilis.

C) Citomegalovírus.

D) Toxoplasmose.

E) Rubéola.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161276)

Enunciado: Para o adequado tratamento de pacientes com betatalassemia maior, inclui terapêutica transfusional crônica, agentes quelantes de ferro, esplenectomia, transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas e medidas de suporte. Entretanto, a terapia transfusional regular leva a complicações relacionadas à sobrecarga de ferro, incluindo manifestações listadas a seguir, com EXCEÇÃO de:

A) Retardo no crescimento.

B) Aceleração da maturação sexual.

C) Miocardiopatia dilatada.

D) Fibrose hepática e cirrose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158801)

Enunciado: Qual o sinal de alarme que surge na criança aos nove meses de vida, devendo-se realizar como conduta, a investigação do comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor?

A) Não fala quatro palavras.

B) Não segue ordens simples.

C) Não tem preensão em pinça.

D) Ausência de sinergia pés-mãos.

E) Não se arrasta para subir em objetos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158809)

Enunciado: Dadas as afirmativas sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor infantil, I. Aos dois anos de vida, a criança é capaz de: correr com desenvoltura, abrir portas, subir em cadeiras, ajudar no vestir, manusear bem colheres e começar a formar frases.; II. Aos três anos de vida, a criança é capaz de: pular, ficar de um pé só, participar de jogos e brincadeiras, controlar evacuação e micção diurna, dizer sua idade e sexo, contar até três objetos.; III. Aos dezoito meses de vida, a criança é capaz de: ao correr, movimentar o corpo em bloco, sentar-se a partir da posição ereta, procurar ajuda em situações de perigo, beijar familiares, falar dez palavras e reconhecer partes do corpo.; Verifica-se que está(ão): correta(s)

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) III, apenas.

D) II, apenas.

E) I, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158825)

Enunciado: Dadas as afirmativas sobre a absorção de ferro, I. O efeito negativo dos fitatos não sofre interferência da dose.; II. A absorção do ferro heme ocorre da mesma forma do ferro inorgânico.; III. O ácido ascórbico e o ácido cítrico melhoram a biodisponibilidade do ferro, reduzindo de ferroso para férrico.; IV. São fatores inibidores de sua absorção: os polifenóis, fitatos, cálcio, caseína e proteínas de legumes.; V. Em refeições ricas em fitatos, recomenda-se a ingestão concomitante de ácido ascórbico, que compensaria o efeito negativo dos fitatos, na proporção 2:1 (ácido ascórbico: ferro).; Verifica-se que estão corretas apenas:

A) I e IV.

B) III e IV.

C) IV e V.

D) I, II e III.

E) I, II e V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131399)

Enunciado: Em que período da vida o crescimento é acelerado?

A) Com 3 anos e com 10 anos.

B) No primeiro ano de vida e na adolescência.

C) Entre 5 e 7 anos de idade.

D) Antes e após a menstruação.

E) Período pré-escolar e escolar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131403)

Enunciado: Qual o tecido ou sistema que primeiro para de crescer?

A) Tecido conjuntivo.

B) Sistema imune.

C) Tecido nervoso.

D) Sistema vascular.

E) Musculoesquelético.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131409)

Enunciado: Você é o (a) médico (a) de um posto de saúde e atende em consulta agendada um bebê de 02 meses de vida, trazido pela primeira vez ao serviço, cuja mãe tem 15 anos de idade. Qual a forma mais adequada de realizar este atendimento de modo a otimizar o máximo possível esta consulta?

A) Deixaria que a mãe falasse espontaneamente e responderia a cada dúvida que ela tivesse.

B) Seguiria o padrão de consulta, começando pela queixa principal, história da doença atual, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, antecedentes patológicos e sociais. Faria a revisão dos sistemas e procederia ao exame físico. No final, faria as orientações necessárias identificadas pela esta anamnese e prescreveria a receita.

C) Iniciaria o atendimento pela identificação, tentando desde o início interagir com a jovem mãe, para

adquirir a confiança da mesma. Seguiria um padrão de anamnese e exame físico priorizando a história alimentar e vacinal. Procederia ao exame físico discutindo cada detalhe e esclarecendo dúvidas. Faria a prescrição conforme os diagnósticos levantados e agendaria o retorno para o próximo mês.

D) Em um posto de saúde a demanda é grande e quanto mais ágil for o atendimento melhor para a população.

E) Deixaria que a enfermeira atendesse, pois se trata apenas de um atendimento de rotina para orientar vacina e dieta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131421)

Enunciado: Mãe traz seu filho com uma semana de vida para consulta, em aleitamento materno exclusivo. A queixa é a de que ?toda vez que mama, evacua?. Sua conduta é:

A) Suspender o aleitamento, dar soro oral e agendar retorno em 24 horas.

B) Suspender o aleitamento materno e prescrever uma fórmula isenta de lactose.

C) Trocar o aleitamento materno para o leite de vaca diluído acrescido de creme de arroz.

D) Manter o aleitamento materno e prescrever soro oral no intervalo das mamadas.

E) Manter o aleitamento materno e tranquilizar a mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134879)

Enunciado: Está cada vez mais comum, entre crianças e jovens, o consumo dos chamados fast foods . Esse tipo de dieta deve ser desestimulado por ter valor nutricional pobre e por ser:

A) Hiperproteica.

B) Hipocalórica.

C) Rica em ferro.

D) Rica em sódio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134792)

Enunciado: Em relação às anemias carenciais, podemos afirmar que

A) o diagnóstico laboratorial da anemia ferropriva inclui ferro sérico e ferritina sérica baixos, capacidade total de ligação de ferro
baixa e saturação de transferrina alta.

B) a deficiência de B12 e as talassemias são exemplos clássicos de anemias macrocíticas.

C) nas crianças com anemia hemolítica esferocítica, está contraindicado o uso de sulfa e quinolonas.

D) baixo peso ao nascimento, desmame precoce e baixa disponibilidade de ferro na dieta predipõem às anemias ferroprivas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134795)

Enunciado: Você recebe em seu consultório um lactente de 3 meses, nascido de termo, sem intercorrências na gestação e período neonatal. Ao exame físico, apresenta as mãos sempre fechadas, não sorri e não sustenta a cabeça. Diante desse caso, qual é a conduta MAIS adequada?

A) Solicitar teste do olhinho e da orelhinha, com retorno em 30 dias para reavaliação.

B) Orientar a família a fazer estimulação motora e sensorial, além de encaminhar para o fisioterapeuta.

C) Aguardar o teste do pezinho para avaliar doenças metabólicas congênitas.

D) Encaminhar ao neurologista para avaliação e investigação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134272)

Enunciado: Os suplementos vitamínicos e minerálicos na adolescência devem ser oferecidos somente:

A) Na fase de aceleração do crescimento.

B) Na fase de desaceleração do crescimento.

C) Antes da menarca.

D) Em situações especiais como distúrbios alimentares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134801)

Enunciado: Em uma consulta de rotina do Posto de Saúde, você atende uma criança que apresenta as seguintes habilidades: anda com apoio, aproxima-se quando é chamada, bate palmas, solta um objeto sob comando, emite 1 ou 2 palavras com significado. Considerando as diretrizes com referência à faixa superior da normalidade, você diria que essa criança tem quanto tempo?

A) 6 meses

B) 9 meses

C) 12 meses

D) 18 meses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134803)

Enunciado: Em relação ao desenvolvimento infantil, podemos afirmar que

A) o desenvolvimento adequado da criança não depende de um ambiente social propício.

B) o lactente se senta sem apoio por volta dos 6 meses.

C) o uso de bebidas alcoólicas durante a gestação não é fator de distúrbios do desenvolvimento.

D) por volta de 1 e 2 meses, a criança é capaz de combinar 2 palavras.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134061)

Enunciado: Pré-escolar, 36 meses, apresenta, ao exame físico, tecido celular subcutâneo diminuído, sem outras alterações clínicas. A avaliação do gráfico da curva de crescimento mostra peso/idade no percentil 2. Segundo as normas do Ministério daSaúde, pode-se afirmar que o pré-escolar

A) é portador de baixo peso.

B) é portador de desnutrição grave.

C) se encontra em alerta nutricional.

D) é portador da forma clínica denominada marasmo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134834)

Enunciado: Criança de 7 anos é levada pela mãe ao Pediatra para consulta de rotina. Ao exame físico, foi constatado que a criança estava no estágio M2P2 de Tanner. Diante de tal caso clínico, a hipótese diagnóstica MAIS provável é:

A) Puberdade precoce.

B) Telarca idiopática precoce.

C) Pseudopuberdade precoce.

D) Puberdade normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134055)

Enunciado: A forma prática de monitorizar a nutrição pós-natal do recém-nascido pré-termo, durante a internação na UTI neonatal, é avaliada por

A) dosagem da pré albumina.

B) dosagem da albumina sérica.

C) utilização das curvas de crescimento.

D) dosagem de creatinina sérica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134267)

Enunciado: A causa mais comum de anemia por deficiência de ferro na infância é

A) Gemelaridade.

B) Infecções crônicas.

C) Desordens gastrointestinais.

D) Ingestão inadequada de ferro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110542)

Enunciado: A deficiência de ferro em lactentes e crianças maiores acompanha-se clinicamente de todos os sinais e sintomas, EXCETO:

A) Irritabilidade.

B) Geofagia.

C) Hipertrofia das papilas gustativas.

D) Anorexia.

E) Palidez.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110604)

Enunciado: São características descritas na Síndrome de Down, EXCETO:

A) hipermobilidade articular;

B) hipotonia muscular;

C) macroglossia;

D) malformações cardíacas;

E) deficiência mental.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110571)

Enunciado: Escolar do sexo masculino de sete anos e seis meses de idade, previamente saudável, trazido ao seu consultório com queixa de baixa estatura. A família tem boa renda e as condições alimentares são adequadas. A altura da mãe é de 1.55 m (p25) e a do pai de 1.75 m (p50-75). Traz exames complementares realizados previamente com resultados dentro do padrão normal. Atualmente a criança mede 1.16 m e pesa 20 kg, tem desenvolvimento neuropsicomotor e exame físico normais. A melhor conduta é:

A) Tranquilizar a família e reavaliar o crescimento em 6 a 12 meses.

B) Solicitar novos exames complementares e

raios X de sela túrcica.

C) Encaminhar ao endocrinologista para avaliação.

D) Solicitar dosagem de hormônio do crescimento.

E) Solicitar T4 livre, TSH e cintilografia de tireoide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110574)

Enunciado: No desenvolvimento neuropsicomotor de um lactente observa-se, aproximadamente aos seis meses de idade, a aquisição da capacidade de:

A) sustentar a cabeça;

B) sorrir socialmente;

C) ficar sentado, inclinando-se para frente;

D) abrir a boca para ser alimentado;

E) ficar em pé segurando no berço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109773)

Enunciado: Criança de 1 ano e 3 meses vem em consulta de rotina e apresenta PC no percentil 50, peso no percentil 25 e estatura no percentil 25 do gráfico de crescimento. Mãe refere que a criança começou a andar há 1 mês e está falando algumas palavras. Come bem, mas toma apenas leite materno. Usa fralda durante o dia e à noite. Qual é a orientação para a mãe?

A) Encaminhar ao neurologista para investigar atraso DNPM, pois a criança começou a andar muito tarde, fala apenas algumas palavras e ainda usa fralda durante o dia.

B) Solicitar hemograma, urina 1, glicemia, ureia e creatinina para investigar a causa da desnutrição.

C) Solicitar TPC de crânio, pois a criança apresenta PC desproporcional ao tamanho e peso.

D) Orientar apenas retorno à consulta de rotina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109994)

Enunciado: Um lactente de seis semanas de vida, com diagnóstico de cardiomiopatia congestiva, está pesando 4 kg. Alimenta-se de 360 ml de fórmula diariamente. Das alternativas abaixo, a consequência MAIS provável da ingestão diminuída nessa criança é:

A) Hipocalcemia.

B) Hipoglicemia.

C) Ganho de peso inadequado.

D) Hipopotassemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109808)

Enunciado: Mãe procura você no consultório para acompanhamento do bebê. Lactente encontra-se com 6 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, sem alterações ao exame físico. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado, crescimento peso no percentil 20% e estatura no percentil 25%. Nesse caso, o que você orienta para a mãe?

A) Manter aleitamento materno exclusivo e retornar em 1 mês para pesar.

B) Manter aleitamento materno e iniciar papas.

C) Suspender aleitamento materno, iniciar fórmula infantil e retornar em 1 mês para pesar.

D) Manter aleitamento materno e associar leite integral com frutas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86611)

Enunciado: O processo de crescimento é multifatorial, englobando a composição genética do indivíduo, fatores neuroendócrinos, ambientais, nutricionais e psicossociais. De acordo com o exposto, assinale a afirmativa CORRETA:

A) No primeiro ano de vida ocorre a maior velocidade de crescimento, cerca de 40 cm/ano e ganha cerca de 8 kg.

B) No primeiro ano de vida ocorre a maior velocidade de crescimento, cerca de 24 cm/ano e ganha cerca de 6 kg.

C) No segundo ano de vida cresce aproximadamente 24 cm/ano.

D) A velocidade de crescimento na fase escolar está em torno de 12 cm/ano.

E) O estirão puberal é mais tardio e mais amplo nas meninas do que nos meninos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86616)

Enunciado: Quais os itens abaixo são marcos do desenvolvimento de uma criança com 6 meses de idade?

A) Sorri, eleva a cabeça e a mantém a 45º.

B) Transfere objeto de uma mão para a outra, pinça polegar-dedo.

C) Bate palmas, acena, vocaliza.

D) Tenta alcançar um brinquedo, chama atenção por meio de um sorriso, vocalização.

E) Senta sem apoio, balbucia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86612)

Enunciado: Marcela, de seis anos de idade, é levada para consulta por apresentar palidez há seis meses e falta de apetite. Exame físico: palidez cutâneo-mucosa e restante normal. Para confirmação de anemia ferropriva, quais as alterações encontradas nos exames?

A) Hb < 11 g/dl, contagem de reticulócitos aumentada, hipercromia e macrocitose.

B) Hb < 11 g/dl, contagem de reticulócitos normal ou diminuída, hipocromia e microcitose.

C) Hb < 11,5 g/dl, contagem de reticulócitos aumentada, hipercromia e macrocitose.

D) Hb < 11,5 g/dl, contagem de reticulócitos normal ou diminuída, hipocromia e microcitose.

E) Hb < 12 g/dl, contagem de reticulócitos aumentada, hipercromia e macrocitose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86617)

Enunciado: Marcela de seis anos de idade é levada para consulta por apresentar palidez há seis meses e falta de apetite. Exame físico: palidez cutâneo-mucosa e restante normal. Após iniciar o tratamento para Anemia Ferropriva de Marcela, qual o exame mais adequado para avaliar precocemente a sua resposta terapêutica?

A) Dosagem de hemoglobina.

B) Contagem de reticulócitos.

C) Saturação de transferrina.

D) Dosagem de ferro sérico.

E) Ferritina sérica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86641)

Enunciado: Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a alternativa CORRETA: ( ) Em casos de doença cardiovascular materna, a amiodarona poderá ser utilizada. ( ) A vincristina é contraindicada na amamentação, bem como a maioria dos quimioterápicos. ( ) Quando há a necessidade do uso do lítio durante a amamentação, deve-se monitorar níveis plasmáticos de lítio na mãe e no bebê, assim como a função tireóidea. ( ) Carbamazepina e ácido valproico são considerados substâncias seguras para uso durante a lactação. As respostas são, respectivamente:

A) V, V, F, F.

B) V, F, F, V.

C) F, F, V, F.

D) V, F, V, F.

E) F, V, V, V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86873)

Enunciado: Lactente feminino, 20 meses de idade, é levado para consulta de puericultura sem queixas. Usou leite materno até o quarto mês de vida, quando começou a usar a alimentação complementar adequada e também leite de vaca 6 vezes ao dia. Não usa ou usou medicamento algum. Trouxe um hemograma que mostra Hb = 9,2 g/dl, VCM = 61 micro3, RDW = 18%. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico MAIS PROVÁVEL para o quadro acima.

A) Anemia falciforme.

B) Talassemia minor.

C) Esferocitose hereditária.

D) Anemia ferropriva.

E) Anemia hemolítica autoimune.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86870)

Enunciado: O início da puberdade é acompanhado de diferentes mudanças corporais e psicológicas. Qual dos eventos abaixo é considerado o melhor parâmetro do início da puberdade em meninos?

A) Aumento dos testículos e da bolsa escrotal;

B) Mudança do timbre de voz;

C) Crescimento de pelos em face;

D) Velocidade rápida do crescimento;

E) Mudanças psicológicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158438)

Enunciado: Em relação ao aleitamento materno, é CORRETO afirmar que:

A) Para retirar o recém-nascido da mama, a nutriz deve esperar que ele adormeça.

B) Deve-se iniciar precocemente, a partir da 2ª hora de vida.

C) Deve ser evitado nas mães que apresentam sangramento maior que 2 litros na parturição.

D) A pega deve ser com o recém-nascido apreendendo toda a aréola mamária e com os lábios evertidos.

E) No ingurgitamento mamário, devem ser indicadas compressas mornas nas mamas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158402)

Enunciado: Segundo os 10 passos para alimentação saudável do lactente, está INCORRETA a afirmativa:

A) Recomenda-se introdução de alimentos sólidos a partir do 6° mês de vida.

B) O suco de fruta não é indicado na dieta de um lactente.

C) Recomenda-se que o aleitamento materno seja oferecido no mínimo até os 12 meses e, depois disso, pelo tempo que desejado mutuamente.

D) Os lactentes que não são alimentados ao seio podem receber leite de vaca integral após o 6° mês de vida.

E) Aos 6 meses, deve-se acrescentar fonte protéica animal, carbohidratos, frutas e verduras.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158388)

Enunciado: Segundo critérios de Tanner, a primeira manifestação da puberdade no sexo feminino é:

A) Menarca.

B) Adrenarca.

C) Pubarca.

D) Telarca.

E) Ciclos anovulatórios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158399)

Enunciado: Qual das situações abaixo representa uma contraindicação absoluta para o aleitamento materno?

A) Prótese de silicone materna.

B) Infecção materna pelo HTLV-1.

C) Recém ? nascido com citomegalovirose congênita.

D) Mãe com tuberculose pulmonar.

E) Mãe com herpes labial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158433)

Enunciado: A amamentação possui inúmeras vantagens para a mãe e para o filho. Assim, cabe ao médico auxiliar na promoção do aleitamento materno através de:

A) Estímulo à amamentação na 1ª hora após o parto.

B) Orientação quanto a horários e intervalos de mamadas a cada 3 horas.

C) Recomendação de fricção mamilar com bucha vegetal durante o pré-natal.

D) Prescrição de cremes à base de lanolina para prevenção de fissuras mamilares.

E) Estímulo à amamentação após todo o cuidado e banho do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108597)

Enunciado: Os eventos habituais no desenvolvimento puberal normal, em ordem de surgimento, são:

A) Velocidade máxima de crescimento, surgimento de pelos pubianos, brotamento mamário, menarca.

B) Surgimento de pelos pubianos, velocidade máxima de crescimento, brotamento mamário, menarca.

C) Brotamento mamário, menarca, surgimento dos pelos pubianos, velocidade máxima de crescimento.

D) Brotamento mamário, surgimento de pelos pubianos, velocidade máxima de crescimento, menarca.

E) Surgimento de pelos pubianos, brotamento mamário, menarca, velocidade máxima de crescimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108610)

Enunciado: Criança de 1 ano e 4 meses vai à UBS onde você realiza o internato de medicina preventiva, por conta de quadro gripal. Alimentação da criança variada. Vacinas realizadas até 1 ano de idade. Ao exame, menor eupneica, hidratada, anictérica, acianótica, afebril, boa interação com o meio, desenvolvimento neuropsicomotor adequado para idade, AP: MV presente bilateralmente com roncos de transmissão, AC: BCNF RCR 2T S/Sopro, abdome flácido sem megas ou massas, extremidades sem alterações. Quais das situações abaixo esperamos que essa criança ainda não realize?

A) Andar sem apoio.

B) Falar até 5 palavras comuns.

C) Andar para trás.

D) Trocar objetos de mãos.

E) Colocar objeto dentro de uma vasilha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108612)

Enunciado: Com relação ao desenvolvimento de uma criança de 2 meses devemos observar:

A) Fixa o olhar no rosto do examinador ou da mãe.

B) Segue objeto na linha média.

C) Reage ao som.

D) Eleva a cabeça.

E) TODAS ACIMA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108616)

Enunciado: Com relação à recomendação para suplementação de ferro, é CORRETO:

A) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, não é indicado a

suplementação.

B) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para idade gestacional, em uso de fórmula infantil até 6 meses de idade e a partir do 6° mês se houver ingestão mínima de 500 ml de fórmula por dia, não é indicado a suplementação.

C) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para idade gestacional, a partir da introdução de alimentos complementares, é indicado a suplementação de ferro.

D) Prematuros maiores de 1.500 g e recém-nascidos de baixo peso, a partir do 30° dia de vida, é indicada a suplementação.

E) Todas corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327281)

Enunciado: Em uma consulta de ambulatório, ao receber mãe, avó e LILS, de 1 semana de vida. Você é questionado pela avó, que seu neto, nasceu a termo com 3.400 kg e elas observaram perda de peso do bebê nos últimos dias. Na triagem, o peso do bebê hoje é de 3.000kg. Na anamnese, mãe relata aleitamento materno exclusivo e a avó sugere, a necessidade de complemento (mamadeira), já que seu neto perdeu peso e na sua família as mães não têm leite. Na oportunidade ao observar a mamada, você detectou que o seio da lactante apresenta fissuras, o que seria evitado se a pega estivesse adequada. O que é necessário para uma boa pega: I. Mais aréola visível, acima da boca do bebê. II. Boca bem aberta. III. Bochechas do bebê encovadas a cada sucção. IV. Ruídos da língua. V. Lábio inferior virado para fora. VI. Queixo tocando a mama. Assinale a alternativa CORRETA.

A) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

B) Somente as afirmativas I, II, V e VI estão corretas.

C) Somente as afirmativas I, III, IV e VI estão corretas.

D) Somente as afirmativas II, III, V e VI estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327288)

Enunciado: Mãe, leva o filho Luís, de 12 meses de idade, a consulta de puericultura, ansiosa, efetuando alguns questionamentos, pois a criança ainda não anda, apesar de ficar de pé com apoio, falar a palavra "mamãe", reconhecer o som do seu nome, dar tchau, bate palminhas, há 2 meses ele passou a estranhar pessoas desconhecidas, tem acordado a noite chorando e querendo permanecer com os pais, algo que não acontecia desde os 4 meses de vida, quando passou a ter um sono mais tranquilo. Ela viu no Instagram que talvez fosse o caso de contratar uma Consultora do Sono. Qual seria a sua orientação:

A) Lactente com provável diagnóstico de terror noturno, com necessidade de avaliação com Neuropediatra e Consultora de Sono.

B) Lactente com sinais precoces de Autismo, com indicação de encaminhamento ao Neuropediatra e início de Melatonina para auxiliar o sono.

C) Lactente com desenvolvimento esperado para a idade, sendo necessário acolher as angústias da mãe e orientá-la que essas alterações são normais.

D) Lactente com sinal de alerta para o desenvolvimento motor, com indicação para estímulo com fisioterapia motora e retorno em 4 semanas para reavaliação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298249)

Enunciado: Os estágios G2, G3 e G4 de Tanner para meninos são marcados, respectivamente, por:

A) Crescimento do pênis em comprimento; aumento do pênis em diâmetro e aumento do volume testicular.

B) Aumento do volume testicular; crescimento do pênis em comprimento e aumento do pênis em diâmetro.

C) Crescimento do pênis em comprimento; aumento do volume testicular e aumento do pênis em diâmetro.

D) Aumento do volume testicular; aumento do pênis em diâmetro e crescimento do pênis em comprimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298256)

Enunciado: Você é médico da Estratégia de Saúde da Família na zona rural de sua cidade. Recebe para consulta um lactente de 10 meses com antecedentes neonatais sem intercorrências e com boa evolução até o momento. Já iniciou introdução alimentar e mantém aleitamento materno. Ao aplicar o instrumento para avaliação do desenvolvimento você verifica que: não duplica sílabas, não transfere objetos de uma mão para outra, brinca de esconde achou, senta-se sem apoio, imita gestos, faz pinça, produz jargão e não anda com apoio. Qual a classificação e qual seria sua conduta nessa consulta?

A) DNPM normal

B) DNPM normal com fator de risco

C) Alerta para desenvolvimento

D) Provável atraso no desenvolvimento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298257)

Enunciado: "Entre as ações para prevenção da deficiência de ferro e anemia ferropriva está o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida e prolongado até dois anos de idade, associado ao acesso universal à alimentação adequada pela mãe durante a lactação e pelo lactente, de forma a aumentar o consumo de alimentos fontes de ferro, bem como de alimentos que aumentam a biodisponibilidade e a absorção do ferro na introdução de alimentos complementares."

Qual das opções a seguir descreve fatores de risco para anemia em crianças?

A) Gestações múltiplas com pouco intervalo entre elas, prematuridade e baixo peso ao nascer (< 2.500g), clampeamento do cordão umbilical antes de um minuto de vida.

B) Suplementação de ferro na gravidez e lactação, meninas com grandes perdas menstruais, aleitamento materno exclusivo prolongado 2 (superior a seis meses).

C) Dieta materna deficiente em ferro, alimentação complementar com alimentos ricos em ferro e de alta biodisponibilidade, malária.

D) Discrasias sanguíneas, hemorragia gastrintestinal (ex: doença inflamatória intestinal, polipose colônica, drogas anti-inflamatórias não esteroides), suplementação profilática com ferro medicamentoso, quando recomendada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286759)

Enunciado: Márcia, 23 anos, acabou de dar à luz ao seu primeiro filho, que nasceu a termo, sem intercorrências e com 3kg. Com relação à amamentação é CORRETO orientar que:

A) As mamadas devem ser em livre demanda e que devemos começar uma nova mamada pelo último seio que foi oferecido na mamada anterior.

B) Os horários das mamadas devem ser a cada 3h e que antes disso não há motivo para ser fome.

C) A duração das mamadas devem ser de 10 minutos e que ela deverá trocar de mama após esse intervalo.

D) As fórmulas infantis podem ser oferecidas durante a madrugada para deixar a mãe descansar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286760)

Enunciado: Pedro e Eduarda são pais de Mateus, um lactente que acabou de completar 6 meses. Mateus é um bebê hígido, sem intercorrências desde o nascimento, com bom desenvolvimento neuropsicomotor e está atualmente em seio materno livre demanda. Você é o médico da UBS e vai orientá-los sobre a introdução da alimentação complementar. Na Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde existem os 10 passos para alimentação saudável que orientam:

A) No início da introdução de alimentos, deve-se deixar a consistência líquida para que as crianças não engasguem.

B) Primeiro deve-se oferecer frutas 2x ao dia até que a criança se adapte e se acostume. Só então, passar para alimentos salgados.

C) As carnes devem ser oferecidas após o nono mês, pois nesse momento já existem os dentes que auxiliarão na mastigação.

D) A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286769)

Enunciado: Os pacientes com Síndrome de Down apresentam mais frequentemente:

A) Hipotireoidismo

B) Microcefalia

C) Hipertireoidismo

D) Diabetes insipidus

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286772)

Enunciado: Estaremos diante de um alerta para atraso do desenvolvimento neuropsicomotor se aos 9 meses o lactente:

A) Não anda.

B) Não fala uma palavra.

C) Não engatinha.

D) Não se senta sem apoio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252220)

Enunciado: A anemia ferropriva permanece como uma das deficiências nutricionais mais frequentes e importantes no mundo. O tratamento com ferro deve ser iniciado preferencialmente por via oral e a investigação apropriada de sua causa é obrigatória. Sobre o tratamento da anemia ferropriva, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A dose terapêutica de ferro elementar recomendada para o tratamento da anemia ferropriva é de 10 mg a 20 mg/kg/dia, não ultrapassando 100 mg/dia nos adultos.

B) O ferro é mais bem absorvido no duodeno e no jejuno proximal, onde as proteínas carreadoras do ferro expressam-se mais fortemente.

C) Os sais de ferro não devem ser administrados com as refeições, porque os farelos, fitatos (fórmulas infantis, ervilha, feijão) e taninos (vinho, chocolate, nozes, canela) da dieta se ligam ao ferro e dificultam a sua absorção.

D) O ferro é também mais bem absorvido como sal ferroso (Fe++) num ambiente levemente ácido; daí a indicação de tomá-lo com meio copo de suco de laranja.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252282)

Enunciado: O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida é considerado o alimento mais importante para o lactente. Qual das infecções maternas é formalmente contraindicação ao aleitamento?

A) Infecção pelo HTLV 1-2

B) Rubéola

C) Hepatite A

D) Infecção por citomegalovírus

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208306)

Enunciado: A sequência e a velocidade de maturação puberal variam entre os indivíduos, porém os eventos sentinelas da puberdade, em geral, seguem um padrão previsível. Assinale o CORRETO:

A) Gonadarca - pubarca - adrenarca - telarca - menarca

B) Pubarca - telarca - adrenarca - gonadara - menarca

C) Gonadarca - adrenarca - pubarca - telarca - menarca

D) Adrenarca - pubarca - gonadarca - telarca - menarca

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208354)

Enunciado: Recém-nascido de termo, sexo feminino, pesou 3.250 gramas ao nascimento. O exame físico na sala de parto evidenciou face achatada, fenda palpebral oblíqua, epicanto, pele abundante no pescoço, sulco entre o hálux e o segundo artelho, hipotonia muscular generalizada e reflexo de Moro débil. Entre os exames complementares rotineiramente indicados para o melhor acompanhamento desse paciente estão:

A) Ecocardiograma e dosagem sérica de cortisol.

B) Tomografia computadorizada de crânio e cariótipo.

C) Audiometria de tronco cerebral e dosagem sérica de TSH, T4 e T3.

D) Eletroneuromiografia e fundo de olho.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208377)

Enunciado: Suelen está de licença maternidade, porém terá que voltar ao trabalho no próximo mês. Mantém aleitamento materno exclusivo e está preocupada como poderá fazer após o fim da licença. Ela leu na internet que poderá ordenhar e guardar seu leite ordenhado cru (não pasteurizado) em um congelador (freezer), podendo oferecê-lo com segurança a seu filho em período após a coleta de até, no máximo:

A) 15 dias

B) 30 dias

C) 2 meses

D) 24 horas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176113)

Enunciado: Lactente, 7 meses de idade, em consulta de rotina na unidade básica de saúde, mãe nega queixas e demais alterações. Sua mãe informa que o paciente realizou aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e não está realizando nenhum tipo de suplementação vitamínica, porém afirma que expõe o filho ao sol, no mínimo 3 vezes por semana, só de fraldas. No momento, já iniciou a introdução alimentar e, como a genitora retornou suas atividades laborais, suspendeu o aleitamento materno e está oferecendo ao seu filho fórmula infantil de seguimento, 3 mamadeiras de 180 ml ao dia. Qual orientação você daria à mãe neste caso?

A) Introduzo vitamina D, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e oriento exposição solar, mínimo de 30 minutos por semana de fraldas, e orientação alimentar, atentado à importância no consumo de carne vermelha e vegetal verde-escuro.

B) Introduzo vitamina D e ferro na dose profilática, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e oriento exposição solar, mínimo de 30 minutos por semana de fraldas, e orientação alimentar, atentado à importância no consumo de carne vermelha e vegetal verde-escuro.

C) Realizo orientações quanto à exposição solar, mínimo de 30 minutos por semana de fraldas, e alimentar, atentado à importância no consumo de carne vermelha e vegetal verde-escuro.

D) Introduzo vitamina D, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e oriento exposição solar, mínimo de 30 minutos por semana de fraldas. Introduzo ferro na dose terapêutica, visto que houve a retirada do aleitamento materno muito precoce; a orientação ideal seria mantê-lo até 2 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176117)

Enunciado: Quanto à avaliação de puberdade no gênero masculino, assinale assertiva CORRETA:

A) A primeira manifestação da puberdade é o aumento do diâmetro do pênis.

B) Deve-se considerar retardo puberal a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 14 anos de idade.

C) O aumento dos testículos ocorre após, aproximadamente, um ano do aumento do diâmetro do pênis.

D) O início da puberdade antes dos 11 anos é considerado puberdade precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176028)

Enunciado: Lactente, 1 ano e 6 meses de idade, sexo feminino, é trazido pela tia materna em consulta ambulatorial para avaliação. Ao questionar pelos pais, tia informa que ambos são usuários de drogas e relata abandono da menor. Neste atendimento, a única queixa é que criança está muito emagrecida. O médico não dispõe de histórico pregresso, bem como da caderneta da criança. Em relação aos dados antropométricos desta paciente, peso 7 kg (escore-Z = -3), comprimento 72 cm (escore-Z = -3) e perímetro cefálico 44 cm (escore-Z = -2 e ? +2), classifica-se paciente como PESO MUITO BAIXO para idade. Assinale a conduta CORRETA neste caso:

A) Encaminhar imediatamente para nutricionista e iniciar dieta especial.

B) Orientar dieta especial e solicitar retorno em 30 dias para avaliação de ganho ponderal no período.

C) Prescrever megadose de vitamina A, se a criança não tiver tomado nos últimos 30 dias.

D) Referir urgentemente ao hospital, para início de dieta enteral via sonda nasogástrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176100)

Enunciado: O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é considerado o alimento mais importante para o lactente. Dentre as infecções maternas, é contraindicado para o aleitamento:

A) Citomegalovírus.

B) Infecção pelo HTLV-1.

C) Hepatite C.

D) Rubéola.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151869)

Enunciado: A.M.O., 11 anos foi levada por sua mãe à primeira consulta ginecológica. Ao exame físico, o médico concluiu que a paciente estava no estágio II de Tanner. Isso significa:

A) Elevação da mama e da papila com separação discreta da aréola. Pêlos velares com a área da linha média coberta.

B) Maior elevação da mama e da papila sem separação dos contornos da aréola e da mama. Pêlos pubianos qualitativamente adultos, mas a área coberta concentra-se na linha média.

C) Separação dos contornos da aréola e da mama. Pêlos pubianos adultos em quantidade e qualidade. No monte de vênus a distribuição obedece à configuração em triângulo invertido.

D) Mamas: elevação discreta da mama e da papila, com aumento do diâmetro areolar (broto mamário) pêlos pubianos terminais grossos, pigmentados, discretamente curvilíneos nos grandes lábios e no monte de vênus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151870)

Enunciado: As diretrizes da suplementação de vitamina D recomendam a ingestão diária para todos os lactentes de:

A) 400 UI\dia.

B) 800 UI\dia.

C) 1.000 UI\dia.

D) 1.200 UI\dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151959)

Enunciado: Sobre as dificuldades e manejo com aleitamento materno, marque a alternativa INCORRETA:

A) Quando existe a queixa de "pouco leite" ou 'leite fraco", o profissional deve apenas orientar a mãe "que não existe leite fraco".

B) Quando a anquiloglossia está causando problemas na amamentação, está indicada a frenotomia.

C) Um recurso que se utiliza para fazer o bebê mamar na mama "recusada", muitas vezes com sucesso, é o uso da posição de "jogador de futebol americano" (football player).

D) As mulheres submetidas à cirurgia de redução de mamas devem ser informadas de que a mamoplastia redutora pode postargar a descida do leite, assim como o estabelecimento pleno da lactação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129812)

Enunciado: Segundo as Orientações do Ministério da Saúde, 2013, em relação ao acompanhamento do adolescente, sexo MASCULINO, é INCORRETO afirmar:

A) A primeira manisfestação da puberdade no sexo masculino é o aumento do volume testicular, em média aos 10 anos e 9 meses.

B) O crescimento peniano acontece associado ao crescimento dos testículos.

C) A idade da primeira ejaculação, conhecida como semenarca ou espermarca, ocorre em média aos 12 anos e 8 meses.

D) A ginecomastia puberal regride espontaneamente em 85% dos casos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129815)

Enunciado: Segundo as Orientações do Ministério da Saúde, 2013, em relação ao acompanhamento da adolescente, sexo FEMININO, é INCORRETO afirmar;

A) O mamário é o primeiro sinal puberal na menina, é chamado de telarca e pode apresentar-se unilateralmente sem significado patológico.

B) Caso a puberdade se inicie com o aparecimento de pelos pubianos e não com o broto mamário, a puberdade é de origem periférica.

C) Nas meninas a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 15 anos de idade, considerar retardo puberal.

D) É frequente ocorrer um corrimento vaginal claro nos 6 aos 12 meses que antecedem a primeira menstruação ou menarca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129723)

Enunciado: Qual alternativa abaixo NÃO corresponde aos 10 passos para Alimentação Complementar Saudável, segundo ENPACS- Ministério da Saúde:

A) A alimentação complementar deve ser liquidificada no início para evitar risco de erro alimentar.

B) Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.

C) Ao completar 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno.

D) Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129738)

Enunciado: A anemia por deficiência de ferro é uma carência nutricional muito frequente nos países em desenvolvimento. Quanto ao uso de suplementação de ferro profilático, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012, assinale a alternativa INADEQUADA.

A) 3 mg/kg peso/dia durante um ano e, posteriormente, 1 mg/kg/dia por mais um ano para recém-nascidos pré-termo com peso entre 1.500 e 1.000 g.

B) 2 mg/kg peso/dia durante um ano. Após este período, 1 mg/kg/dia por mais um ano para recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo peso até 1.500 g a partir do 30º dia de vida.

C) Não recomendado para recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, em uso de 500 ml de fórmula infantil.

D) 3 mg de ferro elementar/kg peso/dia a partir do 6º mês (ou da introdução de outros alimentos) até o 24º mês de vida, para recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129761)

Enunciado: A carência nutricional de ferro afeta o desenvolvimento mental de 40 a 60% das crianças. Assinale a alternativa com as principais alterações bioquímicas encontradas na depleção de ferro SEM anemia:

A) Hgb, VCM, RDW normais; ferro sérico e ferritina baixos.

B) Hbg, ferro sérico e ferritina baixos; RDW e VCM normais.

C) Hgb, ferro sérico, ferritina e VCM baixos; RDW normal.

D) Hbg, VCM normais; RDW elevado; ferro sérico e ferritina baixos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129788)

Enunciado: Durante a avaliação de rotina do atendimento de uma criança de 1 ano e 6 meses, os pais informam que a criança é bem alegre e sorridente, senta sozinha e pega todos os objetos ao seu redor. Índices de peso/idade escore-Z entre +2 < -2; IMC entre +1 < -1. De acordo com a classificação do Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM), pelo método AIDPI/OMS, assinale a alternativa mais ADEQUADA para este caso.

A) Possível atraso no DNPM; parabenizar a família/mãe e aumentar o estímulo.

B) Provável atraso no DNPM; encaminhar ao neurologista/pediatra.

C) Possível atraso no DNPM; encaminhar ao neurologista/pediatra.

D) Provável atraso no DNPM; parabenizar a família/mãe e aumentar o estímulo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129797)

Enunciado: Adolescente do sexo masculino vai a consulta de rotina no Programa de Atendimento do Adolescente na Unidade de Saúde do seu Bairro. Durante o atendimento médico, descreve peso adequado para idade, IMC eutrofia, no desenvolvimento puberal aumento do volume testicular, bolsa escrotal, e comprimento do pênis e pelos em toda região pubiana um pouco encaracolados, escuros e espessos; orientações gerais, e alimentar, prevenção de agravos e promoção de estilo de vida saudável. Assinale a alternativa que corresponde ao estágio puberal de Tanner, do paciente no caso acima.

A) P2G3.

B) P2G2.

C) P3M2.

D) P3G3.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107718)

Enunciado: A mãe do menor J.K.L. foi ao pediatra pedir orientação alimentar, pois o mesmo está completando 6 meses em aleitamento materno exclusivo e segundo a vizinha ela deve parar de dar o leite materno. O médico orienta que ela deve iniciar ALIMENTOS COMPLEMENTARES, o que significa:

A) Conjunto de outros alimentos, além de manter o leite materno oferecido durante o período de aleitamento.

B) Fórmulas artificiais.

C) Conjunto de outros alimentos, substituir o leite materno por leite artificial oferecidos durante o período do primeiro ano de vida.

D) Conjunto de guloseimas, além do leite materno oferecidos durante o período de aleitamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107732)

Enunciado: Duas mães aguardando o atendimento obstétrico conversam sobre a importância da alimentação saudável para a Criança, a fim de prevenir obesidade e suas complicações. Diante do conceito programação metabólica (Programming) devemos começar o estimulo à alimentação saudável desde a:

A) Segunda infância.

B) Gestação.

C) Primeira infância.

D) Lactente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107741)

Enunciado: Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS e Ministério da Saúde devemos estimular o Aleitamento materno exclusivo até_____ e Total até:

A) 3 meses e 1 ano.

B) 8 meses e 3 anos.

C) 6 meses e 1 ano.

D) 6 meses e 2 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107823)

Enunciado: Paciente de 11 anos de idade, vem à consulta de Pediatria médica sem queixas, o Pediatra descreve o estágio de Tanner, como M3P3. Qual descrição abaixo corresponde ao Estágio de Maturação Sexual descrito pelo Pediatra:

A) Projeção da aréola e da papila, formando uma segunda saliência acima do nível da mama. Pêlos tipo adulto, ainda em pouca quantidade.

B) Volume testicular aumentado sem aumento do pênis. Pêlos longos escuros, encaracolados em toda a base do pênis.

C) Aréola e papila sem separação do contorno da mama, Pêlos mais escuros, pouco encaracolados, em toda região pubiana.

D) Broto mamário, pêlos um pouco escuros na linha central da região pubiana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107872)

Enunciado: Lactente de 11 meses chega à consulta de Puericultura, pela primeira vez, acompanhado de sua mãe que informa que a criança já senta com algum apoio, começa a querer segurar firme nos objetos e é sorridente. Avaliando o desenvolvimento neuropsicomotor, segundo a Atenção Integral das Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI -, podemos classificar esta criança como:

A) Desenvolvimento normal com fatores de risco.

B) Desenvolvimento normal, falta de estímulo.

C) Provável atraso.

D) Desenvolvimento normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107884)

Enunciado: Os pais levam o lactente de 4 meses à consulta de Puericultura referindo que o menor apresenta 5 episódios de vômitos ao dia, sem outras queixas. Atualmente está em dieta mista: aleitamento materno e fórmula láctea de partida. Quanto à presença de Doença do Refluxo Gastro Esofágico, assinale a assertiva abaixo que NÃO é esperada nesta patologia.

A) Pais relatarem sono intranquilo do lactente.

B) Lactente com irritabilidade.

C) Presença de esofagite.

D) Aos 5 meses apresentar o dobro do peso de nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107689)

Enunciado: A alimentação saudável é fundamental para o bom crescimento e desenvolvimento ao longo da vida, além de previnir doenças e evitar deficiências nutricionais. A infância representa um momento delicado para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, portanto, os cuidadores de crianças menores de dois anos devem ser orientados quanto à prevenção de riscos, a fim de evitar obesidade. Marque V ou F nas seguintes opções: ( ) Incentivar o aleitamento materno e evitar a superalimentação de bebês alimentados com mamadeira, pois o consumo excessivo de leite de vaca está associado à obesidade entre crianças menores de dois anos. O consumo deve ser limitado a 1000 ml por dia dos seis meses aos dois anos de vida. ( ) Evitar a introdução precoce de sólidos. O tempo adequado para a introdução de sólidos é entre 4 e 6 meses de idade. ( ) Dar estimulantes do apetite a crianças que não tem apetite. ( ) Orientar os cuidadores sobre importância de refeições específicas por idade, consistência de refeições, tipos de lanches, porções adequadas, leitura de rótulos de alimentos e atividades físicas diárias. Avaliando as premissas marque a alternativa correta:

A) F; V; F; V.

B) F; F; F; F.

C) V; V; F; V.

D) V; F; F; V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103796)

Enunciado: Qual das doenças hematológicas é a mais comum na infância, acometendo 30% da população global, sendo que a maioria dos indivíduos afetados vive em países em desenvolvimento?

A) Anemia ferropriva.

B) Anemia megaloblástica.

C) Anemia falciforme.

D) Leucemias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103829)

Enunciado: Quanto ao crescimento da criança, podemos afirmar que:

A) No final do segundo ano, o crescimento somático e cerebral desacelera com a correspondente redução das exigências nutricionais e do apetite, e, por este motivo, cresce, em geral, a queixa de "falta de apetite" no consultório.

B) No primeiro ano de vida, a criança cresce, em geral, 15 cm e, no segundo ano, 10 cm ao ano.

C) A criança deve triplicar o peso de nascimento aos sete meses de idade.

D) Entre dois e cinco anos, a criança normal ganha aproximadamente 5 a 8 kg e cresce em torno de 10 cm ao ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87434)

Enunciado: Maria liga para o médico e fala: "eu sou mãe não faz nem um mês, meu peito esta ferido e não sei como tratar. Meu bebê Sofia, chora e toma leite toda hora e toda vez que ela bebe leite ela morde e chupa com força e dói e o peito esta ficando cada vez mais ferido". Pergunta-se qual o provável diagnóstico e sua conduta:

A) Criança estressada/ Orientar a mãe a acalmar a Criança estressada.

B) Incoordenação oro-facial / Encaminhar para a Fonoaudióloga.

C) Depressão maternal/ Encaminhar ao psiquiatra.

D) É normal /orientar para complementar com fórmula infantil na mamadeira.

E) Pega incorreta / Procurar com Urgência um profissional em Aleitamento Materno para orientar a pega correta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87448)

Enunciado: Em relação à velocidade de crescimento média e à idade das crianças e adolescentes, é CORRETO afirmar:

A) Velocidade de crescimento de 12,5 cm/ano, no primeiro ano de vida.

B) Velocidade de crescimento de 7 cm/ano, dos 2 aos 4 anos incompletos.

C) Velocidade de crescimento de 10 cm/ano, dos 6 anos de idade até a puberdade.

D) Velocidade de crescimento de 25 cm/ano, de 1 a 2 anos incompletos.

E) A velocidade de crescimento não varia com a idade até a adolescência no estirão puberal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87440)

Enunciado: O crescimento de uma criança depende de vários fatores intrínsecos e extrínsecos.

Quanto às variações normais do crescimento, assinale a assertiva CORRETA.

A) A idade cronológica está compatível com a idade óssea no Atraso Constitucional do Crescimento.

B) Na Baixa Estatura Familiar há história familiar de retardo puberal.

C) O exame físico é normal para idade cronológica no Atraso Constitucional do Crescimento.

D) No Atraso Constitucional do Crescimento a idade óssea é compatível com a estatura.

E) Os exames laboratoriais estão normais para a idade óssea na Baixa Estatura Familiar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87458)

Enunciado: O desenvolvimento infantil é um processo que abrange vários aspectos. Assinale a alternativa abaixo onde o marco do desenvolvimento encontrado corresponde ao esperado para a idade:

A) 9 meses de vida, começa a sustentar a cabeça.

B) 18 meses de vida, corre, anda para trás, fala mais de três palavras.

C) 12 meses de vida, senta-se sem apoio, engatinha.

D) 6 meses de vida, eleva a cabeça quando em decúbito ventral, reage ao som, fixa e acompanha a face da mãe.

E) 2 meses de vida, senta com apoio, balbucia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80992)

Enunciado: Entende-se por ALIMENTOS COMPLEMENTARES:

A) Conjunto de outros alimentos, além do leite materno oferececidos durante o período de aleitamento.

B) Fórmulas artificiais.

C) Conjunto de outros alimentos, além do leite artificial oferecidos durante o período do primeiro ano de vida.

D) Conjunto de guloseimas, além do leite materno oferecidos durante o período de aleitamento.

E) Aditivos do leite humano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81922)

Enunciado: Qual o papel do pediatra não especialista no cuidado de crianças com distúrbios raros e comuns?

A) Reconhecer os sinais e sintomas, fazer os encaminhamentos, dar suporte à família, planejar cuidados a longo prazo. Utilizar testes genéticos para guiar tratamento.

B) Cuidar de problemas específicos da especialidade.

C) Desenvolver e interpretar testes, tratar de casos complexos, realizar a consulta familiar; fazer terapias baseadas na genética.

D) Fazer diagnóstico, dar as consultas e cuidados a longo prazo e terapias genéticas.

E) Auxiliar na interpretação dos resultados de testes; fazer terapias baseadas na genética.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81063)

Enunciado: Duas mães aguardando o atendimento obstétrico conversam sobre a importância da alimentação saudável para a criança, a fim de prevenir obesidade e suas complicações. Diante do conceito programação metabólica (programming) devemos começar o estímulo à alimentação saudável desde a:

A) Pós-menopausa.

B) Gestação.

C) Primeira Infância.

D) Segunda infância.

E) Lactente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81080)

Enunciado: Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS e Ministério da Saúde devemos estimular:

A) Aleitamente materno exclusivo até 3 meses e total de 1 ano

B) Aleitamente materno exclusivo até 8 meses e total 3 ano

C) Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e total de 1 ano

D) Aleitamento materno exclusivo até 9 meses e total de 1 ano

E) Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e total de 2 anos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81136)

Enunciado: MST, masculino,14 anos, apresenta palidez, anorexia, astenia e sonolência excessiva.

Está crescendo muito rápido, segundo informa mãe. Qual diagnóstico mais provável?

A) Giardíase

B) Mononucleose

C) Anemia ferropriva

D) anemia megaloblástica

E) depressão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80967)

Enunciado: A.N.T., 8 meses, foi levado por sua mãe ao posto e durante exame o pediatra observou que o perímetro cefálico estava < - 3 escore-Z e apresentava atraso de dois marcos de desenvolvimento. Qual impressão diagnóstica e conduta?

A) Adequado desenvolvimento. Acalmar a mãe.

B) Atraso no desenvolvimento. Referir para avaliação neuropsicomotora.

C) Adequado desenvolvimento. Não registrar na caderneta da criança.

D) Atraso no desenvolvimento. Brigar com a mãe pela negligência.

E) Atraso no desenvolvimento. Chamar o conselho tutelar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80981)

Enunciado: Paciente 12 anos de idade, vem a consulta de Pediatria sem queixas, ao exame físico apresenta bom estado geral, acianótico, anictério, hidratado, hipocorado, nuca livre, sem alterações à ausculta pulmonar e cardíaca, abdome normal sem visceromegalias, genitália presença de pelos finos, lisos, longos escuros na base do pênis, bolsa escrotal afinada e hipervascularizada, aumento do volume testicular sem aumento do tamanho do pênis. Em relação ao Estágio de Maturação Sexual de Tanner, responda:

A) Paciente está em Tanner G3P3

B) Paciente está em Tanner G2P3

C) Paciente está em Tanner M1P2

D) Paciente está em Tanner G2P2

E) Paciente está em Tanner G3P2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80974)

Enunciado: A deficiência de ferro é uma das carências nutricionais mais prevalentes no mundo. Quanto à suplementação profilática do ferro elementar, qual das alternativas abaixo corresponde às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria:

A) Prematuros maiores que 1500g e recém nascidos de baixo peso a partir do 30º dia de vida, recomenda-se 2mg de ferro elementar/kg/dia durante todo o primeiro ano de vida e após este período 1mg/kg/dia até 2 anos de idade.

B) Prematuros com peso menor que 1000g, a partir do 30º dia de vida, recomenda-se 1mg de ferro elementar/kg/dia durante todo o primeiro ano de vida e após este período 2mg/kg/dia até 2 anos de idade.

C) Lactentes nascidos a termo, peso adequado para idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo, recomenda-se 4mg de ferro elementar/kg/dia, a partir do 30º dia de vida e durante todo o primeiro ano de vida. Após este periodo 1mg/kg/dia até 2 anos de idade.

D) Prematuros com peso entre 1000g e 1500g, recomenda-se 1mg/kg/dia de ferro elementar até os 2 anos de idade.

E) No lactente o ferro elementar só deve ser suplementado em caso de documentado de anemia ferropriva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80959)

Enunciado: A queixa de "pouco leite" ou "leite fraco" deve sempre ser valorizada pois, se não valorizada, pode levar ao desmame precoce. Marque a opção CORRETA. 1. Melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não adequados. 2. Oferecer as 2 mamas em cada mamada. 3. Diminuir a frequência das mamadas. 4. Trocar de mama várias vezes em uma mamada se a criança estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente. 5. Não ordenhar o leite residual.

A) V, F, V, F, V.

B) V, V, F, V, V.

C) V, V, V, V, F.

D) V, F, V, F, V.

E) V, V, F, V, F.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61481)

Enunciado: Segundo as orientações para o atendimento à saúde do adolescente, Ministério da Saúde, 2011, quanto ao desenvolvimento puberal normal da menina é correto afirmar, EXCETO:

A) O broto mamário é o primeiro sinal puberal na menina.

B) Os primeiros ciclos menstruais são geralmente anovulatórios e irregulares.

C) É frequente ocorrer um corrimento vaginal claro nos 36 meses que antecedem a menarca.

D) As adolescentes podem ainda crescer em média 4 a 6 cm nos 2 ou 3 anos após a menarca.

E) Deve-se considerar retardo puberal a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 13 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61567)

Enunciado: Considerando que muitos dos profissionais de saúde pouco conhecem sobre o desenvolvimento puberal normal nos meninos, segundo as informações do ministério da saúde quanto ao desenvolvimento puberal normal do menino, é correto afirmar, EXCETO:

A) O crescimento peniano começa, em geral, um ano após o crescimento dos testículos.

B) Deve-se considerar retardo puberal a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 17 anos de idade.

C) A ginecomastia puberal em 85% dos casos regride espontaneamente até 3 anos do seu aparecimento durante a fase puberal.

D) A primeira manifestação da puberdade é o aumento do volume testicular, medido cerca de 3 cc, em média aos 10 anos e 9 meses de idade.

E) O pênis primeiro cresce em tamanho e depois em diâmetro e no final do crescimento puberal mede aproximadamente de 12 a 15 cm quando ereto podendo variar de ± 2 a 3 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61574)

Enunciado: Rapaz de 13 anos vem à consulta com queixa de ginecomastia e pênis pequeno. A ginecomastia surgiu há 6 meses. O exame físico foi normal, exceto por obesidade moderada, ginecomastia bilateral e "pênis embutido". O estadiamento puberal de Tanner é: pêlos pubianos II, genitália III. A conduta adequada neste momento é:

A) Referir à psicóloga para acompanhamento.

B) Encaminhar à genética para fazer cromatina sexual.

C) Indicar cirurgia para a correção da ginecomastia.

D) Observar a evolução da ginecomastia por mais um ano.

E) Solicitar exames laboratoriais para detectar problemas endócrinos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60860)

Enunciado: Qual das drogas abaixo são liberadas pela Organização Mundial de Saúde para aleitamento materno?

A) Manitol, quetamina, fluconazol.

B) Doxepina, prednisona, brometos.

C) Metildopa, linezolida, amiodarona.

D) Digoxina, ergotamina, sais de ouro.

E) Brometos, sais de ouro, cloranfenicol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61581)

Enunciado: Em relação à presença de anemias na infância qual afirmativa NÃO está correta?

A) As anemias podem ser decorrentes de alterações na produção; hemólise; perdas sanguíneas.

B) Correspondem a desordens de produção; desordens imunológicas; falência absoluta da eritropoiese.

C) O VCM (Volume Corpuscular Médio) está aumentado na deficiência da vitamina B12 e na deficiência de ácido fólico.

D) São consideradas desordens por destruição do eritrócito; defeitos estruturais das hemáceas (congênitos); desordens imunológicas; destruição não mediada por anticorpos.

E) A doença falciforme, as talassemias e as deficiências enzimáticas cursam com anemia devido a desordens por destruição dos eritrócitos (hemólise).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60883)

Enunciado: Qual seria a ação política efetiva para resolver o problema da anemia ferropriva em lactentes e pré-escolares em nosso país?

A) Aplicar doses preventivas de ferro nos dias nacionais de vacinação.

B) Contraindicar a alimentação com leite de vaca para todas as crianças.

C) Treinar pediatras para prevenção do ferro profilático.

D) Conscientizar as mães para o problema.

E) Garantir a fortificação exclusiva vit. "D".

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60890)

Enunciado: Adolescente de 14 anos procura AAL com queixa de ginecomastia há seis meses e pênis pequeno. Ao exame: ginecomastia, obesidade moderada, pênis embutido, sem outra anormalidade. Estadiamento de Tanner P2 G3. Qual a conduta?

A) Solicitar TAC de crânio.

B) Encaminhar para endocrinologia.

C) Pedir exame de cromatina sexual.

D) Observar a evolução da ginecomastia por mais um ano.

E) Indicar cirurgia para correção da ginecomastia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61584)

Enunciado: Lactente de quatro meses de vida está em uso de aleitamento materno exclusivo, sem uso de água, chás ou qualquer outro alimento. A mãe informa que as mamas ficam bem cheias e que amamenta seis ou mais vezes por dia. Relata que a criança larga o peito antes de completar 30 minutos de mamada, dorme por longos períodos, evacua várias vezes ao dia, molha cinco a seis fraldas por dia e vem ganhando peso adequadamente. Dentre as informações colhidas com a mãe, aquela que garante que a amamentação é bem sucedida é:

A) Lactente não mama mais que 30 min por vez.

B) Lactente apresenta evacuações abundantes.

C) Lactente apresenta diurese e ganho ponderal adequado.

D) Mãe com mamas cheias e bebê mama seis ou mais vezes ao dia.

E) Lactente larga o peito espontaneamente e dorme por longos períodos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61505)

Enunciado: Considerando as variações normais do crescimento humano é CORRETO afirmar:

A) Atraso constitucional do crescimento não tem relação com o início da puberdade.

B) A idade óssea é compatível com a estatura na baixa estatura constitucional.

C) As duas formas mais frequentes de variação do crescimento estão dissociadas do padrão familiar.

D) No atraso constitucional do crescimento, a idade óssea é compativel com a idade cronológica.

E) Na baixa estatura familiar, o alvo genético é abaixo da média da população geral e a criança está crescendo dentro do esperado para aquele alvo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61513)

Enunciado: Em relação à velocidade do crescimento esperado para idade, qual das afirmativas NÃO representa a média ao ano esperada para idade?

A) Lactentes de 0 a 12 meses incompletos, 15 cm/ano.

B) Lactente de 1 a 2 anos incompletos, 12 cm/ano.

C) Crianças de 2 a 4 anos incompletos, 7 cm/ano.

D) Crianças de 4 a 6 anos incompletos, 6 cm/ano.

E) Crianças de 6 anos até a puberdade, 5 cm/ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46652)

Enunciado: Escolar com sete anos vem ao endocrinologista, pois sua mãe está preocupada com seu crescimento, pois está menor do que seus colegas de escola. Qual dado deverá ser considerado no momento da avaliação?

A) Seguimento pela curva de crescimento.

B) Dosagem do hormônio de crescimento.

C) Dosagem dos hormônios tireoidianos.

D) Estatura dos pais.

E) Idade óssea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46634)

Enunciado: Que suplementação deve receber um filho de mãe vegetariana que não ingere produtos animais, quando este estiver em aleitamento materno?

A) Cálcio.

B) Vit A.

C) Vit C.

D) Vit D.

E) Vit B12.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46637)

Enunciado: Nutriz portadora de citomegalovirose confirmada no pré-natal. Qual a orientação a ser dada relacionada ao aleitamento materno, já que seu recém-nascido é de termo?

A) Formula láctea.

B) Diretamente ao seio.

C) Leite da próxima mãe, após pasteurização.

D) Leite da próxima mãe, após pasteurização e congelamento a 20°C.

E) Leite da própria mãe, após congelamento a 20°C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46686)

Enunciado: " Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe." (Brasil, 2009). Em relação ao aleitamento materno é INCORRETO afirmar:

A) Deve ser feito até os seis meses de vida de forma exclusiva e completamentado até 2 anos ou mais.

B) É considerado aleitamento materno complementado quando a mãe substitui o leite por outros alimentos sólidos ou semi-sólidos.

C) Está indicada a inibição da lactação nas mães HIV positivas e em casos de adoção.

D) É considerado aleitamento materno exclusivo quando a criança recebe apenas leite humano, direto da mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos.

E) O aleitamento materno ajuda a reduzir o risco de infecção no recém-nato.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46689)

Enunciado: São contraindicações absolutas de aleitamento materno EXCETO:

A) HTLV.

B) HIV.

C) Hepatite B.

D) Galactosemia.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324692)

Enunciado: Adolescente, sexo feminino, 15 anos de idade, é levada a consulta de rotina por sua mãe. Reluta para permitir o exame fisico. Ao conversar, sem a presença materna, relata que tem se cortado com gilete nos antebraços, mas seus pais não tem conhecimento do fato pois tem usado mangas compridas para cobrir os ferimentos. Refere término de namoro com um rapaz de 16 anos de idade, com quem teve iniciação sexual, de forma voluntária. Relata fazer uso de contraceptivos e deseja saber se deve continuar. Tem obtido notas medianas na escola. Define-se viciada em internet e jogos eletrônicos, passando mais de 6 horas por dia em uso de telas. Informa que tem poucos amigos. Ao exame físico: em bom estado geral, lúcida, orientada; comunica-se pouco na presença da mãe; demonstra tristeza; fala sobre namoro terminado, hipervalorizando a situação com conteúdo negativo. Demonstra sofrimento, autocrítica e baixa autoestima. Apresenta várias lesões cicatriciais em Atebraços. Sem outros achados anormais. Indique a conduta médica adequada, definida pelas normativas éticas nessa situação, com relação à mãe e à confidencialidade da consulta, no que diz respeito aos indícios de autoagressão:

A) A mãe deve ser informada no momento da consulta, sem a presença da paciente, pois há risco de vida por autoagressão.

B) Caso a paciente escolha uma pessoa adulta para interlocução essa deve ser, necessariamente, seu responsável legal.

C) Pode ser pactuado que a própria adolescente converse com a mãe, pois esta deve ser informada, já que há risco com a autoagressão.

D) A mãe não deve ser informada, pois afetaria a autonomia da paciente, sendo o sigilo um direito do paciente adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324693)

Enunciado: Adolescente, sexo feminino, 15 anos de idade, é levada a consulta de rotina por sua mãe. Reluta para permitir o exame fisico. Ao conversar, sem a presença materna, relata que tem se cortado com gilete nos antebraços, mas seus pais não tem conhecimento do fato pois tem usado mangas compridas para cobrir os ferimentos. Refere término de namoro com um rapaz de 16 anos de idade, com quem teve iniciação sexual, de forma voluntária. Relata fazer uso de contraceptivos e deseja saber se deve continuar. Tem obtido notas medianas na escola. Define-se viciada em internet e jogos eletrônicos, passando mais de 6 horas por dia em uso de telas. Informa que tem poucos amigos. Ao exame físico: em bom estado geral, lúcida, orientada; comunica-se pouco na presença da mãe; demonstra tristeza; fala sobre namoro terminado, hipervalorizando a situação com conteúdo negativo. Demonstra sofrimento, autocrítica e baixa autoestima. Apresenta várias lesões cicatriciais em Atebraços. Sem outros achados anormais. Considerando as especificidades das consultas médicas para o público adolescente, pode-se dizer que

A) A presença de atendente durante o exame físico não é recomendável.

B) A consulta deve ter momentos com e sem a presença dos pais ou responsáveis.

C) Os pais não devem participar do momento da entrevista com o/a adolescente.

D) A presença de atendente na sala, durante o exame físico, precisa ter concordância do/da adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324694)

Enunciado: Adolescente, sexo feminino, 15 anos de idade, é levada a consulta de rotina por sua mãe. Reluta para permitir o exame fisico. Ao conversar, sem a presença materna, relata que tem se cortado com gilete nos antebraços, mas seus pais não tem conhecimento do fato pois tem usado mangas compridas para cobrir os ferimentos. Refere término de namoro com um rapaz de 16 anos de idade, com quem teve iniciação sexual, de forma voluntária. Relata fazer uso de contraceptivos e deseja saber se deve continuar. Tem obtido notas medianas na escola. Define-se viciada em internet e jogos eletrônicos, passando mais de 6 horas por dia em uso de telas. Informa que tem poucos amigos. Ao exame físico: em bom estado geral, lúcida, orientada; comunica-se pouco na presença da mãe; demonstra tristeza; fala sobre namoro terminado, hipervalorizando a situação com conteúdo negativo. Demonstra sofrimento, autocrítica e baixa autoestima. Apresenta várias lesões cicatriciais em Atebraços. Sem outros achados anormais. Com relação à demanda quanto ao uso de contraceptivos, considerando as indicações éticas da Sociedade Brasileira de Pediatria.

A) está contraindicado pela imaturidade hormonal da paciente e deve ser comunicado à mãe.

B) está contraindicado pela imaturidade hormonal da paciente e não deve ser comunicado à mãe.

C) está indicado e é direito da adolescente usar sem informação parental e deve ser prescrito de forma adequada

D) é indicado e o sigilo deve ser quebrado, pois é dever dos parentes participar das decisões quanto à saúde reprodutiva da adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294487)

Enunciado: Adolescente, 16 anos de idade, é levada à UPA pela mãe, por ter sido agredida fisicamente há, aproximadamente, 3 horas. O relato é de que o padrasto a espancou ao chegar, alcoolizado, em casa. O médico observa que a menor está tensa e retraída, limitando-se a responder com a cabeça às suas perguntas, enquanto a genitora relata o quadro que encontrou em casa. Identifique a atitude mais adequada do médico ao proceder à anamnese.

A) Solicitar a presença do padrasto durante a anamnese e acareá-lo para obter a verdade.

B) Solicitar que a menor faça o relato detalhado examiná-la na presença da genitora.

C) Solicitar a presença de uma testemunha durante anamnese e o exame físico.

D) Solicitar à mãe que lhe permita uma conversa só com a menor, antes do exame físico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230163)

Enunciado: Recém-nascido, sexo masculino, é encaminhado ao Ambulatório de Referência por apresentar hipotonia e as seguintes características: O facies mostra fenda palpebral oblíqua; alargamento da base do nariz; orelhas pequenas com implantação baixa. Há sopro audível em borda esternal esquerda. Apresenta ainda prega palmar única e espaço entre os artelhos, notadamente entre o primeiro e o segundo artelho. Nasceu de parto natural, a termo, em município do interior, e teve apenas uma consulta pré-natal. Genitora nega intercorrências gestacionais. Considerando as informações e o seu conhecimento sobre epidemiologia, indique a síndrome mais provável nesse caso.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230164)

Enunciado: Recém-nascido, sexo masculino, é encaminhado ao Ambulatório de Referência por apresentar hipotonia e as seguintes características: O facies mostra fenda palpebral oblíqua; alargamento da base do nariz; orelhas pequenas com implantação baixa. Há sopro audível em borda esternal esquerda. Apresenta ainda prega palmar única e espaço entre os artelhos, notadamente entre o primeiro e o segundo artelho. Nasceu de parto natural, a termo, em município do interior, e teve apenas uma consulta pré-natal. Genitora nega intercorrências gestacionais. Considerando as informações e o seu conhecimento sobre epidemiologia, indique a informação elementar a ser buscada, que constitui o fator de risco para esta doença, embora não seja determinante absoluto para a mesma.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230165)

Enunciado: Recém-nascido, sexo masculino, é encaminhado ao Ambulatório de Referência por apresentar hipotonia e as seguintes características: O facies mostra fenda palpebral oblíqua; alargamento da base do nariz; orelhas pequenas com implantação baixa. Há sopro audível em borda esternal esquerda. Apresenta ainda prega palmar única e espaço entre os artelhos, notadamente entre o primeiro e o segundo artelho. Nasceu de parto natural, a termo, em município do interior, e teve apenas uma consulta pré-natal. Genitora nega intercorrências gestacionais. Considerando as informações e o seu conhecimento sobre epidemiologia, cite o exame diagnóstico a ser realizado, no momento, e especifique a alteração que confirma a suspeita clínica.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206061)

Enunciado: Genitora de uma menina de 8 anos de idade a leva à UBS por apresentar "carocinho no seio", observado há algumas semanas. Refere que a criança não apresenta queixa de dor e nem há alteração de coloração ou secreção local. Refere prurido em região genital e perianal, principalmente à noite. Nega corrimento. Ao exame, a menor apresenta curva de crescimento ponderoestatural dentro da normalidade; dados vitais sem alterações. À palpação, há presença de montículo na região mamária direita, equivalente ao estágio M2 de Tanner. No introito vaginal há hiperemia. Não há outros achados anormais ao exame físico. Diante desse relato, indique o diagnóstico mais provável para o achado mamário.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206064)

Enunciado: Genitora de uma menina de 8 anos de idade a leva à UBS por apresentar "carocinho no seio", observado há algumas semanas. Refere que a criança não apresenta queixa de dor e nem há alteração de coloração ou secreção local. Refere prurido em região genital e perianal, principalmente à noite. Nega corrimento. Ao exame, a menor apresenta curva de crescimento pôndero-estatural dentro da normalidade; dados vitais sem alterações. À palpação, há presença de montículo na região mamária direita, equivalente ao estágio M2 de Tanner. No introito vaginal há hiperemia. Não há outros achados anormais ao exame físico. Diante desse relato, identifique o estágio de crescimento de Tanner em que se encontra essa criança.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206073)

Enunciado: Durante visita domiciliar, o médico de Família e Comunidade avalia criança do sexo masculino com 4 anos e 4 meses de idade. O menor queixa-se de fadiga ao jogar futebol na escola e ao correr. Apresenta hiperpigmentação na região posterior do pescoço e nas zonas de flexão das articulações, de aspecto hipertrófico e aveludado. Sem outra queixa. Ao exame, apresenta 24 kg e 110 cm de altura. O médico, ao atender a criança, considerou o gráfico de Índice de Massa Corporal da Organização Mundial da Saúde, adotada pelo Ministério da Saúde, representado a seguir. Tendo em vista o relato e o gráfico adotado pelo MS, indique duas providências imprescindíveis para definir o prognóstico quanto à estatura dessa criança.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176289)

Enunciado: Puérpera, primípara, 28 anos de idade, durante a consulta no sétimo dia pós-parto, refere dificuldade para amamentar e mastalgia. Ao exame, paciente encontra-se febril, temperatura oral: 39°C. Mama direita com induração palpável e edema na união dos quadrantes superiores, com hiperemia local e dor à palpação. Em região areolar de mama direita, observa-se uma pequena fissura. Mama esquerda dolorosa à palpação, com hiperemia discreta difusa. Expressão mamilar: positiva bilateralmente (apenas leite materno). Paciente pergunta se existe alguma "pomada barata" que possa usar para evitar o aparecimento de novas fissuras. Diante desse quadro, indique o diagnóstico mais provável.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176293)

Enunciado: Puérpera, primípara, 28 anos de idade, durante a consulta no sétimo dia pós-parto, refere dificuldade para amamentar e mastalgia. Ao exame, paciente encontra-se febril, temperatura oral: 39°C. Mama direita com induração palpável e edema na união dos quadrantes superiores, com hiperemia local e dor à palpação. Em região areolar de mama direita, observa-se uma pequena fissura. Mama esquerda dolorosa à palpação, com hiperemia discreta difusa. Expressão mamilar: positiva bilateralmente (apenas leite materno). Paciente pergunta se existe alguma "pomada barata" que possa usar para evitar o aparecimento de novas fissuras. Diante desse quadro, indique o exame complementar, não laboratorial, útil no caso, e a complicação mais comum avaliada por esse exame.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176287)

Enunciado: Puérpera, primípara, 28 anos de idade, durante consulta no sétimo dia pós-parto, refere dificuldade para amamentar e mastalgia. Ao exame, paciente encontra-se febril, temperatura oral: 39°C. Mama direita com induração palpável e edema na união dos quadrantes superiores, com hiperemia local e dor à palpação. Em região areolar de mama direita, observa-se uma pequena fissura. Mama esquerda dolorosa à palpação, com hiperemia discreta difusa. Expressão mamilar: positiva bilateralmente (apenas leite materno). Paciente pergunta se existe alguma "pomada barata" que possa usar para evitar o aparecimento de novas fissuras. Diante desse quadro, indique o tratamento tópico a ser orientado, de melhor relação custo-benefício, para evitar o aparecimento de novas fissuras.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152244)

Enunciado: Bebê, sexo masculino, 13 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, pesa 12 kg e acompanha a curva de crescimento no mesmo percentil do nascimento. A genitora o leva à UBS, desejando orientação sobre o desmame. Ela trabalha fora de casa durante as tardes, é vegetariana e está tentada a introduzir mingau na dieta da criança. Considerando o desmame, indique até que idade a amamentação deve ser incentivada, mesmo tendo iniciado novos alimentos.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152253)

Enunciado: Bebê, sexo masculino, 13 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, pesa 12 kg e acompanha a curva de crescimento no mesmo percentil do nascimento. A genitora o leva à UBS, desejando orientação sobre o desmame. Ela trabalha fora de casa durante as tardes, é vegetariana e está tentada a introduzir mingau na dieta da criança. Considerando o desmame, informe se esse bebê pode iniciar o desmame, e a partir de qual idade pode se recomendar a introdução de outros alimentos, além do leite materno.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152259)

Enunciado: Bebê, sexo masculino, 13 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, pesa 12 kg e acompanha a curva de crescimento no mesmo percentil do nascimento. A genitora o leva à UBS, desejando orientação sobre o desmame. Ela trabalha fora de casa durante as tardes, é vegetariana e está tentada a introduzir mingau na dieta da criança. Considerando o desmame, indique os dois nutrientes, oligoelementos, que devem ser oferecidos como complementação na dieta dessa criança considerando que ela terá alimentação vegetariana.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152183)

Enunciado: Menina, 15 anos de idade, levada ao ambulatório de referência por não ter apresentado menarca. Ao exame dos caracteres sexuais secundários, apresenta telarca e pubarca compatíveis com os critérios de Tanner M4P4. Diante desse relato, cite a impressão diagnóstica.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152186)

Enunciado: Menina, 15 anos de idade, levada ao Ambulatório de Referência por não ter apresentado menarca. Ao exame dos caracteres sexuais secundários, apresenta telarca e pubarca compatíveis com os critérios de Tanner M4P4. Diante desse relato, cite duas principais informações da história da paciente, imprescindíveis nessa avaliação e que não estão explícitas no relato.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152188)

Enunciado: Menina, 15 anos de idade, levada ao Ambulatório de Referência por não ter apresentado menarca. Ao exame dos caracteres sexuais secundários, apresenta telarca e pubarca compatíveis com os critérios de Tanner M4P4. Diante desse relato, indique a orientação adequada para essa adolescente.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129992)

Enunciado: Menina, 8 anos de idade, é levada ao ambulatório geral de pediatria por ter sido notado broto mamário unilateral à esquerda. Ao exame, não apresenta pelos pubianos ou axilares. Frente a esse quadro indique a suspeita diagnóstica.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129995)

Enunciado: Menina, 8 anos de idade, é levada ao ambulatório geral de pediatria por ter sido notado broto mamário unilateral à esquerda. Ao exame, não apresenta pelos pubianos ou axilares. Frente a esse quadro descreva a sequência esperada, no caso do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, até a menarca.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129932)

Enunciado: Menina, 8 anos de idade, é levada ao ambulatório geral de pediatria por ter sido notado broto mamário unilateral à esquerda. Ao exame, não apresenta pelos pubianos ou axilares. Frente a esse quadro, indique a conduta para o caso.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106520)

Enunciado: Mãe, 16 anos de idade, comparece a UBS para atendimento, levando o filho de 1 mês de vida, nascido de parto natural, com 39 semanas, pesando 3,125Kg e medindo 51cm. Informa que o bebê apresenta, continuamente, fezes moles, várias vezes ao dia, sempre após a mamada. Está em aleitamento materno exclusivo. Relata que mora com a mãe e as irmãs, que não estuda nem trabalha, que o bebê chora muito à noite, que o leite, às vezes, está avermelhado e que dói muito ao amamentar. Na avaliação de hoje, o bebê pesou 3,675Kg e mediu 53cm. Está ativo, em bom estado geral, eupneico, afebril e corado. Enchimento capilar de 3 segundos. Exame segmentar mostra timpanismo abdominal, sem outra alteração. Identifique a principal suspeita diagnóstica, considerando as dejeções.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106521)

Enunciado: Mãe, 16 anos de idade, comparece a UBS para atendimento, levando o filho de 1 mês de vida, nascido de parto natural, com 39 semanas, pesando 3,125Kg e medindo 51cm. Informa que o bebê apresenta, continuamente, fezes moles, várias vezes ao dia, sempre após a mamada. Está em aleitamento materno exclusivo. Relata que mora com a mãe e as irmãs, que não estuda nem trabalha, que o bebê chora muito à noite, que o leite, às vezes, está avermelhado e que doi muito ao amamentar. Na avaliação de hoje, o bebê pesou 3,675Kg e mediu 53cm. Está ativo, em bom estado geral, eupneico, afebril e corado. Enchimento capilar de 3 segundos. Exame segmentar mostra timpanismo abdominal, sem outra alteração. Indique a causa mais provável para a coloração alterada do leite materno.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106524)

Enunciado: Mãe, 16 anos de idade, comparece a UBS para atendimento, levando o filho de 1 mês de vida, nascido de parto natural, com 39 semanas, pesando 3,125Kg e medindo 51cm. Informa que o bebê apresenta, continuamente, fezes moles, várias vezes ao dia, sempre após a mamada. Está em aleitamento materno exclusivo. Relata que mora com a mãe e as irmãs, que não estuda nem trabalha, que o bebê chora muito à noite, que o leite, às vezes, está avermelhado e que doi muito ao amamentar. Na avaliação de hoje, o bebê pesou 3,675Kg e mediu 53cm. Está ativo, em bom estado geral, eupneico, afebril e corado. Enchimento capilar de 3 segundos. Exame segmentar mostra timpanismo abdominal, sem outra alteração. Indique a conduta quanto à alimentação da criança.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106535)

Enunciado: Adolescente, 12 anos de idade, procura ansiosa a médica da UBS, pedindo segredo e relatando que está preocupada porque teve relação sexual com o namorado no dia anterior e está apreensiva porque não usaram preservativo masculino. Mais tarde, a mãe da menor comparece à Unidade, buscando conhecer a razão da consulta da filha, que saíra de casa bastante ansiosa. Diante dessa situação, considerando os Princípios Éticos da profissão médica, indique três situações em que um médico pode prescrever anticoncepcional de emergência para adolescentes.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106539)

Enunciado: Adolescente, 12 anos de idade, procura ansiosa a médica da UBS, pedindo segredo e relatando que está preocupada porque teve relação sexual com o namorado no dia anterior e está apreensiva porque não usaram preservativo masculino. Mais tarde, a mãe da menor comparece à Unidade, buscando conhecer a razão da consulta da filha, que saíra de casa bastante ansiosa. Diante dessa situação, considerando os Princípios Éticos da profissão médica, indique a conduta ética e legalmente correta no que diz respeito ao pedido da mãe.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84957)

Enunciado: Kelly Cristina, 18 meses de idade, parda, moradora da zona rural com seguimento irregular na UBS, é trazida para a consulta por sua mãe, Dona Cleusa. Esta acha que a criança está com vermes, pois apresenta manchas brancas no rosto e "o irmão botou larvas pela boca na semana passada". Kelly não faz e nem fez uso de suplementos alimentares, parou de mamar no peito aos 2 meses de idade, quando foi introduzido o leite de vaca. Iniciou alimentos sólidos aos 11 meses e atualmente come carne vermelha duas vezes por semana e ovo uma vez; frutas ocasionalmente e não come verduras. Sua dieta é composta predominantemente por leite em pó, mingau de farinha de trigo, bolacha, arroz e feijão, produtos que o marido ganha na cesta básica de alimentos. A mãe não sabe referir horários das refeições de Kelly, que adora balas e doces caseiros como bolos e bananada que Cleusa, faz quase todos os dia. A gestação foi sem intercorrências, mas Cleusa fez apenas 3 consultas de pré-natal. No cartão da maternidade está registrado: recém-nascido de termo (38 semanas), peso adequado para a idade gestacional (2830 g), Apgar 9/9/9. Recebeu alta no 3º dia de vida, sem nenhuma intercorrência. Kelly engantinha desde os 9 meses e atualmente está andando, fala algumas palavras e manuseia objetos: adora brincar com o celular e bater panelas. Cleusa conta que ele está terrível; coloca tudo na boca e adora brincar com o cachorro da família. Ao exame físico criança ativa, descorada +/4, hidratada, acianótica, afebril, eupneica. Rosto com machas hipocrômicas, não descamativas, bordas definidas e pele seca generalizada. Restante do exame é normal. Peso 8005 g; Comprimento: 75,5 cm. A Caderneta da Criança revela vacinação completa e apresenta as seguintes marcações antropométricas. Os gráficos não estavam preenchidos: (VER IMAGEM). Cite os 08 diagnósticos para esta criança na presente consulta. Considere a diferentes dimensões de abordagem do caso.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84959)

Enunciado: Kelly Cristina, 18 meses de idade, parda, moradora da zona rural com seguimento irregular na UBS, é trazida para a consulta por sua mãe, Dona Cleusa. Esta acha que a criança está com vermes, pois apresenta manchas brancas no rosto e "o irmão botou larvas pela boca na semana passada". Kelly não faz e nem fez uso de suplementos alimentares, parou de mamar no peito aos 2 meses de idade, quando foi introduzido o leite de vaca. Iniciou alimentos sólidos aos 11 meses e atualmente come carne vermelha duas vezes por semana e ovo uma vez; frutas ocasionalmente e não come verduras. Sua dieta é composta predominantemente por leite em pó, mingau de farinha de trigo, bolacha, arroz e feijão, produtos que o marido ganha na cesta básica de alimentos. A mãe não sabe referir horários das refeições de Kelly, que adora balas e doces caseiros como bolos e bananada que Cleusa, faz quase todos os dia. A gestação foi sem intercorrências, mas Cleusa fez apenas 3 consultas de pré-natal. No cartão da maternidade está registrado: recém-nascido de termo (38 semanas), peso adequado para a idade gestacional (2830 g), Apgar 9/9/9. Recebeu alta no 3º dia de vida, sem nenhuma intercorrência. Kelly engantinha desde os 9 meses e atualmente está andando, fala algumas palavras e manuseia objetos: adora brincar com o celular e bater panelas. Cleusa conta que ele está terrível; coloca tudo na boca e adora brincar com o cachorro da família. Ao exame físico criança ativa, descorada +/4, hidratada, acianótica, afebril, eupneica. Rosto com machas hipocrômicas, não descamativas, bordas definidas e pele seca generalizada. Restante do exame é normal. Peso 8005 g; Comprimento: 75,5 cm. A Caderneta da Criança revela vacinação completa e apresenta as seguintes marcações antropométricas. Os gráficos não estavam preenchidos: (VER IMAGEM). Cite qual será a conduta para cada um dos 8 diagnósticos dados para esta criança na presente consulta.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62879)

Enunciado: A respeito das comorbidades em crianças com HIV/AIDS, é correto afirmar, EXCETO:

A) A pneumonia por Pneumocystis jirovecii (antes denominada Pneumocystis carinii) é a mais frequente infecção oportunista em crianças infectadas pelo HIV. A faixa de maior risco é a do primeiro ano de vida, quando o diagnóstico definitivo da infecção pelo HIV, na maioria das crianças expostas, ainda não pode ser feito.

B) Recomenda-se que todas as crianças expostas recebam profilaxia com Sulfametoxazol-Trimetoprima (SMX-TMP) a partir de seis semanas de vida até completar um ano, exceto se a hipótese de infecção pelo HIV puder ser afastada durante o período. Essa profilaxia é mantida depois do primeiro ano de vida somente para as crianças infectadas quando a indicação será orientada pela contagem de células TCD4+.

C) Em crianças, a transmissão vertical do HTLV-1 ocorre exclusivamente pelo leite materno de mulheres infectadas, não ocorrendo naquelas que recebem leite artificial.

D) A infecção precoce do HTLV-1 na criança é uma importante preocupação para a saúde pública, pois está associada com subsequente risco de desenvolver linfoma não Hodgkin, leucemia/linfoma de células T do adulto, dermatite e paraparesia espástica tropical.

E) A transmissão perinatal do vírus da hepatite B acontece predominantemente como resultado da exposição da criança a sangue e secreções genitais da mãe durante o parto e trabalho de parto (cerca de 90 a 95% dos casos). A transmissão intraútero é incomum (5 a 10%) e pelo colostro é rara.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62890)

Enunciado: Há evidências de uma significativa redução na prevalência da desnutrição na população brasileira nas últimas décadas. Preocupante, porém, é que o comportamento da anemia ferropriva não parece acompanhar a melhoria do estado nutricional. A respeito da deficiência de ferro, é falso afirmar:

A) A deficiência de ferro durante a gravidez, principalmente no último trimestre, aumenta o número de nascimentos prematuros e de baixo peso, entretanto a criança, ao nascer, apresenta altas taxas de hemoglobina e tem em seu organismo 75 mg de ferro/kg de peso.

B) Nos primeiros dois meses de vida, ocorre uma queda acentuada na concentração de hemoglobina, sendo os valores mais baixos entre seis e oito semanas de vida e, paralelamente, um aumento na mobilização das reservas de ferro.

C) A queda da hemoglobina nos primeiros dois meses de vida é conhecida como anemia fisiológica do lactente, podendo ser evitada com medida preventiva de ferro oral, mesmo nos nascidos a termo.

D) As reservas de ferro, do nascimento aos seis meses de vida, quando a criança recebe com exclusividade o leite materno, atendem às necessidades fisiológicas da criança, não necessitando de complementação.

E) A biodisponibilidade do aleitamento exclusivo materno pode diminuir até 80%, quando outros alimentos passam a ser ingeridos pelo lactente, sendo a introdução precoce de alimentos complementares considerada como fator de risco para o aparecimento da anemia ferropriva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343349)

Enunciado: Com quais idades considera-se puberdade precoce em meninos e meninas?

A) Entre 8 e 13 anos nas meninas e entre 9 e 14 anos nos meninos.

B) Entre 6 e 8 anos nas meninas e entre 7 e 9 anos nos meninos.

C) Antes dos 8 anos em meninas e 9 anos em meninos.

D) Antes de 9 anos em meninas e 11 anos em meninos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343350)

Enunciado: Em relação à puberdade em meninos e meninas assinale a alternativa correta.

A) Em meninas, o início da puberdade é marcado pela menarca.

B) A puberdade inicia-se entre 8 e 13 anos nas meninas e entre 9 e 14 anos nos meninos.

C) Em meninos, o início da puberdade é marcado por pelos corporais generalizados.

D) A puberdade precoce sempre vai ser central.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343351)

Enunciado: Um adolescente de 13 anos de idade, sexo masculino, relata o aumento da mama direita há 6 meses. Ao exame físico apresenta tecido mamário subareolar palpável bilateralmente, testículos com 10ml e pelos axilares, com pelos pubianos e genitália no estágio 3 de Tanner. Qual a conduta mais indicada nesse momento?

A) Acompanhamento clínico.

B) Cirurgia para remoção das mamas.

C) Tratamento com inibidores de aromatase.

D) Tratamento com antagonistas de estrogênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343353)

Enunciado: Um menino apresenta aumento de pênis em seu comprimento, testículos com 10cc, pelos escuros, grossos e crespos no saco escrotal e na linha média acima de pênis, bem como pelos finos acima do lábio superior, acne, mudança da voz e início do estirão puberal. Qual é a classificação de Tanner para seu estágio puberal?

A) G3P3

B) G2P2

C) G4P3

D) G3P2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281863)

Enunciado: Assinale a alternativa correta em relação à media de sono diária recomendada para uma criança de 6 a 13 anos.

A) 7 a 8 horas.

B) 8 a 9 horas.

C) 9 a 10 horas.

D) 9 a 13 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283858)

Enunciado: As práticas alimentares no primeiro ano de vida exercem um importante papel na formação dos hábitos da criança. Sobre as práticas alimentares recomendadas no primeiro ano de vida, é correto afirmar que

A) o suco de fruta pode e deve ser introduzido aos seis meses de vida em substituição às frutas.

B) se preconiza amamentação exclusiva até o quarto mês de vida, e, a partir dessa idade, a criança deve receber alimentos complementares.

C) proteínas como carne moída e peixe devem ser inseridos ao se introduzir os alimentos complementares no sexto mês de vida. A demora na introdução desses alimentos pode aumentar o risco de anemia ferropriva.

D) se recomenda que, a partir de três meses, a criança receba duas papas de frutas nos lanches e uma papa principal, que poderá ser oferecida no almoço, com alimentos bem cozidos para que possam ser amassados.

E) papas industrializadas, além de não serem adequadas do ponto de vista nutricional, não são seguras em termos de segurança alimentar, portanto não devem ser oferecidas às crianças menores de dois anos, mesmo em situações em que não seja possível oferecer papa caseira.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250010)

Enunciado: Puérpera na segunda semana, apresentando mamas flácidas e com pouco leite. O diagnóstico e tratamento adequado são:

A) Hipogalactia / Ocitocina spray nasal.

B) Ectasia ductal / Sulpirida.

C) Hipogalactia / Sulpirida.

D) Ectasia ductal / Ocitocina spray nasal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218136)

Enunciado: Considerando o crescimento e desenvolvimento da criança, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. ( ) A prematuridade, a hipóxia neonatal, as infecções congênitas e a herança genética são consideradas fatores de risco para problemas futuros de desenvolvimento. ( ) Caso os testículos sejam impalpáveis na bolsa escrotal na consulta do primeiro mês de vida, deve-se solicitar ecografia (ultrassom) e encaminhar o lactente para avaliação cirúrgica. ( ) Diagnosticada hérnia inguinal, é indicada observação até o sexto mês de vida, quando a criança deve ser encaminhada para cirurgia caso não haja resolução espontânea do quadro. ( ) O primeiro sinal de puberdade esperado em meninas é o surgimento de broto mamário (telarca), uni ou bilateral, e é considerada puberdade precoce nas meninas o desenvolvimento das características sexuais secundárias antes da idade de oito anos. A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

A) V, V, F, F.

B) V, F, F, V.

C) V, F, V, F.

D) F, V, V, F.

E) F, F, V, V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218148)

Enunciado: Segundo as Diretrizes Nacionais da Saúde sobre a necessidade e a suplementação de ferro para as crianças até dois anos de vida, é CORRETO afirmar que:

A) O período de maior risco para a carência de ferro é o primeiro semestre de vida.

B) Crianças em aleitamento materno não necessitam da suplementação de ferro no 1° ano de vida.

C) Crianças em uso de fórmulas com leite de vaca devem receber suplementação de ferro após seis meses de vida.

D) A Equipe de Saúde da Família deve realizar exame laboratorial de rotina para anemia e, em função dos resultados, prescrever a suplementação de ferro.

E) Crianças com mais de 6 meses de vida até os 24 meses devem receber a suplementação de ferro independente da realização de exames complementares, sendo período mais crítico o de 6 a 12 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218184)

Enunciado: Maria Aparecida, negra, 36 anos, bem-humorada, compareceu à Unidade Básica de Saúde onde tem como equipe: a agente de saúde Filomena, a técnica de enfermagem Carla, o enfermeiro Mário e a médica Daiane. Maria Aparecida tem uma história de realização de Citopatológico (CP) de colo de útero com uma certa regularidade. Seu último exame foi há 3 anos, quando era casada com Paulo, uma relação que durou 7 anos. O resultado fora normal. Na mesma ocasião, em uma campanha de educação em saúde promovida pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde do Estado e do Município, Maria fez a mamografia também com resultados normais. Maria Aparecida teve menarca aos 13 anos, sexarca aos 16 anos. Teve uma filha, Lelê, e um filho, Carlinhos, com Paulo. Duas gestações com dois partos vaginais. Maria Aparecida menstrua regularmente. Sem casos conhecidos de câncer de mama na família. Divorciou-se de Paulo há 2 anos: me libertei doutora - sempre dizia à Daiane. Recentemente, conheceu um homem de 30 anos, Valdomiro, com quem está namorando e já está pensando em se "juntar". Maria é hipertensa em uso de enalapril 10 mg de 12/12 horas. Na consulta, observou-se PA 140/90 mmHg, pesa 78 kg, mede 1,60 m de altura (IMC 30,5). Maria Aparecida e Valdomiro chegam felizes da vida com a pequena Mara no colo. Depois de ser paparicada por todos profissionais da Unidade de Saúde, "Má", como os pais a chamam, chega finalmente para a consulta com Daiane. Embora tenham participado do pré-natal, Maria Aparecida e Valdomiro trazem muitas dúvidas sobre a amamentação, e Ele, ansioso e com caderninho e caneta nas mãos, já quer montar um calendário com a descrição da alimentação complementar após o período de amamentação exclusiva. Daiane orienta calma, e esclarece todas as questões, aguardando o tempo de Valdomiro anotar ante o sorriso de Maria, que mistura satisfação com divertimento ante a postura sistemática de seu companheiro. Sobre a amamentação e a alimentação da criança nos primeiros anos de vida, segundo as orientações do Ministério da Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. ( ) As frutas devem ser oferecidas amassadas logo no início da alimentação complementar e, também, sobre a forma de suco. A papa salgada deve ser iniciada no 7° mês com legumes e verduras, inicialmente, colocadas no liquidificador e peneiradas, e, somente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

depois, amassadas, e com ovos e carnes introduzidos na mesma, preferencialmente, após o 8° mês de vida. ( ) Uma queixa muito comum nas primeiras consultas de puericultura é a de "pouco leite" ou "leite fraco". Para estas situações, as diretrizes nacionais sugerem à mãe uma dieta hiperproteica; aumentar a frequência das mamadas, se possível de três em três horas no máximo, estimulando a criança; ordenar o leite residual; e usar protetores intermediários de mamilos para o caso de dor ou fissuras. ( ) Recomenda-se a amamentação exclusiva até os seis meses. Dentre as diversas razões, do ponto de vista do desenvolvimento da criança é importante observar que, até o 4° mês, a criança ainda não atingiu o desenvolvimento fisiológico necessário para que possa receber alimentos sólidos (reflexo de protrusão ainda regredindo, não senta sem apoio e não tem controle neuromuscular da cabeça e pescoço para mostrar desinteresse ou saciedade). Dos 4 aos 6 meses, a aceitação e tolerância da alimentação pastosa melhoram sensivelmente devido às funções gastrointestinal e renal, mas é por volta dos 6 meses que a tolerância gastrointestinal e a capacidade de absorção de nutrientes atingem um nível satisfatório. As crianças com aleitamento exclusivo desenvolvem mais cedo o autocontrole da ingestão aprendendo a distinguir as sensações de fome, durante o jejum, e de saciedade, após a alimentação. A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

A) V, F, F.

B) V, V, F.

C) F, F, V.

D) F, V, F.

E) F, V, V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139745)

Enunciado: Em relação à anticoncepção na adolescência, aponte a alternativa CORRETA:

A) Condom e geleia espermaticida aplicados conjuntamente.

B) Em geral não se indicam pílulas anticoncepcionais na fase de ciclos menstruais irregulares pós-menarca.

C) Em emergência pós-coital, a ?pílula do dia seguinte? deve ser utilizada dentro das primeiras 72 horas após o intercurso.

D) Todas as alternativas estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134787)

Enunciado: A puberdade precoce deve sempre ser bloqueada com a GnRH quando apresentar as seguintes características. Analise-as. I. Ser dependente de gonadotrofinas.; II. Ter evolução rápida.; III. Ter previsão de estatura final prejudicada.; IV. Apresentar comprometimento evidente do ponto de vista psicológico e/ou social. Estão CORRETAS, as características contidas em:

A) I e II, apenas.

B) I e IV, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134790)

Enunciado: Em meninos, qual é a idade limite inferior da normalidade para o início da puberdade e a característica sexual presente MAIS frequente?

A) 8 anos e aumento do pênis.

B) 8 anos e pelos pubianos.

C) 9 anos e pelos pubianos.

D) 9 anos e aumento testicular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139783)

Enunciado: Mulher, com sorologia para HIV positiva, dá à luz a recém-nascido (RN) com 3.000 g. A sorologia para HIV do RN, pelo ELISA, revela-se positiva. A amamentação dessa criança deve ser:

A) incentivada, uma vez que o risco de aquisição da doença pelo aleitamento materno é baixo.

B) incentivada, uma vez que a sorologia do RN é positiva.

C) substituída por aleitamento artificial, uma vez que o risco de aquisição da doença através do aleitamento é elevado.

D) incentivada apenas se a mãe e o RN submeterem-se a tratamento com drogas antirretrovirais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134673)

Enunciado: Dentre os principais hormônios ligados na síntese primária da caseína do leite e na ejeção do leite estão, respectivamente:

A) TRH e prolactina.

B) Prolactina e ocitocina.

C) Prolactina e dopamina.

D) Ocitocina e TRH.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111934)

Enunciado: Adolescente de 15 anos é trazida ao consultório pela mãe porque apresentou menarca há 2 meses e depois não menstruou mais. Paciente nega relações sexuais. Trouxe beta BCG negativo realizado por conta própria. Exame físico sem alterações, hímem íntegro. Que tipo de orientação será necessária?

A) Solicitar RNM de abdômen.

B) Tranquilizar a mãe e orientar que os primeiros ciclos menstruais podem ser irregulares.

C) Solicitar dosagens hormonais: FSH / LH / Testosterona.

D) Iniciar anticoncepcional oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111851)

Enunciado: Mãe procura você no consultório para acompanhamento do bebê. Lactente encontra-se com 6 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, sem alterações ao exame físico. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado, crescimento, peso no percentil 20% e estatura no percentil 25%. O que você orientaria para a mãe?

A) Manter aleitamento materno exclusivo e retornar em 1 mês para pesar.

B) Manter aleitamento materno e iniciar papas.

C) Suspender aleitamento materno, iniciar fórmula infantil e retornar em 1 mês para pesar.

D) Manter aleitamento materno e associar leite integral com frutas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350821)

Enunciado: Uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. A partir dos 6 meses o aleitamento materno deve ser mantido e novos alimentos devem ser oferecidos, com diversidade de cores sabores, texturas e cheiros. Quanto à introdução da alimentação complementar, é correto afirmar:

A) As frutas devem ser ofertadas na forma de suco, raspadas ou amassadas.

B) Não é recomendável a oferta de leite materno no horário dos lanches e das papas principais.

C) Para facilitar a aceitação, a papa principal pode ser processada, em mixer ou liquidificador, e ofertada na colher.

D) A papa principal deve ser composta por 1 alimento dos grupos: cereais ou tubérculos; feijões; 1 ou mais legumes e verduras, 1 alimento do grupo das carnes e ovos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350817)

Enunciado: Uma determinada mãe está preocupada com o desenvolvimento do filho para aceitar mensagens de que NÃO pode fazer determinadas coisas. Nesses momentos ele costuma reagir com crises intensas de birra. Essa mesma mãe compreende que o comportamento de birra significa a tentativa da criança de alcançar um objetivo ao tempo em que revela que ela já compreende as regras e reluta em aceitá-las. Em que idade (em anos) a criança já é capaz de utilizar adequadamente a linguagem para compreender explicações e ir reduzindo suas reações birrentas?

A) Dois anos.

B) Três anos.

C) Quatro anos.

D) Cinco anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350816)

Enunciado: Na Puericultura, o mais frequente é o médico atender crianças com desenvolvimento da linguagem e da comunicação em contextos que possibilitam desenvolvimento típico. Qual a alternativa correta em relação aos marcos de desenvolvimento das crianças nessa área da linguagem?

A) 12-18 meses: ainda com dificuldade para compreender e reconhecer boa parte das situações e objetos que fazem parte de seu cotidiano; compreende ordens ou solicitações simples (<me dê a bola=).

B) 2-3 anos: estabelece relações entre objetos e palavras, amplia o tempo de atenção e concentração, não segue as instruções com 2 ou 3 etapas, nem fala o primeiro nome, idade e sexo.

C) Entre 4-5 anos, adquiriu um vocabulário alargado, manifestando um grande interesse pela linguagem. Apresenta grande curiosidade e faz muitas perguntas, gostando de contar e inventar histórias.

D) Entre 5-6 anos aprecia conversar durante as refeições, realizando muitos questionamentos (fase dos porquês?); ainda não utiliza corretamente o plural, os pronomes e tempos verbais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321319)

Enunciado: Recém-nascido termo, 6 dias de vida, peso de 3100g, em aleitamento materno exclusivo, vem ao posto de saúde para coleta do teste do pezinho. Sendo observado icterícia Zona 2 de Kramer. Relato de 7 diureses e 6 evacuações nas últimas 24 horas, com fezes amarelas, explosivas e pastosas. Nasceu de parto vaginal, hospitalar, com 3300g, recebendo alta com 30 horas de vida. A mãe fez pré-natal sem intercorrências e tem tipo sanguíneo A+. Qual a melhor conduta para o bebê?

A) Internação hospitalar para investigar e tratar a icterícia.

B) Manter o aleitamento materno exclusivo e retorno com 1 mês de vida.

C) Internação hospitalar para investigação e tratamento do quadro diarreico.

D) Solicitar exames ABO, Rh, bilirrubinas e hemograma completo de urgência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321321)

Enunciado: Puérpera, de parto vaginal, que fez pré-natal sem intercorrências, está no alojamento conjunto com seu filho que nasceu a termo com peso de 3200 g. Ela considera ter leite insuficiente para o filho que chora com frequência. O bebê tem 24 horas de vida, com exame físico normal, evacuou e apresentou duas diureses. Dentre as abaixo citadas, qual a melhor conduta a ser orientada?

A) Aleitamento materno em livre demanda com aumento da frequência das mamadas.

B) Associar o uso de outro leite após a mamada até que ocorra a apojadura e o bebê aumente a diurese.

C) Aleitamento materno com orientação para aumentar o tempo de mamada e pelo menos de 3/3 horas.

D) Aleitamento materno e solicitação de exames complementares (hemograma, proteína C reativa, eletrólitos e glicemia).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321330)

Enunciado: Uma criança de 3 meses de vida comparece à consulta de rotina e a mãe queixa-se que o bebê está "abusando o peito" pois tem mamado pouco tempo (menos de 10 minutos/vez), cerca de 8 vezes ao dia. Apresenta diurese de 6-8 vezes ao dia, evacua 1 vez a cada dois dias e ganhou 25 gramas de peso/dia e 2 cm no perímetro cefálico no último mês. Apresenta sorriso social e sustenta a cabeça. Qual a melhor orientação para esta criança?

A) Agendar consulta de puericultura de rotina já que criança está eutrófica.

B) Orientar ordenha de leite e ofertar ao final da mamada, com reavaliação em uma semana.

C) Introduzir fórmula infantil como suplementação após a mamada, reavaliando a criança em 15 dias.

D) Introduzir novos alimentos (sucos e papinha de frutas), manter o aleitamento materno e solicitar exames (hemograma e urina tipo 1).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321331)

Enunciado: A mãe de uma criança de 2 anos de idade vem à consulta preocupada com os hábitos alimentares de seu filho. Qual das alternativas é a correta em relação às orientações para hábitos alimentares saudáveis de crianças dessa faixa de idade?

A) Pode-se oferecer refrigerantes, sucos de caixinha e alguns tipos de balas e doces.

B) Pode-se oferecer líquidos durante a refeição, como água, sucos; evitar refrigerantes.

C) Fazer a adequação do prato de acordo com a necessidade da criança, evitando deixar a criança repetir.

D) A sobremesa pode ser oferecida como parte da refeição, não como recompensa; deve-se dar preferência às frutas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321333)

Enunciado: Uma criança é trazida ao posto de saúde, com sua mãe relatando que ele aumentou bastante a salivação (baba muito), está um pouco irritado e com coceira na gengiva. Ao exame, observa-se erupção de dois dentes incisivos inferiores. Na maioria das vezes, qual a idade desta criança?

A) 3 meses.

B) 4 meses.

C) 6 meses.

D) 8 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321335)

Enunciado: Uma senhora vem à consulta de rotina e deseja saber do médico algumas das características de desenvolvimento normais para seu filho de 15 meses de idade. Assinale a alternativa correta.

A) É precária a demonstração de afeto por pessoas conhecidas.

B) Nessa idade, a criança já regulou os acessos de raiva quando frustrada.

C) A criança ainda não compartilha, com os outros objetos, que considera interessante.

D) A criança já é capaz de explorar sozinha o ambiente em que está na presença vigilante dos pais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321362)

Enunciado: CVA, 25 anos, G1P1A0, primeiro pós-operatório de cesárea, realizada com 39 semanas de gestação, por conta de herpes genital em atividade. Encontra-se em uso de aciclovir, e questiona seu obstetra sobre riscos na amamentação. Sobre amamentação, marque a alternativa correta.

A) São condições relacionadas à mãe que contraindicam a amamentação: ser portadora do vírus HIV, ter tuberculose ativa não tratada e estar na vigência de infecção perinatal por varicela.

B) A prática do desmame bilateral intermitente em mamas túrgidas, a hidratação materna vigorosa e o uso de corticoterapia tópica são medidas que previnem a ocorrência de mastite puerperal.

C) No caso da paciente acima, a amamentação não deve ser descontinuada devido ao uso de aciclovir. Outras drogas que não contraindicam a amamentação são: sertralina, losartana e metotrexato.

D) Podemos considerar a diminuição do risco de estenose hipertrófica do piloro, um melhor aporte nutricional e o fortalecimento da imunidade, como sendo benefícios da amamentação para o recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292831)

Enunciado: Um casal de adolescentes traz seu filho de 6 meses à Unidade de Saúde, preocupado se seu desenvolvimento está se dando de forma normal. O lactente nasceu a termo e está em aleitamento materno exclusivo. Ao examiná-lo, o médico orienta o casal em relação à aquisição de novas habilidades pelo bebê. Aos 6 meses, o que se espera que um lactente com desenvolvimento normal seja capaz de fazer?

A) Arrastar-se e dar ""tchau"".

B) Engatinhar e bater palmas.

C) Ficar em pé com apoio e falar ao menos 1 palavra com sentido.

D) Segurar um objeto com as duas mãos, levá-lo à boca e rolar no leito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292835)

Enunciado: O Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos trouxe uma atualização de Dez Passos para Doze Passos para uma Alimentação Saudável, ampliando a importância do conhecimento na manutenção da alimentação saudável no lactente. Qual recomendação é dada pelo Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos acerca da oferta da alimentação infantil?

A) Não deve ser oferecido açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade.

B) Podem ser oferecidos à criança menor de 2 anos alimentos preparados em casa com pequenas quantidades de açúcar.

C) Produtos ultraprocessados que não contenham açúcar em suas preparações, podem ser oferecidos a partir de 1 ano de idade.

D) Para uma alimentação variada, oferecer à criança, além de água própria para o consumo, sucos e outras bebidas açucaradas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292841)

Enunciado: Na etapa inicial da anamnese do adolescente, com a presença dos pais ou responsáveis, devem ser abordados o motivo da consulta e informações sobre história pregressa e imunizações. A seguir, é importante pedir licença aos pais para conversar a sós com o jovem. Alguns instrumentos possibilitam a triagem de situações de risco nessa faixa etária. Quais as situações que devem ser rotineiramente pesquisadas atualmente, possíveis de avaliação através desses instrumentos padronizados de triagem?

A) Uso de substâncias psicoativas, orientação sexual e delinquência.

B) Uso e abuso de meios eletrônicos, ações violentas e mau desempenho escolar.

C) Envolvimento em ações violentas, preferências sexuais e mau desempenho escolar.

D) Uso de substâncias psicoativas, uso e abuso de meios eletrônicos e internet e depressão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292845)

Enunciado: Na Atenção Básica de Saúde você atende uma puérpera amamentando seu filho de 45 dias de vida. Ela informa suas dúvidas acerca do bem estar do filho por causa do ritmo de mamadas, do sono e do ganho de peso dele. Qual a alternativa correta em relação a tais aspectos?

A) Se a mãe estiver acima do peso é recomendável iniciar dieta para emagrecimento e aumentar a ingesta de líquidos.

B) Se o bebê dorme bem, está ganhando peso (curva de crescimento revela percentil 15, a quantidade de leite deve estar sendo suficiente para ele.

C) Essa puérpera deveria ter uma alimentação saudável, tomar líquidos em quantidade suficiente para saciar a sede e incluir alimentos hipercalóricos.

D) Se após a mamada, a mãe percebe que o bebê está satisfeito, mas ela ainda tem muito leite, deveria continuar oferecendo a mama até sentir que elas esvaziaram.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259733)

Enunciado: Os pais de um bebê recém-nascido vão ao seu primeiro atendimento ambulatorial de puericultura. Um momento de estabelecimento de vínculo entre o pediatra e os pais. Assinale a alternativa verdadeira onde encontramos requisitos básicos para que a consulta se estabeleça com acolhimento e empatia.

A) É importante chamar os pais de ""mãezinha"" e ""paizinho"" para personalizar o atendimento e aproximá-los do médico pediatra.

B) Deve-se buscar conhecer, com gentileza, as condições financeiras, o ambiente físico, social e familiar no qual o bebê se desenvolverá.

C) Fatores ecológicos de moradia e conferência da vacinação são atributos da consulta de enfermagem antes do atendimento médico.

D) Não é necessário saber o grau de relacionamento dos pais ou se moram juntos para evitar a invasão da privacidade dos mesmos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259734)

Enunciado: Mãe leva filho de 6 meses para consulta de puericultura em unidade básica de saúde. Criança em aleitamento materno exclusivo com bom ganho ponderoestatural e genitora deseja solucionar algumas dúvidas em relação à alimentação do seu filho. Baseado no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos (Ministério da Saúde, 2019), o pediatra orientou CORRETAMENTE:

A) Introduza ovos, peixe e outros alimentos potencialmente alergênicos a partir do 9º mês de vida.

B) Priorize o uso de mel de abelha em relação a açúcar para adoçar sucos e outras preparações do bebê.

C) Interrompa o aleitamento materno assim que o bebê começar a ter 4 refeições (lanche da manhã, lanche da tarde, almoço e jantar).

D) Ofereça inicialmente alimentos com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumente a consistência até chegar à alimentação da família.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259748)

Enunciado: Um adolescente de 14 anos é trazido à consulta e seus pais queixam-se de que ele mudou completamente o modo de relacionar-se em casa. Não aceita mais os padrões vigentes na família, não mantém mais suas coisas arrumadas e passa muitas horas ouvindo música com o som excessivamente alto. Na escola, o padrão de comportamento de Pedro é normal, não havendo qualquer queixa dos professores. É um aluno bastante responsável com suas obrigações escolares. Ao orientar a família, qual a explicação que o médico deve fornecer à família sobre o comportamento do filho?

A) Está apresentando a Síndrome da Personalidade Dupla.

B) Está vivenciando um evidente conflito e deve ser encaminhado à psicoterapia.

C) Está apresentando características normais, assumindo identidades circunstanciais.

D) Está vivenciando um intenso conflito e a melhor abordagem é a farmacológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259762)

Enunciado: Lactente, de 4 meses, comparece à Unidade de Saúde acompanhado de sua mãe de 18 anos. É atendido pela primeira vez pelo médico de família após isolamento social necessário à família durante a pandemia pelo COVID19. Segundo a mãe, o aleitamento materno ocorreu até 45 dias de vida, tendo sido substituído por fórmula infantil de partida, por queixa de "leite fraco". Quando questionada sobre a possibilidade de retornar o aleitamento materno, a mãe informa que não está mais produzindo leite. A família é composta pela mãe, o lactente de 4 meses e outro filho de 2 anos. A renda familiar atual é de 600 reais. Em relação às recomendações alimentares para o bebê, considerando recomendações científicas e o contexto social, econômico e cultural, assinale a melhor conduta.

A) Manter a fórmula de partida utilizando maior diluição.

B) Substituir a fórmula de partida por leite de vaca in natura.

C) Manter a fórmula de partida e introduzir papa salgada e papa de frutas.

D) Substituir a fórmula de partida para a fórmula de seguimento, visto esta ter menor custo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234045)

Enunciado: Lactente, 2 meses, é levado ao posto de saúde para consulta de puericultura. Bebê nasceu de parto normal, a termo, sem intercorrências, peso de nascimento: 3,1 kg. Está em aleitamento materno exclusivo. Apresenta crescimento e desenvolvimento normais para a idade. Ao exame físico: bom estado geral, pálido (+/4+), hidratado, anictérico, ativo, afebril. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdome flácido, sem visceromegalias. Mãe queixa-se que a criança é pálida. Trouxe um hemograma do lactente que fez por conta própria devido à suspeita de anemia: Hb = 9,6 g/dl; Ht = 30%; VCM = 84 fL; CHCM = 32 g/dl; leucograma: 6.300; plaquetas: 350.000. Com base nesse quadro clínico e nos resultados do hemograma apresentados, a melhor conduta a ser tomada é:

A) Seguir acompanhamento de puericultura.

B) Solicitar exames para investigação de hemólise.

C) Solicitar sangue oculto nas fezes e dosagem de ferritina.

D) Iniciar suplementação de ferro oral em dose terapêutica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234059)

Enunciado: Paciente, 6 anos, sexo feminino, é atendida no ambulatório de Endocrinologia com queixa de dor e aumento das mamas bilateralmente. Ao exame: bom estado geral, eupneica, normocorada. Peso: 21 kg (Z = +0,24). Estatura = 1,20 m (Z = +1). Estágio puberal de Tanner: M3P2. Presença de odor axilar, sem pelos axilares ou acne. Foram solicitados exames com os respectivos resultados: idade óssea = 8 anos; LH com valores puberais; ultrassonografia pélvica com volume de útero e ovários acima do esperado para a idade. Diante do caso apresentado, qual a conduta mais indicada?

A) Prescrever análogo de GnRH.

B) Prescrever inibidor da aromatase.

C) Solicitar dosagem de andrógenos e exame de imagem da suprarrenal.

D) Manter acompanhamento de crescimento e desenvolvimento puberal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234079)

Enunciado: Lactente de 8 meses é trazido para acompanhamento de rotina em UBS. Está em uso de mingau com fórmula infantil e amido de milho duas vezes ao dia, associado ao aleitamento ao seio em livre demanda. Está sem queixas e a criança encontra-se entre o percentil 50 e o percentil 25 do peso e da altura para a idade, marcos do desenvolvimento normais para a idade. Além de retirar a fórmula infantil e a mucilagem, qual orientação dietética deve ser fornecida?

A) Substituição do aleitamento materno, gradualmente, por alimentos pastosos, cinco vezes ao dia.

B) Retirar, gradualmente, o aleitamento materno e acrescentar alimentos sólidos, cinco vezes ao dia.

C) Manutenção do aleitamento materno e introdução de sucos de frutas e sopas ralas, três vezes ao dia.

D) Manutenção do aleitamento materno e acréscimo de alimentos sólidos, gradualmente, três vezes ao dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199694)

Enunciado: Dona Marta traz o seu filho de 45 dias de vida à unidade básica de saúde por notar muito choro nos últimos dois dias. Questiona se está produzindo pouco leite e solicita a prescrição de fórmula láctea. Na anamnese e exame físico, o profissional não identifica obstáculos à amamentação, considera boa a técnica de aleitamento e constata bom ganho de peso. Qual a conduta adequada para esta situação?

A) Prescrição de fórmula láctea adaptada ao 1° semestre.

B) Prescrição de domperidona para a mãe para aumentar a produção de leite.

C) Estímulo ao aleitamento materno exclusivo em horários de 3 em 3 horas, inclusive à noite.

D) Estímulo ao aleitamento materno exclusivo e explicação sobre os períodos de aceleração do crescimento de lactente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199648)

Enunciado: Na Puericultura, o médico solicita aos pais de uma criança de 9 meses de idade que listem as aquisições no desenvolvimento ocorridas desde a última consulta. Quais aquisições são próprias para essa criança?

A) Primeiras palavras; primeiros passos; é ativa e curiosa; rabisca; retira uma vestimenta.

B) Bate palmas, acena; combina sílabas; fica em pé; pinça completa (polpa a polpa); segura o copo ou a mamadeira.

C) Observa sua própria mão; segue com o olhar até 180°; grita; senta com apoio, sustenta a cabeça; agarra um brinquedo colocado em sua mão.

D) Transmite objetos de uma mão para a outra; pinça polegar-dedo; balbucia; senta sem apoio; estranhamento (prefere pessoas de seu convívio); brinca de esconde-achou.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199665)

Enunciado: Lactente de 10 meses de idade é levado para consulta de rotina. Na avaliação oral é observada mancha branca opaca nos dentes, bem junto à gengiva, compatível com o estágio inicial de cárie da primeira infância. Restante do exame físico sem outras alterações. Quais os cuidados são recomendados na prevenção do aparecimento dessas lesões?

A) Suplementação oral de flúor pela mãe durante a gestação.

B) Uso de dentifrício fluoretado a partir da irrupção do primeiro dente.

C) Ingestão diária de suplementos de flúor durante o estágio de formação dos dentes.

D) Escovação dentária sem flúor até completar 12 meses, pelo risco de fluorose dentária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172983)

Enunciado: Aos 3 meses de vida, uma criança em aleitamento materno exclusivo comparece ao posto de saúde para consulta de rotina. Tem história confirmada por exame laboratorial que a mãe teve infecção por Zika no último mês de gestação e ela está apreensiva com o crescimento da cabeça da criança. Ao nascer, a menina pesou 2.780 g e perímetro cefálico de 33 cm. Os dados atuais são: peso de 4.800 g e perímetro cefálico de 40 cm. Qual a melhor conduta quanto ao crescimento da menina?

A) Referenciar imediatamente por atraso no crescimento do perímetro cefálico.

B) Reavaliar em 15 dias, pois ambos peso e perímetro cefálico estão baixos.

C) Reagendar em 1 semana por apresentar baixo ganho ponderal.

D) Considerar crescimento somático normal e tranquilizar a mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173028)

Enunciado: O médico de família atende uma paciente de 23 anos que comparece a unidade de saúde no quinto dia após parto vaginal para revisão puerperal. O recém-nascido encontra-se em aleitamento materno exclusivo. A paciente queixa-se de dificuldade para a amamentação, pois o bebê dorme a maior parte do tempo. Refere mamas dolorosas. Ao exame, o médico observou mamas edemaciadas, com pele brilhante e avermelhada bilateralmente. Não apresentou febre e mal-estar. Qual a conduta correta nesse caso?

A) Prescrever antibiótico sistêmico.

B) Fazer compressas mornas e evitar sutiã.

C) Amamentar frequentemente e analgesia.

D) Suspender a amamentação por 24 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150860)

Enunciado: Ao orientar uma primípara, no alojamento conjunto, cujo recém-nascido é de termo, peso de 3 kg e com boas condições de nascimento, observa-se que a pega está adequada. Desse modo, o que pode ser afirmado?

A) O queixo e o nariz tocam a mama.

B) O lábio inferior está virado para fora.

C) Abocanha bem o mamilo, com aréola livre.

D) Aréola mais visível abaixo da boca do bebê que acima.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150873)

Enunciado: Ao retornar ao posto de saúde, um recém-nascido de termo, com 15 dias de vida, que nasceu em boas condições, pré-natal sem intercorrências, pesando 2400 g, encontra-se com 2300 g, em aleitamento materno exclusivo. A mãe informa que o bebê está irritado, procura muitas vezes o peito, porém tem pegas rápidas de cerca de poucos minutos em cada mama. Ao exame, encontra-se alerta, hidratado, corado, anictérico, ativo, com choro forte e sem outros achados. Qual a melhor conduta para este recém-nascido, com relação ao estado nutricional?

A) Como está dentro do esperado, manter o aleitamento materno conforme vem sendo feito.

B) Orientar que o bebê esvazie bem uma mama, evitando a troca para outra antes de 20-30 minutos.

C) Após a mamada, associar suplemento com fórmula infantil oferecida com colher ou no copinho.

D) Ordenhar o leite materno e oferecer por via oral para evitar a mamada direto no peito, em virtude do esforço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150889)

Enunciado: Criança de 15 meses, nascida a termo e saudável, está em consulta com enfermeira na Unidade Básica de Saúde. A profissional solicita ao médico da equipe que a ajude em relação às aquisições do desenvolvimento da criança. Que aquisições do desenvolvimento são esperadas, como média, para essa idade?

A) Rolar e engatinhar.

B) Correr e subir escadas.

C) Retirar uma peça de roupa e construir frases.

D) Falar as primeiras palavras e andar sem apoio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150793)

Enunciado: Criança de 3 anos está em consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) por apresentar tosse. Ao ser examinada, constata-se péssimo estado de saúde oral, situação frequente nos atendimentos de crianças da área. Os profissionais de saúde da UBS enfatizam para sua mãe a necessidade de tratamento dentário e medidas de prevenção. Qual a medida de prevenção em saúde bucal mais eficaz como estratégia de caráter coletivo?

A) Fluoretação das águas de abastecimento.

B) Utilização de pastas com flúor e fio dental.

C) Realização de oficinas de promoção de saúde bucal nas UBS.

D) Técnicas de escovação específicas para cada tipo de arcada e disposição dentária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126979)

Enunciado: No centro de saúde, a mãe de uma criança de 7 meses de idade solicita orientação para alimentação complementar de sua filha. Quais as orientações mais adequadas?

A) Dar os alimentos semissólidos e sólidos. Colocar as porções de cada alimento no prato, misturando-os. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia.

B) Os alimentos devem ser bem cozidos, passados pela peneira e batidos no liquidificador. Desde cedo a criança deve acostumar-se a comer alimentos variados.

C) Sopas e comidas ralas/moles fornecem energia suficiente para a criança; pode-se oferecê-las de

mamadeira; deve-se ter cuidado com contaminação e transmissão de doenças.

D) Deve-se dar comida espessa desde o início e oferecida de colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126989)

Enunciado: Conversando acerca do desenvolvimento do filho de 5 meses, a mãe questiona ao médico se o filho está se desenvolvendo normalmente. Das aquisições abaixo, em quais o médico poderá se basear para emitir um parecer de que essa criança está se desenvolvendo bem?

A) O bebê sabe quando se dirigem a ele.

B) A criança aponta para as coisas que ele quer.

C) O bebê fala, pelo menos, uma palavra com sentido.

D) A criança dá adeus, bate palmas; gosta de imitar os pais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126982)

Enunciado: Joana leva sua filha de 4 meses à consulta de puericultura na unidade de saúde. A criança apresenta crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor adequados para a idade. Está em aleitamento materno exclusivo. Joana está preocupada, pois trabalha em um empresa privada e deverá voltar ao trabalho na próxima semana. Não sabe como deve proceder em relação à alimentação da filha. Qual a orientação mais adequada para oferecer à mãe?

A) Orientar para iniciar o desmame parcial, utilizando a reconstituição do leite em pó a 15%, ou seja, 1 colher de sopa cheia (15 g) em cada 100 ml de água.

B) Manter o aleitamento materno antes e após o trabalho, e introduzir fórmula infantil adequada para a idade nos horários que a mãe estiver ausente.

C) Iniciar, de modo complementar, a introdução de novos alimentos, começando por papas de frutas

e papas salgadas.

D) Realizar ordenha do leite materno que pode ser conservado no congelador por 15 dias, e oferecer

após esquentar em banho-maria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102100)

Enunciado: Ao concluir o exame de uma criança de quatro meses de idade, o médico comunica à mãe da criança que esta apresenta atraso em seu desenvolvimento motor. Qual dos sinais abaixo representa essa condição de hipotonia?

A) Em suspensão ventral, a criança mantém a cabeça abaixo do tronco.

B) Em decúbito dorsal, segurada pelos braços, a criança ergue a cabeça.

C) Em decúbito ventral, a criança levanta a cabeça e parte do tronco.

D) Em pé, a criança mantém os pés cruzados em extensão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102107)

Enunciado: Lactente de 10 meses vem à consulta de puericultura e sua mãe solicita orientação quanto à alimentação, já que o bebê recebe apenas mingau de leite integral de vaca com maisena e açúcar em mamadeira, desde o 3° mês. Em alguns intervalos consome ?danoninho? e biscoitos. Não recebe complexos vitamínicos, nem ferro. Está com crescimento e desenvolvimento adequados para a idade. Quais as consequências da dieta desse bebê?

A) Hipervitaminose A e D.

B) Anemia ferropriva e sobrecarga renal.

C) Doença celíaca e dermatite herpetiforme.

D) Deficiência de vitaminas do complexo B e cálcio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102175)

Enunciado: Menina vem à Unidade Básica de Saúde, para acompanhamento do crescimento, portando radiografia do punho esquerdo mostrando atraso de 2 anos da idade óssea em relação à idade cronológica. Hemograma e sumário de urina normais. Exibe as seguintes medições: Aos sete anos: 110 cm, aos 8 anos ? 117 cm, aos 9 anos ? 122 cm e aos 10 anos ? 128 cm. Não apresenta telarca ou pubarca e tem peso adequado para a idade. (VER IMAGEM). Após plotar as medidas no gráfico de crescimento, qual a conduta adequada para esse caso?

A) Solicitar curva de hormônio de crescimento.

B) Iniciar tratamento com solução de zinco e arginina.

C) Solicitar dosagens hormonais ? FSH, LH, TSH.

D) Monitorar crescimento, reforçar condições adequadas de nutrição, sono e atividade física.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81323)

Enunciado: Uma criança de 2 anos é levada ao posto de saúde por sua mãe, que estava preocupada, pois seu filho não falava. Relata que os seus filhos mais velhos falaram com 1 ano. Durante a consulta, o médico percebeu que a criança vestiu a camiseta após o exame, pulou com os dois pés, conseguiu empilhar seis cubos sem que eles caíssem e falou: ?Mamãe... embora agora?. Nega intercorrências na gestação, sem intercorrências prévias. Situação vacinal em dia. Diante dessa situação, qual a conduta mais adequada para esse paciente e sua família?

A) Referir para avaliação neuropsicomotora.

B) Informar a mãe sobre os sinais de alerta e agendar consulta para 60 dias.

C) Orientar a mãe sobre a estimulação da criança e encaminhar para avaliação com o neuropediatra.

D) Orientar a mãe para que continue estimulando a criança, e agendar retorno conforme rotina do serviço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65746)

Enunciado: Uma criança de dois anos de idade, com dieta predominantemente láctea, é atendida no centro de saúde. O médico decide utilizar compostos à base de ferro. Que orientações o médico deve fornecer à família?

A) Os estoques são recompostos nos primeiros 15 dias do tratamento.

B) O ferro é mais bem absorvido quando administrado após a refeição de sal.

C) Podem-se oferecer chás, leite, cereais e fibras, pois não interferem na absorção de ferro.

D) Devem-se oferecer frutas cítricas e carboidratos, pois facilitam a absorção do ferro não heme.

E) Em casos de crianças que aceitam mal a medicação, a alternativa é a transfusão de glóbulos vermelhos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65725)

Enunciado: Após entrevista clínica com adolescente de 15 anos de idade, o médico identifica atitudes e comportamentos preocupantes que precisam ser adequadamente manejados. Assinale a alternativa que contém um desses comportamentos.

A) O adolescente declara estar apaixonado definitivamente.

B) O adolescente revela consumo de bebidas alcoólicas por duas vezes.

C) O adolescente faz afirmativas que denotam certo radicalismo religioso.

D) O adolescente responde laconicamente, ao ser indagado sobre suas transformações físicas.

E) O adolescente declara-se desesperado em função de uma grave discussão com a namorada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65740)

Enunciado: A avaliação de uma família é de que o filho de cinco meses de idade não está se desenvolvendo bem. Qual a alternativa que contém sinais de alarme para o desenvolvimento da criança?

A) Senta sem apoio.

B) Apresenta sorriso alto.

C) Rola na cama com facilidade.

D) Não vira a cabeça para localizar sons.

E) Acompanha com o olhar objetos a curta distância.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65719)

Enunciado: Uma criança de seis meses e 15 dias de idade, saudável desde as condições de nascimento até o presente, chega ao ambulatório com a seguinte alimentação: fórmula modificada (horários: 8, 12, 15, 18, 21 horas); frutas (10 horas). Qual a recomendação mais adequada, quanto a sua nutrição?

A) Manter a mesma alimentação até o 7º mês de vida.

B) Acrescentar uma papa de frutas no horário da tarde.

C) Introduzir clara de ovo cozida, peixe, fígado, doces caseiros.

D) Introduzir papa salgada com adição de gorduras de origem animal.

E) Introduzir refeição com carne ou ovo, legumes, verduras, cereais e leguminosas com óleo/azeite no horário do almoço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65698)

Enunciado: Médico de família e comunidade e agente comunitário de saúde visitam em domicílio puérpera de 20 anos de idade e seu Recém-Nascido (RN) com 5 dias de vida. O RN nasceu de parto vaginal, com 38 semanas, pesando 2.800 gramas. O pré-natal foi realizado na Unidade de Saúde da Família e sem intercorrências. Durante o parto, foi necessário o uso de cefalosporina de 1ª geração. Em relação à amamentação do RN acima, qual recomendação deve ser dada?

A) O uso de antibiótico durante o parto contraindica a amamentação.

B) A mamada deve durar em média de 30 a 45 minutos em cada seio.

C) Nos casos de ingurgitamento mamário, as mamas podem ser esvaziadas e o leite, descartado.

D) Em caso de mastite puerperal instalada, a amamentação deve ser suspensa pelo risco de contaminar a criança.

E) A preensão incorreta do mamilo pela criança leva a fissuras na mama, principal responsável pela suspensão da amamentação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65697)

Enunciado: Adolescente do sexo feminino, 12 anos, é levada pela mãe à Unidade Básica de Saúde com queixa de baixa estatura e atraso na menarca. Ela estuda no 7º ano do ensino médio e é considerada boa aluna. Ao examiná-la, o médico constatou peso de 36 kg e 1,32 m de altura. A classificação quanto aos estágios de Tanner foi M2, P2. A idade óssea (radiografia do punho esquerdo) foi relativa a 13 anos. As dosagens de FSH e LH encontravam-se aumentadas, sendo a relação FSH/LH > 1 (exame colhido com paciente em alerta). Em relação ao crescimento e desenvolvimento puberal da adolescente, qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Baixa estatura; índice de massa corporal adequado; atraso constitucional da puberdade.

B) Baixa estatura; índice de massa corporal adequado; puberdade tardia; pulsos inadequados de secreção do LH.

C) Estatura e índice de massa corporal adequados; telarca, pubarca e menarca compatíveis para idade cronológica e idade óssea.

D) Estatura e índice de massa corporal inadequados; adrenarca precoce e ativação dos neurônios secretores de GnRH atrasada em relação à idade óssea.

E) Estatura e índice de massa corporal adequados; telarca e pubarca adequados à idade cronológica e idade óssea; relação FSH/LH alterada para a idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141618)

Enunciado: Para realizar a orientação alimentar de uma criança, assinale a assertiva que contem duas orientações corretas para prevenção de obesidade infantil.

A) Respeitar o horário das alimentações e incremento das atividades físicas.

B) Incremento da atividade física e aumento da ingesta de líquidos para deglutir alimentos mal mastigados.

C) Mastigar muito bem os alimentos e utilização líquidos para deglutir alimentos mal mastigados.

D) Liberdade de horários de alimentação e comer durante atividades que desviem a atenção do alimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141606)

Enunciado: Durante o atendimento de uma criança de quatro meses, a mãe relata que tem dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho. Para afirmar que desenvolvimento apresenta sinais de alerta, ao examinar esse lactente, você encontrou ao exame físico:

A) Olhar vago e pouco interessado e mãos persistentemente fechadas.

B) Controle esfincteriano deficiente.

C) Não senta sem apoio.

D) Não fala sílabas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45393)

Enunciado: Identifique, dentre as abaixo, a opção correta referente ao crescimento de uma criança normal:

A) O recém-nascido a termo e saudável perde aproximadamente 18% do peso corporal nos primeiros dias de vida.

B) Dos 2 aos 8 anos de idade, o ganho corporal médio é de, aproximadamente, 1 kg por ano.

C) O perímetro cefálico aumenta 10 cm no primeiro semestre de vida e é um dos índices de menor variação para os diferentes grupos etários.

D) No primeiro ano de vida, a criança cresce em média 25 cm/ano e o pré-escolar cresce, em média, 4,5 cm por ano.

E) Ao nascimento, a relação segmento superior / segmento inferior (SS/SI) é em torno de 1,0, aumentando para 1,5 até a idade de 8 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45389)

Enunciado: Lactente com 40 dias de vida, amamentado exclusivamente ao seio. Nasceu de parto normal a termo, peso 3.350 g e teve icterícia fisiológica. Atualmente, pesa 5.300 g e apresenta aproximadamente seis evacuações semilíquidas e amareladas ao dia. Qual a conduta mais adequada diante do quadro?

A) Manter aleitamento materno exclusivo.

B) Substituir a dieta por leite de soja ou leite de cabra.

C) Associar chás e soro da OMS à vontade.

D) Suspender leite materno e iniciar a dieta isenta de lactose.

E) Fazer pausa alimentar por 24 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45379)

Enunciado: Em relação às anemias na infância, é correto afirmar:

A) O diagnóstico laboratorial da anemia ferropriva inclui ferro sérico e ferritina sérica baixos, capacidade total de ligação do ferro baixa e saturação de transferrina alta.

B) A deficiência de B12 e as talassemias são exemplos clássicos de anemias macrocíticas.

C) Nas crianças com anemias hemolíticas esferocíticas estão contraindicados o uso de sulfas e quinolonas.

D) Baixo peso ao nascimento, desmame precoce e baixa disponibilidade de ferro na dieta predispõem as anemias ferroprivas.

E) Lactentes com deficiência de ferro quando apresentam alterações de desenvolvimento e comportamento, geralmente são reversíveis após o tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365639)

Enunciado: Uma criança de 1 ano de idade foi levada para consulta de rotina. Na história clínica, a mãe referiu desmame completo aos 3 meses de vida, passando a ofertar leite de vaca integral. Negou uso de ferro oral até o momento. Foram solicitados exames complementares para avaliar possível deficiência de ferro. Acerca do referido caso clínico, poucos dias depois, os pais retornaram com os resultados dos exames, os quais revelaram todos os parâmetros dentro da normalidade, não havendo sinais de deficiência de ferro ou anemia. Assinale a alternativa que corresponde à conduta a ser adotada nesse caso.

A) Orientar os pais acerca de alimentação saudável, não prescrever ferro nesse momento e repetir os exames em um ano.

B) Orientar os pais com relação a alimentação saudável, não prescrever ferro nesse momento e trocar o leite de vaca integral por fórmula infantil.

C) Orientar os familiares a respeito de alimentação saudável e iniciar ferro profilático.

D) Orientar os pais quanto a alimentação saudável, prescrever dose terapêutica de ferro (3-6 mg/kg/dia) em razão de fatores de risco e manter seguimento de rotina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349726)

Enunciado: Um recém-nascido de 27 dias de vida, que recebe aleitamento exclusivo ao seio materno, é levado para consulta de puericultura. O peso e comprimento estão adequados para esse tempo de vida, comparado ao nascimento. Há relato de seis evacuações por dia, das quais duas ou três são semilíquidas e amareladas. Ao exame, o paciente está hidratado com bom estado geral. Qual é a conduta mais adequada diante do quadro?

A) Manter o aleitamento materno exclusivo.

B) Substituir o leite materno por dieta isenta de lactose.

C) Iniciar leite de soja.

D) Sugerir pausa alimentar por 24 horas.

E) Recomendar leite de vaca a 50% com água.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365577)

Enunciado: No dia primeiro de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. Sabe-se que essa prática oferece inúmeros benefícios para o crescimento e o desenvolvimento da criança, além de fortalecer o vínculo mãe-bebê. Entretanto, existem algumas contraindicações a essa prática. Assinale a alternativa que corresponde a uma condição materna considerada contraindicação absoluta à amamentação.

A) Hanseníase não tratada

B) Uso de antidepressivos

C) Tuberculose pulmonar ativa sem tratamento

D) Infecção pelo HTLV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337545)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. Existem alterações sindrômicas que possuem associação com baixa estatura, como as síndromes de Marfan e Soto.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337546)

Enunciado: Um menino, com 8 anos de idade, vem ao ambulatório levado pela mãe com queixa de baixa estatura. Ele diz que é o mais baixo dos seus amigos, e a mãe acha que ele está crescendo pouco. A estatura do paciente é de 120cm, estando no escore Z -1 na curva da estatura. Em relação ao caso clínico descrito e aos conhecimentos médicos relacionados, julgue o item a seguir. A aferição da altura, em criança maior de 2 anos, deve ser realizada com a criança em pé, em balança plataforma com antropômetro, ou em antropômetro de parede.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337595)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. A escolaridade dos pais é fator de risco para desenvolvimento e crescimento infantil inadequado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337596)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. Pelo relato de Rafaela, Miguel apresenta atraso no desenvolvimento, pois, nessa idade, já é esperado que a criança sente sem apoio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337598)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. A velocidade de crescimento esperada para uma criança gira em torno de 15 cm no 1º semestre de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337600)

Enunciado: Miguel é uma criança de 3 meses, que foi levada por sua mãe, Rafaela, para consulta de puericultura. Miguel nasceu com peso de 3450g, perímetro cefálico de 34cm e 48cm de comprimento; seu exame físico, hoje, apresenta as seguintes medidas: peso de 6830g, perímetro cefálico de 41cm e comprimento de 61cm. Quando questionada, Rafaela traz algumas preocupações: refere que está preocupada com o peso de Miguel, pois acha que produz pouco leite; está preocupada também com o desenvolvimento do bebê e se ele já não deveria estar sentando. Ao conferir o cartão de vacinas de Miguel, o médico da UBS verifica as seguintes vacinas no cartão: BCG, DTP, Hib, VIP e pneumo conjugada. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. Considerando a velocidade padrão de ganho ponderal nos 3 primeiros meses, Miguel está com o ganho de peso inadequado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305307)

Enunciado: Uma adolescente de 16 anos pede para que sua mãe dê licença, durante a consulta, para que ela tire algumas dúvidas com seu pediatra. Após a mãe se retirar, a paciente conta que iniciou a vida sexual com seu namorado e que gostaria de usar anticoncepcional oral (ACO), mas sem que sua mãe saiba. Nesse caso, qual das seguintes opções é a conduta mais adequada do médico quanto à prescrição de anticoncepcional oral?

A) O sigilo médico, nessa situação, pode ser quebrado, uma vez que a paciente está sob risco de engravidar ou de contrair infecção sexualmente transmissível.

B) O pediatra pode prescrever o ACO, mas somente com o consentimento da mãe.

C) O pediatra pode prescrever o ACO, mas, após a consulta, deve comunicar sua conduta à mãe, em segredo.

D) O pediatra pode prescrever o ACO, respeitando a vontade da paciente em manter o assunto em sigilo.

E) O pediatra deve conversar sobre opções contraceptivas, mas não deve prescrever ACO, por se tratar de adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298885)

Enunciado: Uma paciente de 1 ano e 6 meses de idade foi encaminhada ao pronto atendimento pediátrico por apresentar febre, há três dias, entre 38ºC e 39,5ºC, sem outras queixas. A criança foi levada pela avó materna, que se mostrou bastante preocupada, pois, além da febre, notou que a criança apresenta manchas arrocheadas nos membros superiores e inferiores. A criança reside com a mãe, um irmão de 5 anos de idade e o padrasto. Ao exame físico, ela mostra-se abatida e prostrada, mas está corada e hidratada. Constataram-se FC = 120 bpm, FR = 40 irpm, SatO2 = 98% em AA, oroscopia sem petéquias, sem placas, sem lesões, otoscopia com membrana timpânica translúcida, sem abaulamento, sem secreção, ausculta cardíaca BNF, RR, 2t, sem sopro e ausculta pulmonar MVUD, sem ruídos adventícios. Também foram observados abdome RHA+, depressível, dor à palpação em baixo ventre, Blumberg e Murph negativos, sem sinais de meningismo, membros inferiores com equimoses < 5 cm e membros superiores com equimoses > 5 cm em braço esquerdo. Inicialmente foram solicitados exame qualitativo de urina com urocultura (via sondagem vesical; ainda sem resultado da urocultura) e radiografia de membro superior esquerdo. O exame qualitativo de urina pode ser verificado a seguir. Realizou-se, ainda, radiografia que evidenciou calo ósseo em rádio e ulna esquerda, conforme a imagem a seguir. Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Aos 18 meses de idade, a criança está apta a se comunicar formando frases curtas de duas palavras ou três palavras.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298896)

Enunciado: Um paciente de 2 anos e 3 meses de idade foi levado ao ambulatório de pediatria pela mãe, pois ela está preocupada com um "caroço" no pescoço do filho, que ela notou há cinco meses. Relatou que o filho é bastante ativo, que se alimenta bem, sempre ganhou peso, mas fala pouco e palavras difíceis de compreender. Ademais, há muito tempo apareceram alguns machucados no couro cabeludo dele, que o menino coça bastante e tem algumas crostas. Ao exame físico, constataram-se altura = 90 cm (escore z 0), peso = 12,300 kg (escore z entre 0 e -2), FC = 120 bpm, FR = 26 irpm e SatO2 = 97% em AA. No couro cabeludo, há várias lesões com crostas melicéricas e presença de linfonodo retroauricular medindo 1,5 cm, móvel, fibroelástico, indolor à palpação. Observaram-se oroscopia, dentes em bom estado, sem lesões, sem frênulo lingual, otoscopia, com membrana timpânica translúcida, sem abaulamentos ou retrações e ausculta cardíaca, BNF, RR, 2t, sem sopro. Verificaram-se, ainda, ausculta pulmonar, MVUD, sem RA, abdome, RHA+, depressível, sem megalias, indolor à palpação e genitália com testículos em bolsa escrotal e fimose. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. É bastante comum meninos não falarem até os 2 anos de idade; nesses casos, deve-se aguardar até os 2 anos e meio e orientar que os pais estimulem a criança a falar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298899)

Enunciado: Um paciente de 2 anos e 3 meses de idade foi levado ao ambulatório de pediatria pela mãe, pois ela está preocupada com um "caroço" no pescoço do filho, que ela notou há cinco meses. Relatou que o filho é bastante ativo, que se alimenta bem, sempre ganhou peso, mas fala pouco e palavras difíceis de compreender. Ademais, há muito tempo apareceram alguns machucados no couro cabeludo dele, que o menino coça bastante e tem algumas crostas. Ao exame físico, constataram-se altura = 90 cm (escore z 0), peso = 12,300 kg (escore z entre 0 e -2), FC = 120 bpm, FR = 26 irpm e SatO2 = 97% em AA. No couro cabeludo, há várias lesões com crostas melicéricas e presença de linfonodo retroauricular medindo 1,5 cm, móvel, fibroelástico, indolor à palpação. Observaram-se oroscopia, dentes em bom estado, sem lesões, sem frênulo lingual, otoscopia, com membrana timpânica translúcida, sem abaulamentos ou retrações e ausculta cardíaca, BNF, RR, 2t, sem sopro. Verificaram-se, ainda, ausculta pulmonar, MVUD, sem RA, abdome, RHA+, depressível, sem megalias, indolor à palpação e genitália com testículos em bolsa escrotal e fimose. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Aos 2 anos de idade, com certeza a criança deve usar colher/garfo, subir degraus, imitar trabalhos caseiros, rabiscar e nomear partes do corpo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298931)

Enunciado: Um bebê de 6 meses de vida foi levado pela mãe à equipe de Saúde da Família (eSF) para consulta de rotina de puericultura. A mãe relata que está preocupada, pois a criança mostra-se mais chorosa, apresentando irritabilidade, dificuldade para dormir e pico febril de 39ºC na noite anterior. A criança está previamente hígida, em aleitamento materno exclusivo, fez uso de paracetamol há duas horas e sua temperatura é de 37,5ºC no momento. A mãe nega que a criança tenha alergias medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se auscultas pulmonar e cardíaca sem alterações, abdome sem particularidades, otoscopia direita com presença de membrana timpânica abaulada e hiperemiada, sem presença de otorreia. A criança é capaz de firmar a cabeça e apanhar objetos, e as medidas antropométricas estão próximas ao percentil 50. Carteira de vacinação atualizada. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Apesar de medidas antropométricas estarem adequadas nesse momento, o desenvolvimento neuropsicomotor está atrasado, pois a criança com essa idade já deveria ser capaz de sentar sem apoio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298932)

Enunciado: Um bebê de 6 meses de vida foi levado pela mãe à equipe de Saúde da Família (eSF) para consulta de rotina de puericultura. A mãe relata que está preocupada, pois a criança mostra-se mais chorosa, apresentando irritabilidade, dificuldade para dormir e pico febril de 39ºC na noite anterior. A criança está previamente hígida, em aleitamento materno exclusivo, fez uso de paracetamol há duas horas e sua temperatura é de 37,5ºC no momento. A mãe nega que a criança tenha alergias medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se auscultas pulmonar e cardíaca sem alterações, abdome sem particularidades, otoscopia direita com presença de membrana timpânica abaulada e hiperemiada, sem presença de otorreia. A criança é capaz de firmar a cabeça e apanhar objetos, e as medidas antropométricas estão próximas ao percentil 50. Carteira de vacinação atualizada. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Nessa consulta, já é possível orientar acerca da introdução de alimentação complementar ao aleitamento materno.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284298)

Enunciado: Um lactente com dez meses de vida, nascido de parto normal a termo, com peso adequado e sem intercorrência, foi levado por sua mãe à unidade de atenção básica para uma consulta de puericultura, apresentando unhas quebradiças, irritabilidade, queilite angular e astenia. Ao exame físico, o pediatra observou palidez da face, das palmas das mãos e da mucosa oral e conjuntival e solicitou um hemograma, que demonstrou hemoglobina igual a 10,5 g/dl e hematócrito 31%, o que o fez suspeitar de anemia ferropriva. A mãe informou que ele é amamentado ao seio materno, mas recebe complementação com leite de vaca em pó desde o 6.º mês, aceita pouca alimentação de sal e nunca fez suplementação com ferro oral. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A prevenção de anemia para lactente a termo com peso adequado é feita com a prescrição de 1 mg/kg de ferro elementar, do 3.º ao 24.º mês de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284299)

Enunciado: Um lactente com dez meses de vida, nascido de parto normal a termo, com peso adequado e sem intercorrência, foi levado por sua mãe à unidade de atenção básica para uma consulta de puericultura, apresentando unhas quebradiças, irritabilidade, queilite angular e astenia. Ao exame físico, o pediatra observou palidez da face, das palmas das mãos e da mucosa oral e conjuntival e solicitou um hemograma, que demonstrou hemoglobina igual a 10,5 g/dl e hematócrito 31%, o que o fez suspeitar de anemia ferropriva. A mãe informou que ele é amamentado ao seio materno, mas recebe complementação com leite de vaca em pó desde o 6.º mês, aceita pouca alimentação de sal e nunca fez suplementação com ferro oral. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A suplementação da alimentação com leite de vaca a partir do 6.º mês protege contra a deficiência de ferro do lactente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261252)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A dor mamária e a perda de peso são sinais sugestivos de má pega do RN.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261253)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Recomenda-se aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de idade, para todas as crianças em condições de serem amamentadas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261254)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A perda de peso do paciente indica que o leite está fraco.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261255)

Enunciado: Certo Recém-Nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O paciente mencionado deve apresentar sorriso social nessa idade.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274390)

Enunciado: Sobre as características farmacológicas das substâncias e seu uso por lactantes, assinale a alternativa correta.

A) Fármacos com alto peso molecular atingem mais facilmente o leite materno que aqueles com peso molecular menor.

B) Fármacos com alta afinidade a proteínas plasmáticas apresentam maior facilidade para atingir o compartimento lácteo, uma vez que os fármacos passam para o leite materno ligados às proteínas plasmáticas.

C) Fármacos lipossolúveis apresentam mais dificuldade para atingir o compartimento lácteo.

D) Fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno, mas, por terem efeito mais duradouro e lento, não passam para o leite materno.

E) Fármacos com baixa biodisponibilidade são ideais para uso durante a lactação porque, mesmo quando presentes no leite, são pouco ou nada absorvidos pelo lactente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274424)

Enunciado: Referente à Saúde da Criança, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) A mortalidade infantil diminuiu muito nas últimas décadas, tendo maior queda a mortalidade pós-neonatal. ( ) A obesidade infantil e a má qualidade da alimentação superaram a desnutrição como problema de saúde das crianças. ( ) As primeiras consultas devem ser feitas preferencialmente pelo médico, mas as demais podem ser feitas exclusivamente por enfermeiros para crianças de baixo risco. ( ) Crianças de alto risco não devem ser acompanhadas na atenção primária, ficando seu acompanhamento restrito aos ambulatórios de especialidades.

A) F ? V ? V ? F.

B) F ? F ? F ? V.

C) V ? V ? F ? F.

D) V ? V ? V ? F.

E) F ? F ? V ? V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261303)

Enunciado: Uma criança de 1 ano e 4 meses de idade, com histórico de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, é levada a atendimento pela mãe que referiu tosse, febre, hiperemia ocular e aparecimento de "manchas" brancas em mucosa oral, com posterior aparecimento de "manchas" vermelhas no corpo. Ao exame, apresenta temperatura axilar de 38 ºC e exantema maculopapular avermelhado, de progressão craniocaudal. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A respeito do aleitamento materno, a recomendação do Ministério da Saúde é de amamentar, se possível, até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250098)

Enunciado: Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir. Mulheres com hepatites dos vírus A, B e C podem amamentar, exceto as portadoras do vírus C que estiverem com mamilos com fissuras.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250099)

Enunciado: Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir. Com o advento do desmame, os alimentos processados, enriquecidos ou calóricos, como, por exemplo, o melado ou a rapadura, na população carente, devem ser a base do início da alimentação da criança.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250100)

Enunciado: Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir. Nos dois primeiros anos de vida, as bebidas não devem ser adoçadas com açúcar, devendo ser utilizados adoçantes naturais como a stevia ou o mel, com a finalidade de criar hábitos saudáveis e evitar cáries dentárias.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250101)

Enunciado: Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir. Na impossibilidade de amamentação até os quatro meses de vida, o leite de vaca deve ser diluído ou deve ser utilizada fórmula de leite desnatado ou semidesnatado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250107)

Enunciado: Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. Quanto à conduta na cronologia da erupção dentária, é correto afirmar que, se o bebê nascer com dente ou vier a tê-lo no primeiro mês de vida, é necessário extraí-lo; caso não ocorra até os doze meses de vida, é necessário investigar a rara possibilidade de anadontia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239311)

Enunciado: Uma mãe de primeira viagem, apresenta grandes inseguranças acerca do desenvolvimento da filha, de quais situações são normais ou anormais, além de quando ela deve esperar que a criança consiga demonstrar certas capacidades. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, considerando principalmente as informações do Tratado de Pediatria (Nelson), julgue o item a seguir. Espera-se a expressão do sorriso social da criança a partir dos 3 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239312)

Enunciado: Uma mãe de primeira viagem, apresenta grandes inseguranças acerca do desenvolvimento da filha, de quais situações são normais ou anormais, além de quando ela deve esperar que a criança consiga demonstrar certas capacidades. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, considerando principalmente as informações do Tratado de Pediatria (Nelson), julgue o item a seguir. Gargalhadas podem ser observadas a partir dos 4 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239313)

Enunciado: Uma mãe de primeira viagem, apresenta grandes inseguranças acerca do desenvolvimento da filha, de quais situações são normais ou anormais, além de quando ela deve esperar que a criança consiga demonstrar certas capacidades. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, considerando principalmente as informações do Tratado de Pediatria (Nelson), julgue o item a seguir. O desenvolvimento da capacidade de engatinhar, necessariamente, precede o da capacidade de andar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239314)

Enunciado: Uma mãe de primeira viagem, apresenta grandes inseguranças acerca do desenvolvimento da filha, de quais situações são normais ou anormais, além de quando ela deve esperar que a criança consiga demonstrar certas capacidades. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, considerando principalmente as informações do Tratado de Pediatria (Nelson), julgue o item a seguir. O movimento de pinça anatômica com o polegar e indicador costuma surgir aos 6 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239315)

Enunciado: Uma mãe de primeira viagem, apresenta grandes inseguranças acerca do desenvolvimento da filha, de quais situações são normais ou anormais, além de quando ela deve esperar que a criança consiga demonstrar certas capacidades. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, considerando principalmente as informações do Tratado de Pediatria (Nelson), julgue o item a seguir. O reflexo cutâneo-plantar em flexão desaparece em torno de 6 a 8 meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255734)

Enunciado: Os pais de uma criança de 4 anos de idade levam seu filho a um pediatra credenciado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para uma rotina de puericultura. Durante a consulta, são feitas várias perguntas relacionadas ao desenvolvimento infantil da criança, que são respondidas pelos pais, e são realizados testes pelo pediatra. Com base no exposto e tendo em vista as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, julgue o item a seguir. Nessa fase, a criança é considerada como pré-escolar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255735)

Enunciado: Os pais de uma criança de 4 anos de idade levam seu filho a um pediatra credenciado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para uma rotina de puericultura. Durante a consulta, são feitas várias perguntas relacionadas ao desenvolvimento infantil da criança, que são respondidas pelos pais, e são realizados testes pelo pediatra. Com base no exposto e tendo em vista as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, julgue o item a seguir. Pular sozinha e pedalar são esperados a partir dessa idade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255736)

Enunciado: Os pais de uma criança de 4 anos de idade levam seu filho a um pediatra credenciado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para uma rotina de puericultura. Durante a consulta, são feitas várias perguntas relacionadas ao desenvolvimento infantil da criança, que são respondidas pelos pais, e são realizados testes pelo pediatra. Com base no exposto e tendo em vista as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, julgue o item a seguir. Provavelmente a criança começa a controlar a micção noturna nessa idade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255737)

Enunciado: Os pais de uma criança de 4 anos de idade levam seu filho a um pediatra credenciado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para uma rotina de puericultura. Durante a consulta, são feitas várias perguntas relacionadas ao desenvolvimento infantil da criança, que são respondidas pelos pais, e são realizados testes pelo pediatra. Com base no exposto e tendo em vista as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, julgue o item a seguir. Independentemente do local de atendimento, o médico deve manter um papel de educador, e não de socorrista nas situações de desenvolvimento infantil.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239350)

Enunciado: Uma paciente de 12 anos de idade vai à consulta agendada em Unidade de Saúde da Família acompanhada pela mãe. A familiar demonstra preocupações quanto ao desenvolvimento da filha, alegando ser esta uma das mais baixas entre as respectivas colegas e que ainda não teve a primeira menstruação, a despeito de estar notando desenvolvimento das mamas há 10 meses, observando-se a presença de broto mamário ao exame físico. Refere-se, também, que a mãe está receosa de a filha vir a ser diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos (SOP), tendo base tal preocupação em leitura de informações da internet em correlação com o fato de a filha apresentar acne facial, de ainda nunca ter menstruado e de possuir histórico familiar de primeiro grau de obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Faz uso de metilfenidato 10 mg/dia por diagnóstico prévio de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade, demonstrando manter atenção apenas para atividades do próprio interesse, sem, no entanto, apresentar histórico de baixo desempenho escolar ou prejuízo da vida social. Em avaliação ponderoestatural, verifica-se IMC de 21 kg/m², considerado adequado para a idade da paciente. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Conforme a normalidade de crescimento e desenvolvimento previsto para o sexo feminino, é esperado que a paciente apresente pico da velocidade de crescimento em período de aproximadamente um ano após o aparecimento do broto mamário, período em que também se espera a menarca.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255780)

Enunciado: Uma criança de 11 meses de vida foi levada à unidade de saúde da família com história de tosse produtiva, febre há quatro dias e dificuldade respiratória. Além do quadro agudo, a mãe demostrava preocupação pelo fato de a filha ainda não conseguir sentar sem apoio. Exame físico: bom estado geral; corada; hidratada; anictérica; acianótica; sem tiragem subcostal; presença de estertoração crepitante na base esquerda; FR = 68 irpm; FC = 118; SpO2 = 97%. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Conforme instrumento de vigilância do desenvolvimento, presente na Caderneta de Saúde da Criança, a criança deverá sentar sem apoio até o final do nono mês de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196679)

Enunciado: Paciente de 6 meses e 20 dias de vida, nascido com 35 semanas de idade gestacional, é levado a uma consulta de puericultura pela mãe. Recebe aleitamento materno, papas de frutas e duas papas principais. A mãe demonstra muita preocupação, pois o lactente não senta sem apoio e não rola no leito. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Como o paciente ainda está em aleitamento materno, não é necessária a suplementação com ferro.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214399)

Enunciado: Determinado paciente, atualmente com 24 meses de vida, é levado pela própria mãe, de 18 anos de idade, a consulta com especialista em desenvolvimento. No histórico, observa- se gestação durante a adolêscencia da mãe, complicada por trauma abdominal durante discussão com o pai da criança, às 34 semanas de gestação, causando descolamento prematuro da placenta, com necessidade de parto cesáreo de emergência por sofrimento fetal agudo por ocasião. O RN nasceu com 1.800 g, sendo necessária a realização de manobras de reanimação neonatal. Ele permaneceu internado na unidade de terapia intensiva neonatal por quatro semanas. Apresentou, ao exame físico, FC de 90 bpm, FR de 20 irpm, saturação de oxigênio de 99%, reflexo cutâneo plantar em extensão, reflexo de preensão palmar ausente e capacidade de marchar com apoio (mas não sozinho). Refere ausência de controle esfincteriano no momento. O paciente fala algumas palavras com duas sílabas. Em relação ao caso clínico descrito, julgue o item a seguir. A presença do reflexo cutâneo plantar em extensão deve ser considerada normal até dois anos de idade; logo, é normal nesse paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196689)

Enunciado: Paciente de 6 meses e 20 dias de vida, nascido com 35 semanas de idade gestacional, é levado a uma consulta de puericultura pela mãe. Recebe aleitamento materno, papas de frutas e duas papas principais. A mãe demonstra muita preocupação, pois o lactente não senta sem apoio e não rola no leito. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A criança apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196694)

Enunciado: Paciente de 6 meses e 20 dias de vida, nascido com 35 semanas de idade gestacional, é levado a uma consulta de puericultura pela mãe. Recebe aleitamento materno, papas de frutas e duas papas principais. A mãe demonstra muita preocupação, pois o lactente não senta sem apoio e não rola no leito. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A interpretação do peso, da estatura e do perímetro cefálico nas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde deve respeitar a idade corrigida do paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196699)

Enunciado: Paciente de 6 meses e 20 dias de vida, nascido com 35 semanas de idade gestacional, é levado a uma consulta de puericultura pela mãe. Recebe aleitamento materno, papas de frutas e duas papas principais. A mãe demonstra muita preocupação, pois o lactente não senta sem apoio e não rola no leito. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Nessa faixa etária, espera-se que o paciente tenha sorriso social, que reaja ao som, que vocalize e que agarre um brinquedo quando colocado na respectiva mão.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196612)

Enunciado: Paciente de 6 meses e 20 dias de vida, nascido com 35 semanas de idade gestacional, é levado a uma consulta de puericultura pela mãe. Recebe aleitamento materno, papas de frutas e duas papas principais. A mãe demonstra muita preocupação, pois o lactante não senta sem apoio e não rola no leito. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O desenvolvimento do paciente precisa ser estimulado com o uso de andadores.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196681)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Até que se obtenham resultados de testes rápidos maternos, efetuados no pré-parto, a criança não deve ser amamentada, uma vez que a gestante não realizou pré-natal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214473)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. Investigação por baixa estatura deve ser iniciada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214482)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. Tendo em vista que H.C.S. teve um desenvolvimento neuromuscular normal, certamente desenvolveu capacidade de engatinhar antes de andar com apoio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214503)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. A realização de hemograma para rastreamento de anemia aos 24 meses de idade deve ser recomendada, na ocasião da suspensão da suplementação de ferro profilática.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214507)

Enunciado: A paciente J. D. R., de 24 anos de idade, é portadora do vírus HIV e está em uso irregular de tratamento antirretroviral (TARV). Atualmente, apresenta contagem de CD4 de 150 células/mm^3.

Manifestou, durante a gestação do último filho, coinfecção com tuberculose. A paciente e o respectivo filho moram na mesma residência que a avó da criança. O filho de J. D. R. tem 9 meses de vida e não apresenta características clínicas de imunossupressão. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. O aleitamento materno é fator de proteção para várias doenças, além de auxiliar na relação do binômio mãe-bebê, mas está contraindicado nesse caso clínico, assim como nas infecções maternas por HTLV e hanseníase.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196655)

Enunciado: Determinada paciente de 16 anos de idade iniciou atendimento pré-natal em posto de saúde da família e foi diagnosticada com HIV nas sorologias de primeiro trimestre, iniciando terapia antirretroviral adequada e com boa adesão imediatamente. Os demais exames de rotina de pré-natal mostraram-se normais. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Apesar dos inúmeros benefícios do aleitamento materno para o crescimento e o desenvolvimento da criança, ele está contraindicado na vigência da infecção materna pelo HIV. Tal contraindicação não se aplica nas infecções maternas por citomegalovírus, caxumba, herpes simples (não mamária) e HTLV.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179188)

Enunciado: Com relação à necessidade de ferro do lactente, é correto afirmar que

A) O leite materno nos primeiros seis meses de vida previna anemia por possuir quantidades bem superiores de ferro que o leite de vaca.

B) O ferro heme presente na hemoglobina e na mioglobina das carnes e vísceras tenha menor biodisponibilidade e absorção que os contidos no feijão e no ovo.

C) Fitatos, taninos, cálcio e fosfatos possuam efeito facilitador, aumentando a absorção do ferro.

D) A vitamina A seja fator inibidor da absorção do ferro e deva ser oferecida como complementação somente após um ano de idade.

E) Crianças de seis a dezoito meses de vida devam receber o suplemento de ferro mesmo em aleitamento materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177649)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfodonos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 mL de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A suplementação de ferro profilática deve ser iniciada ou reiniciada imediatamente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177658)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfodonos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal, nem de insuficiência ventilatória, nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 mL de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Saúde da Criança, recomendam-se sete consultas rotineiras no 1º ano de vida, para que haja, entre outras ações, o acompanhemento do crescimento e do desenvolvimento da criança.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177662)

Enunciado: R.G.R., uma criança de 7 meses de idade, foi levada pelos pais a um pronto atendimento infantil com quadro de tosse e secreção nasal há cerca de 10 dias, com o desenvolvimento de febre, nos últimos 2 dias, e respiração rápida. Ao exame físico, foram observados uma orofaringe com hiperemia discreta, linfonodos cervicais normais, otoscopia normal bilateral, ausculta pulmonar com estertores crepitantes à esquerda, palpação abdominal normal, ausência de sinais de irritação meníngea e inexistência de alterações dermatológicas. A frequência respiratória foi de 52 incursões por minuto. Não havia presença de tiragem subcostal nem de insuficiência ventilatória nem de cianose. A paciente consegue alimentar-se ao seio materno com pouca dificuldade. A saturação periférica de oxigênio é de 96%. A radiografia de tórax demonstra área de consolidação em lobo inferior esquerdo e derrame pleural de cerca de 1,5 cm. R.G.R., após a resolução de seu quadro de saúde, foi levada por seus pais para um atendimento rotineiro de puericultura, agora com 9 meses de idade, com o médico de família e comunidade do posto de saúde próximo à casa deles. Os pais estão realizando, na criança, a introdução alimentar de forma adequada, associada a 600 ml de fórmula láctea apropriada para a idade. A criança não está em uso de qualquer medicação ou suplemento. A respeito do caso clínico apresentado e de conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O primeiro ano de vida é um momento de importante aceleração da velocidade de crescimento da criança.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177613)

Enunciado: C.A.S., filho de J.A.S., agora está com 9 meses de idade. A mãe, muito atarefada devido às responsabilidades maternais associadas à necessidade de prover o sustento da família, resolveu comprar um andador (aparelho com rodas no qual a criança fica suspensa, podendo se propulsionar para frente ou para os lados), para que o filho tivesse mais liberdade para locomover-se pela casa antes de aprender a andar. A respeito do andador e da relação desse objeto com os traumas infantis, julgue o item a seguir. O andador facilita o desenvolvimento da percepção corporal e da capacidade de equilíbrio, essenciais para a marcha sem quedas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177693)

Enunciado: O escopo da abordagem comunitária do médico de família foge do completo isolamento do consultório médico, envolvendo, também, ações de modificação do ambiente da comunidade, visando à promoção da qualidade de vida e à prevenção de doenças da população. Considerando esse contexto, Rafael, residente do 2º ano de medicina de família e comunidade, procurou auxílio da prefeitura para implantar um programa de incentivo à atividade física, na área geográfica de sua atuação, o qual incluía a revitalização da praça próxima ao posto, a implantação de academia ao ar livre e a pista de caminhada. Três vezes por semana, Rafael investia a 1ª hora de sua manhã organizando um grupo de caminhada e orientando a população na prática de exercícios físicos. Considerando a situação hipotética apresentada e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Os exercícios resistidos são contraindicados para crianças, logo, na academia ao ar livre, devem-se afixar placas solicitando que elas não utilizem os aparelhos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289437)

Enunciado: Considere que uma paciente de 7 anos de idade, previamente hígida, foi encaminhada pelo clínico da unidade básica por estar apresentando, há mais de quatro meses, crescimento mamário e pelos pubianos terminais. Apresentava dosagem de hormônio luteinizante (LH) aumentada pós-estímulo, com hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. Trata-se provavelmente de puberdade precoce de origem central.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289439)

Enunciado: Considere que uma paciente de 7 anos de idade, previamente hígida, foi encaminhada pelo clínico da unidade básica por estar apresentando, há mais de quatro meses, crescimento mamário e pelos pubianos terminais. Apresentava dosagem de hormônio luteinizante (LH) aumentada pós-estímulo, com hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. A dosagem sérica de GnRH não determina o diagnóstico bioquímico de puberdade precoce.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289441)

Enunciado: Considere que uma paciente de 7 anos de idade, previamente hígida, foi encaminhada pelo clínico da unidade básica por estar apresentando, há mais de quatro meses, crescimento mamário e pelos pubianos terminais. Apresentava dosagem de hormônio luteinizante (LH) aumentada pós-estímulo, com hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. Deve-se solicitar ressonância magnética de crânio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289443)

Enunciado: Considere que uma paciente de 7 anos de idade, previamente hígida, foi encaminhada pelo clínico da unidade básica por estar apresentando, há mais de quatro meses, crescimento mamário e pelos pubianos terminais. Apresentava dosagem de hormônio luteinizante (LH) aumentada pós-estímulo, com hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. A pubarca também poderia ser manifestação de puberdade precoce de origem periférica, embora a telarca precoce não possa.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289445)

Enunciado: Considere que uma paciente de 7 anos de idade, previamente hígida, foi encaminhada pelo clínico da unidade básica por estar apresentando, há mais de quatro meses, crescimento mamário e pelos pubianos terminais. Apresentava dosagem de hormônio luteinizante (LH) aumentada pós-estímulo, com hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). A respeito desse caso clínico, julgue o item a seguir. Espera-se encontrar idade óssea avançada em relação à idade cronológica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289473)

Enunciado: Um lactente de 6 meses de idade, nascido a termo de parto cesáreo, sem intercorrências no período neonatal, foi levado à consulta de puericultura, sem queixas por parte da mãe. Ao nascer, pesava 2.900 kg, tinha estatura de 45 cm e perímetro cefálico de 34 cm. No momento da consulta, apresenta peso de 7,00 kg, estatura de 60 cm e perímetro cefálico de 40 cm. Possui a fontanela anterior ainda aberta e normotensa. Com base nesse caso clínico, e acerca dos conhecimentos médicos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento nessa faixa etária, julgue o item a seguir. O paciente descrito apresenta peso e estatura abaixo do esperado para a idade, mas tem perímetro cefálico adequado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289478)

Enunciado: Um lactente de 6 meses de idade, nascido a termo de parto cesáreo, sem intercorrências no período neonatal, foi levado à consulta de puericultura, sem queixas por parte da mãe. Ao nascer, pesava 2.900 kg, tinha estatura de 45 cm e perímetro cefálico de 34 cm. No momento da consulta, apresenta peso de 7,00 kg, estatura de 60 cm e perímetro cefálico de 40 cm. Possui a fontanela anterior ainda aberta e normotensa. Com base nesse caso clínico, e acerca dos conhecimentos médicos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento nessa faixa etária, julgue o item a seguir. A fontanela anterior do paciente já deveria estar fechada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289480)

Enunciado: Considere hipoteticamente que um paciente de 11 anos de idade, hígido, é levado à consulta pela mãe por queixar-se de apresentar estatura menor que a da irmã gêmea, além de ginecomastia com broto mamário de 2,5 cm de diâmetro e ausência de pelos axilares e de pubarca, embora apresente aumento testicular. A respeito desse caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos relacionados à puberdade masculina, julgue o item a seguir. Após o desenvolvimento dos túbulos seminíferos, ocorre a maturação das células de Leydig e a produção de andrógenos testiculares. Por essa razão, os pelos pubianos aparecerão posteriormente ao crescimento testicular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289482)

Enunciado: Considere hipoteticamente que um paciente de 11 anos de idade, hígido, é levado à consulta pela mãe por queixar-se de apresentar estatura menor que a da irmã gêmea, além de ginecomastia com broto mamário de 2,5 cm de diâmetro e ausência de pelos axilares e de pubarca, embora apresente aumento testicular. A respeito desse caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos relacionados à puberdade masculina, julgue o item a seguir. O atraso do crescimento em relação ao da irmã é motivo para o início de investigação de causas secundárias de baixa estatura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289484)

Enunciado: Considere hipoteticamente que um paciente de 11 anos de idade, hígido, é levado à consulta pela mãe por queixar-se de apresentar estatura menor que a da irmã gêmea, além de ginecomastia com broto mamário de 2,5 cm de diâmetro e ausência de pelos axilares e de pubarca, embora apresente aumento testicular. A respeito desse caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos relacionados à puberdade masculina, julgue o item a seguir. A massa magra, que geralmente corresponde a 80% no período pré-puberal, aumenta para até 90% nos meninos e diminui para cerca de 70%-75% nas meninas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289487)

Enunciado: Considere hipoteticamente que um paciente de 11 anos de idade, hígido, é levado à consulta pela mãe por queixar-se de apresentar estatura menor que a da irmã gêmea, além de ginecomastia com broto mamário de 2,5 cm de diâmetro e ausência de pelos axilares e de pubarca, embora apresente aumento testicular. A respeito desse caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos relacionados à puberdade masculina, julgue o item a seguir. A ginecomastia é fenômeno normal e comum na puberdade, chegando a acometer 60% dos meninos, mais frequentemente de apresentação unilateral.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289489)

Enunciado: Considere hipoteticamente que um paciente de 11 anos de idade, hígido, é levado à consulta pela mãe por queixar-se de apresentar estatura menor que a da irmã gêmea, além de ginecomastia com broto mamário de 2,5 cm de diâmetro e ausência de pelos axilares e de pubarca, embora apresente aumento testicular. A respeito desse caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos relacionados à puberdade masculina, julgue o item a seguir. Nesse caso, é improvável que ocorra involução espontânea da ginecomastia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289491)

Enunciado: Uma lactente de 10 meses de idade, nascida a termo, é levada ao pronto atendimento por apresentar coriza e tosse de leve intensidade. Ao exame físico, pode-se observar que necessita do apoio do pediatra para manter-se sentada, ou inclina-se para frente apoiando as mãos na maca, e não mantém-se em pé, mesmo com apoio. A paciente rola e rasteja, mas não engatinha. Há presença de reflexos de preensão palmar e plantar. Quanto ao caso clínico apresentado, e considerando o desenvolvimento da paciente, julgue o item a seguir. O desenvolvimento da paciente está compatível com a respectiva idade cronológica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289493)

Enunciado: Uma lactente de 10 meses de idade, nascida a termo, é levada ao pronto atendimento por apresentar coriza e tosse de leve intensidade. Ao exame físico, pode-se observar que necessita do apoio do pediatra para manter-se sentada, ou inclina-se para frente apoiando as mãos na maca, e não mantém-se em pé, mesmo com apoio. A paciente rola e rasteja, mas não engatinha. Há presença de reflexos de preensão palmar e plantar. Quanto ao caso clínico apresentado, e considerando o desenvolvimento da paciente, julgue o item a seguir. Deveriam estar ausentes os reflexos de preensão palmar e plantar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289495)

Enunciado: Uma lactente de 10 meses de idade, nascida a termo, é levada ao pronto atendimento por apresentar coriza e tosse de leve intensidade. Ao exame físico, pode-se observar que necessita do apoio do pediatra para manter-se sentada, ou inclina-se para frente apoiando as mãos na maca, e não mantém-se em pé, mesmo com apoio. A paciente rola e rasteja, mas não engatinha. Há presença de reflexos de preensão palmar e plantar. Quanto ao caso clínico apresentado, e considerando o desenvolvimento da paciente, julgue o item a seguir. Deve-se interrogar os pais acerca do controle do esfíncter vesical, pois este já deve ter sido adquirido.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289497)

Enunciado: Uma lactente de 10 meses de idade, nascida a termo, é levada ao pronto atendimento por apresentar coriza e tosse de leve intensidade. Ao exame físico, pode-se observar que necessita do apoio do pediatra para manter-se sentada, ou inclina-se para frente apoiando as mãos na maca, e não mantém-se em pé, mesmo com apoio. A paciente rola e rasteja, mas não engatinha. Há presença de reflexos de preensão palmar e plantar. Quanto ao caso clínico apresentado, e considerando o desenvolvimento da paciente, julgue o item a seguir. Deve ser avaliada a capacidade de transferir objetos de uma mão a outra, visto que essa habilidade já deve ter sido adquirida nessa idade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289500)

Enunciado: Uma lactente de 10 meses de idade, nascida a termo, é levada ao pronto atendimento por apresentar coriza e tosse de leve intensidade. Ao exame físico, pode-se observar que necessita do apoio do pediatra para manter-se sentada, ou inclina-se para frente apoiando as mãos na maca, e não mantém-se em pé, mesmo com apoio. A paciente rola e rasteja, mas não engatinha. Há presença de reflexos de preensão palmar e plantar. Quanto ao caso clínico apresentado, e considerando o desenvolvimento da paciente, julgue o item a seguir. O desenvolvimento está muito atrasado, e a lactente deveria estar andando sem apoio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152093)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso= 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm, e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O desenvolvimento neuropsicomotor desse recém-nascido deve mostrar que ele, provavelmente, fixa o olhar à luz e pode observar as pessoas, movimentando o corpo quando ouve vozes e tem contatos com outras pessoas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152112)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso= 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm, e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Recém-nascidos amamentados exclusivamente perdem, em média, entre 5% e 7% do peso do nascimento nos primeiros dois ou três dias de vida, mas pode ser aceita a perda ponderal de até 10%, desde que recuperado o peso do nascimento até os 15 dias de vida do paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152120)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso = 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm, e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. No final do primeiro ano de vida, segundo o Ministério da Saúde, esse paciente deve ter comparecido a, no mínimo, oito consultas de puericultura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152128)

Enunciado: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, proteção e nutrição para a criança, e constitui a mais econômica, sensível e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite, ainda, um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Com base nas características do leite materno e nos benefícios do ato de amamentar, julgue o item a seguir: as principais dificuldades no aleitamento materno ocorrem por erros de técnica de amamentação.

A) CERTO

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152139)

Enunciado: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, proteção e nutrição para a criança, e constitui a mais econômica, sensível e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite, ainda, um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Com base nas características do leite materno e nos benefícios do ato de amamentar, julgue o item a seguir: a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo, sob livre demanda, desde a sala de parto até os seis meses de vida, quando se inicia alimentação complementar, mantendo, contudo, até, no mínimo, os dois anos de idade.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152145)

Enunciado: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, proteção e nutrição para a criança, e constitui a mais econômica, sensível e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite, ainda, um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Com base nas características do leite materno e nos benefícios do ato de amamentar, julgue o item a seguir: uma das contraindicações da amamentação ocorre em neonatos que apresentam icterícia associada ao aleitamento materno.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152076)

Enunciado: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, proteção e nutrição para a criança, e constitui a mais econômica, sensível e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite, ainda, um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Com base nas características do leite materno e nos benefícios do ato de amamentar, julgue o item a seguir: o neonato que se encontra com a boca bem aberta, lábio inferior evertido, queixo tocando a mama e aréola materna mais visível acima da boca do bebê do que abaixo apresenta sinais de uma pega efetiva.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152096)

Enunciado: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, proteção e nutrição para a criança, e constitui a mais econômica, sensível e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite, ainda, um grandioso impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade. Com base nas características do leite materno e nos benefícios do ato de amamentar, julgue o item a seguir: o leite materno possui maior concentração de proteínas que o leite de vaca, predominando a caseína que tem a função de defesa.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131843)

Enunciado: Acerca do aleitamento materno, assinale a alternativa CORRETA:

A) São contraindicações absolutas ao aleitamento materno: mãe HIV-positiva, tuberculose materna com doença ativa e uso de drogas antineoplásicas pela mãe.

B) Uma boa técnica de amamentação engloba deglutição visível e audível, a boca do bebê deve estar bem aberta e abocanhando a maior parte da aréola da mama, o lábio inferior invertido e o queixo deve estar tocando a mama materna.

C) O colostro possui maior concentração de proteínas, imunoglobulinas, sais, vitamina A, vitamina E e lactoferrina, com menor concentração de gordura e lactose em relação ao leite maduro.

D) A betalactoglobulina é a proteína do soro de maior concentração no leite materno.

E) O aleitamento materno misto ou parcial é definido quando o bebê se alimenta de leite materno associado a alimentos sólidos ou semissólidos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134984)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. A síndrome de Cushing causa aumento crônico dos níveis séricos de cortisol, o que implica prejuízos ao processo de crescimento. A principal causa dessa patologia é a iatrogênica, motivada pelo uso de corticosteroides na infância.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134993)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. Em regra, a deficiência na produção dos hormônios tireoidianos durante a infância acarreta retardo do crescimento, atraso na idade óssea e sinais clínicos como obstipação intestinal, apatia e lentidão.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135001)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. A síndrome de Turner é uma das principais causas de baixa estatura em meninos, e tratá-la com base em hormônio de crescimento tem se mostrado pouco eficiente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135006)

Enunciado: A respeito da baixa estatura na infância, julgue o item subsequente. Em se tratando de baixa estatura idiopática, o déficit de crescimento se deve à má absorção de nutrientes, o que propicia quadro de desnutrição e presença de marcadores inflamatórios.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

140755)

Enunciado: Acerca do raquitismo na infância, julgue o item a seguir. O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela redução da mineralização da placa epifisária do osso em crescimento.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105548)

Enunciado: O crescimento é um indicador bastante sensível do estado nutricional da criança. As suas desacelerações ou acelerações estão associadas ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças a curto e a longo prazos. No acompanhamento da curva de crescimento no ambulatório de crescimento e desenvolvimento, é CORRETO afirmar que:

A) As crianças com baixo peso ao nascer têm menor risco de apresentar doenças cardiovasculares.

B) Uma elevada velocidade de crescimento durante a infância apresenta risco aumentado para desenvolver obesidade e diabetes tipo I.

C) A baixa estatura é um alerta para a presença de doenças crônicas.

D) A diminuição de apetite da criança, informada pela mãe, geralmente está associada a doenças crônicas, mesmo com as curvas de crescimento dentro do normal.

E) A recuperação geralmente é muito lenta e às vezes irreversível após a perda ponderal devido a alguma doença aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108238)

Enunciado: No item abaixo, é apresentado um caso clínico a respeito do crescimento e do desenvolvimento na infância e na adolescência, seguido de uma assertiva que deve ser julgada. A mãe de um lactente, de quatro meses de idade, alimentado exclusivamente com leite materno, queixou-se ao pediatra que o leite dela não estava sendo suficiente para nutrir o bebê, uma vez que ele estava crescendo pouco e deveria, portanto, receber outros tipos de alimento. O exame médico da criança mostrou um desenvolvimento psicomotor normal com peso e altura situados no escore Z = 0. A caderneta de vacinação da criança estava atualizada até o 3° mês de vida. Nesse caso, o médico deve recomendar que a mãe mantenha o aleitamento materno exclusivo, que exponha o bebê diretamente à luz solar por uma hora pela manhã e que faça as segundas doses das vacinas pentavalentes antipoliomielite injetável, antipneumocócica decavalente e antirrotavírus.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108176)

Enunciado: Julgue o item a seguir, relativo à deficiência de crescimento do corpo. Diversos genes responsáveis por codificar fatores de transcrição estão implicados na etiologia da deficiência combinada dos hormônios hipofisários (pan-hipopituitarismo), sendo o gene PROP-1 o mais frequentemente envolvido.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79673)

Enunciado: Criança de 4 anos, com crescimento normal até os 2 anos de idade, com velocidade de crescimento de 3 cm/ano no último ano. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica:

A) Crescimento normal.

B) Deficit de hormônio de crescimento.

C) Gigantismo.

D) Crescimento acelerado por possível hiperalimentação/obesidade.

E) Crescimento tipo "catch-up" em crianças com histórico de prematuridade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79682)

Enunciado: Dentre as anomalias congênitas frequentes em cirurgia geral, assinale a alternativa cuja doença não seja da prática do Cirurgião Geral.

A) Onfalocele.

B) Gastroquise.

C) Síndrome Conrad Horner.

D) Atresia de Esôfago.

E) Hérnia umbilical infantil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88630)

Enunciado: Com relação ao acompanhamento do crescimento e ao desenvolvimento infantil, julgue o item subsecutivo. O uso de hormônio de crescimento é contraindicado para as pacientes com síndrome de Turner, que apresentam baixa estatura, mas elevada predisposição a desenvolver neoplasias.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88640)

Enunciado: Com relação ao acompanhamento do crescimento e ao desenvolvimento infantil, julgue o item subsecutivo. No raquitismo por resistência à vitamina D, o mecanismo fisiopatológico é uma mutação no gene que codifica a enzima 1-alfa-hidroxilase, o que compromete a conversão da molécula inativa (25-hidroxi-vitamina D) na molécula ativa (1,25-diidroxi-vitamina D).

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88643)

Enunciado: Com relação ao acompanhamento do crescimento e ao desenvolvimento infantil, julgue o item subsecutivo: Cerca de 40% a 50% dos neonatos que nascem a termo e pequenos para a idade gestacional recuperam sua curva de crescimento até os trinta e seis meses de idade.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88649)

Enunciado: Com relação ao acompanhamento do crescimento e ao desenvolvimento infantil, julgue o item subsecutivo. Crianças com baixa estatura constitucional (retardo constitucional do crescimento e puberdade) apresentam estatura abaixo do percentil 3 da curva de crescimento, velocidade de crescimento adequada para a faixa etária e atraso na idade óssea, com previsão de estatura na vida adulta de acordo com a hereditariedade familiar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82075)

Enunciado: No que concerne à atenção à saúde da criança, julgue o próximo item. A caderneta de saúde da criança do Ministério da Saúde utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento de crianças os gráficos de perímetro cefálico, peso para a idade, comprimento/estatura para a idade e Índice de Massa Corporal (IMC).

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82081)

Enunciado: No que concerne à atenção à saúde da criança, julgue o próximo item. Em casos de filhos de mães portadoras de hepatite B, a amamentação traz risco adicional ao recém-nascido, mesmo que ele tenha recebido a primeira dose da vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64323)

Enunciado: Uma paciente foi atendida na emergência hospitalar, relatando dificuldades na amamentação de seu primeiro filho, um recém-nascido de quinze dias de idade. A mãe informou que a criança chorava muito, que seu peito apresentava uma rachadura e que o bebê não sugava a mama adequadamente. Ao examinar o bebê, verificou-se que seu ganho de peso tinha sido abaixo do esperado nos primeiros quinze dias. Com base no caso clínico acima relatado, cite três recomendações para o posicionamento correto do bebê durante a amamentação e três recomendações para a correta pega do bebê à mama, indique quatro vantagens do aleitamento materno e determine o que deve ser feito com relação ao ganho insuficiente de peso do bebê.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64646)

Enunciado: Em relação ao crescimento e ao desenvolvimento de uma criança de 2 (dois) meses, é esperado que ela tenha determinadas respostas. A esse respeito, analise as assertivas abaixo: I. A criança observa rostos. II. A criança segue objetos ultrapassando a linha média. III. A criança reage ao som. IV. A criança eleva a cabeça e a mantém a 45°. V. A criança transfere um objeto de uma mão para outra. É correto o que se afirma em:

A) I e V, apenas.

B) II e III, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343406)

Enunciado: Na Pediatria, diferentemente da população adulta, os valores pressóricos normais são definidos de acordo com dados obtidos a partir da aferição da Pressão Arterial de crianças sadias e distribuídos em uma tabela normativa com base em:

A) Idade, estatura e peso.

B) Sexo, peso, estatura.

C) Idade, sexo e estatura.

D) Sexo, idade e peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334890)

Enunciado: Acerca do tem síndrome de Down, assinale a alternativa correta.

A) Por causa de o risco de hipotireoidismo ser alto ao longo da vida, deve-se solicitar a dosagem de TSH anualmente.

B) O ecocardiograma se faz necessário caso se auscultem sopros cardíacos, pois cardiopatia é rara nesses pacientes.

C) Recomenda-se evitar cambalhotas, futebol e mergulhos em razão da língua protusa da micrognatia.

D) Há um calendário de imunização específico para as crianças com síndrome de Down, com diferenças nas idades das vacinas.

E) Intervenções como fisioterapia motora e fonoaudiologia são indicadas somente quando há queixa específica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343423)

Enunciado: PGL, 3 meses, portador de Síndrome de Down. Mãe comparece à consulta pediátrica relatando que seu filho tem cansaço ao mamar. Na avaliação, foi constatado baixo ganho ponderal. Ao exame cardiológico, observa-se ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, B2 hiperfonética em foco pulmonar, com sopro sistólico em borda esternal esquerda, sendo que a saturação periférica de oxigênio era de 98%. O diagnóstico mais provável é:

A) Transposição das grandes artérias.

B) Defeito do septo atrioventricular forma total.

C) Tetralogia de Fallot.

D) Comunicação interatrial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343424)

Enunciado: Após 5 (cinco) dias de alta da maternidade, um recém-nascido a termo apresentou tendência em manter uma postura com extensão de cabeça e tronco. Tal atitude postural é:

A) Normal nessa e em qualquer faixa etária, com necessidade de intervenção por meio de orientação aos pais.

B) Anormal e com necessidade de encaminhamento imediato à equipe de reabilitação.

C) Anormal, mas com conduta expectante.

D) Normal nessa faixa etária, não necessitando de intervenção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273319)

Enunciado: Lactente com quatro meses é trazido à consulta rotineira, porém a avó diz estar preocupada porque tem notado que as mãos do seu neto estão constantemente fechadas. Qual a conduta adequada?

A) Considerar como uma observação extremamente importante e que necessita de uma avaliação neurológica detalhada, antes de qualquer conclusão, já que é um sinal importante de espasticidade.

B) Considerar como uma preocupação excessiva da avó, porém mandaria retornar para reavaliação após 1 mês.

C) Considerar como uma preocupação excessiva da avó já que esta postura é normal até os 4 meses.

D) Considerar como uma preocupação bastante comum das avós e que geralmente não tem significado patológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

268901)

Enunciado: Um lactente de 4 meses de idade, amamentado exclusivamente com leite materno, é levado à unidade básica de saúde para consulta de puericultura. Durante a verificação da curva de peso da Caderneta de Saúde da Criança, observa-se um declínio dessa curva. Considerando o mencionado quadro clínico e os conhecimentos médicos a ele relacionados, assinale a alternativa correta.

A) A Caderneta de Saúde da Criança não deve ser parâmetro para avaliação do crescimento.

B) As novas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde definem o que seria um crescimento ideal para crianças pequenas.

C) As curvas de crescimento somente devem ser usadas quando há dúvida quanto ao crescimento após o exame físico.

D) Nesse caso, a melhor conduta seria a retirada do aleitamento materno com substituição por fórmula infantil.

E) A curva de peso é um bom parâmetro, utilizado isoladamente, para avaliação do crescimento infantil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

268905)

Enunciado: Durante a consulta de puericultura, a mãe de um lactente de 1 mês de vida queixa-se de muita dor ao oferecer a mama esquerda para o filho. A mama está turgida, vermelha e quente. No que se refere ao diagnóstico de mastite, assinale a alternativa correta.

A) Para a prevenção da mastite, é necessário orientar as mães a oferecerem mamadas com horários regulares.

B) Nos recém-nascidos prematuros que não esvaziam a mama, pode-se melhorar a sucção oferecendo o bico da mamadeira.

C) O sabor do leite materno costuma alterar-se nas mastites em razão do aumento dos níveis de sódio e da diminuição dos níveis de lactose.

D) Deve-se explicar à mãe que a dor, muitas vezes, faz parte da amamentação, sendo necessários analgésicos regulares.

E) No lactente sadio, a conduta imediata é a suspensão do aleitamento materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

268909)

Enunciado: Uma menina de 7 anos de idade apresenta cheiro axilar forte, pelos pubianos e axilares ralos e mamas em fase de botão (elevação da mama e aréola como pequeno montículo). Tendo em vista o mencionado quadro clínico e os conhecimentos médicos correlatos, assinale a alternativa correta.

A) Pela descrição, o estadiamento de Tanner é de M3 P3.

B) O diagnóstico é de puberdade precoce, em razão do aparecimento das mamas antes dos 8 anos de idade nas meninas.

C) Espera-se, normalmente, um ritmo de desenvolvimento rápido entre o início das mamas e a primeira menstruação.

D) O crescimento exagerado de mãos e pés pode ser o primeiro sinal de puberdade central.

E) Os desreguladores endócrinos podem ajudar a reduzir os casos de puberdade precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274626)

Enunciado: Várias patologias podem também apresentar anomalias laboratoriais comuns com sinais e sintomas clínicos diferentes. As síndromes usualmente são denominadas pelo nome do médico ou cientista que primeiro as descreveu. Quanto às características da Síndrome de Hutchinson-Gilford, é CORRETO afirmar:

A) É conhecida como a doença dos tiques e as crianças que a sofrem realizam movimentos rápidos e involuntários dos músculos e produção involuntária de ruídos e palavras.

B) É uma doença genética rara caracterizada pelo envelhecimento acelerado das crianças. As crianças nascem saudáveis, mas em poucos meses a doença mostra o seu lado, dando o aspecto à criança como de um ancião.

C) É uma doença genética rara caracterizada pelo não envelhecimento das crianças. As crianças nascem saudáveis, mas não se desenvolvem, apresentando aspecto infantil até mesmo na fase adulta.

D) É conhecida como a doença dos ossos de vidro, que é uma condição rara que tem como principal característica a fragilidade dos ossos, que quebram com enorme facilidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266466)

Enunciado: Uma menina de seis anos de idade foi levada ao pediatra por apresentar discreto sangramento vaginal. A mãe informou que a criança apresentava aumento do volume das mamas seguido do aparecimento de pelos pubianos havia um ano. Não havia história familiar semelhante e outros antecedentes significativos. Ao exame físico, foram verificados: peso = 22 kg (escore Z = +1 para a idade); altura = 122,5 cm (escore +1<Z<+2 para a idade); sem achados morfológicos significativos; Tanner: M3P1. Os exames complementares apresentaram os seguintes resultados: LH 3 mU/mL (VR < 1,3); FSH 7mU/mL (VR = 0,11 a 1,6); estradiol 80 mU/mL (VR = 0 a 46); US pélvica: útero de volume normal, com linha endometrial e ovários aumentados de volume; idade óssea: 8 anos. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. Nesse caso, não está indicada a realização de ressonância magnética do cérebro com contraste como método avaliativo adicional.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266467)

Enunciado: Uma menina de seis anos de idade foi levada ao pediatra por apresentar discreto sangramento vaginal. A mãe informou que a criança apresentava aumento do volume das mamas seguido do aparecimento de pelos pubianos havia um ano. Não havia história familiar semelhante e outros antecedentes significativos. Ao exame físico, foram verificados: peso = 22 kg (escore Z = +1 para a idade); altura = 122,5 cm (escore +1<Z<+2 para a idade); sem achados morfológicos significativos; Tanner: M3P1. Os exames complementares apresentaram os seguintes resultados: LH 3 mU/mL (VR < 1,3); FSH 7mU/mL (VR = 0,11 a 1,6); estradiol 80 mU/mL (VR = 0 a 46); US pélvica: útero de volume normal, com linha endometrial e ovários aumentados de volume; idade óssea: 8 anos. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. Cerca de 80% dos casos como o da criança em questão são de origem idiopática, devido ao amadurecimento precoce do eixo hipófise-hipotálamo-gônadas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266468)

Enunciado: A ginecologia infanto-puberal é a área de estudo que abrange os cuidados do sistema reprodutor feminino, desde o nascimento até a puberdade. Essa área abarca, por exemplo, distúrbios de diferenciação sexual, sinequias, corrimentos e traumas genitais. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. No tratamento inicial da sinequia de pequenos lábios, deve-se indicar cremes de estrogênio tópico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291519)

Enunciado: Uma lactente de 13 meses de idade, de sexo feminino, é levada à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. A mãe está preocupada, pois a criança ainda não é capaz de andar sem apoio. Não há outras queixas. O pré-natal materno não possui intercorrências; nasceu de parto normal, com 40 semanas de idade gestacional; Boletim de Apgar no 1º. minuto = 6; no 5º. minuto = 9; e no 10º. minuto = 10; com peso ao nascer = 3 200 g e comprimento ao nascer = 50 cm. No exame clínico neonatal, observou-se estalido à manobra de Ortolani à direita; na ocasião, realizou exame ultrassonográfico de quadril apresentando resultado I pelo método de Graf. Recebeu alta no segundo dia de vida. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Desenvolvimento neuropsicomotor prévio: sorriso social aos 2 meses; fixou o pescoço aos três meses; sentou sem apoio aos sete meses; passou a distinguir familiares de estranhos e a reconhecer seu nome aos nove meses; primeiras palavras com significado aos 11 meses. Atualmente engatinha, fica em pé com apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio, mas logo cai; usa copo com ajuda, compreende ordens simples, bate palma, manda beijo, fala "mama" e "papa" para referir-se à mãe e ao pai respectivamente. Não apresenta alterações ao exame clínico. A conduta adequada para essa criança, considerando o desenvolvimento da marcha é

A) manter acompanhamento de rotina.

B) encaminhar para fisioterapia motora para membros inferiores.

C) encaminhar ao neurologista devido à anoxia perinatal.

D) encaminhar ao ortopedista por suspeita de displasia congênita do quadril.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266469)

Enunciado: A ginecologia infanto-puberal é a área de estudo que abrange os cuidados do sistema reprodutor feminino, desde o nascimento até a puberdade. Essa área abarca, por exemplo, distúrbios de diferenciação sexual, sinequias, corrimentos e traumas genitais. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. A puberdade precoce, que se manifesta por meio do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes dos oito anos de idade, pode ser dividida em puberdade precoce verdadeira - até 80% dos casos - ou pseudopuberdade precoce - cerca 20% dos casos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266471)

Enunciado: A ginecologia infanto-puberal é a área de estudo que abrange os cuidados do sistema reprodutor feminino, desde o nascimento até a puberdade. Essa área abarca, por exemplo, distúrbios de diferenciação sexual, sinequias, corrimentos e traumas genitais. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. No processo de investigação do tipo de puberdade tardia - a qual pode ser dividida em hipogonadismo hipogonadotrófico, hipogonadismo hipergonadotrófico e atraso constitucional do desenvolvimento puberal -, além de anamnese e de exames físicos, são necessárias dosagens hormonais e realização de exames de imagem para elucidação diagnóstica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263404)

Enunciado: Um lactente com 1 mês de vida, nascido a termo de parto normal sem intercorrências, em aleitamento materno exclusivo, retornou à Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura. A mãe começou a apresentar febre (temperatura axilar = 38ºC) há 2 dias e encontra-se em bom estado geral. Apresenta dor, calor, edema e rubor em quadrante superior esquerdo da mama direita, sendo indicado tratamento domiciliar com cefalexina e ibuprofeno. Nesse caso, o aleitamento materno deverá

A) ser mantido em ambas as mamas como parte da terapêutica materna.

B) ser mantido, oferecendo somente a mama esquerda e preservando a mama afetada.

C) ser suspenso pelo risco de contaminação do lactente pelas bactérias presentes no leite.

D) ser suspenso devido ao uso materno de medicamentos incompatíveis com a amamentação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266498)

Enunciado: Alice, com 16 anos de idade, questionou, durante consulta médica, sobre a possibilidade de colocar um DIU na UBS, pois tivera relação sexual desprotegida havia cerca de quatro dias. Ao médico ela relatou que a sua última menstruação havia ocorrido 15 dias atrás e que o seu ciclo menstrual era irregular, de 20 a 28 dias, com 7 dias de fluxo normal, sem cólicas. Tendo como referência esse caso clínico hipotético, julgue o item subsecutivo. Um termo de consentimento para a inserção do DIU em Alice, que é menor de idade, deve ser necessariamente assinado pela paciente e por seu responsável legal maior de idade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244485)

Enunciado: Determinada mulher leva o respectivo filho de 2 anos de idade para consulta ao pediatra. Queixa-se de que acha seu filho diferente das outras crianças, dizendo que ele tem um comportamento estranho. A criança apresenta grande dificuldade para se alimentar, sendo bastante seletivo. Tem comportamento muitas vezes agitado e ainda não fala. Com base na avaliação clínica feita pelo pediatra, suspeita-se de transtorno do espectro autista. Tendo em vista o caso clínico descrito, assinale a alternativa correspondente aos sinais clínicos que podem, em conjunto, estar relacionados a esse diagnóstico.

A) Ser afetuoso com os pais; gostar de carinhos; correr bem sem apoio.

B) Ter movimentos estereotipados ao brincar; pode dar gritos; preferir contato com figuras humanas que objetos; pedir ajuda para empilhar blocos.

C) Tender a ordenar objetos de forma sistemática; não dar ""tchau"" ou mandar beijo; dificilmente expressar afeto.

D) Estabelecer pouco contato visual; ser muito apegado à mãe; preferir brincar com cuidador habitual que sozinho.

E) Responder bem quando é chamado; ser agitado; ter dificuldade de se concentrar em atividades dirigidas, mas ficar quieto quando tem grande interesse.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227411)

Enunciado: Uma menina de sete anos de idade foi levada a um pediatra porque a mãe havia observado aumento das mamas da criança seguido pelo aparecimento de pilificação pubiana, fatos esses ocorridos nos últimos 3 meses anteriores à consulta. Não havia relato de metrorragia. A menina pesava 25 kg (Z Score +1) e media 125 cm (Z Score +1). No exame físico, o médico observou aumento da aréola e da papila, sem separação do contorno da mama, e pelugem fina, longa e pouco escura na linha central da região pubiana. O restante do exame físico somático e o exame neurológico resultaram normais. O valor do nível de LH após estímulo com GnRH foi de 6 UI/L. Com base nesse caso clínico, julgue o item que se segue. É indispensável que a menina realize exames de raios X das mãos e dos punhos, para avaliação da sua idade óssea, ultrassonografia pélvica, para avaliação do tamanho do seu útero e de sua espessura endometrial, além de ressonância magnética do sistema nervoso central, para afastar o diagnóstico de lesões tumorais ou malformações.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227412)

Enunciado: Uma menina de sete anos de idade foi levada a um pediatra porque a mãe havia observado aumento das mamas da criança seguido pelo aparecimento de pilificação pubiana, fatos esses ocorridos nos últimos 3 meses anteriores à consulta. Não havia relato de metrorragia. A menina pesava 25 kg (Z Score +1) e media 125 cm (Z Score +1). No exame físico, o médico observou aumento da aréola e da papila, sem separação do contorno da mama, e pelugem fina, longa e pouco escura na linha central da região pubiana. O restante do exame físico somático e o exame neurológico resultaram normais. O valor do nível de LH após estímulo com GnRH foi de 6 UI/L. Com base nesse caso clínico, julgue o item que se segue. O tratamento mais indicado ao caso é a administração de agonistas de longa ação do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), com o objetivo de suprimir a produção de gonadotrofinas hipofisárias e de esteroides sexuais, para, assim, promover-se a regressão dos caracteres sexuais secundários e diminuir a velocidade de crescimento e progressão da idade óssea.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227413)

Enunciado: Uma menina de sete anos de idade foi levada a um pediatra porque a mãe havia observado aumento das mamas da criança seguido pelo aparecimento de pilificação pubiana, fatos esses ocorridos nos últimos 3 meses anteriores à consulta. Não havia relato de metrorragia. A menina pesava 25 kg (Z Score +1) e media 125 cm (Z Score +1). No exame físico, o médico observou aumento da aréola e da papila, sem separação do contorno da mama, e pelugem fina, longa e pouco escura na linha central da região pubiana. O restante do exame físico somático e o exame neurológico resultaram normais. O valor do nível de LH após estímulo com GnRH foi de 6 UI/L. Com base nesse caso clínico, julgue o item que se segue. Nessa criança, o estagiamento do desenvolvimento puberal segundo Tanner é M4P3.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227414)

Enunciado: Uma menina de sete anos de idade foi levada a um pediatra porque a mãe havia observado aumento das mamas da criança seguido pelo aparecimento de pilificação pubiana, fatos esses ocorridos nos últimos 3 meses anteriores à consulta. Não havia relato de metrorragia. A menina pesava 25 kg (Z Score +1) e media 125 cm (Z Score +1). No exame físico, o médico observou aumento da aréola e da papila, sem separação do contorno da mama, e pelugem fina, longa e pouco escura na linha central da região pubiana. O restante do exame físico somático e o exame neurológico resultaram normais. O valor do nível de LH após estímulo com GnRH foi de 6 UI/L. Com base nesse caso clínico, julgue o item que se segue. O diagnóstico clínico é de puberdade precoce central.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230599)

Enunciado: A ginecomastia é a proliferação benigna mais comum do tecido glandular da mama masculina, causada pela alteração do equilíbrio entre as concentrações de estrógeno e androgênios. Pela Classificação de Simon, a mama que apresenta aumento mamário moderado com redundância de pele definida, similar a mama feminina corresponde ao grau:

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206173)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA sobre a Puberdade Precoce (PP):

A) Tumor ovariano é a causa mais comum de PP em meninas.

B) Telarca é o marco inicial da PP Central (Dependente de Gonadotrofinas) em meninas.

C) Pacientes com telarca precoce habitualmente cursam com atraso na idade óssea.

D) Em meninos com PP central, há predomínio da forma idiopática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203154)

Enunciado: Os pais levam a filha de 8 meses de idade a uma consulta de rotina de puericultura. A criança é nascida a termo, de 40 semanas de gestação, com peso e comprimento ao nascimento adequados para idade gestacional e previamente hígida. Durante a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, os pais questionam se o desenvolvimento da menina está dentro do normal para a idade. Acerca desse caso clínico, é correto afirmar que o desenvolvimento neuropsicomotor dessa paciente está adequado se ela apresentar as seguintes características:

A) brinca de esconde-achou, produz "jargão", imita gestos e senta-se sem apoio.

B) Transfere objetos de uma mão para outra, produz "jargão", duplica sílabas e senta-se sem apoio.

C) Brinca de esconde-achou, transfere objetos de uma mão para outra, duplica sílabas e senta-se sem apoio.

D) Transfere objetos de uma mão para outra, faz pinça, imita objetos e duplica sílabas.

E) Brinca de esconde-achou, transfere objetos de uma mão para outra, "produz jargão" e imita gestos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206164)

Enunciado: No hipogonadismo hipogonadotrófico, encontramos:

A) Atraso puberal por deficiência primária das gônodas.

B) Atraso puberal na Síndrome de Turnner.

C) Atraso puberal por deficiência hipofisária ou hipotalâmica.

D) Atraso puberal na Síndrome de Klinefelter.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203075)

Enunciado: Em relação aos princípios éticos em uma consulta de hebiatria, assinale a alternativa correta.

A) O adolescente de 10 anos a 14 anos de idade frequentemente ainda não tem a capacidade de assumir todas as responsabilidades, porém pode ser visto sozinho durante toda a consulta, desde que conste em prontuário tal informação.

B) O adolescente terá autonomia para dar assentimento à assistência ou recusá-la, mesmo à revelia dos pais, caso isso conste em prontuário, exceto em situações consideradas de risco.

C) O termo de assentimento é recomendado para adolescentes que têm a capacidade de tomar decisões com relação à vida futura.

D) O termo de consentimento é fornecido para adolescentes que têm a capacidade de tomar decisões a respeito da própria vida futura.

E) O adolescente terá autonomia para dar assentimento à assistência ou recusá-la, mesmo à revelia dos pais, caso isso conste em prontuário, independentemente do tipo de assistência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203063)

Enunciado: Uma paciente de 9 anos de idade é levada ao consultório pela mãe para avaliação, já que a mãe se apresentava muito preocupada em razão do surgimento de broto mamário e pilificação pubiana da filha, que ainda não apresentou menarca. Ao exame físico, apresenta estatura no percentil 75 para a idade, mamas no estágio M2 de Tanner e pilificação no estágio P3. Quanto a esse caso clínico, assinale a alternativa que indica a conduta a ser tomada pelo médico assistente.

A) Orientar a paciente e a respectiva mãe de que se trata de quadro de puberdade fisiológica, e não há necessidade de realizar, no momento, investigação com dosagem hormonal sérica.

B) Avaliar a idade óssea com raio X da mão direita para definição da compatibilidade da idade óssea e puberal.

C) Iniciar agonista de GnRh para evitar a continuação do desenvolvimento puberal no momento, tendo em vista que se trata de puberdade precoce.

D) Realizar o rastreio de condições clínicas que cursam com hirsutismo, como síndrome dos ovários policísticos e hiperplasia adrenal congênita.

E) Solicitar ecografia mamária para exclusão de ginecomastia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212034)

Enunciado: Para consulta de rotina, uma mãe levou ao pediatra seus filhos: Mariana, de 7 anos de idade, e João, de 11 anos de idade. No exame físico, de acordo com os critérios de Tanner: Mariana - M2P2; e João - G1P1. Considerando essas informações e os vários aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. De acordo com os critérios de Tanner, Mariana apresenta telarca precoce.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212124)

Enunciado: Para consulta de rotina, uma mãe levou ao pediatra seus filhos: Mariana, de 7 anos de idade, e João, de 11 anos de idade. No exame físico, de acordo com os critérios de Tanner: Mariana - M2P2; e João - G1P1. Considerando essas informações e os vários aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. Segundo os critérios de Tanner, João está com atraso puberal.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212127)

Enunciado: Para consulta de rotina, uma mãe levou ao pediatra seus filhos: Mariana, de 7 anos de idade, e João, de 11 anos de idade. No exame físico, de acordo com os critérios de Tanner: Mariana - M2P2; e João - G1P1. Considerando essas informações e os vários aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. O marco biológico do início da puberdade no menino é, o aumento testicular, que corresponde a G2 dos critérios de Tanner.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212019)

Enunciado: Para consulta de rotina, uma mãe levou ao pediatra seus filhos: Mariana, de 7 anos de idade, e João, de 11 anos de idade. No exame físico, de acordo com os critérios de Tanner: Mariana - M2P2; e João - G1P1. Considerando essas informações e os vários aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. É esperado que a menarca da Mariana ocorra entre dois, e dois ano e meio a partir da telarca.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212028)

Enunciado: Para consulta de rotina, uma mãe levou ao pediatra seus filhos: Mariana, de 7 anos de idade, e João, de 11 anos de idade. No exame físico, de acordo com os critérios de Tanner: Mariana - M2P2; e João - G1P1. Considerando essas informações e os vários aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. Verifica-se o estirão puberal nas fases iniciais da puberdade: no sexo masculino, ocorre no estágio G2; no sexo feminino, no estágio M3 e M4 das mamas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175101)

Enunciado: A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a alimentação e a suplementação vitamínica em crianças seja:

A) Vitamina D 400 UI/dia e Ferro 1 mg/Kg dia, desde o nascimento até os seis meses de vida, para crianças em aleitamento materno exclusivo.

B) Vitamina D 600 UI/dia e Ferro 2 mg/Kg dia para crianças com seis meses de vida que se alimentem com aleitamento materno, duas papas de frutas/dia e duas papas salgadas/dia.

C) Vitamina D 600 UI/dia e Ferro elementar 1 mg/Kg dia para crianças com 13 meses que estejam recebendo aleitamento materno, duas papas de frutas/dia e duas refeições salgadas/dia.

D) Viamina D 400 UI/dia e Ferro elementar 1 mg/Kg dia para crianças com 18 meses que recebem aleitamento materno, duas papas de frutas/dia e duas refeições salgadas/dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177225)

Enunciado: Uma paciente puérpera, no quinto dia após o parto vaginal, começa a apresentar lesões vesiculares peribucais. O filho da paciente é saudável e não apresenta lesões.

Considerando-se o mencionado caso hipotético e os conhecimentos médicos relacionados a ele, é correto afirmar que a conduta recomendada é

A) suspender o aleitamento materno, isolando o recém-nascido da mãe até a melhora das lesões.

B) suspender o aleitamento materno e utilizar fórmula.

C) manter o aleitamento materno e iniciar tratamento com aciclovir.

D) manter o aleitamento materno.

E) suspender o aleitamento materno, isolando o recém nascido da mãe e iniciando tratamento com aciclovir tópico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175102)

Enunciado: O crescimento e desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida devem ser monitorados com rigor para o reconhecimento de patologias de risco. Deve-se esperar que no

A) primeiro semestre de vida, o lactente deva crescer 10 cm.

B) segundo trimestre de vida, o lactente deva ganhar 15g/dia.

C) quinto mês de vida, o seu peso será o triplo do peso do seu nascimento.

D) primeiro mês de vida, o perímetro cefálico deva crescer 0,5 cm/semana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175103)

Enunciado: As crianças vão ganhando aptidões ao longo dos seus dias de vida devido ao desenvolvimento neuropssicomotor, que quando adequado

A) a criança anda com apoio a partir do oitavo mês.

B) a criança transfere objetos de uma mão para outra, desde o quinto mês de vida.

C) a criança senta-se sem apoio a partir do sexto mês de vida.

D) a criança segura objetos a partir do sexto mês de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183877)

Enunciado: O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança é fundamental como medida de medicina preventiva. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item que se segue. A presença bilateral do reflexo ou sinal de Babinski em um bebê de dezessete meses de idade pode ser considerada normal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183881)

Enunciado: O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança é fundamental como medida de medicina preventiva. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item que se segue. Um escore Z "maior que" 0 indica que o valor da medida do indivíduo é maior que a média da população de referência.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183884)

Enunciado: O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança é fundamental como medida de medicina preventiva. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item que se segue. O hormônio de crescimento atua diretamente sobre a síntese dos condroblastos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183914)

Enunciado: Tendo como referência as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e da Rede Cegonha, julgue o item seguinte. Para a segurança do recém-nascido, caso a mãe seja diagnosticada com tuberculose pulmonar bacilífera, a amamentação deve ser interrompida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183919)

Enunciado: Tendo como referência as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e da Rede Cegonha, julgue o item seguinte. Não há restrição à amamentação por portadora de doenças de Chagas na fase aguda.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183925)

Enunciado: Tendo como referência as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e da Rede Cegonha, julgue o item seguinte. A vacinação contra hepatite B e a administração de imunoglobulina específica (IGHAHB) à mãe após o parto não eliminam o risco de transmissão da doença via leite materno.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183929)

Enunciado: Tendo como referência as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e da Rede Cegonha, julgue o item seguinte. Mãe que tenha contraído dengue e que apresente quadro de diarreia e vômito deverá interromper a amamentação, por causa do distúrbio metabólico habitualmente presente e do risco de transmissão vertical.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183955)

Enunciado: A respeito do crescimento e do desenvolvimento infantil e de seus impactos na saúde da criança, julgue o item a seguir. Padrões de comportamento alimentar devem ser implantados a partir dos seis meses de idade, priorizando-se hábitos alimentares saudáveis, o que poderá determinar a prevenção de doenças relacionadas à má alimentação, como sobrepeso, obesidade e diabetes.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183959)

Enunciado: A respeito do crescimento e do desenvolvimento infantil e de seus impactos na saúde da criança, julgue o item a seguir. A nutrição inequada nos primeiros dois anos de vida compromete irreversivelmente o crescimento e o desenvolvimento da criança.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157998)

Enunciado: Mãe deseja saber a respeito da altura final que o filho dela, de 12 anos de idade, poderá ter. Sabendo-se que a estatura da mãe é de 1,69 m. e a do pai de 1,86 m. a provável altura do adolescente, quando adulto, será de, aproximadamente:

A) 178 cm.

B) 180 cm.

C) 184 cm.

D) 186 cm.

E) 189 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154482)

Enunciado: A respeito do crescimento e desenvolvimento físico da criança no primeiro ano de vida, é possível afirmar que:

A) A criança alcança o dobro do peso de nascimento por volta de 6 meses e o comprimento aumenta em 50%.

B) Entre 3 e 4 meses, o ganho ponderal esperado é de 20 g/dia e o peso está em torno do dobro do peso de nascimento.

C) Ao final do primeiro ano de vida, o peso de nascimento encontra- se triplicado e o perímetro cefálico com um aumento de 15 cm.

D) Aos 12 meses, a circunferência cefálica apresenta um aumento de 50% em relação a medida do nascimento.

E) Lactentes de termo têm até a primeira semana de vida para recuperar o peso de nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154494)

Enunciado: Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, o pediatra deve estar atento se seu paciente aos 7 meses é capaz de:

A) Transferir objetos entre as mãos.

B) Dizer palavras como "mama" e "papa".

C) Segurar objetos entre o polegar e o indicador.

D) Responder quando é chamado pelo nome.

E) Apresentar pensamento simbólico como fingir beber chá em uma xícara.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168444)

Enunciado: Uma criança do sexo feminino de 2 anos de idade é atendida por pediatra em decorrência de aumento de mamas. A mãe da menor relata que vem notando que as mamas da criança vem crescendo progressivamente no último ano, de forma flutuante, ou seja, ora parecem aumentar, ora parecem reduzir de tamanho. A mãe nega surgimento de pelos pubianos, odor axilar ou surgimento de menstruação. Nega doenças prévias. Ao exame, a criança mostra-se em bom estado geral, corada, hidratada, com broto mamário aumentado de tamanho, (escala M2 de Tanner), sem evidência de pilificação em regiões axilar e pubiana, com mucosa rosada na genitália e pele sem manchas. De acordo com o quadro clínico descrito, o exame complementar a ser solicitado é:

A) Tomografia de abdome.

B) Cariótipo com bandas G.

C) Radiografia de punhos.

D) Dosagem de LH/FSH.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159536)

Enunciado: O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a propósito da fisiopatologia, do diagnóstico precoce e do tratamento de doenças em crianças e adolescentes. Um recém-nascido foi diagnosticado com síndrome de Beckwith-Wiedemann. Nesse caso, ele deverá ser submetido ao rastreamento ultrassonografico de abdome a cada três meses até completar oito anos de idade e a dosagem sérica de alfafetoproteína a cada três meses até os quatro anos de idade, para detecção precoce de hepatoblastoma e tumor de Wilms, para os quais o recém-nascido apresenta predisposição.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159593)

Enunciado: Um lactente de dois meses de idade foi levado ao médico por sua mãe para uma consulta de rotina. A mãe referiu que nunca havia amamentado no peito e que atualmente o lactente era alimentado com leite de vaca in natura integral e açúcar, em doses de 150 mL cinco vezes ao dia, e água nos intervalos. O médico observou ainda, no cartão da criança, que o lactente havia recebido a primeira dose da vacina contra hepatite B e o BCG intradérmico. No que se refere a esse caso clínico, julgue o item subsecutivo. Esse lactente está sendo alimentado erroneamente, pois, além de não estar recebendo leite materno, ele deveria estar sendo alimentado, na impossibilidade do uso de fórmula infantil, com leite de vaca in natura integral e óleo vegetal a 6%, 180 mL dez vezes ao dia, e água nos intervalos.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159619)

Enunciado: Com relação a aspectos técnicos e éticos do planejamento familiar, julgue o próximo item. Caso uma adolescente de dezesseis anos de idade, hígida, solicite receita médica de contraceptivo oral, o médico poderá realizar essa prescrição, mesmo que não haja o consentimento dos pais da paciente.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133991)

Enunciado: Criança de 1 ano de idade, nascida de parto vaginal, a termo, de gestação sem intercorrências, apresenta peso ao nascimento de 3.000 g, estatura de nascimento de 50 cm e perímetro cefálico de 35 cm. No momento, possui as medidas antropométricas de peso igual a 9.500 g, estatura de 78 cm e perímetro cefálico de 48 cm. Considerando essa situação hipotética, de acordo com a progressão de peso, estatura e perímetro cefálico, é CORRETO afirmar que se trata de criança com:

A) Baixo ganho de peso, mas com crescimento estatural e de perímetro cefálico esperados para o primeiro ano de vida.

B) Bom ganho de peso e crescimento estatural esperado para o primeiro ano de vida, mas com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade.

C) Bom ganho de peso e crescimento estrutural e de perímetro cefálico esperados para o primeiro ano de vida.

D) Baixo ganho de peso, pouco crescimento estatural e pouco aumento de perímetro cefálico esperados para o primeiro ano de vida.

E) Baixo ganho de peso, pouco crescimento estatural, mas com perímetro cefálico esperado para o primeiro ano de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133941)

Enunciado: Criança de 2 anos de idade é levada à consulta de puericultura, com queixa de palidez e seletividade alimentar. Traz hemograma de rotina com hemoglobina de 10,3 g/dL. Considerando essa situação hipotética, em relação à anemia ferropriva na infância, assinale a alternativa correta.

A) A criança não possui anemia ferropriva, já que a faixa etária de 2 anos de idade, somente é considerado anemia uma hemoglobina menor de 10 g/dL.

B) Essa anemia caracteriza-se por ferritina e ferro séricos baixos, microcitose, hipocromia, anisocitose e reticulócitos aumentados.

C) Deve-se ser realizado a reposição de ferro elementar na dose de 3-6 mg/Kg/dia até oito semanas após a normalização da hemoglobina.

D) Essa anemia não dever ser tratada em crianças menores de 2 anos de idade, e sim deve-se ofertar maior carga de alimentos ricos em ferro.

E) Na tentativa de reduzir o risco dessa anemia dos lactentes a termo, AIG e em aleitamento materno exclusivo, a profilaxia com uso de ferro oral deve ser realizada desde o nascimento, com dose de 1 mg/Kg/dia de ferro elementar, até os 2 anos de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129076)

Enunciado: No que diz respeito ao tema "alimentação saudável", assinale a alternativa CORRETA:

A) Gordura trans e gordura vegetal hidrogenada são semelhantes, pois o fato de não haver gordura trans na tabela nutricional não impede que o produto contenha gordura vegetal hidrogenada.

B) Além de verificar na tabela nutricional, outra maneira de perceber a quantidade de sódio no alimento é o gosto salgado, pois, proporcionalmente à sua quantidade, o produto ficará salgado.

C) A substituição do sal por orégano, salsa e manjericão não deve ser incentivada, pois essas ervas ocasionam outros tipos de danos à saúde, às vezes até piores que os ocasionados pelo sal.

D) A tabela nutricional, obrigatória nos alimentos processados, contém a quantidade de nutrientes em ordem crescente de concentração.

E) Alimento diet e (ou) light é a melhor opção, pois sempre é menos calórico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129061)

Enunciado: O Ministério da Saúde recomenda que alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta exemplo de alimento ultraprocessado que deve ser evitado:

A) Milho em conserva.

B) Pêssego em calda.

C) Leite longa vida.

D) Barrinha de cereais.

E) Carne de gado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104774)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA de alimentação saudável para crianças menores de dois anos de idade:

A) Administrar vitamina D aos lactentes que não são amamentados ao seio materno.

B) Estimular o consumo de leite de vaca e seus derivados no segundo ano de vida.

C) A alimentação comum da família só deve ser ofertada à criança após os dois anos de idade.

D) Lactentes e crianças jovens não têm capacidade de autorregular a ingestão calórica, por isso não emitem sinais de saciedade, devendo a alimentação ter quantidades estabelecidas.

E) A administração de vitamina A, na forma de megadoses, somente deve ser realizada com a comprovação laboratorial de sua hipovitaminose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111313)

Enunciado: As características do desenvolvimento puberal ocorrem na seguinte ordem:

A) Pubarca, velocidade máxima de crescimento telarca, menarca.

B) Velocidade do crescimento máximo, pubarca, telarca e menarca.

C) Telarca, menarca, pubarca, velocidade máxima de crescimento.

D) Telarca, pubarca, velocidade máxima de crescimento, menarca.

E) Pubarca, telarca, menarca, velocidade máxima de crescimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111358)

Enunciado: Uma criança do sexo feminino, de 11 meses de idade, é levada ao pediatra por falta de apetite e palidez. História de prematuridade e aleitamento materno exclusivo até os 2 meses de idade, sendo então introduzido leite de vaca. Sem icterícia neonatal. Hemograma: hemoglobina = 7,1 g/dl; hematócrito = 21%; VCM = 55 fl; reticulócitos = 0.5%; leucócitos = 6000/mm³; plaquetas 700.000/mm³. Assinale a hipótese diagnóstica mais provável e os exames necessários para a confirmação:

A) Esferocitose - fragilidade osmótica.

B) Anemia ferropriva - eletroforese de hemoglobina.

C) Talassemia - dosagem de hemoglobina fetal.

D) Deficiência de G6PD - dosagem de G6PD.

E) Anemia ferropriva - dosagem de ferro sérico e ferritina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111314)

Enunciado: A puberdade no sexo masculino é iniciada por:

A) Surgimento de pelos pubianos.

B) Surgimento de pelos axilares.

C) Crescimento do pênis.

D) Crescimento do testículo.

E) Estirão do crescimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111325)

Enunciado: Menino com 2 meses de idade é levado à uma Unidade Básica de Saúde, pois a mãe está muito preocupada com o aumento de suas mamas. Ao examiná-lo, o médico detecta tecido mamário hipertrofiado, com mamas com diâmetro de cerca de 2,5 cm. O médico deve orientar:

A) Observação, pois a ginecomastia é transitória e decorrente de estimulação pelos hormônios maternos.

B) Observação, pois a ginecomastia é um achado raro, porém benigno em lactentes, tornandose problema estético se persistir até a idade escolar.

C) Realização de ultrassonografia.

D) Retirada cirúrgica, pois se trata de criança do sexo masculino, com possibilidade elevada de tumor de comportamento maligno.

E) Realização de dosagem de prolactina e estrógeno, para investigar a presença de tumor produtor de um desses hormônios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111336)

Enunciado: A estatura-alvo (tendência de crescimento) de um menino filho de um pai com 168 cm de estatura e de uma mãe com 155 cm é:

A) 155,0 cm.

B) 161,5 cm.

C) 164,5 cm.

D) 168,0 cm.

E) 169,5 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111284)

Enunciado: Criança escolar, 8 anos, com suspeita de Baixa Estatura Familiar (BEF). O que esperar, para esse diagnóstico, da radiografia de punho e mão esquerda para idade óssea (IO)?

A) IO igual à idade altura.

B) IO maior que a idade cronológica.

C) IO igual à idade cronológica.

D) IO menor que a idade cronológica.

E) IO igual à idade peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97734)

Enunciado: Puérpera no quinto dia após o parto normal, retorna à Unidade Básica de Saúde para reavaliação. Na consulta, paciente e recém-nascido apresentam-se em bom estado geral. No exame físico materno, mamas ingurgitadas, dolorosas à palpação, edemaciadas, com saída de leite à expressão. No decorrer da consulta, a paciente queixa-se de que o bebê "chora muito" e acredita que seu leite é muito "fraco" para ele. A puérpera demonstra preocupação e dúvidas sobre os benefícios da amamentação. A conduta nessa situação deve ser:

A) Substituir o leite materno pelo leite artificial, para satisfação do bebê e melhora da ansiedade materna.

B) Encorajar a amamentação e orientar a expressão manual do leite, para evitar o ingurgitamento.

C) Suspender a amamentação pelo quadro clínico de mastite e prescrever antibióticos via oral.

D) Alternar o leite artificial com o leite materno, para a complementação nutricional do bebê.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80702)

Enunciado: Um bebê que nasceu a termo de parto normal, sem intercorrências, com 3,2 kg, e que durante os primeiros onze meses de vida sempre esteve no percentil 50 (p50) da curva de peso, é levado pela mãe para a consulta de puericultura de um ano de idade. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta o peso esperado do bebê.

A) 12,8 kg

B) 12 kg

C) 11,6 kg

D) 9,6 kg

E) 8 kg

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80709)

Enunciado: Um bebê que nasceu a termo de parto normal, sem intercorrências, com 3,2 kg, e que durante os primeiros onze meses de vida sempre esteve no percentil 50 (p50) da curva de peso, é levado pela mãe para a consulta de puericultura de um ano de idade. Considerando que o bebê nasceu com 50 cm e que durante os primeiros onze meses de vida sempre esteve no percentil 50 (p50) da curva de estatura, na consulta de puericultura de um ano de idade, estará com:

A) 65 cm.

B) 70 cm.

C) 75 cm.

D) 80 cm.

E) 90 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75524)

Enunciado: Primípara, no 5º dia pós-parto, procura a Unidade Básica de Saúde queixando-se de dor e inchaço nas mamas, com dificuldade para amamentar. Relata que seu filho chora constantemente e que ele é preguiçoso para sugar o leite. Ao exame físico apresenta mamas volumosas, brilhantes, endurecidas, doloridas, com calor local. As aréolas apresentam-se tensas e os mamilos planos. Com base nos dados clínicos apresentados, a conduta correta a ser orientada é:

A) manter o aleitamento exclusivo sob livre demanda;
corrigir a pega; aumentar a frequência das mamadas; realizar ordenha manual antes da mamada para diminuir a tensão da aréola; e recomendar uso de sutiã com alças que suspendam as mamas.

B) introduzir antibioticoterapia associada com analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais; administrar compressas frias nas mamas; e suspender a amamentação até que se garanta uma boa pega e ocorra melhora dos sinais flogísticos nas mamas.

C) suspender a amamentação até que se garanta uma boa pega e para que ocorra melhora dos sinais flogísticos nas mamas; administrar compressas mornas para reduzir os aglomerados de leite nos ductos; e realizar a ordenha manual.

D) suspender o aleitamento exclusivo até haver a melhora do processo inflamatório; administrar analgésicos e anti-inflamatórios; iniciar exercícios para correção dos mamilos planos; e realizar a ordenha manual.

E) introduzir antibioticoterapia; realizar compressas
mornas para reduzir os aglomerados de leite nos ductos; e manter o aleitamento exclusivo sob livre demanda, após correção da pega.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75474)

Enunciado: Estudante, com 9 anos de idade, vem apresentando dificuldades de aprendizagem e atos de indisciplina frequentes em relação aos professores, principalmente aos novos, que tiveram de ser substituídos por três vezes nos últimos dois meses, por problemas de saúde. A escola solicitou que a mãe procurasse um "neurologista" para o menino, esta levou a criança inicialmente ao pediatra, referindo que ele tinha boa índole, ajudava nas tarefas de casa e tomava conta do irmão com 5 anos. Notou que tem apresentado notas mais baixas e reclama muito dos professores ultimamente. Nega atos indisciplinares que não sejam próprios da idade. O menino não gosta de ficar na rua, costuma brincar em casa e jogar futebol no final de semana com os amigos e primos. Em casa não tem computador e a mãe acha que esse é o motivo do mau desempenho escolar. A criança perdeu o pai há um ano, vítima de atropelamento. Ao exame físico, o pediatra não encontrou alterações. Com base nessa narrativa, a suspeita clínica e a conduta do pediatra devem ser:

A) transtorno de distúrbio de comunicação (provavelmente linguagem); encaminhar para avaliação com o neurologista infantil.

B) déficit de atenção e hiperatividade; encaminhar para avaliação com o neurologista e com o psiquiatra infantil.

C) comportamento aceitável para a idade; avaliar melhor com seguimento e então decidir se encaminha ao psiquiatra infantil.

D) comportamento antissocial decorrente da perda familiar; encaminhar de imediato para avaliação com o psiquiatra infantil.

E) transtorno de conduta (comportamento desafiador opositor); encaminhar para avaliação com o psiquiatra infantil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75538)

Enunciado: Menino com 7 meses de idade é levado pela mãe a Unidade Básica de Saúde em consulta de Puericultura. A mãe está preocupada, pois acha que ele é mais lento que os irmãos. Após anamnese detalhada, o pediatra realizou o exame físico e afirmou que o exame neurológico e o desenvolvimento neuropsicomotor estavam condizentes com a idade. O que o pediatra observou em relação a linguagem, motricidade, comportamento adaptativo e reflexos arcaicos, respectivamente, para fazer tal afirmação?

A) Emissão espontânea sem intenção imitativa;
sustentação cefálica; dirige a mão para objetos; reflexo de Moro.

B) Emissão bissilábica significante; engatinha durante a consulta; preensão palmar em pinça; reflexo de Landau II.

C) Emissão espontânea sem intenção imitativa; senta-se com apoio; preensão palmar voluntária; reflexo de Moro incompleto.

D) Ecolalia; senta-se sem apoio; muda objeto de uma mão para outra; reflexo de preensão plantar.

E) Emissão de palavras-frase; capacidade de andar com apoio observada na consulta; bate palmas; reflexo do paraquedista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351606)

Enunciado: Acerca do aleitamento do lactente, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. ( ) O aleitamento exclusivo ao seio materno é preconizado até os 6 meses, não devendo ser complementado por alimentos sólidos, sendo recomendado apenas água filtrada entre as mamadas. ( ) O leite humano maduro conta soro/caseína otimizada, havendo predomínio da concentração lactoalbumina sobre a concentração de caseína, proporcionando melhor digestibilidade. ( ) Em casos em que o leite materno se apresente como insuficiente, fórmulas de primeiro semestre parcialmente hidrolisadas demonstram eficácia semelhante ao leite materno, no tocante à proteção imunológica. ( ) O aleitamento ao seio materno está expressamente contraindicado em casos em que de mãe acometida por hepatite B aguda ou cronificada. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

A) F ? V ? F ? F

B) V ? V ? F ? F

C) V ? V ? V ? F

D) F ? V ? F ? V

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351583)

Enunciado: À avaliação do desenvolvimento de uma criança que acabou de completar dois anos de nascimento, espera-se que a mesma

A) reconheça-se pelo nome, obedeça a ordens simples, repita frequentemente a palavra ?não?, ande com segurança e seja capaz de dar pequenas corridas

B) ande apenas com auxílio de apoio, reconheça-se pelo nome, realize muitos questionamentos e crie amigos imaginários.

C) use bem palavras no plural, tenha vocabulário de cerca de mil palavras, ande com segurança e seja capaz de saltar alternadamente sobre cada pé.

D) seja capaz de contar historinhas, entenda bem os conceitos de antes e depois, ande em linha reta com toda a superfície do pé e esteja apta a comer sozinha com uma colher.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

352159)

Enunciado: A mãe de uma bebê com 10 dias de vida, vem à primeira consulta com muitas dúvidas sobre a amamentação. Das informações que ela recebeu das pessoas que a estão apoiando nessa etapa, qual é a correta?

A) É recomendável que o bebê mame com regularidade, de 3 em 3 horas.

B) É importante que a criança esvazie a mama por completo, pois o leite do final da mamada contém mais calorias e sacia a criança.

C) A aréola deve ficar bem visível ao redor da boca do bebê e os ruídos feitos com a língua, durante a sucção, indicam uma boa pega.

D) Para o bebê abocanhar o tecido mamário de forma eficiente, a mãe pode auxiliar segurando a mama com os dedos em ""forma de tesoura"".

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351602)

Enunciado: O aleitamento materno é um processo que envolve interação profunda entre a mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo. Além de todos os benefícios para a criança, o aleitamento também pode trazer benefícios, cientificamente comprovados, à mãe que amamenta, sendo eles, EXCETO:

A) Proteção contra câncer de mama.

B) Redução do risco de diabetes tipo 1.

C) Diminuição do risco de recaída de esclerose múltipla pós-parto.

D) Proteção contra câncer de ovário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337634)

Enunciado: Além de alimentar a criança, o Aleitamento Materno (AM) protege mãe e criança contra algumas doenças e promove o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o bem-estar físico e psíquico da díade mãe-filho. Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa CORRETA:

A) Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é aquele que a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, além de água e bebidas à base de água (chás e infusões).

B) A mama na gravidez é preparada para a lactação sob a ação de diferentes hormônios, sendo os mais importantes a prolactina, que é responsável pela ramificação dos ductos lactíferos, e o progestagênio, responsável pela formação dos lóbulos.

C) O leite maduro só é secretado por volta do 15° dia pós-parto. Nos primeiros dias, a secreção láctea é chamada de colostro, que contém menos proteínas e lipídios do que o leite maduro, e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgA.

D) O tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser preestabelecido, pois o tempo necessário para esvaziar uma mama varia entre os bebês e, em uma mesma criança, pode variar dependendo da fome, do intervalo transcorrido desde a última mamada e do volume de leite armazenado na mama, entre outros fatores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321174)

Enunciado: M.C.D. 10 anos, comparece à consulta acompanhada do pai que se mostrava preocupado com o desenvolvimento de características sexuais na filha de forma precoce, mas relatou ausência da menarca. Exame físico evidenciou M4 P3 segundo critérios de Tanner. Sobre a puberdade precoce, é CORRETO afirmar que:

A) A puberdade precoce central é, na grande maioria dos casos, de origem idiopática, não possuindo também influência genética no seu desencadeamento.

B) A puberdade precoce pode ser de origem central, independente das gonadotrofinas, ou periférica, dependente das gonadotrofinas.

C) A dosagem de LH basal, a radiografia de punho e mão não dominantes para avaliação da idade óssea, e a ultrassonografia pélvica para avaliação do volume ovariano e uterino, são exames indicados para complementar a avaliação em meninas.

D) No caso em questão deve-se tranquilizar o pai quanto a possibilidade de puberdade precoce, uma vez que para meninas ela ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece, antes dos 9 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320438)

Enunciado: Mãe de lactente de quatro meses em aleitamento materno exclusivo, procura orientação porque volta a trabalhar em 15 dias. A orientação adequada é que a mãe retire seu leite e armazene em frascos de vidro com tampa plástica na geladeira:

A) Por até 1 horas ou congelador/freezer por até três semanas; oferecer preferencialmente por copinho.

B) Por até duas horas ou congelador/freezer por até 12 horas; oferecer preferencialmente por copinho.

C) Por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por copinho.

D) Por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira.

E) Por até 24 horas ou congelador/freezer por até quatro semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320440)

Enunciado: Primípara procura o posto de saúde porque está apresentando ?dor no bico do peito? ao amamentar, desde a segunda semana pós-parto. No exame da mama, o pediatra identifica fissura mamilar. A conduta mais importante neste caso é:

A) avaliar a mamada e corrigir a técnica de amamentar.

B) amamentar em diferentes posições.

C) passar o próprio leite nos mamilos após as mamadas e secar ao ar livre.

D) usar, na aréola e nos mamilos, produtos (cremes ou pomadas) cicatrizantes.

E) expor as mamas ao sol 4x ao dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336279)

Enunciado: Menino, 5 anos, chega ao ambulatório com queixa principal de aumento peniano há 1 ano associado ao rápido crescimento de pêlos pubianos e voz grossa. História patológica pregressa de investigação de vômitos esporádicos desde os 2 anos de idade com o gastropediatra sendo descartado refluxo gastro-esofágico. História familiar negativa para casos semelhantes a sua queixa atual. Exame físico: peso 20,5 kg altura 117 cm , testículos de 6 cm3 cada, consistência fibroelástica, contornos regulares, ausência de sinais flogísticos. Pênis 8 cm (maior que P 95 para tamanho de pênis para idade). Tanner G3P3. A principal hipótese diagnóstica é:

A) Puberdade precoce central idiopática, já que apresenta todos os carácteres sexuais desenvolvidos e este representa o principal diagnóstico de puberdade precoce entre os acometidos do sexo masculino.

B) Tumor de sistema nervoso central com secreção de GnRH.

C) Neurofibromatose tipo 1, que a criança ainda não apresentou neurofibromas devido a sua pouca idade.

D) Hiperplasia suprarrenal congênita forma clássica perdedora de sal já que apresenta história de vômitos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334754)

Enunciado: O acompanhamento do peso, altura/comprimento e perímetro craniano, este nos 3 primeiros anos de vida, pode orientar o médico sobre as condições de saúde de seu paciente. No acompanhamento do crescimento é correto afirmar:

A) Se o recém-nascido apresenta um comprometimento só do peso, é maior a probabilidade de um agravo ter ocorrido nos meses finais da gestação.

B) Crianças nascidas com peso inferior a 3 kg são denominadas de baixo peso.

C) O crescimento intrauterino é predominantemente dependente do potencial genético da criança.

D) A criança cresce aproximadamente 45 cm e duplica de peso em torno do seu primeiro aniversário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334756)

Enunciado: O aleitamento materno é a primeira prática alimentar a ser recomendada para a promoção da saúde e adequado desenvolvimento infantil. No aleitamento materno é correto afirmar:

A) O leite materno tem mais caseína do que proteína do soro, o que leva a capacidade de provocar esvaziamento gástrico mais lento, deixando a criança mais saciada.

B) Em recém-nascidos pré-termos, o leite materno deve ser evitado devido ao risco aumentado de enterocolite necrosante.

C) A composição e aspecto do leite materno é bastante heterogêneo e varia com a alimentação, idade e raça da mãe.

D) O colostro contém mais proteínas e menos lipídios do que o leite maduro e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334759)

Enunciado: Na anemia ferropriva é correto afirmar:

A) São fatores de risco para anemia ferropriva crianças grandes para idade gestacional (GIG), ou com peso superior a 4 kg no nascimento, e lactente em crescimento lento.

B) São fatores de risco para anemia ferropriva o clampeamento do cordão umbilical após cinco minutos de vida.

C) Nos lactentes em aleitamento materno exclusivo, sem fatores de risco, recomenda-se a suplementação medicamentosa profilática a partir dos 180 dias de vida, até o final do segundo ano.

D) Em recém-nascidos prematuros (idade gestacional inferior a 39 semanas) ou com peso inferior a 2.500g, o início da suplementação de ferro deve ocorrer ao nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

335110)

Enunciado: As crianças frequentemente utilizam a linguagem não verbal para se comunicarem, por exemplo, por meio de irritabilidade, agressividade, regressão, dores em geral, queda no rendimento escolar. A esse respeito, analise os aspectos a seguir. I. Dificuldade específica de aprendizagem II. Maus-tratos físicos e / ou emocionais III. Negligência IV. Alto nível de estresse dos pais É(são) aspecto(s) que deve(m) ser investigado(s) diante de uma criança com essas manifestações

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

306705)

Enunciado: Além de alimentar a criança, o aleitamento materno protege mãe e criança contra algumas doenças e promove o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o bem-estar físico e psíquico da díade mãe- filho. Sobre o leite materno, assinale a alternativa CORRETA:

A) A água contribui com quase 90% da composição do leite materno, o que garante o suprimento das necessidades hídricas de uma criança em aleitamento materno exclusivo.

B) Nos primeiros dias de vida, a secreção láctea é chamada de colostro, que contém mais lipídeos e menos proteínas do que o leite maduro, e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgA.

C) A concentração de gordura no leite (e consequentemente o teor energético) reduz no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do início da mamada (leite anterior) é mais rico em energia e sacia melhor a criança.

D) Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente ativados pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5°C por 30 minutos) tem o mesmo valor biológico que o leite cru.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291930)

Enunciado: Em relação à ginecomastia, é INCORRETO afirmar que:

A) Não há diferenças quanto à responsividade do tecido mamário masculino e feminino ao estrogênio.

B) A maioria dos estrogênios circulantes no homem, deriva da conversão extra gonadal dos precursores de estrogênios pelos tecidos extra-gonadais como pele, fígado, tecido gorduroso e músculo.

C) Uma das maneiras de prevenir o desenvolvimento da ginecomastia é a administração de baixas doses de radioterapia naqueles pacientes que devem receber estrogênio devido ao câncer de próstata.

D) O percentual de ginecomastia induzida por drogas está em torno de 40-50% dos casos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291931)

Enunciado: Em relação à puberdade, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A puberdade é definida como o período durante o qual começam a se desenvolver as características sexuais secundárias e é obtida a capacidade de reprodução sexual.

B) O estadiamento proposto por Tunner & Marshall dos pelos pubianos, está relacionado à quantidade e à sua distribuição sendo que no estádio I não há pelos pubianos sexualmente estimulados presentes, na área genital.

C) A puberdade tardia existe em adolescentes do sexo feminino que não desenvolvem quaisquer características sexuais secundárias aos 13 anos, não tiveram menarca aos 16 anos ou nas quais se passaram 5 anos ou mais desde o início do desenvolvimento puberal ter tido a menarca.

D) A puberdade precoce é o desenvolvimento puberal que se inicia antes de 8 anos e pode ser caracterizado de várias formas como issosexual, heterossexual, verdadeira e hipotalâmica-hipofisária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291627)

Enunciado: A mãe de um lactente de 4 meses, em amamentação exclusiva, procura orientação porque vai voltar a trabalhar em 15 dias. A orientação adequada é que a mãe retire seu leite e armazene em frascos de vidro com tampa plástica na geladeira:

A) Por até duas horas na geladeira ou 12 h congelador; oferecer preferencialmente por copinho.

B) Por até 12 h no refrigerador e até duas semanas no congelador; oferecer preferencialmente no copinho.

C) Por até 48 horas no Refrigerador e duas semanas no congelador; preferencialmente por copinho.

D) Por até 12 horas refrigerador e duas semanas congelador; oferecer preferencialmente por mamadeira.

E) Por até 24 horas no refrigerador ou congelador por até quatro semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291937)

Enunciado: Paciente sexo feminino de 11 anos é trazida à consulta pediátrica pela avó materna devido à preocupação pela neta estar ?virando moça? muito rápido, embora ainda não havia menstruado. Ao exame físico, a paciente estava em M3 P4 segundo os critérios de Tanner. Sobre o caso descrito, é CORRETO que:

A) Após anamnese e exame físico completo, devemos tranquilizar a avó sobre a queixa trazida na consulta, uma vez que, por definição, a puberdade precoce ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos.

B) Deve-se dosar as gonadotrofinas, pois possivelmente se trata de um quadro de puberdade precoce central.

C) Deve-se dar à avó a possibilidade de intervenção farmacológica para o bloqueio hormonal da puberdade.

D) Embora a menarca, o primeiro marco da puberdade nas meninas, ainda não tenha ocorrido na paciente, o desenvolvimento não parece patológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

306721)

Enunciado: Lactente do sexo masculino, nascido prematuro com 28 semanas de idade gestacional, hoje, com 9 meses de idade, vem para consulta de puericultura. Na avaliação do desenvolvimento foram observados os seguintes marcos presentes: brinca de esconde-achou, rola no leito e leva objetos a boca. Você nota que a criança não se senta sem apoio, não transfere objetos de uma mão para a outra e não apresenta o movimento de pinça. O desenvolvimento deste lactente está:

A) atrasado para a idade cronológica e adequado para a idade corrigida pela prematuridade.

B) atrasado para a idade cronológica e idade corrigida pela prematuridade.

C) adequado para a idade cronológica e atrasado para a idade corrigida pela prematuridade.

D) adequado para a idade cronológica e idade corrigida pela prematuridade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291943)

Enunciado: A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o Aleitamento Materno (AM) por 2 anos ou mais, sendo esse de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Essa recomendação se deve a importância que o Leite Materno (LM) ter não apenas os aspectos nutricionais, mas também imunológicos e do desenvolvimento. Sobre a composiçao do LM, é CORRETO afirmar que:

A) Apesar de rico em nutrientes, a parcela do leite que corresponde a água é baixa, sendo assim importante para a lactante sempre complementar o aleitamento ofertando água para o neonato, de forma a manter a sua hidratação.

B) O teor energético do leite não se mantem fixo durante toda a mamada, sendo sua concentração de gorduras no leite posterior mais alto, o que torna muito importante a criança fazer um bom esvaziamento da mama, garantindo uma maior saciedade e energia.

C) O leite maduro só é secretado por volta do 10º dia pós-parto, sendo nos primeiros dias a secreção chamada colostro. São caracteristicas desse colostro concentrações menores de proteinas e maiores de gorduras, quando comparado ao leite maduro, e também seu alto teor de imunoglobulinas, principalmente a IgA.

D) O leite materno, embora rico em ferro, contém baixas concentrações das vitaminas K e D, o que faz com que a suplementação dessas vitaminas sejam recomendadas. A vitamina K é suplementada ao nascer, e a vitamina D é suplementada diariamente até os 18 meses, para crianças com baixa exposição regular ao sol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304875)

Enunciado: Existe uma ampla variação fisiológica em idade para o início da puberdade que depende do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. A situação que deve ser investigada é:

A) Menina que não apresenta telarca aos 14 anos de idade.

B) Menino que não apresenta sinais de puberdade aos 12 anos.

C) Menina com adrenarca aos oito anos de idade e telarca aos dez anos.

D) Menino com aumento do volume testicular para $4mm^3$ aos nove anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304880)

Enunciado: A mãe de um lactente de quatro meses em aleitamento materno exclusivo procura orientação porque vai trabalhar em 15 dias. A orientação adequada é que a mãe retire seu leite e armazene em frascos de vidro com tampa plástica:

A) Na geladeira por até 2 horas ou congelador/freezer por até 12 horas; oferecer preferencialmente por copinho.

B) Na geladeira por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por copinho.

C) Na geladeira por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira.

D) Na geladeira por até 24 horas ou congelador/freezer por até quatro semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291963)

Enunciado: Sobre aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior quanto menor é a criança, e a amamentação previne mais mortes entre as crianças de menor nível socioeconômico.

B) O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro.

C) Oferecer à criança amamentada água ou chás, prática considerada inadequada até pouco tempo atrás, pode reduzir o risco de desidratação nos primeiros seis meses.

D) Estudos mostram que a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314074)

Enunciado: Em relação à idade em que ocorre a puberdade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: (1) Atraso puberal. (2) Puberdade precoce. (3) Puberdade normal. ( ) Ocorre quando a puberdade feminina se inicia, em média, aos 9,7 anos, e a dos meninos, 10,9 anos. ( ) Ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. ( ) Ocorre quando há falta de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundário aos 13 anos de idade nas meninas, e 14 anos nos meninos, ou seja, ausência de broto mamário e testículo menos que 4mL, respectivamente.

A) 1 - 2 - 3.

B) 3 - 2 - 1.

C) 2 - 3 - 1.

D) 2 - 1 - 3.

E) 3 - 1 - 2

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314075)

Enunciado: De acordo com CAMPOS, BURNS e LOPEZ, a gravidez na adolescência tem sido considerada um problema de saúde pública pelas repercussões clínicas, emocionais e sociais que acarreta para essa faixa etária, particularmente quando ocorre abaixo de 15 anos. Em relação à gestação de adolescentes, analisar a sentença abaixo: A negação da atividade sexual e a irregularidade menstrual não devem excluir o diagnóstico, pois a gravidez ainda é o diagnóstico mais comum em adolescentes com amenorreia secundária (1ª parte). Durante a gestação, a adolescente ainda está se adaptando emocionalmente às suas próprias características e formatos, e o corpo, que ainda está em transformação, sofre novas mudanças de tamanho e forma (2ª parte). A gravidez na adolescência pode cursar com sintomas tradicionais de gravidez: enjoo matinal, vômitos, mamas dolorosas, ganho de peso, estrias e amenorreia (3ª parte). A sentença está:

A) Totalmente correta.

B) Correta somente em sua 3ª parte.

C) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.

D) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

E) Totalmente incorreta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314088)

Enunciado: De acordo com CAMPOS, BURNS e LOPEZ, além de alimentar a criança, o aleitamento materno (AM) protege mãe e criança contra algumas doenças e promove o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o bem-estar físico e psíquico da díade mãe-filho. Assinalar a alternativa que classifica CORRETAMENTE o padrão de aleitamento quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos:

A) Aleitamento Materno Predominante.

B) Aleitamento Materno Misto.

C) Aleitamento Materno Exclusivo.

D) Aleitamento Materno Complementado.

E) Aleitamento Materno Parcial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266359)

Enunciado: Avaliar o crescimento da criança é uma atividade fundamental da prática pediátrica e a monitoração detecta antecipadamente a desnutrição e alerta para outros agravos que podem estar afetando o crescimento das crianças. No acompanhamento do crescimento é CORRETO afirmar:

A) As crianças nascidas com peso menor que 2.000 gramas são consideradas baixo peso e as crianças nascidas com peso acima de 2.000 gramas são consideradas peso normal.

B) Em torno do quarto mês de vida, o peso do nascimento duplica e próximo ao primeiro aniversário, o peso triplica.

C) Ao nascer, se o recém-nascido apresenta comprometimento somente da estatura, é maior a probabilidade de o agravo ter ocorrido nos meses finais da gestação e se houver uma diminuição no peso, é mais provável que o agravo tenha ocorrido há mais tempo.

D) É alta a correlação do tamanho ao nascer em relação à estatura final e o crescimento intrauterino é dependente do seu potencial genético.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266360)

Enunciado: O aleitamento materno, além de alimentar a criança, protege mãe e filho contra algumas doenças e promove o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o bem-estar físico e psíquico da díade mãe-filho. No aleitamento materno é CORRETO afirmar:

A) A composição e aspecto do leite materno é bastante heterogêneo e varia com a alimentação, idade e raça da mãe.

B) Nos primeiros dias de amamentação, a secreção láctea é chamada de colostro, que contém mais lipídio e menos proteína do que o leite maduro, e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgG.

C) O leite materno contém altas concentrações de vitamina K, vitamina D e ferro.

D) Alguns dos fatores de proteção do leite materno são totalmente ou parcialmente inativados pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5ºC por 30 minutos) não tem o mesmo valor biológico que o leite cru.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

257359)

Enunciado: O aleitamento materno exclusivo é a alimentação ideal para todo lactente até o sexto mês, porém existem algumas situações que não se recomenda o aleitamento materno. Lembrando que a suspensão do aleitamento deve ser avaliada caso a caso. Dentre as CONTRAINDICAÇÕES clássicas para o aleitamento materno está a/o:

A) Covid-19.

B) Mastite.

C) Galactosemia.

D) Epstein Barr.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260690)

Enunciado: Suplementação profilática de ferro para lactente nascido a termo com peso adequado para a idade gestacional, que esteja em aleitamento materno exclusivo, deve ser iniciada:

A) 6 meses.

B) 3 meses.

C) 1 ano.

D) 4 meses.

E) 9 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287350)

Enunciado: Mãe leva o filho de 14 meses na Unidade Básica de Saúde para avaliação de rotina. A criança está com o desenvolvimento normal. Qual a orientação correta sobre a retirada das fraldas e uso do sanitário?

A) Esse treinamento já pode começar, pois a criança já senta.

B) Orientar que o treinamento deve iniciar por volta dos 18 meses, compatível com o desenvolvimento neurológico.

C) Orientar que o treinamento deve iniciar quando a criança consegue avisar que evacuou.

D) Orientar que o treinamento deve ocorrer depois dos 03 anos, para evitar traumas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260691)

Enunciado: Uma gestante dá a luz de parto vaginal com 39 semanas e cinco dias. Está tratando tuberculose forma pulmonar há um mês, com escarro negativo há três semanas. A amamentação ao seio deverá ser realizada:

A) Utilizando máscara e após 3 doses de isoniazida.

B) Após realizar a BCG.

C) Sem restrições.

D) Após o recém-nascido iniciar isoniazida.

E) Após o teste tuberculínico da mãe.

Gabarito

343780.

Comentário: A alimentação complementar deve ser iniciado no sexto mês de vida, com a introdução das frutas e da primeira papa principal (almoço ou jantar), com a introdução da segunda papa principal no mês seguinte (letra A incorreta). Orienta-se que, desde a primeira papa, a refeição deve conter cereais ou tubérculos, proteína vegetal ou leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão de bico), proteína animal (todos os tipos de carnes, vísceras e ovos), hortaliças (verduras de folhas e legumes). Devem ser temperados com salsa, cebolinha, alecrim, manjericão, sem adição de sal. Da mesma forma, não há indicação de açúcar simples antes do segundo ano de vida, e mesmo após esta idade, o consumo deve ser esporádico e não rotineiro (letra C incorreta). A criança pode gostar do alimento na primeira vez que o experimenta ou pode precisar provar o alimento várias vezes até se familiarizar com ele. Caretas não significam que a criança não esteja gostando do alimento, mas somente que é um sabor novo, diferente do que estava acostumada (por exemplo, o leite materno). Se ela continuar a rejeitar o alimento, não desista. Deixe passar alguns dias e ofereça-o preparado de outras formas. Algumas crianças precisam provar mais de oito vezes um alimento para gostar dele (letra B correta). No início, a criança deverá receber a comida amassada com garfo. Em seguida, deve-se evoluir para alimentos picados em pedaços pequenos, raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los. Também podem ser oferecidos alimentos macios em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pedaços grandes, para que ela pegue com a mão e leve à boca. Quando já estiver um pouco maior, a criança pode comer a comida da família, cortando-se os pedaços grandes, quando necessário. Os alimentos não devem ser oferecidos em preparações líquidas, e o liquidificador, mixer ou peneira não devem ser utilizados. Se a criança continuar com a consistência líquida, terá dificuldade em aceitar alimentos mais sólidos no futuro, podendo apresentar engasgo e ânsia de vômito. Alimentos líquidos como sopas, sucos e caldos, por conterem mais água, fornecem menos energia e nutrientes do que a criança precisa. A consistência adequada é aquela que não escorre da colher, que é firme, que dá trabalho para mastigar, ajudando no desenvolvimento da face e dos ossos da cabeça, colaborando para a respiração adequada e o aprendizado da mastigação (letra D incorreta). Resposta letra B.

343786.

Comentário: Para todos os recém-nascidos, há indicação de suplementação com vitamina D. A indicação atual é suplementar vitamina D com 400 UI dia (1 ano) e 600 UI dia (1 ano). Em relação à vitamina A, o Ministério da Saúde só indica a suplementação para lactentes, em regiões de alta prevalência de hipovitaminose A (lactentes 6-12 meses 100.000 UI em cápsulas, por via oral, dose única crianças 12-59 meses 200.000 UI em cápsulas, por via oral, a cada seis meses). Não há indicação para suplementação de vitamina C. Resposta letra D.

343791.

Comentário: Em relação ao ganho de peso, no primeiro trimestre de vida, um lactente irá ganhar em média, 700g mês e no segundo trimestre, 600g mês. Dessa forma, no primeiro trimestre o lactente irá ganhar 2.100g, somado a mais 600g do primeiro mês do segundo trimestre. Sendo assim, pesará próximo a 6.300g. Em relação ao crescimento, no primeiro trimestre irá crescer 3,5 cm mês e no segundo trimestre, 2 cm mês. Sendo assim, com quatro meses de idade esse lactente estará com aproximadamente 60cm. Em relação ao perímetro cefálico, no primeiro trimestre irá crescer 2 cm mês e no segundo trimestre, 1 cm mês. Sendo assim, o perímetro cefálico desse lactente deverá ser de 41 cm. Resposta letra A.

343792.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), aos seis meses de idade, os seguintes marcos devem estar presentes tenta alcançar um brinquedo procura objetos fora do alcance volta-se para o som rola no leito inicia uma interação. Já segundo o Tratado de Pediatria do Nelson, entre os seis e sete meses a criança deve apresentar rola sobre o corpo, engatinha ou se arrasta eleva a cabeça, rola, se contorce senta brevemente, com apoio na pelve se inclina à frente sobre as mãos sustenta a maior parte do peso, busca a captura objetos transfere objetos de uma das mãos para a outra forma sons vogais, prefere a mãe, balbucia, gosta de espelhos, responde a alterações no conteúdo emocional e contato social. Sabemos que esses dados podem variar. Se seguirmos as orientações da SBP, a questão não poderia ser considerada correta, mas de acordo com o Nelson, a resposta está na letra D. Resposta letra D.

345495.

Comentário: Acerca de puberdade precoce, vamos analisar as alternativas Letra A incorreta. O marco que define o surgimento de puberdade precoce no sexo feminino é a telarca surgindo antes dos oito anos de idade em meninas. Letra B correta. Tumores de células de Leydig ou gonadoblastomas (tumores secretores de HCG) são distúrbios associados à puberdade precoce periférica, bem como alguns tumores cistos ovarianos, a síndrome de McCune-Albright e doenças da suprarrenal (como a hiperplasia adrenal congênita). Letra C incorreta. Na puberdade precoce ocorre ativação prematura (fato que não está destacado no enunciado) do eixo hipotálamo-hipófise-gônada (parte que não é mencionada e é a principal responsável pelas manifestações clínicas). Letra D incorreta. No sexo masculino a puberdade precoce é definida pelo aumento do volume testicular de início antes dos nove anos de idade. Resposta Letra B.

283290.

Comentário: Vamos analisar cada alternativa A) INCORRETA. Os sucos não devem ser oferecidos, mesmo que naturais - devemos dar preferência a oferta da própria fruta, que contém fibras e menor quantidade de calorias. B) INCORRETA. O aleitamento materno exclusivo é recomendado até o sexto mês, devendo ser mantido até pelo menos os 2 anos de vida. C) INCORRETA. A papa principal (que não deve mais ser chamada de papa salgada, para desestimular o consumo de sal)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

deve ser amassada e a consistência dos alimentos deve ir aumentando progressivamente, para estimular a mastigação. D) CORRETA. É muito comum que a criança recuse novos alimentos - a recomendação é de ofertar de 8 a 15 vezes após a recusa inicial. É claro que alguns alimentos a criança pode realmente não gostar , mas a tentativa deve ser feita várias vezes para que o cardápio seja o mais variado possível. Resposta letra D.

283297.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas referentes ao desenvolvimento puberal A) ERRADA O crescimento começa distalmente, ou seja, primeiro crescem mãos e pés para depois ocorrer o crescimento de tronco. B) CORRETA A telarca (aparecimento do broto mamário entre 8 e 13 anos) é o primeiro sinal da puberdade feminina, seguido do surgimento de pelos pubianos (pubarca) e axilares, e posteriormente da menarca. A telarca pode ser assimétrica ou unilateral no início do desenvolvimento puberal. C) ERRADA O estirão puberal ocorre primeiramente nas meninas, com pico de 8,3 cm ano nas meninas e de 9,5 cm ano nos meninos. Geralmente, o estirão puberal ocorre em média 2 anos mais tarde nos meninos. D) ERRADA No sexo masculino há maior aumento de massa muscular, sobretudo pela ação da testosterona, enquanto no sexo feminino há maior acúmulo de gordura. Resposta letra D. Questão correta e não passível de recurso

283301.

Comentário: A confirmação diagnóstica da síndrome de down é feita com o cariótipo, mas algumas alterações que geralmente estão presentes ao nascimento podem levantar a suspeita dessa condição. Essas alterações incluem hipotonia, braquicefalia (diâmetro antero-posterior craniano reduzido), fendas palpebrais oblíquas, epicanto, macroglossia, braquidactilia, mãos largas com prega palmar única, sinal da sandália (afastamento entre 1º e 2º pododáctilos) e frouxidão ligamentar. Em decorrência da hipotonia axial e apendicular, o neonato pode apresentar problemas de sucção e ganho de peso nos primeiros meses de vida. Além disso, outras comorbidades também estão associadas, como o hipotireoidismo congênito, atraso de desenvolvimento, cardiopatias, infecções respiratórias de repetição. podem agregar morbidade ao paciente, as quais podem ser minimizadas e prevenidas com cuidados médicos adicionais. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291790.

Comentário: Em relação ao ganho ponderal, é importante lembrar que o peso de nascimento duplica aos 4-5 meses e triplíca no final do primeiro ano de vida. Outra forma mais específica de avaliar o ganho ponderal é lembrar que a criança ganha 700g mês no trimestre 600g mês no segundo trimestre 500 g mês no 3 trimestre e 400g mês no 4 trimestre. Isso significa que uma criança que nasceu com 3,3 kg terá cerca de 8 kg no oitavo mês de vida (3,3kg 2,1kg 1,8kg 0,8kg 8kg). No quee diz respeito ao ganho estatural, a criança cresce 25 cm no primeiro ano de vida, sendo 15 cm no primeiro semestre e 10 cm no segundo semestre, atingindo cerca de 49 cm no oitavo mês. Sabendo disso, podemos concluir que o peso e a estatura estão adequados para a idade. Resposta letra A.

291791.

Comentário: Lembramos que o perímetro cefálico cresce 2cm mês no primeiro trimestre 1cm mês no segundo trimestre e 0,5 cm mês no terceiro e quarto trimestre (um aumento de 12 cm ao longo do primeiro ano de vida). Portanto, aos 8 meses ela terá 44 cm (34 6cm 3 cm 1 44cm). Resposta letra C.

291792.

Comentário: Questão conceitual. As tabelas que descrevem o desenvolvimento encontradas no livro Nelson tratado de pediatria indicam que os padrões emergentes de comportamento aos sete meses incluem rolar, sentar brevemente com apoio da pelve e projetar-se sobre as mãos agarrar objetos grandes e transferir objetos de uma mão para a outra formar sons de polissílabos vogais. O marco de levantar sozinho com apoio é atingido apenas aos 12 meses na maioria das crianças, assim como empilhar cubos. Pegar objetos com movimento de pinça (polegar e indicador) tem início aos 10 meses e termina por completo aos 12 meses. Portanto, o único marco presente aos 8 meses é o descrito na letra C. Resposta letra C.

283355.

Comentário: Como sempre, questão controversa e com gabarito questionável Aos 7 meses de vida é esperado que uma criança sente COM apoio, sendo esperado que apenas aos 10 meses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sente-se sozinho, sem apoio e com a coluna ereta. A criança só aponta o que deseja por volta dos 15 meses e usa colher para comer sozinhos aos 18 meses. O movimento de pinça incompleto começa a ser realizado aos 10 meses, mas só é feito de forma completa aos 12 meses. Como podemos ver, não há resposta para a questão, que deveria ter sido anulada. Mesmo após formulação de recurso, a banca manteve o gabarito. Resposta da banca letra A.

247189.

Comentário: Questão sobre eventos na puberdade. Analisando as opções A - errada. A puberdade na menina deve ser iniciada entre 8 e 13 anos de forma fisiológica sendo o estirão de crescimento entre M2 e M3. Nos meninos a puberdade pode ter inicio entre 9 e 14 anos, sendo o estirão mais ao final entre G4 e G5. B - correta. O primeiro sinal de puberdade nas meninas é o broto mamário, marcando M2 da escala de Tanner. C - errada. É o aumento do volume testicular que marca o inicio da puberdade nos meninos. D - errada. O pico do estirão de crescimento das meninas está em M2 e M3. No inicio de M4 há a menarca e com ela a desaceleração do crescimento. E - errada. A muda vocal ocorre do meio para o final da puberdade no sexo masculino. Resposta letra B.

251912.

Comentário: A pinça assistida é caracterizada pelapega de objetos com o polegar e o indicador, que é um marco esperado para lactentes de 9-10 meses de idade, enquanto a transferência de objetos de uma mão para a outra é um marco esperado aos 6-7 meses de idade. Logo, como o lactente não é capaz de realizar o primeiro e realiza o segundo marco, a idade mais adequada dentre as alternativas é a letra B. No entanto, fica uma ressalva com relação ao sentar sentar-se sozinho e sem apoio com o dorso ereto é esperado aos 9-10 meses, enquanto sentar-se com apoio, inclinando-se com as mãos à frente e com dorso curvado é esperado aos 6-7 meses. Pelo enunciado, infere-se que a criança já seja capaz de sentar sem apoio, no entanto, a criança pode adquirir precocemente marcos de uma idade mais à frente. Logo, não podemos considerar o lactente do enunciado com 10 meses porque, considerando lactentes normais, a ausência da pinça assistida caracteriza um sinal de alarme, o que impossibilita então esta alternativa. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247197.

Comentário: Desde que a adolescente seja capaz de avaliar e expressar o seu problema sozinha, ela tem o direito de ser atendida pelo ginecologista sem a presença dos pais ou responsáveis. Orientações sexuais, prescrição de contraceptivos (para pacientes com maturidade para adesão) e tratamento de ISTs (afastada violência sexual e desde que adolescente tenha maturidade para adesão ao tratamento) são situações em que o sigilo médico deve ser mantido. Portanto, a melhor conduta encontra-se descrita na letra A. Cabe aqui lembrar que são consideradas situações de quebra de sigilo presença de qualquer tipo de violência (emocional, maus tratos, sexual, bullying, interpessoal no namoro etc.) uso escalonado (cada vez maior) de álcool e outras drogas e sinais de dependência química autoagressão, ideações suicidas ou de fuga de casa, tendência homicida gravidez ou abortamento sorologia positiva de HIV (comunicar aos familiares e à parceria sexual) não adesão a tratamentos (deixando o adolescente ou terceiros em risco) diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental. Resposta letra A

251918.

Comentário: Aleitamento materno é tema recorrente nas provas de Residência Médica. É recomendado pela SBP o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, não devendo ser ofertados água, chás ou sucos, mesmo em dias mais quentes (letra D errada). O regime é em livre demanda, ou seja, não deve ser estabelecido intervalo rígido entre as mamadas (letra C errada). Neste período, é importante checar e orientar a técnica da amamentação, uma vez que erro no posicionamento e pega constituem principal causa de baixo ganho ponderal (letra B certa). A introdução de alimentos deve ser a partir dos 6 meses, e não 1 ano de idade (letra A errada). Gabarito letra B

251930.

Comentário: Com relação aos marcos motores descritos nas alternativas, a criança é capaz de realizar o sustento cefálico aos 3 meses, sentar-se com apoio aos 7 meses e sentar-se sem apoio aos 10 meses de idade. Após este marco, a criança começa a explorar o ambiente, desenvolvendo a autoconsciência, podendo evoluir com o engatinhar até que, aos 12 meses, seja capaz de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

levantar-se sozinho a andar com uma das mãos apoiadas. Por fim, nos resta a alternativa C, que apresenta um dado correto, pois o ganho ponderal no primeiro trimestre é de 700 g mês ou 25-30 g dia. No entanto, este dado não faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o que invalida a alternativa. Resposta letra C.

251933.

Comentário: A anemia ferropriva constitui um problema de saúde pública e por este motivo, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta uso profilático do sulfato ferroso. Como a questão não citou comorbidades, consideramos crianças nascidas a termo e com peso adequado. Para estas crianças é orientado o uso de ferro elementar 1 mg por quilo, entre 3 e 24 meses. Gabarito letra C

217645.

Comentário: Como regra geral, o desenvolvimento motor é sequencial e previsível, tendo como sequência o sentido cefalocaudal e do centro para a periferia. Nesse sentido, os marcos apresentados surgem na seguinte ordem No 3º mês, sustenta a cabeça No 4º mês, junta as mãos na linha média No 5º mês, senta em posição de tripé No 12º mês, faz movimento de pinça No 15º mês, anda sem apoio. Resposta letra A.

217726.

Comentário: Vejamos as alternativas A) incorreta. A primeira manifestação da puberdade no sexo feminino é o surgimento do broto mamário. B) incorreta. A menarca ocorre cerca de 2 a 2 anos e meio após a telarca. C) correta. A ginecomastia puberal no sexo masculino é um evento frequente e fisiológico, e ocorre em cerca de 50-65% dos meninos entre os estágios II-III de Tanner. Costuma ser bilateral, muitas vezes assimétrica, e não ultrapassar 4 cm de diâmetro glandular. A conduta é expectante, pois tal alteração tende a desaparecer nos próximo 2-3 anos. D) incorreta. O primeiro caracter sexual que marca o início do desenvolvimento puberal no sexo masculino é o aumento do volume testicular. Resposta letra C.

217695.

Comentário: Estamos diante de um provável quadro de ingurgitamento mamário. Vamos, então, relembrar os três componentes básicos da fisiopatologia desta condição congestão aumento da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vascularização, acúmulo de leite e edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático. O aumento da pressão intraductal faz com que o leite acumulado sofra um processo de transformação em nível intermolecular, tornando-se mais viscoso. Daí a origem do termo leite empedrado . Ok, mas o caso apresentado é fisiológico ou patológico Pela pobre descrição mostrada no enunciado, nos parece que se trata de um ingurgitamento fisiológico. Sendo assim, o tratamento com recomendação de ordenha manual da aréola antes das mamadas é o mais indicado. Resposta letra B.

217708.

Comentário: Vamos analisar as alternativas I) VERDADEIRA As queixas dos pais, devem ser consideradas sem qualquer dúvida. II) VERDADEIRA O uso de tecnologias vêm cada vez mais trazendo déficits em crianças. III) FALSA O atraso na aquisição ou distúrbio específico da linguagem não é um distúrbio raro n infância e pode não ter relação com outras condições, podendo se manifestar de forma isolada, sobretudo os quadros menos graves. IV) VERDADEIRA O comportamento da criança na consulta é um preditor de condições e distúrbios e portanto deve ser observado durante a consulta. Resposta letra A.

182701.

Comentário: Por mais que as questões sobre desenvolvimento neuropsicomotor apresentam um teor essencialmente decorativo , com o tempo você irá perceber que os marcos cobrados são sempre os mesmos. Entre eles, um é essencial memorizar a criança senta sozinha e sem apoio aos nove meses de idade. Espera-se que aos seis meses a criança já sente com apoio, mas não é considerado atraso se ela não se sentar sozinha. Com relação aos demais marcos, todos eles são marcos esperados por volta dos 6 a 7 meses de idade, a depender da referência estudada. Resposta letra C.

182621.

Comentário: Vamos aproveitar a questão e revisar alguns conceitos sobre aleitamento materno Aleitamento materno quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independente de receber ou não outros alimentos. Aleitamento materno exclusivo a criança recebe

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apenas o leite humano, da própria fonte (diretamente do seio ou ordenhado) ou de outra fonte (ex. banco de leite), sem outros líquidos ou sólidos à exceção de vitaminas, sais de hidratação e medicamentos (gotas ou xaropes). Aleitamento materno predominante além do leite humano, a criança recebe água, chás, suco de frutas, e outros fluidos infusões em quantidades limitadas. Aleitamento materno complementado Além do leite humano, a criança recebe alimento sólidos ou semissólidos com o objetivo de complementar o leite materno, mas não de substituí-lo. Aleitamento materno misto ou parcial Além do leite humano a criança recebe outros tipos de leite (ex. leite de cabra, leite de soja, leite de vaca). Resposta correta letra D.

183135.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) ERRADA Ambos apresentam baixo teor de ferro, mas apresenta maior biodisponibilidade devido a lactoferrina presente no leite humano. B) ERRADA A lisozima é um fator de proteção presente no leite humano que apresenta ação bactericida e anti-inflamatória, com maior atividade após os seis meses de idade. C) ERRADA O leite humano tem 200 a 250 mEq L de cálcio e 100 a 150 mg l de fósforo, ou seja, a relação está ao contrário da apresentada na alternativa. D) ERRADA A taurina é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E) CORRETA A IgA secretória é a principal imunogloblina do leite humano, que confere proteção contra diversos agentes infecciosos. Resposta letra E.

183140.

Comentário: São contraindicações de aleitamento materno infecção pelo HIV, HTLV-1 e HTLV-2 psicose puerperal uso de drogas antineoplásicas e derivados do Ergot em doses habituais para enxaqueca doença de Chagas em fase ativa ou com lesão mamilar sangrante lesão ativa por hepes simplex contraindica a amamentação apenas no seio afetado mãe que abre um quadro de varicela entre 5 dias antes do parto e 2 dias após o parto. Resposta correta letra D.

182688.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A) ERRADA O erro do item está na palavra horizontal, pois o comprimento é avaliado verticalmente. B) CORRETA O item está correto na sua afirmação,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pois a vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento objetivam promover e proteger a saúde da criança e, quando necessário, por meio de diagnóstico e tratamento precoce para sub ou sobre alimentação, para evitar que desvios do crescimento possam comprometer sua saúde atual e sua qualidade de vida futura, pois muitas deficiências nutricionais ocorrem sem comprometimento antopométrico imediato, fortalecendo a importância de uma correta anamnese nutricional e todas as consultas. C) ERRADA O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), sendo que os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis para todas as consultas, para crianças de risco ou não, até os 2 anos de idade. D) ERRADA A precisão é em milimetros. Resposta letra B.

159049.

Comentário: Os adolescentes experimentam muitos tipos de maturação, incluindo cognitiva (desenvolvimento do pensamento formal operacional), psicossocial (estágios da adolescência) e física. Essa série complexa de mudanças físicas é conhecida como puberdade, que impacta nos fatores psicossociais. As alterações mais visíveis são o aumento da estatura e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. A puberdade precoce é definida como aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade. Resposta letra D.

159073.

Comentário: Questão simples, mas ao mesmo tempo difícil. Segundo recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, a primeira consulta com o pediatra deverá ocorrer no chamado quinto dia útil , que é uma reavaliação após a alta hospitalar que se dá no quinto dia de vida da criança. Apesar de muitos acharem precoce, a grande questão é para reavaliação de possível icterícia, da evolução ponderal e principalmente, do aleitamento materno, afim de realizar as orientações adequadas de forma precoce, caso seja encontrada alguma alteração. Resposta letra A.

159039.

Comentário: A idade esperada para que a criança comece a engatinhar é por volta dos 9-10 meses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

após ela conseguir sentar-se sem apoio. No entanto, este marco não é necessariamente obrigatório para todas as crianças, pois muitas delas iniciam a marcha sem passar por esta fase. Sendo assim, a conduta nessa situação é tranquilizar a mãe, pois tal ausência, à princípio, não significa comprometimento patológico, devendo reavaliar o seu desenvolvimento pela rotina normal da puericultura. Resposta letra C.

159044.

Comentário: O primeiro sinal da puberdade nos meninos é o aumento testicular que ocorre por volta dos 9 anos e meio de idade, definindo assim o estágio G2 de Tanner. Segue-se posteriormente o aparecimento dos pelos pubianos (pubarca) e o aumento do pênis. Após dois anos da pubarca ocorre a pilificação axilar, depois o estirão puberal (G4), que é quando ocorre o pico da velocidade de crescimento, normalmente 3-4 anos após o início da puberdade. Por fim, ocorre o surgimento dos pelos faciais e finalmente, as mudanças na voz (G4-5), devido ao aumento no tamanho da faringe, laringe e pulmões. Após essa análise, concluimos que a alternativa correta é a letra A.

159058.

Comentário: Uma criança que apresenta quadro de cefaleia e vômitos sempre devemos pensar na possibilidade de hipertensão intracraniana. Entre as possíveis etiologias, o tumor cerebral é uma delas. No entanto, quais sinais e sintomas falariam a favor desta hipótese A principal topografia para ocasionar um quadro de hipertensão intracraniana seria em fossa posterior, próximo ao cerebelo e tronco encefálico. Se houver compressão das estruturas cerebelares, o paciente poderá apresentar quadro de ataxia, incoordenação e alterações da marcha, sobretudo com claudicação. Já se houver compressão das estruturas do tronco encefálico, o primeiro nervo craniano acometido é o sexto, que está associado ao seu trajeto no cérebro. Logo, o paciente apresentará um desvio medial de um ou ambos os olhos, a depender se ambos os nervos estão ou não acometidos, podendo ocasionar um estrabismo convergente. Desta forma, a melhor resposta é a letra C.

159105.

Comentário: Durante a gestação, apesar dos altos níveis de prolactina, não há secreção de leite graças ao lactogênio placentário de ação inibitória. Com o nascimento e saída da placenta, ocorre o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aumento da secreção de leite e aumento da produção de ocitocina, que atuará na ejeção. A apojadura se dá, independentemente da sucção do mamilo, por volta do 3º e 4º dias. Em seguida, para a manutenção da produção e ejeção do leite, existe a necessidade da sucção do mamilo para que haja o estímulo da hipófise anterior a produzir prolactina. Da mesma forma, a hipófise posterior também sofre estímulo para produzir a ocitocina, responsável pela ejeção do leite. A amamentação é um fenômeno complexo, que traz diversos benefícios para mãe e bebê, como prevenção de hemorragia pós-parto, redução do risco de câncer de mama e ovário, prevenção de doenças do bebê, consolidação do vínculo materno, além da composição nutricional ideal para o bebê. Desta forma, única correta afirmativa III. Resposta letra D.

135968.

Comentário: Sabemos que o recém-nascido tende a desenvolver uma anemia fisiológica a partir da primeira semana de vida causada por uma queda progressiva do nível de hemoglobina por aproximadamente seis a oito semanas. Entre os fatores responsáveis por essa anemia destacam-se 1) parada abrupta da eritropoiese ao nascimento, relacionada com o início da respiração, e aumento da saturação de oxigênio 2) Níveis baixos de eritropoietina cuja produção é predominantemente hepática e a sua liberação mais lenta diante da hipoxia tecidual 3) Vida média dos glóbulos vermelhos diminuída. Além disso, a expansão do volume sangüíneo (volemia) que acompanha o rápido ganho ponderal nos três primeiros meses de vida é outro fator que leva à necessidade aumentada de glóbulos vermelhos. A anemia fisiológica do lactente atinge valores de 9-11g dl de hemoglobina entre dois-três meses de vida em crianças nascidas a termo (ocasião em que a eritropoietina volta a ser ativada). O prematuro também desenvolve anemia fisiológica decorrente dos mesmos fatores já mencionados, só que de maneira mais exagerada. O declínio da hemoglobina é mais rápido e mais precoce, atingindo valores de 7 a 9g dl entre a 3ª e 6ª semana de vida. Como se trata de uma questão fisológica, basta esclarecer à mãe de que não se trata de morbidade e não carece de tratamento. Resposta letra B.

135914.

Comentário: Questão bem polêmica e super mal formulada. Vamos às alternativas A) Passível de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

interpretação Depende do que é uma doença potencialmente transmissível pelo leite materno para o autor. Existe um risco teórico de transmissão, pois o DNA do HBV já foi encontrado no leite materno. Entretanto até hoje não há evidências de transmissão pela amamentação. Ademais, ao realizar a profilaxia no recém nascido (vacina e imunoglobulina) o risco teórico é praticamente eliminado. Vejamos se há uma alternativa melhor... B) Incorreta. Toxoplasmose não passa pelo leite materno e não contraindica a amamentação C) Correta. A tuberculose é transmitida via aérea D) Também passível de interpretação. A amamentação deve ser interrompida transitoriamente apenas se houver lesões herpéticas na mama, mas pode seguir na mama contralateral. Porém, na alternativa o autor diz lesões herpéticas nas mamas , talvez sugerindo que a mãe tem lesões em ambas as mamas Enfim...a alternativa não deixa claro se é para suspender totalmente a amamentação ou apenas na mama afetada Viu que confusão Bom, entre as alternativas a mais correta seria a letra C. A banca liberou como gabarito inicial a letra D. Mas pelo menos tiveram o bom senso de anular a questão após solicitação de recursos...

135939.

Comentário: Vejamos as assertivas I - Falsa. Deficiência de tiamina causa o beriberi. Anemia megaloblástica é causada por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12 II- Verdadeira e autoexplicativa III- Falsa. Mesma explicação que a assertiva I. IV - Verdadeira. Escorbuto é causado pela dificiência de vitamina C e se apresenta por manifestações hemorrágicas, síndrome sica e dores ósseas com hemorragia periosteal... Resposta correta letra C

108647.

Comentário: A técnica de amamentação abrange o posicionamento e a pega. Com relação ao posicionamento, o rosto do bebê deve estar de frente para a mama, com o nariz encostado no mamilo, a cabeça e o tronco devem estar alinhados e o corpo do bebê bem próximo ao corpo da mãe. Com relação à pega, a boca do bebê deve estar aberta, englobando a maior parte da aréola, lábio inferior evertido e queixo tocando a mama. Não está indicado apoiar a mama com os dedos na aréola. Logo, resposta letra C .

108656.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: De acordo com a SBP, até os seis meses deve-se manter o aleitamento materno exclusivo. A partir do sexto mês de vida, deve-se introduzir a alimentação complementar, mantendo-se o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais. Portanto, resposta correta letra C .

84499.

Comentário: Na avaliação do desenvolvimento motor, o pediatra deve observar as habilidades relacionadas à movimentação, associadas ao uso dos grandes músculos. A aquisição destes marcos tem uma sequência previsível no sentido craniocaudal. Desta forma, é esperada a seguinte sequência sustentar a região da cabeça (idade média de aquisição 2 meses), sentar com apoio (idade média de aquisição 7 meses) e, finalmente, andar com apoio (idade média de aquisição 12 meses). Atualmente, é esperado que esta lactente com 18 meses corra, suba escada quando segurada por uma das mãos e explore gavetas e cestos. Resposta letra E.

84467.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas A) INCORRETA. As fibras solúveis reduzem os níveis de colesterol. O mecanismo redutor da concentração sanguínea de colesterol através das fibras solúveis não é totalmente esclarecido. Uma das hipóteses é o aumento da excreção de ácidos biliares na presença destas fibras, fazendo com que o fígado remova colesterol do sangue para a síntese de novos ácidos e sais biliares. E outra hipótese é que o propionato, produto da fermentação das fibras solúveis, iniba a síntese hepática do colesterol. B) INCORRETA. A fibra insolúvel está relacionada ao aumento do volume fecal e da frequência dos movimentos intestinais, apresentando efeito mecânico e acelerando o tempo de trânsito intestinal. C) INCORRETA. Os oligossacarídeos do leite materno não são digeridos no intestino delgado e formam fibras solúveis. D) CORRETA. As fibras solúveis diminuem concentrações de colesterol total e LDL-c. O consumo de aproximadamente 3 g de fibra solúvel está associado à diminuição de 5 mg dl nas concentrações de colesterol total e LDL-c, o que pode predizer uma redução na incidência de doença cardiovascular por volta de 4%. E) INCORRETA. As fibras insolúveis fazem parte da estrutura das células vegetais, são encontradas principalmente em farelo de cereais, frutas e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hortaliças. Resposta letra D.

84483.

Comentário: Em relação à suplementação de ferro, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os lactentes, como Jonas, que foram recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional e estão em aleitamento materno, recomenda-se 1 mg kg de peso dia a partir do 6º mês (ou da introdução de novos alimentos) até 24º mês. Mas, vamos aproveitar esta questão e relembrar quais são as recomendações da SBP quanto à suplementação de ferro em crianças para profilaxia de anemia ferropriva é - Lactentes que foram prematuros e ou com baixo peso ao nascer (2.500g) até 1500g a partir do 30º dia de vida, 2 mg kg de peso dia de ferro elementar até 1 ano e depois com 1 mg kg dia até os 2 anos. - Lactentes que foram prematuros e ou peso ao nascer de 1500g a 1000g a partir do 30º dia de vida, 3 mg kg de peso dia de ferro elementar até 1 ano e depois com 1 mg kg dia até os 2 anos. - Lactentes que foram prematuros e ou peso ao nascer 1000g a partir do 30º dia de vida, 4 mg kg de peso dia de ferro elementar até 1 ano e depois com 1 mg kg dia até os 2 anos. - Lactentes a termo, com peso adequado ao nascimento que ingerem 500 ml dia de fórmula infantil enriquecida com ferro não necessitam da suplementação de ferro. Resposta letra D.

84503.

Comentário: Em relação ao desenvolvimento puberal, podemos dizer que no sexo feminino, o primeiro sinal perceptível do desenvolvimento puberal é o surgimento do broto mamário (telarca). A telarca é seguida pelo surgimento dos pelos pubianos (pubarca) e, posteriormente, pela primeira menstruação (menarca). Em relação ao crescimento humano, sabemos que este não ocorre de maneira uniforme. O crescimento durante a vida intrauterina é bastante intenso e acelerado. O crescimento pós-natal é um processo que vai sofrendo desaceleração progressiva, voltando a se acelerar somente com o início da puberdade. Esta aceleração da velocidade de crescimento é conhecida como estirão da puberdade , seguida por um período de desaceleração e, finalmente, a parada do crescimento resultante do fechamento das epífises ósseas. Os esteroides sexuais e o hormônio de crescimento são os grandes efetores do crescimento nesta fase. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66956.

Comentário: As anomalias congênitas são, dentre as doenças genéticas, as mais frequentes na clínica pediátrica. Entende-se como malformações congênitas qualquer anomalia anatômica, estrutural ou funcional presente ao nascimento, diagnosticável ou não naquela ocasião. A etiologia das malformações congênitas pode ser de origem genética, ambiental ou multifatorial (afirmativa II incorreta). As anomalias de origem genética representam cerca de 25% do total das anomalias e 15% são de origem ambiental, como por exemplo, infecções maternas, drogas teratogênicas, álcool. As causas multifatoriais representam cerca de 60%, incluindo as de origem desconhecida e a interação gene-ambiente. É muito importante não confundirmos os conceitos doença genética não é sinônimo de doença hereditária. Doença genética é todo e qualquer distúrbio que afete nosso material genético, como o câncer, a obesidade e o diabetes, por exemplo. (afirmativa IV incorreta). Visto isso, as únicas afirmativas corretas são I e III, gabarito, portanto, letra C.

66962.

Comentário: A Síndrome de Turner é a anormalidade dos cromossomos sexuais mais comum nas mulheres, ocorrendo em 1 a cada 1.500-2.500 crianças do sexo feminino nascidas vivas. A constituição cromossômica pode ser ausência de um cromossomo X (cariótipo 45,X), mosaicismo cromossômico (cariótipo 45,X 46,XX), além de outras anomalias estruturais do cromossomo X. As anormalidades típicas da síndrome de Turner incluem baixa estatura, disgenesia gonadal, pescoço alado, linha posterior de implantação dos cabelos baixo, facies típica, tórax alargado com aumento da distância entre os mamilos, linfedema, cúbito valgo, tireoidite autoimune com ou sem hipotireoidismo, anormalidades renais, cardiovasculares e auditivas, além de deficiência cognitiva em algumas atividades, embora a inteligência média seja considerada normal. Baixa estatura é o achado mais comum da síndrome de Turner e pode ser o único, o que torna importante a investigação da doença nesses casos. Caracteristicamente há retardo leve do crescimento na fase intrauterina, redução progressiva da velocidade de crescimento durante a infância e marcada ausência de crescimento na fase puberal, como em nossa paciente. O gabarito está, assim, correto. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343181.

Comentário: A puberdade é considerada como precoce quando se inicia antes dos oito anos em meninas e antes dos nove anos em meninos. Resposta letra C.

343182.

Comentário: Em relação à puberdade, vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. A puberdade feminina se inicia com a telarca. Letra B correta. A puberdade é considerada como fisiológica quando se inicia entre 8-13 anos no sexo feminino e 9-14 anos no sexo masculino. Letra C incorreta. O início da puberdade no sexo masculino é marcado pelo aumento do volume dos testículos (3 ml). Letra D incorreta. A puberdade precoce pode ter causas de origem periférica, como tumores adrenais ou nas gônadas. Resposta letra B.

343183.

Comentário: A ginecomastia representa o desenvolvimento de tecido glandular mamário no sexo masculino. A ginecomastia verdadeira é caracterizada pela identificação de tecido fibroglandular palpável, com pelo menos 0,5 cm de diâmetro localizado concentricamente sob o mamilo e região areolar. O desenvolvimento de ginecomastia durante a puberdade é um evento bastante comum e cerca de 70% dos adolescentes do sexo masculino terão algum grau de hiperplasia glandular mamária, com um pico de incidência nos estágio 3 4 de Tanner, resultante de um desequilíbrio entre os níveis circulantes de andrógenos e estrógenos. O aumento pode ser uni ou bilateral, ocorrendo involução espontânea geralmente em até dois anos. Durante o exame físico, pode haver dor à palpação da região, mas não há saída de sangue ou secreções pelos mamilos. Sendo assim, o que o paciente descrito apresenta é um evento que pode ocorrer na puberdade, não apresentando características de causas patológicas ou necessitando de qualquer intervenção. Resposta letra A.

343184.

Comentário: Questão maldosa, que com certeza pegou muito candidato bom. Por definição clássica, puberdade precoce ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. A puberdade precoce

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pode ser de origem central, dependente de gonadotrofinas, ou periférica, independente das gonadotrofinas. Outra classificação importante diz respeito à concordância dos caracteres sexuais com o sexo do indivíduo. Então, pode ser de padrão isossexual (normalmente central ou heterossexual), e de causa periférica (virilização ou feminização). Nos meninos, o desenvolvimento dos testículos costuma indicar ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonodal (indicando uma puberdade precoce central), enquanto, na puberdade periférica, o crescimento do pênis ocorre sem o concomitante desenvolvimento testicular, ou o tamanho testicular é desproporcional à virilização do genital e à concentração de testosterona total. O aumento do volume dos testículos é indicativo de produção endógena de gonadotrofinas (indicando puberdade central e não periférica), enquanto o aumento do pênis apenas, com presença de pelos púbicos, é sugestivo da produção de androgênios, geralmente de origem suprarrenal. Portanto, diante de uma menino que apresenta virilização, a suspeita de tratar-se de uma puberdade periférica se dá pelo achado dos testículos de volume infantil (caso não fosse, pensaríamos em puberdade precoce de origem central). Aproximadamente 60% dos meninos com puberdade precoce central têm lesão no sistema nervoso central (letra C indica para puberdade central). A pubarca e a ginecomastia, também indicam ativação do eixo HHG (letra A e B incorretas).Resposta letra D.

343185.

Comentário: A classificação de Marshall e Tanner (conhecida como classificação de Tanner) é utilizada sempre que se refere ao desenvolvimento puberal feminino, mamas (M) e pelos (P), assim como masculino, genital (G) e pelos (P). Nos meninos, em relação ao aumento do pênis e testículo, temos (G1) Fase pré-adolescência (G2) Aumento do escroto e dos testículos, sem aumento do pênis (G3) Aumento do pênis em toda a extensão (G4) Aumento do diâmetro do pênis e da glande, crescimento dos testículos e do escroto, cuja pele escurece (G5) Tipo adulto. Em relação ao crescimento dos pelos (P1) Fase pré-adolescência (não há pelugem) (P2) Presença de pelos longos, macios e ligeiramente pigmentados, na base do pênis (P3) Pelos mais escuros e ásperos sobre o púbis (P4) Pelugem do tipo adulto, mas a área coberta é menor que no adulto (P5) Tipo adulto, estendendo-se até a face interna da coxa. Portanto, o menino encontra-se no estágio G3P3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de Tanner. Resposta letra A.

341071.

Comentário: Sabemos que o Ministério da Saúde, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, indicam dar somente leite materno até os seis meses de idade, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Ao completar seis meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais. A questão traz informações a fim de confundir o candidato, mas a pergunta é bem direta. Resposta letra B.

341072.

Comentário: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), considera-se vegetariano aquele indivíduo que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves, peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. As dietas vegetarianas oferecem em geral quantidades energéticas menores por refeição e proporção de gordura saturada, além de maior teor de fibras, frutas e vegetais. Por outro lado, o não consumo de alimentos de origem animal e laticínios podem contribuir para menor ingestão de ferro, vitamina B12, cálcio e zinco. As carnes também são as principais fontes, além de apresentarem melhor biodisponibilidade do ferro e do zinco. No caso dos vegetarianos é preciso orientar outras fontes e repor para não que não haja risco de anemia ferropriva ou deficiência grave de zinco. Reposição de zinco 2 mg kg dia (máx 20 mg dia). As principais fontes de vitamina B12 são as proteínas animais (carnes vermelhas, peixes, ovos e vísceras) e em menor quantidade laticínios. Nas famílias que excluem estes alimentos da dieta indica-se a suplementação desta vitamina para a mãe que amamenta (50 mcg dia) e para o lactente (5 mcg dia). Desta forma, não basta apenas a reposição de ferro e zinco, devendo receber também a suplementação de vitamina B12. Na época do concurso, foi solicitado recurso pelo motivo exposto acima. A melhor resposta seria ferro, zinco e vitamina B12.

341073.

Comentário: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), considera-se vegetariano aquele indivíduo que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves, peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. As dietas vegetarianas oferecem em geral quantidades

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

energéticas menores por refeição e proporção de gordura saturada, além de maior teor de fibras, frutas e vegetais. Por outro lado, o não consumo de alimentos de origem animal e laticínios podem contribuir para menor ingestão de ferro, vitamina B12, cálcio e zinco. A proteína não é fator preocupante na dieta vegetariana. Se a pessoa supre sua necessidade calórica com alimentos baseados em cereais e leguminosas, a cota proteica com todos os aminoá cidos essenciais é atingida automaticamente. Resposta letra D.

341074.

Comentário: Que lambança feita pela banca A classificação de Marshall e Tanner (conhecida como classificação de Tanner) é utilizada para se referir ao desenvolvimento puberal feminino, mamas (M) e pelos (P), assim como masculino, genital (G) e pelos (P). Na verdade, a telarca (aparecimento do broto mamário) e a pubarca (pelos púbicos) se referem aos estágios M2 e P2 de Tanner, mas não em si a sua classificação. Por tal motivo, foi solicitado recurso na época do concurso solicitando a anulação.

341075.

Comentário: A puberdade no sexo feminino ocorre entre oito e 13 anos de idade, sendo marcada pelo aparecimento do broto mamário (telarca), o estágio M2 de Tanner. O intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser de 2-2,5 anos, quando as mamas estão em M3-M4 (mais comumente M4). Em geral, quando a menarca não ocorre em até cinco anos após a telarca, pode ser recomendada uma investigação. Porém, é descrito que o intervalo entre os eventos pode chegar a seis anos. Considerando que a telarca pode ter ocorrido aos oito anos de idade, a menarca pode ainda acontecer, sem que seja necessário nenhuma investigação no momento. Portanto, a adolescente apresenta uma puberdade fisiológica. Resposta letra B.

341076.

Comentário: A puberdade no sexo feminino ocorre entre oito e 13 anos de idade, sendo marcada pelo aparecimento do broto mamário (telarca), o estágio M2 de Tanner. O intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser de 2-2,5 anos, quando as mamas estão em M3-M4 (mais comumente M4). Em geral, quando a menarca não ocorre em até cinco anos após a telarca, pode ser recomendada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uma investigação. Porém, é descrito que o intervalo entre os eventos pode chegar a seis anos. Considerando que a telarca pode ter ocorrido aos oito anos de idade, a menarca pode ainda acontecer, sem que seja necessário nenhuma investigação no momento. Portanto, a adolescente apresenta uma puberdade fisiológica, bastando orientar os pais à respeito da evolução natural do quadro. Resposta letra A.

315174.

Comentário: Temos aqui um cenário clássico de um bebê que aos 30 dias de vida apresenta dificuldades com a amamentação. Nesse sentido, a grande dúvida é em relação suplência do leite materno, pergunta que na maioria das vezes é respondida avaliando-se a técnica da amamentação (pega e posicionamento) e a progressão dos dados antropométricos, especialmente o peso. Independentemente, perceba que a banca já afirmou no enunciado que o bebê está normal ao exame físico, ou seja, consideramos que o ganho de peso está adequado. Logo, devemos incentivar a manutenção do aleitamento materno exclusivo, mas focando na correção das técnica de pega, postura e posição, para compreender o porquê o bebê não realiza mamadas mais prolongadas. Não há indicação, neste momento, de introdução de complementação com fórmula láctea. Resposta letra A.

315175.

Comentário: A banca trouxe afirmativas sobre o tema aleitamento materno, mas era fácil reconhecer a correta. As opções B e E estão erradas cabe lembrar que as crianças em aleitamento materno exclusivo, o que é recomendado pelos primeiros seis meses de vida, não devem receber água ou outros tipos de líquidos e alimentos sólidos. A alimentação complementar será iniciada após este período e a suplementação de ferro se iniciará aos 6 meses, sendo antecipada somente para lactentes de risco, com baixo peso ao nascimento ou com antecedente de prematuridade. A opção A também está errada além da doença diarreica, a proteção da amamentação contra infecções respiratórias e otite média foi demonstrada em vários estudos. A letra D também esta errada a criança irá recuperar o ganho de peso gradualmente e o leite de vaca não deve ser utilizado para este fim, visto que a sua introdução precoce aumenta a possibilidade de desmame,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

além do risco de alergias. Por fim, a alternativa correta, a letra C o leite humano possui vários fatores imunológicos específicos e não específicos que conferem proteção ativa e passiva contra infecções nas crianças amamentadas. A IgA secretória é a principal imunoglobulina, que atua contra microrganismos que colonizam ou invadem superfícies mucosas. Outros fatores de proteção que se encontram no leite materno são leucócitos, que matam microrganismos lisozima e lactoferrina, que atuam sobre bactérias, vírus e fungos oligossacarídios (mais de 130 compostos), que previnem ligação da bactéria na superfície mucosa e protegem contra enterotoxinas no intestino, ligando-se à bactéria fator bífido, que favorece o crescimento do Lactobacilus bifidus na criança, uma bactéria saprófita que acidifica as fezes, dificultando a instalação de bactérias que causam diarreia. Resposta letra C.

315176.

Comentário: Sabemos que o volume de leite produzido tem relação direta com a sucção do bebê e esvaziamento da mama. É por isso que o aleitamento materno deve ser exclusivo e em livre demanda Caso não haja sucção adequada, a produção do leite pode ser afetada na mama comprometida, com diminuição do volume secretado. É claro que além da sucção frequente, outros estímulos sensoriais também são capazes de levar à liberação da ocitocina. Porém, para que a produção se mantenha, é fundamental a sucção e o esvaziamento. Todas as demais medidas citadas podem aumentar a produção láctea, mas a sucção frequente é a medida mais eficaz. Resposta letra A.

314206.

Comentário: Uma das grandes funções pediatra que trabalha com puericultura é o acompanhamento da criança para que ela cresça com saúde e integrada em seu ambiente, de modo que ao final do crescimento e do desenvolvimento atinja a idade adulta com saúde. Cabe ao pediatra orientar sobre os malefícios dos hábitos familiares negativos, tais como alimentação inadequada, sedentarismo e tabagismo passivo. Apenas orientar viagens anuais com a família não faz parte das suas atribuições. Resposta letra A.

313444.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A questão envolve abordagens no cuidado e qualidade para alcançar resultados no controle de sintomas no paciente pediátrico. Todas as alternativas estão corretas, com exceção da alternativa B, por um motivo claro. Não são apenas medidas farmacológicas que auxiliam no cuidado para controle o dos sintomas. Existem diversas medidas, como a prática de algumas atividades físicas, fisioterapia, fonoterapia e psicoterapia, que podem auxiliar no controle dos sintomas. Resposta letra B.

313445.

Comentário: Durante um atendimento pediátrico, temos que valorizar tanto os sinais quanto os sintomas apresentados pelo paciente. Os sinais são dados objetivos e verificáveis pelo médico. Já os sintomas, são relatos subjetivos, cabendo ao médico interpretar e associar aos sinais para chegar a um diagnóstico correto. Portanto, a única manifestação clínica, dentre as apresentadas, que apresenta um dado subjetivo que não pode ser verificado pelo avaliador é a dor abdominal. Resposta letra D.

307062.

Comentário: A cabergolina é um derivado da ergotamina, que atua como agonista dopaminérgico na hipófise. O estímulo dopaminérgico é inibitório para a secreção de prolactina, hormônio responsável pela produção de leite. Logo, ao utilizar um agonista dopaminérgico, há inibição da prolactina e inibição da produção de leite pelas glândulas mamária. Vale lembrar que a cabergolina também é utilizada nos casos de hiperprolactinemia. Resposta letra A.

280410.

Comentário: A síndrome de Klinefelter resulta de um cromossomo X a mais em um paciente masculino, sendo a causa mais comum de hipogonadismo primário no sexo masculino. As principais características clínicas são sinais de atraso puberal e ginecomastia, além de alta estatura e testículos pequenos. A síndrome de Kallmann é causada por uma mutação no gene ANOS1 localizado no cromossomo X, cursando com deficiência de GnRh. As marcas clínicas da doença incluem anosmia, criptorquidia, testículos pequenos e ginecomastia. Por fim, a síndrome de Peutz Jeghers é um distúrbio autossômico dominante causado por uma mutação no cromossomo 19. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

principal marca clínica são os pólipos no tubo digestivo, mas o excesso de estrógenos e testosterona também podem causar ginecomastia, puberdade precoce, crescimento acelerado e tumor testicular. Não há correlação da síndrome de Down com ginecomastia. Resposta letra A.

278094.

Comentário: Vejamos as alternativas A letra A está correta essas crianças realmente apresentam maior risco de desenvolver atelectasias pulmonares, devido à alteração na complacência pulmonar, que geralmente está reduzida. A letra B está incorreta a escala de Bayley consiste em instrumento adequado para a avaliação de crianças de um a 42 meses de idade (com e sem deficiências) e são amplamente reconhecidas e utilizadas em estudos sobre o desenvolvimento infantil. Já a Escala Infantil Motora de Alberta é um protocolo objetivo utilizado para a triagem dos bebês com atrasos motores, para nortear a intervenção dos profissionais do setor de fisioterapia e dar orientação aos pais sobre as posturas a serem estimuladas em domicílio com o objetivo de alcançar a evolução do desenvolvimento motor da criança. A letra C está incorreta existem outras escalas para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente a escala de denver. A letra D está incorreta pacientes hospitalizados (principalmente os mais acamados ou em internação prolongada) têm seu sistema neuromusculoesqueléticos altamente prejudicados indiretamente. Isso ocorre pela limitação de uso de musculatura, tanto pela restrição ao leito quanto pela doença, assim como pela limitação de estímulos oferecidos durante o período de internação. Resposta letra A.

275994.

Comentário: A avaliação dos parâmetros antropométricos faz parte de toda consulta de puericultura - é importante que saibamos reconhecer o padrão normal de crescimento, para que alterações sejam detectadas precocemente. Em relação ao peso, é esperado que a criança triplique o peso de nascimento com 1 ano de vida. Nesse caso, se o paciente nasceu com 3,4 kg, esperamos que aos 12 meses apresente um peso de 10,2 kg. Em relação a estatura, a velocidade de crescimento no primeiro ano de vida é de 25 cm ano (15 cm no primeiro semestre e 10 cm no segundo semestre). Portanto, é esperado que esse paciente tenha 75 cm de estatura aos 12 meses. Por fim, o perímetro cefálico cresce cerca de 12 cm no primeiro ano de vida (2 cm mês no primeiro trimestre,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1 cm mês no segundo trimestre e 0,5 cm mês no segundo semestre). Esperamos então que o PC seja de 47 cm aos 12 meses. Resposta letra A.

275995.

Comentário: Enunciado cheio de enrolação para fazer uma pergunta simples qual a sequência esperada dos eventos puberais em meninas O primeiro sinal de puberdade em meninas é o surgimento do broto mamário, denominado telarca. Em seguida, ocorre a pubarca (surgimento dos pelos púbicos) e, por fim, a menarca (primeira menstruação). O intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser de 2 a 2,5 anos, quando as mamas estão em estágio M3-M4 de Tanner. O início do desenvolvimento sexual em meninas é considerado normal quando ocorre entre 8 e 13 anos de idade, por isso não há motivo para preocupação com a paciente em questão. Se a telarca ocorrer aos 11 anos, é esperado que a menarca ocorra entre os 13 e 14 anos. Resposta letra C.

283746.

Comentário: Durante o primeiro ano de vida, o ganho esperado de perímetro cefálico é de 2 centímetros mês no primeiro trimestre (6 cm), 1 centímetro mês no segundo trimeestre (3 cm) e de 0,5 cm mês no último semestre (3 cm). Portanto, espera-se um ganho de 10 centímetros nessa medida do nascimento até o presente momento, ou seja, 44 centímetros na medida total. Resposta letra C.

283747.

Comentário: Apesar de muitas questões sobre esse tema apresentarem problemas, por haver muita divergência na literatura em relação à idade limite para os marcos do desenvolvimento, nessa aqui não há margem para discussão. Esperamos que aos 7 meses, a criança já seja capaz de transferir objetos de uma mão para outra, portanto esse bebê de 8 meses já deve ser capaz de realizar este movimento. Só aos 15 meses é que a criança é capaz de empilhar cubos. O movimento de pinça incompleto é realizado aos 10 meses e completo aos 12 meses, mesmo período em que a criança começa a levantar-se sozinha. Resposta letra C.

249289.

Comentário: Questão direta aqui O objetivo do acompanhamento ambulatorial do prematuro é a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

chance de detecção de possíveis desvios do crescimento normal, principalmente quanto ao peso, comprimento e perímetro cefálico. Além disso, muito importante também - apesar de não citado na questão, é o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor deste bebê. Resposta letra C.

249291.

Comentário: Tanto durante a formação embrionária-fetal comodurante o desenvolvimento infanto-juvenil, o cérebro perpassa por fases de crescimento heterogêneas, com certas regiões sendo impulsionadas ao crescimento e amadurecimento em diferentes épocas. A trajetória do desenvolvimento está atrelada também à carga genética, porém grande parte da influência sobre o desenvolvimento cerebral deriva do ambiente que se foi exposto durante os períodos críticos do crescimento. Já é na descrito na literatura científica que os primeiros 1000 dias de vida - incluindo o período fetal e embrionário , por alguns denominados fase neonatal e também primeira infância, é um período de grande remodelamento cerebral. Até os 2-3 anos de idade, o infante já desenvolveu cerca de 90% do cérebro que terá quando adulto e a repercussão disso na prática da pediatria se encontra de forma perfeitamente expressa na letra B.

249905.

Comentário: Boa questão sobre nutrição materna e infantil. Vamos, então, analisar as opções Letra A- INCORRETA. Apesar de a alimentação variar enormemente, o leite materno, surpreendentemente, apresenta composição semelhante para todas as mulheres que amamentam do mundo. Apenas os casos de mulheres com desnutrição grave podem ter o seu leite afetado na sua qualidade e ou quantidade. Assim, apenas uma nutrição deficiente não leva a repercussões no sistema motor da criança. Letra B- CORRETA. Considerando o período gestacional, uma nutrição materna e infantil inadequadas pode trazer prejuízo importante no desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. Letra C- INCORRETA. Não há relação de anemia no primeiro trimestre com o prejuízo do crescimento infantil. Letra D- INCORRETA. O estado nutricional da gestante pode atuar como um fator de risco para problemas comportamentais na idade escolar. Resposta letra B.

249303.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos aproveitar essa questão difícil para relembrar a classificação de Simon de 1973 para ginecomastia. Grau I e pequeno aumento mamário visível nenhuma redundância de pele Grau IIA aumento mamário moderado sem redundância de pele Grau IIB aumento mamário moderado com redundância de pele Grau III aumento mamário moderado com redundância de pele definida (mama feminina pendentes) . Resposta letra C.

249404.

Comentário: Boa questão sobre semiologia aqui Note que, embora tenha aparecido na prova de pediatria, alguns itens nos cobraram a semiologia geral clássica que estamos acostumados. Letra A Como é difícil a colaboração e a compreensão dos pequenos pacientes , aproveita-se o momento em que o abdome tem menor tensão - o momento da expiração. CORRETA Letra B Como a dor irá proporcionar um tônus maior na parede do abdome, além de poder levar ao choro do paciente, deixa-se a região sabidamente dolorosa para o fim. CORRETA Letra C Justamente a fim de evitar gerar uma sensação dolorosa e desconfortável, usa-se a mão espalmada no exame do abdome. INCORRETA Letra D A abordagem global facilita a conduta prospectiva antes de se correr o risco de atingir algum órgão doloroso num primeiro momento. CORRETA Gabarito letra C.

231388.

Comentário: Como o enunciado citou as estratégias profiláticas criadas no Brasil para deficiência de ferro, vamos seguir as recomendações doMinistério da Saúde. Com relação a gestante, recomenda-se a administração de ácido fólico na dose de 5 mg dia a partir de 90 dias antes da concepção e até no mínimo 14 dias de gestação, apesar de muitos autores recomendam seu uso até o final da gravidez, sobretudo para evitar defeitos do tubo neural. Com relação ao ferro, recomenda-se que toda gestante receba 30 a 60 mg de ferro elementar ao dia, na forma de sulfato ferroso, durante o segundo e terceiro trimestres da gestação, durante toda a lactação, ou por dois a três meses pós-parto nas não lactentes. Já para o lactente, recomenda-se que lactentes nascidos a termo e com peso adequado para a idade gestacional devem ser suplementados com 1mg kg dia de ferro elementar entre 6 e 24 meses, que é distoante a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda a suplementação a partir dos 3 meses de idade. Por fim, segundo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê quantidades mínimas de ferro e ácido fólico para cada uma das farinhas, recomenda-se que as farinhas de trigo e de milho sejam enriquecidas com 4 a 9 mg de ferro para cada 100g de produto e com 140 a 220 µg de ácido fólico também para cada 100g de farinha. Desta forma, concluimos que a questão não apresenta resposta e deveria ser anulada. No entanto, a banca considerou a alternativa B como o gabarito oficial.

201763.

Comentário: Sabemos que após o nascimento e a saída da placenta, ocorre aumento da secreção de leite e aumento da produção de ocitocina que atuará na ejeção. A apojadura se dá independente da sucção do mamilo, por volta do 3º e 4º dia. Em seguida, para a manutenção da produção e ejeção do leite existe a necessidade da sucção do mamilo para que haja o estímulo da hipófise anterior a produzir prolactina. Da mesma forma, a hipófise posterior também sofre estímulo para produzir a ocitocina, responsável pela ejeção do leite. Logo, sem a sucção do bebê, esta cascata de eventos hormonais não ocorrerá. Sendo assim, a sucçao frequente é o melhor estímulo para garantir uma boa produção de leite pela nutriz. Resposta letra A.

201764.

Comentário: A puberdade tardia ou puberdade atrasada ou atraso puberal é definida pela ausência do desenvolvimento puberal após 13 anos em meninas e após 14 anos em meninos. Resposta letra C.

215513.

Comentário: Temos aqui um caso típico de uma criança saudável, com crescimento e desenvolvimento adequados à idade. Lembre-se de que, apesar de a maioria das crianças andar com 12 meses, este marco pode ser atingido sem representar doença até os 18 meses de vida. O controle esfincteriano só é atingido entre 2 e 4 anos, e o leite materno é o leite necessário para ela até os 2 anos ou mais (apesar de culturalmente o leite de vaca ser introduzido precocemente nos primeiros dois anos de vida). Resposta letra C.

219915.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Segundo Código de Ética Médica brasileiro (2010), temos que É vedado ao médico Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Parágrafo único. Permanece essa proibição a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito. Sendo assim, a única alternativa correta é a letra D.

219896.

Comentário: Sobre orientações do Ministério da Saúde quanto à alimentação saudável, responda as alternativas A) CORRETA Os alimentos devem ser preparados separadamente até os 8 meses, quando, então, a criança poderá receber a alimentação da família, desde que com poucos temperos. B) ERRADA O leite materno deve ser mantido até os 2 anos de idade ou mais, mesmo que complementado por outros alimentos. C) ERRADA Conforme a alternativa A. D) ERRADA Um mesmo alimento deve ser oferecido de oito a dez vezes até que se possa afirmar sobre preferências e intolerâncias. Resposta letra A.

212202.

Comentário: Vejamos as alternativas A) Incorreta. A escuta é fundamental, porém, a exposição das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vantagens é de suma importância quando falamos de aconselhamento. B) Incorreta. Em casos em que o aleitamento materno é contraindicado, é obrigatório que o preparo da fórmula seja claramente orientado ainda na maternidade. C) Incorreta. Mães inseguras quanto às vantagens do aleitamento materno devem ser ouvidas e esclarecidas, porém, a liberação para a alta não está vinculada apenas a alimentação com leite materno exclusivo. D) Incorreta. Deve-se lembrar sempre que o aleitamento materno é um direito da mulher e não uma obrigação. Assim, a exposição das vantagens e benefícios desta prática deve ser feita de forma empática, porém sem julgamentos e respeitando as limitações e decisões maternas. E) Correta. É importante entender a diferença entre o simples ato de aconselhar e aconselhamento. Aconselhar ou dar conselho é dizer à pessoa o que ela deve fazer aconselhamento é uma forma de atuação do profissional com a mãe em que ele a escuta, procura compreendê-la e, com seus conhecimentos, oferece ajuda para propiciar que a mãe planeje, tome decisões e se fortaleça para lidar com pressões, aumentando sua autoconfiança e autoestima. Resposta letra E.

212177.

Comentário: Nos estágios de Tanner em meninas há o crescimento do broto mamário em M2, crescimento da mama e aréola sem separação dos contornos em M3, crescimento e projeção da aréola e da papila formando uma elevação acima do corpo da mama em M4 e o estágio adulto em M5 (I correta). Quanto aos meninos, há início do aumento dos testículos e do escroto em G2, com textura mais fina e avermelhada, crescimento do pênis em comprimento em G3 e em diâmetro em G4 e em G5 temos uma genitália adulta. Quanto à pilificação nos meninos, há o crescimento de pelos finos, lisos e discretamente pigmentados ao longo da base do pênis em P2 eles se tornam mais espessos e pigmentados em pequena quantidade na sínfise púbica em G3 em G4 está quase na conformação adulta, poupando apenas a raiz das coxas, que surge em G5 (II correta). Portanto, afirmativa III incorreta. Resposta letra C.

180119.

Comentário: A questão apresenta uma bebê, filho de mãe de primeira viagem e que encontra-se em aleitamento materno exclusivo. Na avaliação, a mãe queixa-se que o bebê mama o tempo todo,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não ganhou peso de forma adequada, porém com exame físico normal. Qual será a causa do insucesso desse bebê no primeiro mês Muito provavelmente está relacionado à pega e ou posição incorreta durante a amamentação. Para tal, devemos observar a mamada da criança e a mãe deve ser adequadamente orientada quanto à técnica correta de amamentação, corrigindo os erros e estimulando a persistência do aleitamento materno exclusivo. Das alternativas, a única que apresenta uma resposta relacionada a técnica de amamentação é a letra A.

180129.

Comentário: A- Incorreta. O leite materno é protetor não apenas de infecções gastrointestinais, mas também de doenças respiratórias. B- Incorreta. A recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde é de que o aleitamento materno exclusivo seja mantido até os 6 meses. C- Correta. São muitos os fatores imunológicos presentes no leite humano que protegem a criança contra infecções. O principal anticorpo é a IgA secretória. Os anticorpos IgA do leite materno protegem a criança contra os germes prevalentes no meio em que a mãe vive. Outros fatores de proteção são os anticorpos IgG e IgM, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisozima e fator bífido. D- Incorreta. Essa afirmativa não é uma verdade absoluta. Muitas crianças com baixo peso podem ser mantidas em aleitamento materno exclusivo. Somente casos selecionados serão indicados a receberem complementação com fórmula láctea. E- Incorreta, como vimos anteriormente. Resposta letra C.

180132.

Comentário: Com o nascimento e saída da placenta, ocorre o aumento da secreção de leite e aumento da produção de ocitocina que atuará na ejeção. A apojadura se dá independente da sucção do mamilo, por volta do 3º e 4º dias. Em seguida, para a manutenção da produção e ejeção do leite existe a necessidade da sucção do mamilo para que haja o estímulo da hipófise anterior a produzir prolactina. Da mesma forma, a hipófise posterior também sofre estímulo para produzir a ocitocina, responsável pela ejeção do leite. Logo, sem a sucção do bebê, esta cascata de eventos hormonais não ocorrerá. Sendo assim, a sucçao frequente é o melhor estímulo para garantir uma boa produção de leite pela nutriz. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187762.

Comentário: A comunicação em pediatria possui características peculiares comparadas aos pacientes adultos, visto que a criança está em processo de desenvolvimento cognitivo, social e psicológico, além de possuir adultos responsáveis pela sua saúde. Na pediatria, aquele a quem se chama de paciente não é uma criança, e sim a mãe, o pai ou o cuidador. Na realidade, é com a mãe ou o pai a quem o médico constrói a relação médico-paciente de fato (opção A correta). Nas últimas décadas, apesar do grande avanço tecnológico permitir um diagnóstico e um tratamento médico com sucesso, a insatisfação dos pacientes com os médicos vem crescendo, principalmente relacionados com o modo insensível, impessoal e áspero do atendimento médico recebido (D incorreta). Na pediatria, referir-se à mãe do paciente como mãe e não por seu nome é um exemplo da impessoalidade do atendimento (letra B incorreta). A opção C também é incorreta, uma vez que o pagamento direto pelos serviços médicos aumentou a aquisição de direitos sobre o pediatra. Resposta letra A.

187811.

Comentário: Questão bem difícil, mas vamos lá A) CORRETA. Em relação à profilaxia para anemia ferropriva, é importante que você saiba o seguinte os lactentes nascidos a termo e com mais de 2.500g devem ser mantidos em aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, após essa idade, devemos iniciar a introdução da alimentação complementar e o oferecimento de ferro (1 mg kg dia de ferro elementar até os 2 anos de idade). Não necessitam desta profilaxia somente as crianças que receberem mais do que 500 ml dia de fórmula infantil. Já as crianças nascidas pré-termo ou com menos de 2.500g devem receber a profilaxia a partir de 30 dias de vida, independentemente do regime alimentar. B) INCORRETA. Sabemos que o espinafre é um alimento rico em ferro, porém não possui grandes quantidades, cerca de 3,3 mg 100g. Temos outros alimentos com quantidades maiores de ferro, quando comparado ao espinafre ovo (5,5), fígado bovino (8,2), miúdos de galinha (4,3), feijão (7,0), cereais matinais (12,5), entre outros... C) INCORRETA. O feijão possui um teor relativamente alto de ferro (7 mg 100g), porém o mineral é pouco absorvido (baixa biodisponibilidade), devido a presença de filatos e taninos que inibem a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

absorção do ferro. Uma estratégia para melhorar a biodisponibilidade é o remolho e a retirada da película (peneiração após cozimento). D) INCORRETA. Como vimos, a reposição de ferro só não é indicada para os bebês que fazem uso de pelo menos 500 ml dia de fórmula infantil. Resposta correta letra A.

182759.

Comentário: O termo cognição é sinônimo de ato ou processo de conhecimento , ou algo que é conhecido através dele , o que envolve a coativação integrada e coerente de vários instrumentos ou ferramentas mentais, tais como atenção percepção processamento (simultâneo e sucessivo) memória (curto termo, longo termo e de trabalho) raciocínio, visualização, planificação, resolução de problemas, execução e expressão de informação. Resposta letra D.

182764.

Comentário: O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO é um processo contínuo que acontece durante a infância, especialmente nos primeiros 2 anos de vida, fase de intensa sinaptogênese (formação de conexões neurais). Diversos fatores podem influenciar positiva ou negativamente o desenvolvimento neuropsicomotor global, tais como prematuridade, crescimento intrauterino restrito, asfixia pré-natal, perinatal ou pós-natal, desnutrição proteico calórica grave, privação psicoafetiva, dentre outros. Contudo, o neonato grande para a idade gestacional, seja por diabete materno, obesidade materna, causas genéticas ou constitucionais, não apresenta risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Resposta letra B.

182776.

Comentário: Vamos analisar as opções acerca do DESENVOLVIMENTO COGNITIVO INFANTIL A CORRETA. É durante o período fetal que ocorrem a embriogênese do sistema nervoso. Na quarta semana de vida tem início a formação da placa neural, e já na quinta semana formam-se a 5 vesículas precurssoras do encéfalo (telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mieloencéfalo) por volta da 20º semana ocorre a proliferação neuronal, e em seguida os processos de migração neuronal, organização cortical e desenvolvimento cortical. Por volta do terceiro mês de vida pós-natal ocorre a proliferação das células da glia, e até o segundo ano de vida completa-se a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mielinização. Os dois primeiros anos de vida pós-natal são marcados por intensa mielinização, crescimento multiplicação de dendritos e axônios e formação de sinapses. Todo esse crescimento e desenvolvimento é particularmente vulnerável aos agravos ambientais. B INCORRETA. Nutrição, estímulo psicoafetivo e doenças são todos fatores externos que influenciam o desenvolvimento do sistema nervoso. C INCORRETA. O cérebro tem capacidade limitada de se recuperar após um quadro de desnutrição grave ou privação psicoafetiva. D INCORRETA. Todas as habilidades cerebrais tornam-se prejudicadas durante um agravo nutricional ou doença grave motor, motor fino, adaptativo, linguagem e pessoal-social. RESPOSTA LETRA A.

182785.

Comentário: A- Correta. A desnutrição nos primeiros dois anos de vida, período de maior crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso central, pode estar associada a alterações do desenvolvimento da linguagem e do aprendizado. B- Correta. O grande perigo da deficiência de ferro é que ela é, na maioria dos casos, silenciosa, e sua importante e grave consequência é a chance de um pior desenvolvimento cognitivo durante a infância. C- Correta. A dieta materna influencia as variações no conteúdo de gordura do leite materno e, por essa razão, é tão importante uma alimentação equilibrada por parte da lactante nesta fase. Mães desnutridas, por exemplo, podem apresentar leite pobre em gordura. D- Incorreta. Não há esta relação entre maior número de gestações e maiores concentrações de gordura no leite materno. Resposta letra D.

181413.

Comentário: A questão pede a alternativa correta em relação a puberdade precoce. Vamos a elas Letra A incorreta. A radiografia de mãos e punhos é utilizada para a determinação da idade óssea. Porém, esta avaliação não faz parte da avaliação de Tanner, que classifica, para o sexo feminino, o desenvolvimento mamário e a distribuição e quantidade de pelos pubianos e, para o sexo masculino, o aspecto dos órgãos genitais e também a distribuição e quantidade de pelos pubianos. Letra B incorreta. Os critérios que avaliam o desenvolvimento mamário e a distribuição e quantidade de pelos pubianos são os critérios de Tanner. Letra C correta. A puberdade precoce central ou verdadeira se instala por estímulo do GnRH havendo uma ativação do eixo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipotálamo-hipófise-ovário e resultando em desenvolvimento puberal com padrão semelhante à puberdade fisiológica. Letra D incorreta. A puberdade precoce periférica é independente do estímulo de GnRH. O desenvolvimento puberal é estimulado por esteroides sexuais endógenos ou exógenos, não dependentes das gonadotrofinas hipofisárias. Letra E incorreta. Entre as pausas de puberdade precoce periférica estão tumores de ovário secretores de estrogênio, cistos de ovário secretores de estrogênio, tumores feminilizantes da adrenal e Síndrome de McCune-Albright. Resposta letra C.

181401.

Comentário: Dentre as contraindicações listadas, a única que configura como absoluta é a galactosemia, doença causada por deficiência de enzimas envolvidas no metabolismo da galactose, que é um dos monossacarídeos responsáveis pela formação da lactose, que está presente no leite materno. A mastite e o ingurgitamento são problemas relacionados a técnica de amamentação e a conduta nesses casos é manter o aleitamento, corrigir os erros presentes de posição e pega ao seio, além de cuidados específicos de cada patologia. A fissura labiopalatal dificulta o aleitamento diante do defeito anatômico, mas não representa uma contraindicação, principalmente após a sua correção. Por fim, a doença da urina de xarope de bordo cursa com déficit na atividade do complexo desidrogenase dos cetoácidos de cadeia ramificada, mas que é possível manter a amamentação com modificações na dieta materna, que incluem uma menor ingesta de proteica e restrição da ingesta de cetoácidos de cadeia ramificada. Resposta letra A.

152625.

Comentário: As principais contraindicações maternas absolutas à amamentação são a infecção pelo HIV e HTLV-1 e 2. Existem, também, algumas condições maternas que contraindicam temporariamente a amamentação, tais como hanseníase virchowiana não tratada ou hanseníase em tratamento inferior a 3 meses, herpes simples na mama afetada, varicela materna 5 dias antes até 2 dias após o parto (o leite poderá ser ordenhado e oferecido à criança), fase aguda da doença de Chagas, leptospirose, listeriose e brucelose. Resposta letra A.

161276.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos relembrar algumas complicações relacionadas à sobrecarga de ferro fadiga, artralgia artrite, dor abdominal, diminuição da libido ou impotência, perda de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, baixa estatura e artropatia, cirrose hepática e insuficiência hepática adelgaçamento e hiperpigmentação da pele, hipogonadismo hipogonadotrófico, diabetes mellitus e hipotireoidismo, miocardiopatia (dilatação e hipertrofia cardíaca), arritmia (ventricular, supraventricular, taquiarritmia paroxística, flutter atrial, fibrilação atrial e bloqueio atrioventricular) e insuficiência cardíaca, que podem ser agravadas quando concomitantes a outras condições como miocardite e hipertensão pulmonar. Agora ficou fácil. Resposta letra B.

158801.

Comentário: Vamos analisar cada marco separadamente A) Errado. Uma criança de 9-10 meses é capaz de realizar sons consonantais (mama, papa) e, aos 12 meses, deve falar uma ou duas palavras além de mama e papa. Logo, não consegue falar quatro palavras. B) Errado Por volta dos 9 10 meses que começa a olhar quando chamado pelo nome. Algumas podem até obedecer ordens simples, mas normalmente tal marco ocorre após o primeiro ano de vida. C) Correto A preensão em pinça já é um marco esperado para esta faixa etária, pois por volta dos 9-10 meses tem que conseguir pegar objetos com o polegar o indicador. Sem realizar tal marco, a criança apresenta um sinal de alarme para atraso do desenvolvimento. D) Errado A ausência de sinergia pés-mãos significa que a criança seja capaz de coordenar a mão ou o pé e que obviamente não é um marco esperado pela criança, visto que ela ainda não tem domínio completo da coordenação, sobretudo dos membros inferiores já que ela não anda. E) Errado A criança por volta dos 9-10 meses iniciará o movimento de arrastar ou engatinhar, sendo que este marco não é necessariamente obrigatório para todas as crianças, pois muitas delas iniciam a marcha sem passar por esta fase. No entanto, para subir em objetos ela deverá ter um controle maior do tronco, que é esperado após o primeiro ano de vida. Sendo assim, a resposta correta é a letra C.

158809.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre condutas do DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR INFANTIL I) Correta. Além disso, é capaz de pular, ouve e presta atenção

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

em histórias. II) Correta. Além disso, maior parte da fala é compreendida por desconhecidos e pode andar de triciclo. III) Correta. Além disso, imita rabiscos e faz torres de 4 cubos. As três AFIRMATIVAS estão corretas. Resposta letra A.

158825.

Comentário: Vamos avaliar as afirmativas sobre a absorção de FERRO I - INCORRETA. Os fitatos (cereais e legumes) diminuem a absorção intestinal de ferro. II - INCORRETA. Na dieta existem dois tipos de ferro ferro não heme (inorgânico), presente tanto em plantas quanto em tecidos animais, e ferro heme, presente na mioglobina e hemoglobina. Estima-se que o ferro heme contribua em 10 a 15% da ingestão de ferro, entretanto, é responsável por mais de 40% do ferro absorvido em decorrência de sua melhor e mais uniforme absorção (15 a 35%). A absorção do ferro não heme é de 2 a 10%. III - INCORRETA. O acido ascórbico e o acido cítrico melhoram a biodisponibilidade do ferro, reduzindo-o de férrico (2 oxidado) para ferroso (3 reduzido), além de seu efeito quelante. IV e V - CORRETAS. Resposta letra C

131399.

Comentário: A primeira fase de crescimento acelerado ocorre nos dois primeiros anos de vida, nos quais a velocidade de crescimento é de 15 cm ano, caindo para 7-8 cm ano na fase de pré-escolar e diminuindo ainda mais para 6-7 cm ano na fase escolar. A segunda fase de crescimento rápido ocorre na adolescência, por conta do estirão puberal, caracterizado por aumento na velocidade de crescimento, chegando a 10 cm ano nas meninas e 12 cm ano em meninos. Portanto, os dois picos de estirão de crescimento ocorrem na lactância e na adolescência. Gabarito letra B.

131403.

Comentário: Os diferentes tecidos do organismo também apresentam crescimento distinto de acordo com a idade. O tecido linfoide cresce pouco no primeiro ano, mas tem seu crescimento muito acelerado em seguida, involuindo após a puberdade. Já o tecido neural apresenta crescimento característico sua maior velocidade de crescimento se dá no primeiro ano de vida, com posterior desaceleração, sendo o primeiro tecido a parar de crescer, atingindo um platô no qual permanece por toda a vida. Gabarito letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131409.

Comentário: A resposta desta questão pode ser alcançada apenas utilizando-se o bom senso. Trata-se um lactente jovem, filho de uma mãe adolescente. Cada consulta deve ser conduzida de acordo com o paciente e o cenário ambiente familiar no qual ele está inserido, no sentido de captar as informações pertinentes de forma adequada e ser capaz de levar à mãe as informações necessárias de forma correta e simples, evitando ruídos na comunicação. Em se tratando de uma mãe muito jovem, é importante que o pediatra seja capaz de conquistar a sua confiança, o que contribuirá para que futuramente haja plena aceitação das orientações e condutas propostas. Muitas vezes não seremos capazes de obter a anamnese completa na primeira consulta. Mas temos que ter clareza para distinguir quais dados são indispensáveis para conduzirmos o caso da melhor forma, naquele momento. Gabarito letra C.

131421.

Comentário: Isso é algo rotineiramente observado nos ambulatórios de pediatria e não deve causar surpresa Existem lactentes que evacuam diversas vezes ao dia, após cada uma das mamadas. A causa disso é tão somente um reflexo gastrocólico exacerbado. Havendo bom ganho ponderal e ausência de outras manifestações, não há razão para investigar qualquer possível causa de diarreia crônica e, muito menos, suspender o aleitamento. Resposta letra E.

134879.

Comentário: Um dos problemas mais abordados nos ambulatórios de Pediatria se referem aos hábitos alimentares inadequados. Entre eles, está o abuso das fast foods, alimentos que apresentam um excesso de consumo calórico e de sódio, que podem levar a obesidade e hipertensão, além de baixos valores nutricionais. Desta forma, a resposta correta é a alternativa D

134792.

Comentário: Sobre as anemias carenciais temos A) Os achados laboratoriais da anemia ferropriva são ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina diminuídos e capacidade total de ligação do ferro aumentada. - Incorreta B) A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico acarretam uma anemia macrocítica, enquanto as talassemias cursam com anemia microcítica. - Incorreta C) Na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

esferocitose, a hemólise não está relacionada ao uso de drogas. Estes cuidados devem ser tomados no caso de deficiência de glicose-6-fosfato. Incorreta D) Vários fatores podem estar relacionados ao desenvolvimento de anemia ferropriva, como baixo peso ao nascer, prematuridade, desmame precoce e erros alimentares. Correta. Resposta letra D.

134795.

Comentário: Um lactente aos 3 meses de vida deve apresentar postura tônica cervical assimétrica, iniciando a sustentação da cabeça que ainda titubeia para alcançar o controle. As mãos podem alcançar a linha média, mas ainda não consegue segurar objetos por muito tempo. Já sorri ao contato social, presta atenção em músicas e inicia a vocalização. Desta forma, percebemos que o lactente da questão apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, havendo indicação de avaliação neurológica específica e investigação diagnóstica. Resposta letra D.

134272.

Comentário: Durante a adolescência e a puberdade, ainda que se trate de fase acelerada do crescimento (estirão puberal), caso o indivíduo seja saudável, sem comorbidades e apresente alimentação saudável, não é necessário o uso de qualquer suplementação (de vitaminas ou minerais). Estas ficam reservadas para os diagnósticos de hipovitaminose associados aos distúrbios alimentares (bulimia, anorexia). Gabarito letra D.

134801.

Comentário: Aos 12 meses de vida o bebê é capaz de levantar-se sozinho e permanecer de pé, caminhar com as mãos apoiadas, segurar objetos de forma segura utilizando a pega em pinça (com o polegar e o indicador), ajudar a vestir-se, bater palmas, colocar cubos em uma bacia e falar uma ou duas palavras com sentido. Resposta letra C.

134803.

Comentário: Sobre o desenvolvimento infantil temos as alternativas Letra A) O desenvolvimento neuropsicomotor da criança é dependente e influenciado por diversos fatores genéticos, ambientais, nutricionais, socioeconômicos e afetivos. INCORRETA Letra B) Os marcos do desenvolvimento encontrados em cada faixa etária podem ser variáveis de acordo com a literatura

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

consultada. Alguns autores relatam que aos 6 meses a criança já é capaz de sentar-se sozinha, enquanto outros advogam que esta habilidade se inicia apenas por volta do 9 mês. Letra C) O consumo de álcool durante a gestação está relacionado não só à síndrome alcoólica fetal, como a diversas alterações do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, dificuldades no aprendizado e déficit cognitivo. INCORRETA Letra D) As manifestações de linguagem iniciam, em geral, por volta do segundo e terceiro meses, com a vocalização e repetição de vogais isoladas. INCORRETA Por estarem as demais alternativas completamente incorretas, a melhor resposta é letra B.

134061.

Comentário: De acordo com a classificação do Ministério da Saúde através das curvas de peso idade recomendadas, temos estabelecido que crianças abaixo dos 5 anos de idade entre o percentil 0,1 e o percentil 3 (como o paciente da questão) são consideradas como baixo peso. A desnutrição grave é definida como presença de edema ou peso estatura abaixo de -3 desvios padrão (DP) e ou estatura idade abaixo de -3 DP da média, que não é o caso do paciente. O estado de alerta nutricional ocorre em crianças ainda dentro da faixa normal dos gráficos de peso idade, mas com tendência declinante em direção ao baixo peso ou excessivamente ascendente em direção à obesidade. Já o marasmo é um estado de má nutrição por deficiência calórica total, em geral, observado em menores de 1 ano e caracterizado por diversos sinais e sintomas. Única correta letra A.

134834.

Comentário: Uma menina apresenta o início do desenvolvimento puberal antes dos oito anos de idade, o que carateriza um quadro de puberdade precoce. Lembre-se de que a puberdade no sexo feminino pode ter início entre 8 e 13 anos assim, estar no estádio M2P2 aos sete anos configura uma precocidade do desenvolvimento puberal e indica a necessidade de avaliação. Na telarca precoce não haveria o surgimento da pilificação. Resposta letra A.

134055.

Comentário: Os recém-nascidos prematuros, ainda que extremos e de muito baixo peso, devem ter o crescimento acompanhado de forma regular, avaliando-se a eficácia da nutrição oferecida. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

forma mais adequada de realizar esta monitoração é através da utilização de curvas de crescimento atentando-se para a sua idade gestacional corrigida em relação ao nascimento, evitando erros de classificação. A dosagem sérica de albumina e creatinina são utilizadas na avaliação dos possíveis efeitos adversos da nutrição parenteral. Resposta letra C.

134267.

Comentário: A carência de ferro é a deficiência nutricional mais comum em países desenvolvidos e em desenvolvimento, constituindo um problema importante de saúde pública no Brasil e no mundo. A dieta pobre em ferro e o aumento da sua necessidade, devido ao crescimento, são causas importantes de deficiência de ferro, particularmente na infância. O ferro é encontrado em vários alimentos, tanto de origem animal (carnes de todos os tipos, leite e ovos), como vegetal (verduras de coloração verde escura, feijão, soja, entre outros). Entretanto, o que precisa ser evidenciado é a capacidade do organismo em aproveitar este ferro oferecido para exercer as suas mais diversas funções, o que determina a sua biodisponibilidade. Gabarito letra D.

110542.

Comentário: A maioria das crianças com deficiência de ferro é assintomática. Quando sintomática, a palidez é o sinal clínico mais importante da deficiência de ferro, porém não é normalmente visível até que a hemoglobina caia para 7-8 mg dl. Quando o nível de hemoglobina cai para menos de 5 mg dl, a irritabilidade, a anorexia e o desenvolvimento letárgico costumam aparecer. Pica, o desejo de ingerir substâncias não nutritivas, e o desejo de ingerir gelo (pagofagia) são sintomas sistêmicos da deficiência de ferro. Das manifestações descritas nas alternativas, a única que não é descrita na deficiência de ferro é a HIPERTROFIA das papilas gustativas. Na realidade, em qualquer anemia carencial (ferropriva e megaloblástica) pode ser observado um quadro de ATROFIA das referidas papilas (condição conhecida como glossite atrófica). Resposta certa C.

110604.

Comentário: A Síndrome de Down tem alterações fenotípicas clássicas hipotonia, braquicefalia, face plana, pregas epicânticas, ponte nasal achatada, pele redundante na nuca, dentre tantas outras. A língua é protuberante com a boca aberta mas não há macroglossia. As cardiopatias mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

associadas são defeito de septo atrioventricular, defeitos no septo ventricular, CIA, PCA e tetralogia e Fallot. Resposta letra C.

110571.

Comentário: A forma ideal de acompanharmos o crescimento na infância (peso e estatura) é através da construção de sua curva de crescimento e da comparação dos dados obtidos com os referenciais populacionais. Mas, também devemos memorizar o incremento esperado na estatura de uma criança, pois ajuda quando não temos os gráficos disponíveis, como nesse caso para aquelas entre 2 - 12 anos altura idade (anos) x 6 77. Nesse caso, a criança tem 6 anos e seis meses 6,5 x 6 77 116 cm seria a altura média esperada para idade. Essa criança apresenta exatamente 116 cm, possuindo, portanto, altura adequada. Em relação ao peso esperado para crianças de 1-6 anos Peso (kg) idade (anos) x 2 8 20 kg. Ou seja, a criança da questão está com o peso adequado e estatura adequada. Portanto, devemos tranquilizar a família e reavaliar o crescimento em 6 a 12 meses para cálculo da velocidade de crescimento. Gabarito letra A.

110574.

Comentário: Por volta dos seis meses de idade, a criança adquire a capacidade de rolar sobre seu eixo, sentar-se com apoio, inclinando-se com as mãos para frente, transferir objetos de uma mão para a outra, realizar pega com a palma radial, formar polissílabos vogais e também passa a preferir a mãe e gostar de espelho. Resposta letra C.

109773.

Comentário: A lactente apresenta crescimento (peso e estatura) adequado para sua idade, estando eutrófica segundo as curvas de crescimento. O perímetro cefálico em p50 também encontra-se dentro da normalidade. Em torno de 1 ano de idade, a criança é capaz de andar sem apoio e falar algumas palavras com sentido, podendo haver pequenas variações na idade de aparecimento destes marcos. Assim, seu desenvolvimento neuropsicomotor - mais especificamente suas condutas motora e de linguagem - também é satisfatório. A alimentação é variada e a criança ainda recebe o leite materno, que pode ser mantido até os dois anos ou mais, sendo complementado por outros alimentos. Não existe regra para se desfraldar uma criança, mas em geral, costuma ocorrer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entre 2 e 4 anos de idade quando a criança já apresenta capacidade física e maturidade emocional para tal. Portanto, temos uma lactente eutrófica, com desenvolvimento neuropsicomotor normal para a idade, que recebe alimentação corretamente. Gabarito letra D.

109994.

Comentário: Temos uma criança com baixo ganho ponderal e volume de dieta inferior ao ideal, vejamos porque Se considerarmos que uma criança nasce com peso médio de 3,4 kg e que, no primeiro trimestre, o esperado é um ganho de 25-30 g dia, o ganho de peso deverá ser entre 1,050-1,260 g, o que resulta em uma criança de 6 semanas pesando entre 4,45-4,66 kg. Além disso, a capacidade gástrica de um bebê varia entre 25-30 ml kg, logo essa criança deverá receber entre 100 e 120 ml de fórmula por refeição, de 3 3h, resultando em 800-900 ml dia. Logo, a consequência mais provável da ingestão diminuída é, como percebemos neste caso, o ganho de peso inadequado. Resposta correta letra C .

109808.

Comentário: De acordo com a SBP, até os seis meses deve-se manter o aleitamento materno exclusivo. A partir do sexto mês de vida, deve-se introduzir a alimentação complementar, mantendo-se o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais. A recomendação, portanto, é iniciar aos 6 meses no horário do almoço ou do jantar a primeira papa principal. As frutas in natura, preferencialmente sob a forma de papa, devem ser oferecidas nesta idade, amassadas, sempre em colheradas, ou espremidas. Portanto, resposta correta letra B .

86611.

Comentário: A- INCORRETA Em geral, as crianças nascem com 50 centímetros e crescem ao longo do primeiro ano de vida 50% do seu comprimento ao nascimento, apresentando uma velocidade de crescimento de 25 cm ano. O bebê triplica seu peso de nascimento com 12 meses, sendo o ganho de cerca de 6 kg. B- CORRETA Como vimos acima. C- INCORRETA No período do segundo ano de vida a criança tende a crescer cerca de 12 cm ano. D- INCORRETA Durante a fase escolar as crianças crescem em média 5 a 7 cm por ano. E- INCORRETA O estirão puberal é mais tardio e mais amplo no sexo masculino. O pico do estirão puberal nos meninos ocorre 2-3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anos mais tarde do que nas meninas, e dura 2-3 anos a mais, depois que as meninas já pararam de crescer. Isso justifica a diferença de estatura encontrada entre os sexos na vida adulta, que é em média de 13 cm. Resposta letra B.

86616.

Comentário: O desenvolvimento motor se dá no sentido craniocaudal e próximo distal, através de aquisições mais simples para mais complexas. O que se observa nos primeiros anos de vida é um controle progressivo das musculaturas contra a influência da gravidade, ocorrendo inicialmente a sustentação da cabeça, seguindo-se do tronco e, finalmente, aquisição da postura ortostática. O controle progressivo da musculatura dos braços e antebraços permite o engatinhar. A aquisição do movimento de pinça é importante evolutivamente ao nascimento a criança mantém-se com as mãos fechadas, e ao terceiro mês vemos uma capacidade de agarrar objetos, ainda incapaz de soltá-los, capacidade adquirida mais tardiamente. A conduta pessoal-social varia de acordo com o temperamento da criança e com o ambiente em que vive. Vamos ver com que idades os seguintes marcos são atingidos A - Sorriso e sustentação da cabeça 2 meses B - Transferência de objetos 7 meses pinça 12 meses C - Bater palmas, acenar 10 meses D - Tentar alcançar um brinquedo, chamar atenção por meio de um sorriso, vocalizar 6 meses E - Sentar sem apoio 10 meses balbuciar 7 meses. Resposta letra D.

86612.

Comentário: Antes de tudo qual o valor de hemoglobina que define anemia para uma criança de 6 anos Lembre-se de 5 a 7 anos, valores abaixo de 11,5 g dl definem anemia. E os índices hematimétricos Vamos relembrar os estágios da anemia ferropriva para alcançarmos a resposta. O primeiro estágio da deficiência de ferro caracteriza-se pela depleção do estoque do mesmo sem anemia, caracterizado pela queda da ferritina e do ferro na medula óssea. A eritropoiese deficiente em ferro ocorre quando os estoques começam a ser depletados e o ferro sérico começa a diminuir, a capacidade de ligação de ferro no soro (transferrina sérica) aumenta gradualmente, assim como as protoporfirinas, marcando o segundo estágio. Uma vez que a saturação de transferrina cai abaixo de 15 a 20%, a síntese de hemoglobina passa a ser prejudicada e algumas hemácias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

passam a ser microcíticas, justificando o aparecimento de anisocitose no sangue periférico, caracterizado pelo RDW alto. No terceiro estágio, em que há anemia ferropriva propriamente dita, a hipocromia e microcitose começam a se tornar mais evidentes. A microcitose é evidenciada pelo Volume Corpuscular Médio (VCM) diminuído. E os reticulócitos São as células precursoras das hemácias e podem estar normais (inicialmente) ou reduzidas na anemia ferropriva. Resposta letra D.

86617.

Comentário: Os reticulócitos são as células precursoras das hemácias, e podem estar normais (inicialmente) ou reduzidos na anemia ferropriva. Eles são o principal parâmetro para avaliação quanto à eficácia do tratamento, pois se elevam nos primeiros dias de reposição, atingindo um pico entre 5-10 dias. Mais tarde, com cerca de 2 semanas, a hemoglobina e o hematócrito começam a se elevar, normalizando próximo a 2 meses após início da terapia. Resposta letra B

86641.

Comentário: Vamos revisar aqui as contraindicações à amamentação, que não são muitas algumas drogas, como as antineoplásicas e imunossupressoras, substâncias radioativas, derivados do ergot em doses para enxaqueca casos graves de psicose puerperal, eclâmpsia ou choque lesões ativas na mama ou mamilo por herpes mães HIV, HTLV 1 e 2 positivas. Lembre-se de que a tuberculose ativa materna NÃO contraindica a amamentação, devendo a mãe utilizar máscara e a criança receber quimioprofilaxia. Em relação à criança, são contraindicações a galactosemia, em que a criança está impossibilitada de receber leite materno, de vaca e de cabra, podendo-se usar apenas o leite de soja, pois a doença é caracterizada por uma deficiência em desdobrar a lactose e a fenilcetonúria, em que o aleitamento materno deve ser suspenso por 5 dias em RN com fenilalanina 17 mg dl e, à medida que os níveis séricos forem caindo, o aleitamento pode ser reintroduzido aos poucos. A questão traz apenas opções referentes a medicações utilizadas pela mãe. Sabemos que o Ministério da Saúde divide as medicações para a lactação em 3 categorias drogas liberadas (que têm uso permitido, sem efeitos colaterais para o bebê), drogas usadas com cautela (quando se deve avaliar risco benefício de seu uso e acompanhar o lactente quanto a possíveis efeitos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

colaterais da droga) e drogas contraindicadas (de uso proibido). Vamos ver, então, as afirmativas 1- Falsa. A amiodarona é droga de uso proibido. 2- Verdadeira. Com raras exceções, os antineoplásicos são drogas contraindicadas durante a amamentação. 3- Verdadeira. A recomendação da dosagem do lítio e da função tireoidiana existe pelo risco de intoxicação e hipotireoidismo. 4- Verdadeira. A carbamazepina e o ácido valproico são drogas que podem ser utilizadas, liberadas para mães que amamentam. Resposta letra E.

86873.

Comentário: Guarde o conceito a causa mais comum de anemia na infância é a anemia ferropriva Os primeiros meses e anos de vida são caracterizados por um crescimento corporal intenso e grande aumento da massa eritrocitária. A quantidade de ferro necessária para atender a essa demanda é muito alta e frequentemente não é atendida apenas pela alimentação. Justamente por isso, a maioria absoluta das crianças é candidata ao uso de suplementos de ferro nos primeiros dois anos de idade. Apenas com base neste conceito, nossa principal hipótese já poderia ser esta, mas o enunciado nos traz mais informações. Identificamos a presença de fatores de risco para a anemia ferropriva, que é o tempo curto de aleitamento materno e o uso excessivo de leite de vaca. O leite de vaca associa-se com a anemia ferropriva por dois motivos em primeiro lugar, tem baixo teor de ferro e o ferro aí encontrado é mal absorvido em segundo lugar, crianças que recebem leite de vaca têm risco de apresentarem alergia ao alimento e evoluírem com perda sanguínea intestinal. Por fim, a avaliação complementar apresentada corrobora a suspeita além da anemia, há microcitose com índice de anisocitose aumentado, achados típicos dessa condição. Na talassemia, também haveria microcitose, mas não há RDW aumentado, pois todas as hemácias são igualmente pequenas. Resposta letra D.

86870.

Comentário: O primeiro sinal de puberdade no menino é percebido pelo aumento do volume testicular (3ml ou 4 ml de volume ou 2,5 cm no maior diâmetro), representado no estadiamento de Tanner por G2. O aumento testicular é seguido de pilificação pubiana e o crescimento do pênis, primeiro em comprimento e depois em diâmetro. A mudança vocal ocorre na fase mais avançado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do desenvolvimento genital. Nos meninos, o pico de velocidade geralmente no estadiamento G4, com 10 a 12 cm ano. Resposta A.

158438.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) Errada O aleitamento materno deve ser sob livre demanda, ou seja, quanto e quando o recém-nascido quiser. Caso mesmo interrompa a amamentação, mesmo acordado, a nutriz pode retirá-lo da mama. B) Errada Em caso de recém-nascido a termo que apresente boas condições de vitalidade ao nascimento, devemos estimular o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida. C) Errada O sangramento durante o parto não é contraindicação ao aleitamento materno. Somente duas doenças maternas que são contraindicações absolutas, que são as infecções maternas pelos vírus HIV ou HTLV 1 e 2. Existem outras doenças infectocontagiosas que apresentam contraindicações relativas ou necessidade de cuidados especiais, porém, caso a mãe não apresente qualquer intercorrência durante o parto, o aleitamento poderá ser iniciado e estimulado. D) Correta Para uma boa pega, o recém-nascido deve estar com a boca bem aberta, com a maior parte da aréola acima da boca do bebê. O lábio inferior deverá estar evertido (voltado para fora) e o queixo tocando a mama da mãe. E) Errada O recomendado é aplicar compressas frias nos intervalos entre as mamadas por até quinze minutos, para diminuir a produção láctea e assim, reduzir o volume das mamas exacerbado pelo ingurgitamento. Resposta letra D

158402.

Comentário: Vamos analisar às alternativas A) Correta A alimentação complementar deverá ser introduzida a partir do sexto mês de vida, tanto alimentos sólidos (em consistência pastosa, papas ou purês) e de alimentos líquidos (suco de frutas). B) Errada As frutas serão oferecidas a partir dos 6 meses de idade, tanto em forma de papas assim como sucos. No entanto, recomenda-se sempre a preferência da fruta in natura . C) Errada Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado até, no mínimo, por 2 anos. D) Errada Recomenda-se o uso de fórmulas infantis (de partida até os 6 meses e de seguimentos, dos 6 aos 12 meses de idade) para crianças que, por qualquer motivo, não poderão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser amamentadas. O leite de vaca integral só poderá ser oferecido após os 12 meses de idade. E) Correta A alimentação complementar a ser introduzida nesta idade é composta por cerais ou tubérculos, proteína animal, frutas, leguminosas e legumes. Como a questão apresentou mais de uma alternativa incorreta, a banca optou pela sua anulação.

158388.

Comentário: No sexo feminino, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do broto mamário - telarca (estágio M2 de Tanner). Geralmente ocorre entre 8 e 13 anos e é dependente principalmente da secreção de estrógenos. Em seguida ocorre a pilificação pubiana - pubarca, que é dependente dos andrógenos adrenais. Por último, ocorre a pilificação axilar. A menarca ocorre nas fases mais avançadas da maturação sexual (M3 E M4 de Tanner), cerca de 2 - 2 anos e meio após telarca. A ovulação pode ocorrer desde a menarca, mas normalmente os ciclos mestruais nos dois primeiros anos após menarca são anovulatórios e irregulares. Logo, gabarito letra D.

158399.

Comentário: Questão direta. Pouquíssimas são as situações que contraindicam uma mãe de amamentar. Dentre elas, podem ser citadas as sorologias positivas para HIV ou HTLV. As demais condições apresentadas nas alternativas não contraindicam a amamentação. No caso da tuberculose, deve-se apenas ter o cuidado do uso de máscara. Resposta letra B.

158433.

Comentário: Vamos analisar as alternativas no que se refere a promoção do aleitamento materno A) Correta A amamentação deve ser iniciada na primeira hora de vida, ainda na sala de parto, antes mesmo dos primeiros cuidados (banho, curativo umbilical, pesagem, etc) se a mãe e o recém-nascido estiverem em boas condições de saúde, favorecendo o contato pele a pele de ambos. Esse contato precoce entre mãe e filho está associado à maior duração do aleitamento materno exclusivo. Além disso, o reflexo da sucção da criança é mais ativo e enérgico nos primeiros 30 a 60 minutos após o nascimento. B) Errada O aleitamento materno deverá ser realizado sob livre demanda, ou seja, quando e quanto o recém-nascido desejar mamar. Desta forma, não devemos recomendar horários fixos e intervalos entre as mamadas. A única ressalva é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

que, nos primeiros dias de vida, deve-se orientar a mãe a oferecer o seio ao menor caso o mesmo demore mais de 3 horas para mamar. C) Errada A mãe não precisa passar qualquer substância nos mamilos, exceto o próprio leite que tem características cicatrizantes e hidratantes em caso de fissura mamilar. D) Errada Segue o já discutido na avaliação do item anterior. E) Errada Como o aleitamento materno é realizado sob livre demanda, não necessita de estímulo em um horário específico do dia, mas sim de acordo com a demanda da criança. Resposta letra A.

108597.

Comentário: No sexo feminino, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do broto mamário (telarca). A telarca é seguida pelo surgimento dos pelos pubianos (pubarca). A menina geralmente atinge o pico da velocidade de crescimento no estágio M3 de Tanner. A menarca é o evento seguinte, que ocorre cerca de 2 a 2,5 anos após a telarca, nos estágios 3-4 de Tanner. Resposta CORRETA letra D.

108610.

Comentário: Quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma lactente de 1 ano e 4 meses, esperamos que seja capaz de andar sem apoio, dê nome a objetos familiares, falando até 5 palavras, trocar objetos de mãos (esperado aos 7 meses), e colocar um objeto dentro de uma vasilha. No entanto, ainda não é esperado a capacidade de andar para trás, capacidade adquirida aos 18 meses de idade. Gabarito letra C.

108612.

Comentário: Aos 2 meses de idade, é esperado que uma criança eleve a cabeça quando em prona, sustentando-a no plano do corpo durante a suspensão ventral. Quando em posição supina, tem ainda postura tônica cervical assimétrica predominante e a cabeça pende quando é puxada para sentar. Nessa idade, é esperado ainda que a criança siga um objeto em movimento por 180º, tenha sorriso social, e expresse sons guturais. A fixação da face humana é um marco ainda do período neonatal, assim como a reação ao som. Resposta letra E.

108616.

Comentário: A SBP preconiza que lactentes a termo e AIG, em aleitamento materno exclusivo até

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

os 6 meses, recebam 1 mg kg dia de ferro elementar a partir do 6º mês (ou a partir do desmame do aleitamento materno exclusivo) até os 2 anos de idade. Caso o lactente a termo e AIG receba 500 ml dia de fórmula infantil, não há necessidade de suplementação de ferro. Lactentes que foram prematuros e ou com baixo peso ao nascer (menos que 2.500 g), devem receber 2 mg kg dia de Fe dos 30 dias até 1 ano de idade, e 1 mg kg dia após esse período, até completar 2 anos. Lactentes que foram prematuros e com muito baixo peso ao nascer (menos que 1.500 g), devem receber 3 mg kg dia de Fe dos 30 dias até 1 ano, e 1 mg kg dia após esse período, até completar 2 anos. Por fim, lactentes que foram prematuros e com extremo baixo peso ao nascer (menos que 1.000 g), devem receber 4 mg kg dia de Fe dos 30 dias até 1 ano, e 1 mg kg dia após esse período, até completar 2 anos. Resposta correta E .

327281.

Comentário: A quase totalidade dos recém-nascidos (RN) apresenta perda ponderal nos primeiros dias de vida. Dada essa grande frequência, os autores a denominam de perda fisiológica de peso. A maioria dos estudos sugere que a perda corresponde, principalmente, à redução de fluidos, mas também é consequência do uso, pelo RN, de tecido adiposo como fonte de energia. Nos primeiros 2-3 dias de vida, os RN amamentados exclusivamente perdem, em média, entre 5-7% do peso do nascimento. Os limites fisiológicos máximos de perda de peso para RN amamentados exclusivamente ao seio são controversos, mas em geral, pode ser considerado normal ou aceitável a perda ponderal de até 10%. Em um RN que nasceu pesando 3.400kg, esperaríamos uma perda máxima de 340g, mas houve uma perda de 400g, possivelmente relacionada a uma pega posição inadequada, visto que a mãe apresenta fissuras mamilares. Ao avaliarmos a técnica da amamentação devemos conferir uma série de parâmetros. Podemos simplificar essa avaliação pela análise de alguns pontos-chaves propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), da seguinte forma 1. Pontos-chaves do posicionamento adequado (Bebê bem apoiado Corpo do bebê próximo ao da mãe Bebê com cabeça e tronco alinhados - pescoço não torcido Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo) 2. Pontos-chaves da pega adequada (Boca bem aberta Lábio inferior virado para fora Mais aréola visível acima da boca do bebê Queixo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tocando a mama). São sinais de técnica incorreta de amamentação Bochechas do bebê encovadas durante a sucção Ruídos da língua Mama muito esticada ou deformada durante a mamada Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando a criança solta a mama Dor à amamentação. Resposta letra B.

327288.

Comentário: Temos uma criança de 1 ano com desenvolvimento motor, adaptativo, linguístico e social perfeitamente adequados. Vale lembrar que apenas aos 15 meses é esperado que a criança ande sem apoio (letra D incorreta). A partir dos 10 meses é normal que as crianças demonstrem ansiedade com estranhos, preferindo a presença dos pais, sem que haja qualquer implicação desse comportamento no diagnóstico de autismo precoce (letra B incorreta). Mudanças no padrão de sono, chamadas por alguns de regressão do sono (embora não representem uma regressão em si e sim uma mudança normal de padrão), ocorrem comumente em lactentes. Não há porque pensar em terror noturno, uma parassonia mais comum em crianças entre 3 e 7 anos (letra A incorreta). Os pais devem ser orientados e acolhidos em suas angústias, para que possam, por sua vez, acolher as necessidades desse bebê. Resposta letra C.

298249.

Comentário: Em relação ao desenvolvimento genital masculino, segundo os estágios de Tanner, temos que G1 Testículos, escroto e pênis de tamanho e proporções infantis. G2 Aumento inicial do volume testicular (3 a 4 mL). Pele do escroto muda de textura e torna-se avermelhada. Aumento do pênis pequeno ou ausente. G3 Crescimento do pênis em comprimento. Maior aumento dos testículos e do escroto. G4 Aumento do pênis, principalmente em diâmetro, e desenvolvimento da glande. Maior crescimento de testículos e escroto, cuja pele se torna mais enrugada e pigmentada. G5 Desenvolvimento completo da genitália, que assume características adultas. Resposta letra B.

298256.

Comentário: Essa questão é relativamente simples Ao observar os dados da tabela, vemos que logo nas primeiras linhas, a criança com 10 meses já deveria estar duplicando sílabas e transferindo objetos de uma mão para outra, mas infelizmente o bebê do enunciado não apresenta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estes marcos. Segundo o Ministério da Saúde, conforme a figura em anexo, a ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior (vejam que estes marcos o limite máximo é 9 meses) é classificado como provável atraso no desenvolvimento. Logo, a conduta imediata é referir esta criança para avaliação neuropsicomotora. Resposta letra D.

298257.

Comentário: A Sociedade Brasileira de Pediatra (SBP) elenca diversos fatores de risco para o desenvolvimento de anemia ferropriva em crianças e adolescentes e são devidos em baixa reserva materna aumento da demanda metabólica diminuição do fornecimento perda sanguínea e má absorção do ferro. Das alternativas listadas, a única que contempla fatores de risco para anemia ferropriva é a letra A. Gestações múltiplas com pouco intervalo entre elas representa fator de risco por baixa reserva materna. Prematuridade e baixo peso ao nascer (2.500g) representa fator de risco por aumento da demanda metabólica e o clampeamento do cordão umbilical antes de um minuto de vida, por diminuição do fornecimento. Resposta letra A.

286759.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas a letra A está correta essa é a recomendação correta, com o objetivo de promover a saciedade ao bebê e manter a produção adequada, uma vez que a maior quantidade de gordura está presente no leite posterior (fim da mamada). As letras B e C estão incorretas como vimos, a amamentação deve ser feita sob livre demanda, e não com intervalos fixos. A letra D está incorreta a princípio, indica-se o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Resposta letra A.

286760.

Comentário: Vamos analisar cada alternativa a) INCORRETA. Desde o início da introdução da alimentação complementar, os alimentos não devem ser oferecidos com consistência líquida, não devendo ser liquidificados ou peneirados, apenas amassados. A consistência deve ser aumentada progressivamente, para estimular a mastigação. b) INCORRETA. A alimentação complementar é iniciada com uma papa de mistura múltipla (antes chamada de papa salgada), no horário do almoço ou jantar, além de frutas como lanches. c) INCORRETA. Desde o início da alimentação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complementar, a papa de mistura múltipla deve conter cereais ou tubérculos, leguminosas, proteína animal e hortaliças. As carnes devem ser picadas, amassadas ou desfiadas para serem oferecidas à criança. d) CORRETA. Esta recomendação é um dos 10 passos para alimentação saudável, presente no manual do Ministério da Saúde. Resposta letra D.

286769.

Comentário: Cerca de 4 a 18% dos portadores da síndrome de Down apresentarão hipotireoidisismo. Dessa forma, o Ministério da Saúde recomenda a avaliação da função tireoideana ao nascimento (triagem neonatal), aos 6 e aos 12 meses e, em seguida, anualmente. Existe um risco de 1,4% de hipotireoidismo congênito e 14% a 66% ou mais de hipotireoidismo ao longo da vida. Vale ressaltar que o hipotireoidismo é basicamente a única alteração endocrinológica que está associada a síndrome de Down.Resposta letra A.

286772.

Comentário: Para um lactente de 9 meses, o que poderia indicar um alerta para atraso no desenvolvimento motor Lembramos que engatinhar é um marco facultativo (não obrigatório) presente aos 10 meses (letra C errada). Falar palavras somente aos 2 a 3 palavras com significado só é esperado aos 12 meses (letra B errada). Não andar também não reflete um alerta, uma vez que só esperado que as crianças andem com apoio aos 12 meses (letra A errada). Agora, não se sentar sem apoio aos 9 meses é preocupante, pois isso já é esperado a partir de 8-9 meses. É esperado que a criança sente temporariamente sem apoio aos 6-7 meses (após alguns segundos a criança se apoia sobre as mãos para permanecer sentada), mas aos 9-10 meses já permanece sentada indefinidamente. Resposta letra D.

252220.

Comentário: Vamos de baixo para cima... O ferro é absorvido no intestino preferencialmente em sua forma reduzida, isto é, no estado ferroso (Fe), que é menos ionizado que o estado férrico (Fe) e portanto tem mais facilidade em cruzar a membrana celular. O uso de substâncias ácidas (como suco de laranja, que é rico em vitamina C, ou ácido ascórbico) ajuda a transformar o ferro do estado férrico para o estado ferroso (D correta)... O ideal é que o ferro seja ministrado longe das refeições,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

já que muitos alimentos podem impedir ou dificultar sua absorção (C correta)... Os locais preferenciais de absorção do ferro são as porções iniciais do intestino delgado, especialmente o duodeno e o jejuno proximal. A explicação é que nestes segmentos existe maior expressão de receptores para ferro na borda em escova das células epiteliais da mucosa intestinal (B correta)... Enfim, a letra A está errada A dose terapêutica de ferro oral em adultos é de 150 a 200 mg de ferro elementar por dia , dividido em 3 a 4 tomadas. Lembrar que um tablete de 300 mg de sulfato ferroso contém cerca de 60 mg de ferro elementar (relação 5 1). Resposta A.

252282.

Comentário: Infecção por HTLV 1 2 e infecção pelo HIV são contraindicações clássicas ao aleitamento materno. Resposta correta letra A

208306.

Comentário: No desenvolvimento puberal feminino, a sequência de eventos esperada é telarca, pubarca ou adrenarca e posteriormente a menarca. Em nenhuma das opções a telarca é o primeiro sinal da puberdade, portanto não há resposta adequada. A resposta da banca foi letra D, mas a questão deveria ter sido anulada. Resposta letra D.

208354.

Comentário: Questão que exige atenção na hora de marcar a resposta. O enunciado descreve características fenotípicas da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Além do que foi descrito, esses pacientes podem apresentar cardiopatias congênitas, anomalias gastrointestinais (atresia duodenal, pâncreas anular, fístula traqueoesofágica, doença de Hirschsprung e ânus imperfurado), hipotireoidismo, manifestações hematológicas, alterações musculoesqueléticas (como displasia pélvica), alterações na visão e audição. Pacientes com estigmas da síndrome devem ser submetidos à realização de cariótipo, ecocardiograma, ultrassonografia de abdome, fundoscopia, audiometria, hemograma e dosagem de hormônios tireoideanos. Em cada alternativa da questão o autor coloca dois exames sugeridos, no entanto, a única alternativa que contém dois exames indicados para este bebê é a alternativa C. A dosagem de cortisol, a tomografia de crânio e a eletroneuromiografia não estão indicadas. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208377.

Comentário: Questão simples, direta e objetiva O leite ordenhado cru pode ser armazenado em geladeira por até 12 horas e no freezer ou congelador por até 15 dias (no máximo). Preferencialmente, deve ser oferecido em copinho, xícara, seringa ou colher, para evitar que a criança perca o estímulo da sucção ao seio com o uso de mamadeiras. Resposta letra A.

176113.

Comentário: A questão pecou por não ter dito que referência ela queria que vocês seguissem recomendações do Ministério da Saúde (MS) ou da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Para a SBP, de acordo com documento de 2016, temos Suplementar vitamina D, com 400 UI dia (1 ano) e 600 UI dia (1 ano), em crianças em aleitamento materno exclusivo, iniciando logo após o nascimento. Para os prematuros, a suplementação deve ser iniciada quando o peso for superior a 1500 gramas e houver tolerância à ingestão oral crianças em uso de fórmula láctea fortificada com vitamina D que ingerem um volume menor que 1000 mL dia crianças e adolescentes que não ingerem pelo menos 600 UI de vitamina D dia na dieta crianças e adolescentes que não se exponham ao sol regularmente. Este lactente, portanto, teria indicação para suplementação de vitamina D desde o nascimento e, agora, aos 7 meses, com ingestão de menos de 1.000 ml de fórmula, mantém a indicação. A suplementação medicamentosa de ferro tem sido recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria independentemente da condição socioeconômica, da seguinte maneira lactentes que foram recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em aleitamento materno 1 mg kg de peso dia de ferro elementar a partir do 6º mês (ou da introdução de novos alimentos) até o 24º mês lactentes que foram prematuros e ou com peso ao nascer entre 1.500 a 2.500 g a partir do 30º dia de vida, 2 mg kg de peso dia de ferro elementar até um ano e depois 1 mg kg dia até os dois anos lactentes que foram prematuros e ou com peso ao nascer de 1.000 g a 1.500 g a partir do 30º dia de vida, 3 mg kg de peso dia de ferro elementar até um ano e depois 1 mg kg dia até os dois anos lactentes que foram prematuros e ou com peso ao nascer 1.000 g a partir do 30º dia de vida, 4 mg kg de peso dia de ferro elementar até um ano e depois 1 mg kg dia até os dois anos Crianças que fazem uso de fórmula infantil em um volume de,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

no mínimo, 500 mL dia, não precisam receber a suplementação de ferro. Nosso lactente recebe 540 ml dia e, portanto, não tem indicação para suplementar ferro de acordo com esta referência. Assim, pelas recomendações da SBP, este bebê tem indicação para suplementar vitamina D (não por recomendação do MS, como diz a letra A), sem ferro. Contudo, se formos usar o Ministério da Saúde (e as alternativas citam esta referência), este lactente tem indicação de suplementação de ferro. De acordo com o MS, o esquema de administração profilática de sulfato ferroso se faz para todas as crianças de 6 a 24 meses, diariamente, com 1 mg kg. Não há a ressalva quanto ao volume de fórmula láctea ingerido por dia e, por isso, mesmo o lactente usando 540 ml de fórmula por dia, está indicado o uso do ferro. Quanto à vitamina D, o MS não se posiciona. Ficou confuso, não é mesmo Não há resposta adequada, mas a banca liberou (e manteve) o gabarito como letra C.

176117.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) INCORRETA. O primeiro caráter sexual que marca o início puberal no sexo masculino é o aumento do volume testicular. B) CORRETA. O início do desenvolvimento puberal nos meninos ocorre entre 9 e 14 anos. C) INCORRETA. O aumento dos testículos (primeiro sinal da puberdade em meninos - G2) ocorre antes do aumento do diâmetro do pênis (G4). D) INCORRETA. O início da puberdade antes de 9 anos nos meninos e antes de 8 anos nas meninas é considerado puberdade precoce. Logo, gabarito letra B.

176028.

Comentário: Temos uma criança com peso e estatura abaixo do escore-Z -3, assim, temos uma lactente com peso e altura muito baixos para a idade. Logo, podemos dizer que estamos diante de uma criança com desnutrição energético-proteica. Além de todos os cuidados pediátricos acerca de avaliação da caderneta de vacinação, temos que fazer o tratamento nutricional desta criança. A parte inicial deste tratamento inclui hospitalização para corrigir condições metabólicas graves como hipoglicemia, hipotermia e desidratação, tratamento precoce de infecções e parasitoses, mesmo na ausência de sinais clínicos, prescrição de uma dieta branda e gradual, preferencialmente por via oral, e prescrição de uma megadose de vitamina A, já que crianças gravemente desnutridas têm alto risco de desenvolver cegueira. Também devemos iniciar ácido fólico, zinco e cobre. Resposta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

certa letra C.

176100.

Comentário: As únicas infecções maternas que são contraindicações absolutas ao aleitamento materno são HIV e HTLV 1 e 2. Todas as demais alternativas não contraindicam o aleitamento materno. Cabe lembrar que o citomegalovírus pode ser transmitido através do leite, mas como a infecção é assintomática, normalmente não requer cuidados especiais, com exceção dos recém-nascidos menores de 32 semanas de idade gestacional, pois estes podem desenvolver uma doença grave. Cabe, ainda, lembrar que não existe uma contraindicação formal para o aleitamento nos casos em que mulher é portadora do vírus da hepatite C não há transmissão pelo leite, mas existe o risco teórico de transmissão por uma lesão sangrante. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que seja discutido com a família os vários benefícios e riscos teóricos nestes casos, para que seja tomada a decisão quando à manutenção ou não do aleitamento. Resposta letra B.

151869.

Comentário: No, estadiamento de Tanner, as mamas e os genitais masculinos são avaliados quanto ao tamanho, à forma e às características e os pêlos pubianos quanto às suas características, à quantidade e à distribuição. O estágio II de Tanner, pedido na questão, se refere ao aparecimento do broto mamário, com aumento inicial da glândula mamária e elevação da aréola e papila, formando uma pequena saliência e ao aparecimento de pêlos longos e finos, levemente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados, ao longo dos grandes lábios. Resposta letra D.

151870.

Comentário: De acordo com as mais recentes recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre suplementação na infância, a vitamina D deverá ser administrada de forma PROFILÁTICA a TODAS as crianças, independente da região do país, cor da pele ou tipo de alimentação 1) Primeira semana de vida até 12 meses 400 UI dia 2) 12 meses até 24 meses 600 UI dia. O autor não especifica em qual idade faz referência, se de 0 a 12 meses ou se de 12 a 24 meses. Apesar da elaboração de recursos na época do concurso, a banca manteve como resposta a letra A.

151959.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos avaliar cada afirmativa a) INCORRETA. A aparência do leite muda conforme a fase da amamentação nos primeiros dias o leite é geralmente em pequena quantidade. É o colostro, um leite concentrado, nutritivo e com muitos anticorpos. É a primeira vacina do bebê. No começo da vida é muito importante que ele receba o colostro a toda hora. Além de dar proteção, ajuda a treinar o jeito de mamar. Com o passar do tempo, o peito produz um leite adequado às necessidades e à idade do bebê, mudando de aparência conforme a duração da mamada. Quando o bebê começa a mamar, quando nasce, ainda na sala de parto, a descida e a produção do leite são mais rápidas. Quanto mais o bebê mama, mais leite se produz. Ou seja, quando existe a queixa de pouco leite ou leite fraco além de orientar a mãe que não existe leite fraco (explicar as fases e características do leite inicial) , o profissional deve entender o real motivo do problema que está acontecendo (ansiedade, falta de conhecimento, pega equivocada, mamilo invertido, dentre outros) e atuar nesse fator, afim de que a mulher possa amamentar corretamente seu filho. B) CORRETA. A anquiloglossia ou freio lingual curto pode interferir na amamentação, por isso está indicado o rastreamento desta condição, através do teste da linguinha. Se mesmo após orientações sobre técnicas de amamentação, houver problemas na amamentação, a frenotomia está indicada. C) CORRETA. Para driblar a recusa de uma das mamas, a melhor estratégia é utilizar diferentes posições para amamentar. Uma dessas posições é a do jogador de futebol americano , muito utilizada para amamentar gêmeos. D) CORRETA. Embora as técnicas de mamoplastia redutora venham sendo modificadas para evitar interferências na amamentação, isso pode ocorrer, principalmente se houver lesão dos ductos lactíferos durante a cirurgia. O papel do pediatra é estimular o aleitamento e fornecer suporte quanto à técnica de amamentação para que seja bem sucedida. Resposta letra A.

129812.

Comentário: Sobre o acompanhamento da adolescência no sexo masculino temos A) O primeiro sinal de puberdade nos meninos é o aumento testicular, que deve ocorrer até os 14 anos de idade. Correta. B) Após o crescimento testicular, ocorre o aparecimento dos pelos pubianos e só, então, o aumento do pênis. Incorreta. C) A espermarca, primeira ejaculação do menino, ocorre geralmente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

em torno dos 12 anos e 8 meses, já na fase final da puberdade. Correta. D) A ginecomastia ou aumento das mamas no sexo masculino é fenômeno normal na puberdade, geralmente bilateral, regredindo espontaneamente em 3 anos na maioria dos casos. Incorreta. Resposta letra B.

129815.

Comentário: Sobre o acompanhamento da adolescência no sexo feminino temos A) O primeiro sinal de puberdade nas meninas é o aparecimento do broto mamário, chamado de telarca, que pode inicialmente ser unilateral. Correta. B) Fisiologicamente, a pubarca surge após a telarca, podendo se anteceder a ela nos casos de puberdade precoce de origem periférica. Correta. C) Atraso puberal no sexo feminino define-se como ausência de telarca após os 13 anos. Incorreta. D) A menarca acontece nas fases mais avançadas da maturação sexual, podendo ser precedida por secreção vaginal clara e espessada. Correta. Resposta letra C.

129723.

Comentário: Vamos relembrar os 10 Passos para uma Alimentação Saudável na Infância 1. Dar somente leite materno até os seis meses de idade, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros alimentos. 2. A partir de seis meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais. 3. Após os seis meses, oferecer alimentação complementar (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes), três vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada. 4. A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher começar com consistência pastosa (papas, purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é, também, uma alimentação colorida. 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos garantir o seu armazenamento e conservação adequados. 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo a sua

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Desta forma, resposta letra A.

129738.

Comentário: Para esta questão levamos em consideração as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre profilaxia da anemia ferropriva. A) Recém-natos pré-termo, nascidos com peso entre 1.000 e 1.500 g devem receber, a partir do trigésimo dia de vida, 3 mg kg dia de ferro elementar pelo período de 1 ano, seguido de 1 mg kg dia por mais um ano correta. B) Recém-natos pré-termo e aqueles nascidos com baixo peso até 1.500 g devem receber a partir do 30º dia de vida 2 mg kg dia de ferro elementar durante 1 ano. Após este período, receberão 1 mg kg dia de ferro elementar por mais um ano correta. C) Recém-nascidos a termo, com peso adequado para a idade gestacional, em uso de, no mínimo, 500 ml de fórmula infantil não necessitam receber suplementação correta. D) Recém-nascidos a termo, com peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno, devem receber 1 mg kg dia de ferro elementar do sexto mês de vida até o 24º mês incorreta. Resposta letra D.

129761.

Comentário: Sabemos que o primeiro estágio da carência de ferro se chama balanço corporal negativo de ferro , em que o ferro que é naturalmente perdido supera em quantidade o ferro absorvido na dieta. Nesta fase, o paciente ainda possui estoques endógenos de ferro (os quais permitem a manutenção temporária da eritropoiese), e por este motivo não desenvolve franca anemia. Acontece que mesmo assim algumas alterações passam a ser progressivamente notadas, na medida em que o estoque corporal de ferro vai se esgotando, por exemplo (1) a ferritina, que é o principal marcador do tamanho desses estoques, diminui (2) o ferro sérico começa a circular em níveis cada vez mais reduzidos, pois há menos ferro sendo liberado dos estoques (3) a transferrina aumenta, fazendo o TIBC aumentar e a saturação de transferrina diminuir. Como dissemos, pelo fato de ainda não haver franco comprometimento da eritropoiese, a contagem de hemácias e o índice hematimétrico são perfeitamente normais neste momento Resposta certa A.

129788.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Nesta questão temos um lactente de 18 meses, eutrófico (peso adequado para a idade) segundo os índices antropométricos. Há relato de que a criança sorri, senta sem apoio e pega os objetos ao redor, um desenvolvimento compatível com cerca de 9 meses de idade. Aos 15 meses a criança anda sozinha, fala ao menos 1 palavra e executa gestos quando solicitada. Aos 18 meses a criança já deve ser capaz de rabiscar, identificar objetos, falar cerca de 3 palavras e, além de andar sem apoio, consegue andar para trás. Esta criança apresenta, então, ausência de mais de um marco do desenvolvimento para a faixa etária anterior. Desta forma, deve ser classificada como provável atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com o AIDPI, estando indicada avaliação neuropsicomotora por pediatra ou neuropediatra. Melhor resposta letra B.

129797.

Comentário: Questão sobre estágios puberal de Tanner no sexo masculino. Vamos relembrar G1 pênis, testículo e escroto de aparência e tamanho infantis. G2 início de aumento dos testículos e escroto cuja pele se torna mais fina e avermelhada, sem aumento do pênis. G3 continua o crescimento escrotal e o pênis aumenta principalmente em comprimento. G4 continua o crescimento de testículos e escroto há aumento do pênis em comprimento e diâmetro, tornando-se a glande evidente. G5 genitais adultos em tamanho e forma. P1 pelos pubianos ausentes. P2 crescimento esparso de pelos finos, discretamente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados, ao longo da base do pênis. P3 pelos mais pigmentados, mais espessos e mais encaracolados em pequena quantidade na sínfise púbica. P4 pelos com características adultas, porém não atingindo a superfície interna das coxas. P5 pelos adultos em tipo e quantidade, atingindo a superfície interna das coxas. Desta forma, o paciente da questão encontra-se em G3P3. Resposta letra D.

107718.

Comentário: A alimentação complementar é o início da oferta de alimentos sólidos ou semissólidos, com a finalidade de complementar o aleitamento materno, que deixa de ser exclusivo. Em hipótese alguma deve-se cessar a amamentação com 6 meses de idade, já que ela é preconizada até pelo menos 2 anos de idade. Quando a criança recebe, além do leite materno, outros tipos de leite, chamamos de aleitamento materno misto. Portanto, resposta correta letra A .

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107732.

Comentário: A programação metabólica (programming) é definida como a indução, a deleção ou o prejuízo do desenvolvimento de uma estrutura somática permanente ou o ajuste de um sistema fisiológico por um estímulo ou agressão precoce, ocorrendo num período suscetível, resultando em consequências de longo prazo para a função. Evidências demonstram que o desenvolvimento da Síndrome Metabólica pode ter origem em alterações ocorridas na gestação e durante o início da vida pós-natal. Por isso, o estímulo à alimentação saudável deve começar na gestação. Resposta letra B .

107741.

Comentário: De acordo com as Orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, até os seis meses de idade deve-se manter o aleitamento materno exclusivo. A partir do sexto mês de vida, deve-se introduzir a alimentação complementar, mantendo-se o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais. Portanto, resposta certa letra D .

107823.

Comentário: M3 crescimento da mama e da aréola parecendo uma pequena mama adulta. Não há separação dos contornos da mama e da aréola. P3 os pelos tornam-se mais escuros, mais espessos e mais encaracolados, distribuindo-se na sínfise púbica. Resposta letra C.

107872.

Comentário: As definições presentes no AIDPI quanto à vigilância do desenvolvimento de crianças de 2 meses a 2 anos de idade - Desenvolvimento normal Todos os marcos para sua faixa etária estão presentes. - Desenvolvimento normal com fatores de risco Todos os marcos para a sua faixa etária estão presentes, mas existem um ou mais fatores de risco (depressão materna, alcoolismo, drogas, violência, etc.). - Possível atraso no desenvolvimento Ausência de um ou mais marcos para a sua faixa etária. - Provável atraso do desenvolvimento Perímetro cefálico 90 ou presença de 3 ou mais alterações fenotípicas ou ausência de um ou mais marcos para a faixa etária anterior. Os marcos esperados aos 9 meses, a faixa etária anterior, são Brinca de esconde achou, transfere objetos de uma mão para outra, duplica sílabas, senta sem apoio. Como no caso em questão a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

criança não tem o marco da faixa anterior (sentar sem apoio), trata-se de um provável atraso.

107884.

Comentário: São queixas frequentes de pais de crianças com DRGE irritabilidade, choro constante com ou sem vômitos, dor abdominal ou retroesternal, dificuldade de ganhar peso. Outros sintomas eventualmente relacionados pirose, tosse crônica, constipação. Dentre as alterações detectáveis por exames complementares, a impedanciophmetria pode detectar a presença de refluxos ácidos e não ácidos (padrão ouro de diagnóstico) e a endocopia digestiva pode detectar e presença de esofagite e diferenciar entre esofagite péptica e eosinofilica. Dentre as opções listadas, a que não é esperada nessa patologia encontra-se na Letra D. A criança apresentar o dobro do peso de nascimento aos 5 meses é o esperado dentro da normalidade. Crianças com DRGE caracteristicamente apresentam dificuldade de ganho de peso. Gabarito letra D

107689.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre crescimento, desenvolvimento e alimentação (F) O aleitamento materno sempre deve ser incentivado, devendo ser exclusivo no primeiro semestre. A partir da introdução da alimentação complementar esta deve ser fornecida sem rigidez de horário, respeitando a vontade da criança. Além disso, a SBP recomenda o uso de leite de vaca apenas após o primeiro ano de vida, não antes. (F) A alimentação complementar deve ser fornecida a partir dos seis meses, sendo espessa desde o início, com consistência pastosa e evoluir gradativamente até chegar a alimentação da família. (F) As crianças não devem receber estimulantes de apetite. O apetite fome da criança devem ser respeitados. (V). A alimentação complementar deve ser oferecida de maneira regular, 6 refeições dia, em porções adequadas ao apetite da criança, rica em tubérculos, leguminosas, legumes e hortaliças. Portanto, a sequência correta deveria ser F-F-F-V. Por ausência de resposta, a banca anulou a questão.

103796.

Comentário: A deficiência de ferro é o distúrbio nutricional mais disseminado e mais comum do mundo. Estima-se que cerca de 30% da população global sofra de anemia ferropriva e que a maioria dos indivíduos afetados vive em países em desenvolvimento. O padrão comum de dieta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

observado em recém-nascidos e bebês acima do peso com anemia ferropriva nutricional nos países em desenvolvimento é o consumo excessivo de leite de vaca. A subnutrição em geral é mundialmente responsável pela deficiência de ferro. Portanto, resposta certa letra A .

103829.

Comentário: Vamos à análise das afirmativas. Letra A CERTA. No final do segundo ano de vida, a velocidade de crescimento cerebral e somático diminui, com redução correspondente das exigências nutricionais e do apetite. Letra B ERRADA. No primeiro ano de vida, a criança cresce, em geral, 25 cm e, no segundo ano, 12 cm ano. Letra C ERRADA. A criança triplica o peso de nascimento aos 12 meses de idade. Letra D ERRADA. Entre 2 e 5 anos, a criança ganha 2 kg ano e cresce 7 cm ano dos 2-4 anos e 6 cm ano dos 4-6 anos.

87434.

Comentário: Temos aqui uma queixa muito comum das primeiras consultas de puericultura dor às mamadas e ferimentos no peito, sugerindo-nos o diagnóstico de fissuras. As fissuras e traumas mamilares apresentam como principal causa a pega e posicionamento incorretos do bebê durante a amamentação, e não a frequência das mamadas ou estresse do bebê, que normalmente chora quando está com fome. Portanto, o pediatra precisa em consulta ambulatorial avaliar a técnica da amamentação, e corrigir os erros que estejam levando a tal problema. São sinais de boa pega e posicionamento os seguintes PEGA a boca do lactente engloba toda a aréola, e não apenas o mamilo o lábio inferior está evertido as deglutições são audíveis a língua repousa sobre a gengiva inferior. POSICIONAMENTO a face do bebê está de frente para a mama com nariz encostando na mama a barriga do bebê encosta na barriga da mãe corpo e cabeça alinhados no mesmo eixo e bem apoiados pelas mãos da mãe pescoço levemente extendido. Assim, a conduta do profissional de saúde deve ser corrigir a pega incorreta e orientar quanto ao retorno para reavaliação. Resposta letra E.

87448.

Comentário: Em relação ao crescimento em crianças e adolescentes, vamos discutir as alternativas abaixo A Incorreta - Em geral, as crianças nascem com 50 centímetros e crescem ao longo do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

primeiro ano de vida, 50% do seu comprimento ao nascimento, apresentando uma velocidade de crescimento de 25 cm ano. B Correta - Dos 2 aos 4 anos, as crianças apresentam uma velocidade de crescimento de cerca de 7 centímetros por ano. C Incorreta - Durante a fase escolar, as crianças crescem em média 5 a 7 cm por ano. D Incorreta - No período do segundo ano de vida, a criança tende a crescer cerca de 12 cm ano. E Incorreta - Desde o período neonatal até a puberdade, a velocidade de crescimento das crianças sofre variações. Os primeiros anos de vida são os de crescimento mais acelerado, havendo uma desaceleração iniciada na fase pré-escolar, que se acentua na fase escolar, voltando a um crescimento mais rápido na adolescência durante o estirão puberal. Resposta letra B.

87440.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre as variações normais do crescimento A Incorreta. No atraso constitucional do crescimento a idade óssea está geralmente atrasada em relação à idade cronológica, evidenciando um potencial de crescimento. Estas crianças apresentam crescimento mais lento, porém mais prolongado, adquirindo a estatura final normal. B Incorreta. Na baixa estatura familiar, as crianças apresentam crescimento compatível com seu alvo genético. Geralmente, uma história de retardo puberal parental é encontrada nos casos de retardo constitucional do crescimento, e não na variante familiar da baixa estatura. C Incorreta. O exame físico no atraso constitucional do crescimento é normal para a idade óssea que, nesses casos, é menor que a cronológica. D Correta. No atraso constitucional do desenvolvimento, a idade óssea é atrasada em relação à idade cronológica, mas está compatível com a idade estatural do paciente. E Incorreta. Na baixa estatura familiar, não há alterações laboratoriais tanto para a idade cronológica quanto para a idade óssea. Resposta letra D.

87458.

Comentário: Tema frequente em provas Vamos analisar cada marco do desenvolvimento em relação a sua idade média de aquisição A) Começa a sustentar a cabeça aos 2 meses. B) Corre, anda para trás, fala mais de três palavras aos 18 meses. C) Senta-se sem apoio, engatinha aos 10 meses. D) Eleva a cabeça quando em decúbito ventral, reage ao som, fixa e acompanha a face da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mãe com 1 mês. E) Senta com apoio, balbucia aos 7 meses. Resposta letra B.

80992.

Comentário: O início da alimentação complementar é o período de introdução de qualquer outro tipo de alimento além do leite materno. São considerados alimentos complementares as frutas, cereais tubérculos, leguminosas, hortaliças e carnes. Gabarito letra A.

81922.

Comentário: Questão que pode ser respondida apenas com o bom senso crítico e observação da prática pediátrica. O papel do pediatra geral não especialista é cuidar de temas relacionados à puericultura (crescimento, desenvolvimento, prevenção de acidentes, imunizações, práticas saudáveis de alimentação e esportes), diagnosticar e tratar condições comuns da infância (dermatoses, infecções respiratórias e gastrointestinais, distúrbios nutricionais), estar atento aos sinais sintomas de doenças mais raras, sugerindo testes diagnósticos mais complexos que possam detectá-lo precocemente (inclusive genéticos, como para síndrome de Down, síndrome de Turner), dar suporte e orientação à família e realizar os encaminhamentos pertinentes às especialidades médicas responsáveis. A realização de terapias genéticas é papel do especialista (ex geneticista, pneumologista, neurologista), e não do pediatra geral. Resposta letra A.

81063.

Comentário: A programação metabólica (programming) é definida como a indução, a deleção ou o prejuízo do desenvolvimento de uma estrutura somática permanente ou o ajuste de um sistema fisiológico por um estímulo ou agressão precoce, ocorrendo num período suscetível, resultando em consequências de longo prazo para a função. O padrão de ingestão de gordura pela mãe, durante a gestação, tem sido relacionado ao desenvolvimento de doenças alérgicas na criança, sendo a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos linoleico e linolênico vinculados ao aumento do risco dessas doenças no futuro. Verificou-se também que, além do baixo peso ao nascer, o ganho ponderal acentuado precocemente nos primeiros seis meses de vida relaciona-se com o desenvolvimento futuro de obesidade e adiposidade central. Gabarito letra B.

81080.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: As recomendações atuais do Ministério da Saúde (MS), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) são 1. Aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Portanto, não é necessário oferecer à criança água, chás, sucos ou qualquer outro alimento durante os seis primeiros meses de vida. Se for oferecido outro alimento à criança durante esse período, o processo de desmame terá sido iniciado. 2. A partir dos seis meses de vida, o leite materno como alimento único se torna insuficiente, e deve ter inicio a introdução de alimentação complementar. Entretanto, não se recomenda nenhum outro tipo de leite (industrializado, de vaca, soja, cabra, etc.). Observem o leite materno sozinho após os seis meses é insuficiente, porém continua sendo importante, especial mente como fonte de vitamina C (cobre 95% das necessidades), vitamina A (cobre 45% das necessidades), proteínas (cobre 38% das necessidades) e energia (cobre 31% das necessidades), além é claro de fornecer elementos imunológicos para prevenção de doenças. 3. O leite materno deve ser mantido, no mínimo, até os dois anos de vida. Gabarito letra E.

81136.

Comentário: A anemia ferropriva é a desordem nutricional mais comum do mundo e afeta crianças nos períodos de maior demanda metabólica 1º infância (9 - 24 meses) e adolescência puberdade ou seja, os momentos de maior velocidade de crescimento extrauterinos. A anorexia e sonolência são sintomas de ferropenia, e a palidez cutâneo-mucosa e astenia adinamia são sintomas da anemia. Gabarito letra C.

80967.

Comentário: Há dois dados muito importantes neste enunciado. MICROCEFALIA o perímetro cefálico é uma medida que representa o crescimento cerebral, e nos primeiros meses de vida é útil para identificação de desvios do desenvolvimento neurológico. ATRASO DOS MARCOS avaliação do desenvolvimento pode ser avaliada pelo teste de triagem de Denver II que divide a avaliação de inúmeros marcos em 4 domínios de funções pessoal-social, motor-adaptativo, linguagem e motor-grosseiro. É considerado atraso suspeito quando dois ou mais marcos estão atrasados independente da área em que a falha ocorreu. Diante dos achados, a impressão diagnóstica é que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

este paciente tenha atraso no desenvolvimento. E em relação a conduta, devemos referir para avaliação neuropsicomotora o mais rápido possível, pois quanto mais precoce forem o diagnóstico e a intervenção, menor será o impacto na vida da criança. Letra B correta.

80981.

Comentário: Este adolescente já apresenta sinais de que o processo de maturação sexual já se iniciou. Pelo estadiamento proposto por Tanner, no sexo masculino será feita a avaliação do desenvolvimento genital e também dos pelos pubianos. Vamos relembrar os estágios de Tanner G1 pênis, testículo e escroto de aparência e tamanho infantis. G2 início de aumento de testículos e escroto cuja pele se torna mais fina e avermelhada não há aumento do pênis. G3 continua o crescimento escrotal e o pênis aumenta principalmente em comprimento. G4 continua o crescimento de testículos e escroto. Há aumento do pênis em comprimento e diâmetro, tornando-se a glande evidente. G5 genitais adultos em tamanho e forma. P1 pelos pubianos ausentes. P2 crescimento esparso de pelos finos, discretamente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados, ao longo da base do pênis. P3 pelos mais pigmentados, mais espessos e mais encaracolados em pequena quantidade em sínfise púbica. P4 pelos com características adultas, porém não atingindo superfície interna das coxas. P5 pelos adultos em tipo e quantidade, atingindo a superfície interna das coxas. Portanto, este adolescente apresenta estadiamento de Tanner G2P2. Letra D correta.

80974.

Comentário: Quanto à suplementação de ferro na primeira infância, a SBP recomenda que Lactentes que foram Prematuros 1500g A termo de Baixo peso (2500 g) SBP 2 mg kg dia de Fe elementar do 30º dia de vida até 1 ano. De 1 até 2 anos 1 mg kg dia de Fe elementar. Lactentes que foram prematuros com peso entre 1000-1500g SBP AAP 3mg kg dia de Fe elementar até o 1º ano De 1 até 2 anos 1mg kg dia de Fe elementar Lactentes que foram prematuros com peso menor que 1000g SBP AAP 4mg kg dia de Fe elementar até o 1º ano De 1 até 2 anos 1mg kg dia de Fe elementar Gabarito letra A.

80959.

Comentário: Vamos analisar cada uma das afirmativas, e então classificá-las como V - Verdadeiras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ou F - Falsas . 1. Verdadeira. Melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não adequados, são fundamentais para evitar o desmame precoce. 2. Verdadeira. Deve-se oferecer as 2 mamas em cada mamada começar por uma, esvaziá-la e completar com a outra na mamada seguinte, iniciar pela mama que foi dada por último a fim de promover sempre o esvaziamento completo das glândulas. 3. Falsa. A frequência das mamadas deve ser ditada pelo lactente, em um regime de livre demanda. 4. Verdadeira. É possível a troca de mama várias vezes em uma mamada se a criança estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente. 5. Falsa. O leite residual poderá ser sugado na próxima mamada. Não há necessidade de ordenhar o que sobra em cada mama, a menos que sobre muito leite em uma das mamas. Neste caso, a nutriz deverá ordenhar o excesso a fim de evitar que o acúmulo leve à obstrução dos ductos, concorrendo para a diminuição da secreção láctea futuramente. Gabarito letra E.

61481.

Comentário: De acordo com o documento do Ministério da Saúde sobre a saúde do adolescente, é frequente ocorrer um corrimento vaginal claro nos 6 aos 12 meses que antecedem a menarca, fato marcante da puberdade feminina. Deve-se, portanto, esclarecer a adolescente de que esta condição é natural, pois trata-se do crescimento do tecido endometrial uterino, devendo-se reforçar apenas os cuidados com a higiene corporal. Gabarito letra C.

61567.

Comentário: De acordo com o documento do Ministério da Saúde, é considerado retardo puberal em meninos ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 14 anos de idade, enquanto nas meninas a partir dos 13 anos. A alternativa incorreta encontra-se, portanto, na opção B as demais alternativas estão corretas. Gabarito letra B.

61574.

Comentário: A ginecomastia é o desenvolvimento uni ou bilateral das mamas presente em adolescentes do sexo masculino no início da maturação sexual e do estirão puberal, mais frequente em obesos e com história familiar positiva. Na maioria dos casos, é um processo fisiológico que faz parte do desenvolvimento puberal normal, principalmente nas fases de maturação G3 e G4 de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Tanner. O pênis embutido é um pênis normalmente desenvolvido que se encontra encoberto pela gordura suprapúbica comum em crianças obesas. Em ambos os casos, como o do nosso paciente, o acompanhamento clínico e psicológico estão indicados, sendo a reafirmação de que a puberdade está seguindo seu curso normal uma base importante da conduta. Nos casos de ginecomastia intensa e prolongada, sem remissão após dois anos e com desenvolvimento puberal completo, pode-se considerar a cirurgia como a melhor opção terapêutica. Nosso paciente apresenta o problema há 6 meses, sem desenvolvimento completo e, portanto, ainda não há indicação cirúrgica. Resposta, portanto, opção D.

60860.

Comentário: As drogas formalmente contraindicadas durante a fase de amamentação segundo o Ministério da Saúde são Meios de Contraste Fibrinogênio marcado, sódio marcado A nticonvulsivantes zonisamida Antidepressivos doxepina Hipnóticos e ansiolíticos brometos Antiparkinsonianos bromocriptina, selegilina Sais de ouro Antibióticos linezolida Antivirais ganciclovir Antiarrítmicos Amiodarona Anticoncepcional oral combinado Etinilestradiol Cabergolina Ciproterona Leuprolide Lisurida Tamoxifen Clomifeno Dietilestilbestrol Mifepristona Misoprostol Antineoplásicos (exceção metotrexate, bleomicina e hidroxiureia, que podem ser usados com cautela).

61581.

Comentário: Questão estranha , mas que tem como melhor resposta a letra B. Veja bem em linhas gerais, pode-se afirmar que todas as anemias acabarão sendo enquadradas dentro de uma das três categorias citadas na letra A (alterações na produção, hemólise ou perdas sanguínea). Sabemos que o VCM aumenta nas deficiências de vitamina B12 e ácido fólico (anemias macrocíticas). São anemias que cursam com destruição precoce do eritrócito as anemias associadas a defeitos estruturais das hemácias (ex. esferocitose congênita), as hemólises imunomediadas e não-imunomediadas (ex. deficiência de G6PD). Todas as entidades citadas na letra E são causas clássicas de anemia hemolítica. Ora, a letra B deve ser entendida então como uma tentativa de generalizar os tipos básicos de anemia. Vimos que esses tipos foram

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

corretamente citados na letra A, portanto, a letra B encontra-se conceitualmente INCOMPLETA. Resposta certa B.

60883.

Comentário: Em 2007, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento intitulado Anemia Carencial Ferropriva , com o objetivo de revisar de forma prática o tema e colocar o posicionamento da SBP sobre as estratégias de prevenção adotadas no Brasil. Nesse sentido, alguns pontos mereceram destaque nesse documento e foram ressaltados no Manual de Alimentação do Lactente, Pré-escolar, Escolar, Adolescente e na Escola , publicado em 2008. São eles - Aleitamento materno de forma exclusiva até 6 meses e complementado até dois anos ou mais. - Contraindicação do uso de leite de vaca integral na alimentação de crianças menores de um ano e consumo de no máximo 700 ml dia para os maiores de um ano (observem para maiores de 1 ano) - Utilização de carne na alimentação complementar desde o início (70 a 100 g dia) por ser excelente fonte de ferro de elevada biodisponibilidade. - Suplementação profilática de ferro diária no lugar da semanal. Portanto, a única opção que contempla a medida mais eficaz para prevenção da ferropenia no lactente é a letra C.

60890.

Comentário: A ginecomastia é o desenvolvimento uni ou bilateral das mamas presente em adolescentes do sexo masculino no início da maturação sexual e do estirão puberal, mais frequente em obesos e com história familiar positiva. Na maioria dos casos, é um processo fisiológico que faz parte do desenvolvimento puberal normal, principalmente nas fases de maturação G3 e G4 de Tanner. O pênis embutido é um pênis normalmente desenvolvido que se encontra encoberto pela gordura suprapúbica comum em crianças obesas. Em ambos os casos, como o do nosso paciente, o acompanhamento clínico e psicológico estão indicados, sendo a reafirmação de que a puberdade está seguindo seu curso normal, uma base importante da conduta. Nos casos de ginecomastia intensa e prolongada, sem remissão após dois anos e com desenvolvimento puberal completo, pode-se considerar a cirurgia como a melhor opção terapêutica. Nosso paciente apresenta o problema há 6 meses, sem desenvolvimento completo e, portanto, ainda não há indicação cirúrgica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Resposta, portanto, opção D.

61584.

Comentário: Questão interessante, que remete a conceitos práticos comuns. Enquanto as crianças estão em aleitamento materno, especialmente quando de forma exclusiva, várias dúvidas surgem e, para respondê-las, precisamos nos cercar de parâmetros objetivos. É exatamente isso que se pergunta aqui. O tempo das mamadas, bem como o intervalo entre elas, o número de evacuações e o sono do bebê fornecem informações que podem ser levadas em consideração quando avaliamos o sucesso da amamentação, mas possuem grande variabilidade individual e, por isso, são de caráter extremamente subjetivos. Já o ganho de peso adequado e a presença de diurese pelo menos 6-8x dia são evidências inquestionáveis de que a amamentação está surtindo os resultados esperados.

61505.

Comentário: Vamos ver o que dizem as opções A errada. O atraso constitucional do crescimento se reflete diretamente na entrada da puberdade. Geralmente há um atraso também nesse fenômeno, dando ao distúrbio apresentado, inclusive, o nome completo de atraso constitucional do crescimento e da puberdade. B errada, e confusa. Não ficou muito claro o que o autor da questão quis dizer, mas vamos lembrar na baixa estatura constitucional, a idade óssea é tipicamente atrasada em relação à idade cronológica. C errada. As mais importantes variações do crescimento (atraso constitucional e baixa estatura genética) normalmente seguem a história padrão familiar, isto é, pais baixos geralmente tem filhos baixos e pais com retardo de crescimento geralmente tem filhos com a mesma evolução. D errada. Nesses casos, a idade óssea está atrasada em relação à idade cronológica, configurando um bom prognóstico estatural para esses pacientes. E correta. A criança com baixa estatura familiar geralmente cresce numa curva abaixo do p3 (por isso, baixa estatura), porém com um crescimento dentro do esperado para aquele alvo. A resposta liberada inicialmente foi a opção E. Contudo, a questão foi ANULADA provavelmente pela confusão da opção B.

61513.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O crescimento linear sofre variações ao longo da infância e adolescência, tanto que existem diferentes velocidades de crescimento para cada faixa etária. Ao longo do primeiro ano de vida, o lactente cresce 1º trimestre 3,5 cm mês, 2º trimestre 2 cm mês, 3º trimestre 1,5 cm mês, 4º trimestre 1,2 cm mês. No primeiro ano então, a criança cresce 25 cm. No segundo ano, ele cresce 15 cm ano. O pré-escolar cresce 7-8 cm ano O escolar 6-7 cm ano Na adolescência a VC volta a subir meninas crescem 8-10 cm ano e meninos crescem 10-12 cm ano. Sendo assim, podemos observar que as maiores velocidades de crescimento pós-natal ocorrem durante os 2 primeiros anos de vida e na adolescência. As opções exibem pequenas diferenças nas VC, as quais são intepretadas como aceitáveis, em função das variações na literatura. Contudo, a letra A mostra uma VC absurda. Por isso, gabarito letra A.

46652.

Comentário: O primeiro passo na avaliação de uma queixa relacionada ao crescimento estatural é a verificação da estatura atual e da velocidade de crescimento, isto é, o padrão apresentado pela curva de crescimento. Via de regra, as crianças que apresentam baixa estatura por algum quadro patológico possuem uma velocidade de crescimento baixa sua curva é horizontal ou pouco inclinada. Já as crianças com variantes normais do crescimento possuem velocidade de crescimento normal. Assim, a opção A traz o primeiro dado a ser avaliado na consulta atual.

46634.

Comentário: A grande preocupação nestes casos é com a hipovitaminose B, pois essa vitamina não é encontrada em vegetais. Outro dado que deve ser avaliado é se as nutrizes estão ingerindo quantidade suficiente de proteínas. Assim, quando surgir para você um bebê com anemia megaloblástica, filho de mãe vegetariana, não pense muito antes de marcar que a hipótese é a de deficiência de B12.

46637.

Comentário: Se o recém-nascido é a termo, nada muda A criança pode mamar diretamente no seio, sem qualquer restrição (letra B correta). O vírus é encontrado no leite de até 96% das mulheres infectadas e a transmissão pós-natal chega a 38%. Porém, no recém-nascido a termo, essa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transmissão não traz complicações. O aleitamento diretamente ao seio não é recomendado apenas quando o recém-nascido tem menos de 32 semanas de idade gestacional, pelo risco de doença grave nesse grupo. Nesta situação, recomenda-se o congelamento com posterior pasteurização do leite materno ordenhado, antes de ser oferecido.

46686.

Comentário: A questão foi anulada, possivelmente, pela presença de erro na opção C. Mulheres saudáveis, que adotam uma criança, podem amamentar Existem inclusive serviços especializados na promoção da lactação nesses casos, que recebe o nome de lactação adotiva ou amamentação adotiva.

46689.

Comentário: O aleitamento materno pode ser contraindicado por doenças maternas ou por doenças no lactente, mas são poucas as situações em que isso ocorre. A principal doença no lactente que contraindica o aleitamento é a galactosemia. Esta condição consiste em um erro inato do metabolismo da galactose e a criança não pode receber leite materno, de vaca e de cabra (qualquer leite com lactose, que é um dissacarídeo de glicose e galactose). Em relação às doenças maternas, as duas grandes contraindicações são a infecção pelo HIV e pelo HTLV. Já quando a mãe é portadora crônica do vírus da hepatite B o recém-nascido recebe após o parto a vacina e a imunoglobulina específica contra hepatite B, e pode ser amamentado normalmente. Resposta letra C.

324692.

Comentário: Na consulta do adolescente, é fundamental estabelecer uma relação mútua de confiança. Para tanto, o pediatra deve garantir sigilo, privacidade e confiabilidade, e ser claro e sincero em suas colocações para que o adolescente perceba isso durante a consulta. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), são situações que podem levar à quebra de sigilo presença de qualquer tipo de violência (emocional, maus-tratos, sexual, bullying e outras situações delicadas) uso escalonado de álcool e outras drogas sinais de dependência química, autoagressão, ideações suicidas ou de fuga de casa tendência homicida gravidez com ou sem o intuito de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

interrupção abortamento sorologia positiva de HIV (neste caso, além dos familiares, também os parceiros sexuais serão informados) não adesão a tratamentos, deixando o adolescente ou terceiros em risco diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos, outros transtornos do campo mental e outras situações que se façam necessárias. Assim, no que diz respeito à autoagressão, a quebra de sigilo deve ser realizada (letra D incorreta) isto deve ser feito com o conhecimento dos(as) adolescentes e na sua presença (letra A incorreta), expondo-se os motivos para essa atitude e registrando-os no prontuário. Poderia ser pactuado que o próprio adolescente converse com a mãe para essa revelação, mas a questão não deixa claro se essa conversa ocorreria na própria consulta, o que pode gerar questionamento. Frente ao risco evidente pela autoagressão e a atitude da paciente na presença da mãe, essa conversa não poderia ser adiada para outro momento. Ainda assim, o gabarito da banca foi a alternativa C. Resposta letra C.

324693.

Comentário: A consulta do adolescente deve respeitar princípios como privacidade, sigilo e confidencialidade. Assim, ela pode ser, didaticamente, dividida em três momentos o primeiro momento consiste no atendimento do adolescente e sua família em seguida, é feito o atendimento do paciente individualmente e, num terceiro momento, todos estão em conjunto para que as orientações necessárias sejam dadas (letra C incorreta e B correta). Durante o atendimento reservado com o adolescente, o pediatra pode aprofundar-se em questões sobre sexualidade, uso de drogas, violência e projetos futuros. O conteúdo das consultas, como, por exemplo, relações sexuais e prescrição de métodos contraceptivos, somente será revelado aos pais com expressa autorização do adolescente, exceto em situações de risco nas quais a quebra de sigilo estaria autorizada. O exame físico pode ou não ser feito na presença dos pais, cabendo ao paciente a decisão de limitar sua intimidade. É importante que o médico tenha na sala de exame um outro profissional de apoio cuja função é neutra, apenas de acompanhamento (letras A e D incorretas). Resposta letra B.

324694.

Comentário: O início da vida sexual insere as(os) adolescentes em contextos de vulnerabilidade às

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

infecções sexualmente transmissíveis e HIV aids, gestação não planejada e abortamento, além de transtornos depressivos. Assim, o uso de métodos contraceptivos de barreira, principalmente o preservativo masculino, é desejável e fortemente recomendável. A incidência de gestações entre adolescentes no Brasil continua alta - aproximadamente 24% de todos os partos com nascidos vivos ocorrem em jovens com idade de até 20 anos. Entre 15 e 19 anos, 14,7% das adolescentes usam algum método o anticoncepcional oral é o método mais utilizado, mas a maioria só procura pela anticoncepção cerca de seis a 12 meses após o início da vida sexual. Sabendo da importância da anticoncepção nessa faixa etária, devemos lembrar que a adolescente tem direito à privacidade, ou seja, de ser atendida sozinha, em espaço privado, e as informações discutidas durante e depois da consulta não podem ser informadas a seus pais e ou responsáveis sem a permissão expressa do adolescente, exceto em situações que autorizam a quebra do sigilo, como situações de violência, autoagressão e gravidez. A confidencialidade apoia-se em regras da bioética médica, através de princípios morais de autonomia (artigo 103 do Código de Ética Médica) a prescrição de contraceptivos não está entre as situações que podem levar à quebra de sigilo. Dessa forma, a adolescente tem direito à educação sexual, ao acesso à informação sobre contracepção, à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade sexual e sobre a prescrição de métodos anticoncepcionais, não havendo infração ética ao profissional que assim se conduz. Resposta letra C.

294487.

Comentário: Independentemente do ocorrido, um dos cuidados que devemos ter durante o atendimento aos adolescentes é garantir que exista um momento de conversa sem a presença dos responsáveis. Neste momento, poderão ser abordados aspectos relacionados as condições gerais de vida do adolescente que o mesmo não se sinta a vontade de falar na presença dos pais. Lembre-se de que o adolescente tem direito ao sigilo e a confidencialidade. Logo, neste momento, devemos solicitar um momento para uma conversa individual. O exame físico deve ser feito na presença de outra pessoa. Resposta letra D.

230163.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: As características fenotípicas descritas neste enunciado nos permitem reconhecer a síndrome de Down. O fenótipo da SD se caracteriza principalmente por pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto (prega cutânea no canto interno do olho), sinófris (união das sobrancelhas), base nasal plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival (alto), orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino, clinodactilia do 5º dedo da mão (5º dedo curvo), braquidactilia (dedos curtos), afastamento entre o 1º e o 2º dedos do pé, pé plano, prega simiesca (prega palmar única transversa), hipotonia, frouxidão ligamentar, excesso de tecido adiposo no dorso do pescoço, retrognatia, diástase (afastamento) dos músculos dos retos abdominais e hérnia umbilical. O gabarito fornecido pela banca contemplava como resposta síndrome de Down ou trissomia do 21, a principal alteração cromossomial encontrada na síndrome. GABARITO PÓS OFICIAL Síndrome de Down OU Trissomia do 21 OU Trissomia do cromossoma 21 OU Down.

230164.

Comentário: O enunciado descreve características fenotípicas de uma criança com a síndrome de Down. É sabido que um dos grande fatores associados com o aumento na prevalência desta condição é a idade materna avançada. Isso ocorre porque a alteração cromossomial mais comum na síndrome é a trissomia livre do cromossomo 21 na maioria dos casos (95%) o cromossomo extra se origina de não disjunção meiótica materna. A idade materna é um dos principais mecanismos associados à não disjunção, pois com a idade avançada há predisposição a erros meióticos e pouca seleção a óvulos aneuploides. GABARITO PÓS OFICIAL Idade materna avançada OU Idade materna OU idade da mãe.

230165.

Comentário: O enunciado descreve características fenotípicas de uma criança com a síndrome de Down. A síndrome é caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra, que citogeneticamente pode se apresentar de três formas trissomia simples (forma mais comum) translocação mosaicismo. A avaliação é possível pelo cariótipo. Na trissomia simples há presença de um cromossomo 21 extra livre, descrito da seguinte forma no exame de cariótipo 47, XX 21 para o sexo feminino e 47, XY 21 para o sexo masculino. Na translocação, a trissomia do cromossomo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

21 neste caso é identificada no cariótipo não como um cromossomo livre e sim translocado (montado ligado) a outro cromossomo (um pedaço de um cromossomo vai para outro isto está presente em um dos genitores, mas, como estes não tem quantidade excessiva de material genético do cromossomo 21, não tem a síndrome quando os gametas são formados, podem ser formados com o cromossoma 21 original e mais o translocado). Mais frequentemente a translocação envolve o cromossomo 21 e o cromossomo 14. No exame do cariótipo é descrito como 46, XX, t(14 21)(14q21q) para sexo feminino e 46,XY, t(14 21)(14q21q) para sexo masculino. GABARITO OFICIAL Cariótipo OU cariotipagem OU estudocromossômico OU exame citogenético E existência de um cromossomo extra no par 21 OU trissomia do 21 OU cariótipo 47, XY, 21.

206061.

Comentário: O desenvolvimento do broto mamário representa o primeiro sinal habitualmente observado na puberdade feminina e recebe o nome de telarca, caracterizando o estádio M2 de Tanner, como indicado no próprio caso. A puberdade fisiológica feminina pode ter início entre 8 e 13 anos. Logo, o que esta menina que já tem 8 anos apresenta é, simplesmente, o desenvolvimento puberal normal. A banca aceitou uma série de respostas, desde a simples descrição da telarca até a caracterização da normalidade.

206064.

Comentário: É bem possível que esta questão tenha gerado muitas dúvidas, pois a respostas pretendida estava no próprio enunciado. A descrição de um pequeno montículo indica a presença de telarca. No próprio enunciado já estava descrito que a menina estava no estádio M2 e era isso o que deveria ser indicado. Além disso, poderia ser citado apenas estádio II (em geral, o desenvolvimento da mama é que dita o estádio de desenvolvimento). Resposta oficial Estágio II M2 OU Estágio II OU M2 OU Estágio de broto mamário.

206073.

Comentário: Questão muito confusa, ainda mais quando vemos o gabarito oficial da banca. Temos uma criança com IMC de 19,8, e ao plotarmos no gráfico fornecido, observamos que a criança se encontra acima do percentil 97 para idade. Então, obviamente devemos conhecer a altura dos pais,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com a finalidade de definir se a criança está dentro do seu canal genético. Além disso, uma medida isolada é insuficiente para avaliar a estatura e, por isso, refazer as medidas antropométricas também é indicado, sobretudo para avaliação da velocidade de crescimento. Porém, a pergunta da questão não foi bem feita e não dava para saber a intenção da banca neste caso.

176289.

Comentário: Uma puérpera no seu 7º dia pós-parto encontra-se febril, com queixa de dificuldade para amamentar e mastalgia. A mama direita apresenta área de induração palpável com sinais flogísticos e fissura mamilar, enquanto a mama esquerda é dolorosa à palpação, com hiperemia discreta difusa. A mastite puerperal é o diagnóstico mais provável para o quadro e consiste em uma condição inflamatória que na maioria das vezes deriva de germes saprófitas da pele que entram na mama a partir de fissuras mamilares e proliferam em mamas ingurgitadas. Ela pode evoluir com mal estar, febre, calafrios, náuseas e vômitos, com sintomas locais de dor, calor, vermelhidão, edema, endurecimento, retração papilar e, em alguns casos, áreas de flutuação, celulite e até necrose. Resposta mastite puerperal ou mastite.

176293.

Comentário: Uma puérpera no sétimo dia pós-parto apresenta mastalgia, febre e sinais flogísticos na mama, sugerindo uma mastite. A complicação mais comum da mastite é a evolução para um abscesso mamário, que corresponde à presença de coleção purulenta no parênquima mamário. Ao exame físico podemos notar uma área de flutuação no local do abscesso mas a melhor forma de avaliação é através da ultrassonografia das mamas, que irá identificar de forma bastante específica o local acometido e muitas vezes irá guiar a punção para o esvaziamento do abscesso. Resposta Ultrassonografia de Mamas OU Ultrassom das mamas OU USG de mamas. E abscesso mamário.

176287.

Comentário: Uma puérpera no sétimo dia pós-parto apresenta mastalgia, febre e sinais flogísticos na mama, sugerindo uma mastite. No exame físico, identificamos uma fissura em mama direita e a questão pergunta qual o tratamento tópico pode ser utilizado, de melhor custo-benefício, para evitar o surgimento de novas fissuras. A orientação do Ministério da Saúde para o tratamento das fissuras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é a utilização do próprio leite ao redor do mamilo, já que ele tem capacidade cicatrizante. A orientação da técnica de pega e da posição do bebê também contribui para evitar o aparecimento de novas fissuras, mas não seria um tratamento tópico conforme perguntado. Produtos químicos não são recomendados ao redor do mamilo, uma vez que estes contribuem para despigmentação, remoção da camada lipídica fisiológica e diminuição da espessura mamilar natural. Resposta O próprio leite OU Leite materno.

152244.

Comentário: De acordo com o Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, e complementado dos 6 meses até, no mínimo, 2 anos de idade. Para essa mãe podemos dar a opção de ordenhar seu próprio leite e armazenar na geladeira (até 12h) ou congelador (até 15 dias), e reaquecer o leite em banho-maria antes de oferecer à criança. GABARITO OFICIAL Até os dois anos RESPOSTAS EQUIVALENTES Dois anos 24 meses GABARITO PÓS Resposta Oficial Até os dois anos Respostas Equivalentes Dois anos 24 meses.

152253.

Comentário: De acordo com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, o aleitamento materno exclusivo deve ser realizado até os 6 meses de idade. Depois disso o leite materno, como alimento único, torna-se insuficiente e, por isso, deve-se iniciar a alimentação complementar, com as papas principais e frutas. GABARITO OFICIAL Sim. A partir dos 6 meses. RESPOSTAS EQUIVALENTES Sim. 6 meses. GABARITO PÓS Respostas Oficial Sim. A partir dos 6 meses. Respostas Equivalentes Sim. 6 meses.

152259.

Comentário: Ferro e zinco. O vegetarianismo é a prática de seguir uma dieta que exclui as carnes. Existem variações na dieta, e algumas excluem os ovos e produtos originários de exploração animal, como produtos lácteos e mel. As dietas vegetarianas têm níveis similares de ferro em comparação com as não vegetarianas, mas o ferro pode ter uma biodisponibilidade menor que a do ferro das carnes, e a absorção pode ser inibida por outros constituintes da dieta. Alimentos como a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

carne vermelha contêm também grande quantidade de zinco. A biodisponibilidade deste oligoelemento em fontes vegetais tende a ser baixa, em virtude da presença concomitante de inibidores da absorção de zinco, como os fitatos e as fibras. GABARITO OFICIAL Ferro e Zinco RESPOSTAS EQUIVALENTES Fe e Zn GABARITO PÓS Resposta Oficial Ferro e Zinco Respostas Equivalentes Fe e Zn.

152183.

Comentário: A puberdade no sexo feminino pode ocorrer entre 8 e 13 anos. O primeiro sinal habitualmente percebido é o surgimento do broto mamário (telarca), que caracteriza o estádio M2 de Tanner. A primeira menstruação (menarca) tipicamente ocorre cerca de dois a dois anos e meio após a telarca, quando a menina alcançou o estádio M4. Logo, esta paciente de 15 anos não tem qualquer razão para preocupação, pois está justamente no momento em que a menarca costuma acontecer. Quando a adolescente já tem 16 anos e tem caracteres sexuais presentes, mas ainda não teve a menarca, até pode ser considerada uma avaliação, mas não é este o caso. GABARITO OFICIAL puberdade fisiológica. RESPOSTAS EQUIVALENTES puberdade normal normal sem anormalidade. GABARITO PÓS puberdade fisiológica. RESPOSTAS EQUIVALENTE puberdade normal normal sem anormalidade.

152186.

Comentário: Ao que tudo indica, não parece haver quaisquer problemas com o desenvolvimento puberal desta adolescente. A menarca costuma ocorrer, tipicamente, quando as mamas estão em estádio M4. Por isso, essa pergunta foi, sem sombra de dúvidas, uma pergunta difícil, pois parecia um tanto quanto subjetiva... de todo modo, vamos aproveitar para aprender. Ao atendermos um quadro de amenorreia primária, algumas avaliações são fundamentais. Em primeiro lugar, é importante saber se há presença de outros caracteres sexuais. Além disso, é importante saber em que momento a puberdade teve início, pois quando o intervalo entre a telarca e a menarca for muito grande, a avaliação torna-se necessária. Ou seja, a cronologia dos eventos é um dado importante e, nesse sentido, é importante avaliar a presença de pilificação axilar, não descrita no enunciado. Outra informação importante diz respeito à história familiar, pois os quadros de atraso constitucional

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tipicamente seguem esse padrão. Essas foram as informações contempladas pela banca. Acreditamos que outras informações também seriam importantes, tais como padrão alimentar, prática de atividades físicas, presença de outros sintomas associados, presença de doenças crônicas. Porém, nada disso foi contemplado no gabarito. GABARITO OFICIAL Informações sobre a axilarca da paciente e sobre a idade em que ocorreu a menarca da sua mãe e de familiares. RESPOSTAS EQUIVALENTES perguntar se há pelos em axilas da paciente e a idade em que ocorreu a menarca da sua mãe e de familiares. GABARITO PÓS Informações sobre a axilarca da paciente e sobre a idade em que ocorreu a menarca da sua mãe e de familiares. RESPOSTAS EQUIVALENTES Perguntar se há pelos em axilas da paciente e a idade em que ocorreu a menarca da sua mãe e de familiares.

152188.

Comentário: A paciente apresenta desenvolvimento puberal normal, visto que encontra-se em M4P4 aos 15 anos. A menarca ocorre em fases mais avançadas da maturação sexual (M3 e M4), geralmente 2-2 anos e meio após a telarca. É provável que ocorra a menarca desta paciente em período bem próximo, por isso, a conduta é aguardar e observar. GABARITO OFICIAL Expectar. RESPOSTAS EQUIVALENTES aguardar conduta expectante observar. GABARITO PÓS Resposta Oficial Expectar. RESPOSTAS EQUIVALENTES aguardar conduta expectante observar.

129992.

Comentário: O primeiro sinal do desenvolvimento puberal habitualmente observado no sexo feminino é justamente o desenvolvimento do broto mamário, que pode ser, inicialmente, unilateral. Considera-se normal o início do desenvolvimento puberal no sexo feminino aquele que ocorre entre 8 e 13 anos. Assim, esta menina teve tão somente o início da puberdade e este é o seu diagnóstico. Gabarito oficial Puberdade fisiológica OU Início da fase puberal OU Telarca OU Puberdade

129995.

Comentário: Sabemos que o surgimento dos caracteres sexuais durante o desenvolvimento puberal segue uma sequência, habitualmente, pré-estabelecida. No sexo feminino, o primeiro sinal do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desenvolvimento puberal habitualmente observado é o surgimento do broto mamário, que caracteriza a telarca. Após isso, tem início a pilificação pubiana, sob efeito dos androgênios da suprarrenal, que recebe o nome de pubarca. Um dos eventos mais tardios é a primeira menstruação, a menarca, que costuma ocorrer de 2 a 2,5 anos após a telarca, quando as mamas estão no estágio M4 de Tanner. O pico da aceleração da velocidade de crescimento ocorre antes da menarca, mas a banca não perguntou sobre o crescimento, apenas sobre os caracteres sexuais secundários. Gabarito oficial telarca, pubarca, axilarca e menarca OU telarca, pubarca e menarca.

129932.

Comentário: Questão bem simples, não é mesmo O primeiro sinal do desenvolvimento puberal habitualmente observado no sexo feminino é justamente o desenvolvimento do broto mamário, que pode ser, inicialmente, unilateral. Considera-se normal o início do desenvolvimento puberal no sexo feminino aquele que ocorre entre 8 e 13 anos. Assim, o desenvolvimento do broto mamário (telarca) em uma menina que já completou 8 anos é algo fisiológico e que não demanda qualquer intervenção. Gabarito oficial Expectante OU Observar (ou observação) OU acompanhar (ou acompanhamento) OU Nenhuma intervenção.

106520.

Comentário: Esta é uma questão que poderia ter sido simples, não fosse o gabarito estranho liberado pela banca. Trata-se de uma criança com um mês de vida que vem apresentando fezes continuamente moles após as mamadas. Será que estamos diante de uma criança com uma doença diarreica Certamente que não O que essa criança apresenta é tão somente um reflexo gastrocólico exacerbado. Sabemos que crianças em aleitamento materno exclusivo podem ter padrões de evacuações distintos, sendo que algumas evacuam fezes amolecidas ou liquefeitas várias vezes ao dia, justamente pela presença desse reflexo mais exacerbado. A benignidade do quadro é corroborada pelo ganho ponderal adequado. Houve um ganho de peso desde o nascimento de 550 g. Poderíamos pensar que esse ganho está insuficiente, mas se considerarmos que esta criança pode ter perdido até 10% do seu peso de nascimento durante a primeira semana de vida (chegando a algo próximo de 2.800 g), podemos ver que nas últimas três semanas o ganho

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ponderal vem sendo superior a 40 g dia. Qual foi o problema dessa questão A banca perguntou qual seria a suspeita diagnóstica em relação às dejeções, mas no gabarito indicou que o diagnóstico seria estado eutrófico ou normal normalidade. Ou seja, indicou uma avaliação nutricional. Muito candidatos apontaram como resposta a descrição do reflexo exacerbado. Às vezes é difícil entender por qual razão não se faz uma pergunta de forma mais objetiva. Gabarito oficial estado eutrófico ou normal normalidade.

106521.

Comentário: Temos uma mãe jovem, provavelmente uma primípara, com uma criança que nasceu a termo, com bons valores de peso e comprimento, sem comorbidades. A mãe refere dor ao amamentar, o que nos sugere que talvez a pega esteja inadequada. Ao exame, a criança apresenta um tempo de enchimento capilar um pouco lentificado (o ideal é até 2 segundos). Timpanismo abdominal pode ser ocasionado por aerofagia, mais um indício de pega inadequada. Portanto, o que está havendo é, de fato, pega inadequada, que causa lesões e fissuras mamilares, justificando a dor a amamentação e a coloração alterada do leite materno. Não temos no enunciado algo que sugira mastite, como vermelhidão e dor nas mamas de forma contínua (somente há dor ao amamentar). E a causa imediata da alteração na cor do leite não é a pega inadequada, muita atenção ao que é pedido na questão Logo, gabarito correto.

106524.

Comentário: Temos uma mãe jovem, provavelmente uma primípara, com uma criança que nasceu a termo, com bons valores de peso e comprimento, sem comorbidades. A mãe refere dor ao amamentar, o que nos sugere que talvez a pega esteja inadequada. Ao exame, a criança apresenta um tempo de enchimento capilar um pouco lentificado (o ideal é até 2 segundos). Timpanismo abdominal pode ser ocasionado por aerofagia, mais um indício de pega inadequada. Logo, a conduta mais adequada é corrigir a pega e estimular o aleitamento materno exclusivo.

106535.

Comentário: O profissional de saúde que prescreve método anticonceptivo para adolescentes, incluindo a anticoncepção de emergência (AE), não fere nenhum princípio ético ou legal. Ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

contrário, os profissionais de saúde têm clara responsabilidade com a atenção à saúde sexual e reprodutiva do adolescente. A Constituição Federal (Lei n.º 9.263, de 1996, que regulamenta o 7º do art. 226) , determina que o planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Acrescenta-se que o adolescente tem direito à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade sexual e sobre a prescrição de métodos anticonceptivos, segundo o Código de Ética Médica e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante dessa situação, as três situações em que um médico pode prescrever a AE para adolescentes são 1- relação sexual sem uso de método anticonceptivo 2- falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do anticonceptivo 3-abuso sexual.

106539.

Comentário: A questão do sigilo relacionado à consulta do adolescente é uma dúvida recorrente de muitos alunos, mas encontramos algumas referências que nos permitem responder com respaldo à pergunta feita pela banca. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, nos relembra vários pontos relacionados ao atendimento do adolescente. O primeiro diz que o adolescente tem direito à privacidade durante a consulta, lembrando-se que que a privacidade não está obrigatoriamente relacionada à confidencialidade. A confidencialidade também está garantida, sendo que a confidencialidade é estabelecer que as informações discutidas durante e depois da consulta ou entrevista não podem ser passadas a seus pais e ou responsáveis sem a permissão do adolescente. Este sigilo poderá ser rompido em casos excepcionais de risco de vida para o adolescente ou para outrem. A questão aborda especificamente o tema contracepção de emergência e os passos a serem seguidos também estão bem descritos. Pode ser feita a prescrição de anticoncepção de emergência às adolescentes expostas ao risco iminente de gravidez, nas seguintes situações não estar usando qualquer método anticoncepcional falha do método anticoncepcional em uso violência sexual. Vale lembrar que na atenção à menor de 14 anos sexualmente ativa, a presunção de estupro deixa de existir, frente ao conhecimento que o profissional possui de sua não ocorrência, a partir da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

informação da adolescente e da avaliação criteriosa do caso, que deve estar devidamente registrada no prontuário médico. Assim, não devemos revelar à mãe qual foi o conteúdo da consulta e nem os procedimentos adotados. O gabarito oficial foi não revelar à mãe.

84957.

Comentário: Questão bem difícil. Mas, com um pouco de calma e cuidado na leitura, seria possível chegarmos às respostas aceitas pela banca. Sempre que estamos realizando a consulta de puericultura de um criança, uma série de pontos devem ser rotineiramente avaliados e para cada um deles é instituído um diagnóstico próprio. Faz parte da consulta de puericultura a avaliação do crescimento, do desenvolvimento neuropsicomotor, dos hábitos alimentares, da situação vacinal e de todas as queixas apresentadas pela família. Veja qual o gabarito oficial da banca e leia nossos comentários após Gabarito oficial 1. Crescimento adequado. 2. Nutricional baixo peso ou baixo ganho ponderal. 3. Vacinação completa. 4.DNPM(Desenvolvimento Neuropsicomotor) adequado. 5. Alimentação inadequada. 6. Anemia ferropriva OU anemia carencial OU deficiência de ferro. 7. Suspeita de Verminose OU parasitose. 8. Ptiríase alba OU xerodermia. Em relação ao ponto 1, é provável que a banca tenha se referido ao crescimento como sendo o crescimento linear desta criança. De fato, ainda que a lactente se mantenha próximo ao percentil inferior do gráfico, mantem uma curva ascendente e está logo acima do percentil 3. Em relação ao ponto 2, bastava que os valores de peso fosse indicados e você iria ver que o ganho ponderal dessa criança vinha sendo insatisfatório e que agora a mesma já apresentava baixo peso para a idade (peso abaixo do percentil 3). A caderneta de vacinação mostrava calendário atualiado, como descrito no item 3. O ponto 4 fazia referência à avaliação do desenvolvimento, que, pela descrição também se revelou apropriado para a idade. A alimentação descrita no recordatório mostrava-se inadequada sabemos que a alimentação saudável de uma criança abaixo dos dois anos deve ser variada, com estímulo para o consumo de frutas, verduras e legumes. Além disso, o consumo de balas e doces deve ser desencorajado. O tópico 6 gerou alguns questionamentos será possível afirmar que há anemia ou deficiência de ferro apenas pela descrição de que a criança está descorada Sim A anemia ferropriva é uma condição de alta prevalência e a OMS chega a recomedar que o tratamento seja

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

instituído apenas pela presença de palidez, mesmo sem a confirmação laboratorial. A suspeita de parasitose, do item 7, poderia ser suspeita pela descrição dos maus hábitos de higiene, mas o relato de eliminação de vermes pelo irmão reforçam essa suspeita. E, por fim, a imagem mostrada é, de fato, compatível com a pitiríase alba.

84959.

Comentário: Faz parte da consulta de puericultura a abordagem de vários aspectos relacionados à saúde infantil. Na parte inicial desta questão, a banca havia solicitado o estabelecimento dos diagnósticos pertinentes ao caso e agora deseja saber qual a conduta para cada um dos diagnósticos estabelecidos. Veja, primeiramente, qual foi o gabarito oficial e leia depois nossos comentários. GABARITO OFICIAL 1. Crescimento observação. 2.Nutricional a. Introduzir sulfato ferroso 5mg Fe Kg 45 mg, dependendo da formulação pode ser 18 gotas (2,5mg Fe gota). Ou Só introduzir sulfato ferroso. b. b1. Nesta idade a criança deve apresentar seguintes refeições café-da-mahã, lanche da manhã , almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite (ou ceia). b2. Limitar guloseimas e carboidratos livres em excesso como bolacha e doces. Introduzir proteína carnes, ovos e leguminosas 4 vezes por semana. Introduzir frutas, verduras e legumes todos os dias. 3. Vacinação Reforço da DTP. Reforço da Polio OU VOP. Reforço da meningo C. Reforço da Tetra Ou Tríplice Viral. 4. Suspeita de Verminose Tratar verminose ou pedir 3PPFs. OU TRATAR com Albendazol. Na avaliação do crescimento, havíamos visto que a criança apresentava estatura logo acima do percentil 3, mantendo uma curva ascendente de crescimento. No que a banca chamou de avaliação nutricional, percebemos a presença de baixo peso para a idade e uma alimentação inadequada para um lactente. Com base nos passos para uma alimentação saudável para crianças menores de dois meses, poderíamos dar todas as orientações contidas no gabarito. Ainda na conduta nutricional, a banca incluiu a recomendação da prescrição de sulfato ferroso com a dose terapêutica de ferro, isto é, para tratamento de anemia ferropriva. É possível iniciarmos o tratamento mesmo sem a realização de qualquer exame complementar Sim A Organização Mundial de Saúde permite o tratamento de anemia ferropriva apenas pela presença de palidez, dada a tamanha prevalência da carência de ferro na população mundial. Em relação à vacinação, as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

recomendações da banca estão confusas. Se uma criança de 18 meses tem calendário vacinal completo, as próximas vacinas serão apenas o reforço de DTP aos 4 anos e a vacina contra poliomielite nas campanhas anuais. Não há reforço de tríplice viral, nem de meningocócica. E, por fim, em relação ao tratamento da parasitose intestinal, o gabarito da banca foi o uso de albendazol. O uso de mebendazol está correto e também é apropriado. Alguns autores demonstraram que o uso de dose única de albendazol pode ser mais eficaz que o mebendazol, porém, a recomendação do mebendazol está fartamente documentada na literatura.

62879.

Comentário: Vamos analisar cada uma das opções Opções A e B Corretas. A doença pode manifestar-se rapidamente, causando insuficiência respiratória aguda com alta letalidade, justificando a indicação de profilaxia primária. Opção C Incorreta. É importante destacar que as crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV também podem ter maior risco de exposição a outros agentes infecciosos durante o período INTRAUTERINO E PERINATAL. Entre estes, destacam-se Treponema pallidum , vírus das Hepatites B e C, vírus HTLV-I, vírus do Herpes Simples, Citomegalovírus, Toxoplasma gondii e Mycobacterium tuberculosis . Opção D Correta. O HTLV-1 é o agente causador da leucemia linfoma de células T do adulto (ATL). A probabilidade de desenvolvimento desta doença nos infectados é de 4%. Na forma linfomatosa (10-15%) está ligada ao linfoma de células T não Hodgkin, sem comprometimento sanguíneo e da medula óssea. A dermatite infecciosa associada ao HTLV é um eczema crônico, recorrente, que compromete na maioria das vezes crianças e adolescentes. Ela é caracterizada por lesões eritematosas, escamosas e crostosas, acomete regiões do couro cabeludo, retroauriculares, cervicais, periorais, nasais e inguinocrurais. Opção E Correta.

62890.

Comentário: Vamos analisar as opções A correta. Isso se dá por um mecanismo não muito bem explicado, mas o que se sabe é que a maior transferência maternofetal de ferro se dá nas últimas semanas de gestação, ou seja, quanto menor a idade gestacional, menor a quantidade absoluta (e não relativa, que se mantém em 75 mg kg) de ferro no organismo do concepto. B correta. A menor

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

meia-vida das hemácias fetais, que carreiam uma grande concentração de hemoglobina fetal, faz com que tal fenômeno ocorra, levando à clássica anemia fisiológica da infância (ou da lactância), que ocorre nessa fase da vida. C incorreta. O fenômeno é fisiológico, como já descrevemos e não traz qualquer consequência deletéria para o bebê. Por esse motivo, não há necessidade de tratamento ou profilaxia nesse contexto. D correta. Exatamente por esse motivo, quando falamos de recém-nascidos a termo, só devemos iniciar a suplementação profilática quando do início da transição alimentar, idealmente aos 6 meses de vida, na dose de 1 mg kg dia de ferro elementar (até os 2 anos). E correta. A grande biodisponibilidade do ferro do leite humano se dá, dentre outros fatores, pela presença de lactoferrina nesse alimento. A alimentação com outras fontes diminui a ligação entre o ferro do leite e essa proteína, fazendo com que a biodisponibilidade do mineral decresça em grandes proporções.

343349.

Comentário: A puberdade normal é o período de transição entre a infância e a vida adulta, fase biológica de crescimento e desenvolvimento na qual ocorrem modificações marcantes, físicas e psicológicas, que culminam com maturidade sexual e capacidade de reprodução. Nos meninos ocorre entre os nove e 14 anos e nas meninas entre os oito e 13 anos de idade. A puberdade precoce, por sua vez, ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece antes dos oito anos em meninas e antes dos nove anos em meninos. Resposta letra C.

343350.

Comentário: Em relação à puberdade em meninos e meninas, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. O primeiro sinal do início da puberdade feminina é a telarca (desenvolvimento do tecido mamário) e corresponde ao estádio puberal M2. Já a menarca ocorrerá apenas 2 a 2,5 anos depois da telarca, geralmente em M3-M4. A letra B está correta. A puberdade normal é o período de transição entre a infância e a vida adulta, fase biológica de crescimento e desenvolvimento na qual ocorrem modificações marcantes, físicas e psicológicas, que culminam com maturidade sexual e capacidade de reprodução. Nos meninos ocorre entre os nove e 14 anos e nas meninas entre os oito e 13 anos de idade. A letra C está incorreta. O primeiro sinal visível da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

puberdade masculina é o crescimento dos testículos (3 ml ou 4 ml de volume ou 2,5 cm no maior diâmetro). A letra D está incorreta. A puberdade precoce pode ser central ou periférica. Resposta letra B.

343351.

Comentário: O aumento das glândulas mamária no sexo masculino, é definido tecnicamente como ginecomastia. A ginecomastia é caracterizada como o desenvolvimento benigno da mama masculina, podendo ser temporária ou definitiva, unilateral ou bilateral. A origem fisiológica é classificada em fases neonatal, puberal e senil, enquanto a patológica provém de causas hormonais, que ocorrem por um desequilíbrio entre as quantidades de estrógeno e andrógeno. A maioria das ocorrências é assintomática, porém existem alguns indícios que levam à busca por auxílio médico, como desconforto, mastalgia, sensibilidade e aumento das mamas. O conjunto desses sintomas leva, consequentemente, ao temor de doença maligna pelo paciente. Entretanto, a ginecomastia é determinada por um crescimento benigno do tecido glandular, através de ramificações secundárias dos ductos e hiperplasia estromal, levando ao seu alargamento macio, simétrico e discoide. Na fase da puberdade é normal que a ginecomastia esteja presente nos meninos, com incidência de até 50%, e na grande maioria se resolve naturalmente, bastando que seja feito acompanhamento clínico. Resposta letra A.

343353.

Comentário: Em relação ao desenvolvimento genital masculino, segundo os estágios de Tanner, temos que G1 Testículos, escroto e pênis de tamanho e proporções infantis G2 Aumento inicial do volume testicular (3 a 4 mL). A pele do escroto muda de textura e torna-se avermelhada. Aumento do pênis pequeno ou ausente G3 Crescimento do pênis em comprimento. Maior aumento dos testículos e do escroto G4 Aumento do pênis, principalmente em diâmetro, e desenvolvimento da glande. Maior crescimento de testículos e escroto, cuja pele se torna mais enrugada e pigmentada G5 Desenvolvimento completo da genitália, que assume características adultas. Em relação ao desenvolvimento dos pelos púbicos em meninos, temos o seguinte P1 - Ausência de pelos púbicos. Pode haver uma leve penugem semelhante à da parede abdominal P2 - Pelos longos e finos,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

levemente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados, principalmente na base do pênis P3 - Maior quantidade de pêlos, mais grossos, escuros e levemente encaracolados, espalhando-se esparsamente pela sínfise púbica P4 - Pelos iguais aos do adulto, grossos e encaracolados, cobrindo mais densamente a região púbica, mas ainda sem atingir a face interna das coxas P5 - Pelos iguais aos do adulto em quantidade e distribuição, invadindo a face interna das coxas. Resposta letra A.

281863.

Comentário: Questão conceitual. Segundo as últimas recomendações da Academia Americana de Pediatria, as h oras de sono recomendadas variam de acordo com a idade - 4 a 12 meses 12 a 16 horas diárias - 1 a 2 anos 11 a 14 horas diárias - 3 a 5 anos 10 a 13 horas diárias - 6 a 12 anos 9 a 12 horas diárias - 13 a 18 anos 8 a 10 horas Resposta letra D.

283858.

Comentário: Vamos analisar cada afirmativa a) INCORRETA. O consumo dos sucos, mesmo que naturais, deve ser desestimulado. O menor teor de fibra em comparação com a fruta in natura faz com que mais açúcar seja absorvido, o que é prejudicial para a saúde do bebê. b) INCORRETA. O aleitamento materno deve ser mantido em regime exclusivo até o sexto mês de vida, período em que deve ser iniciada a alimentação complementar. c) CORRETA. Desde o início da introdução alimentar, o recomendado é que sejam oferecidos alimentos de grupos variados, incluindo proteínas, leguminosas, hortaliças e carboidratos. Não há restrição a nenhum tipo de alimento, com exceção do mel, que não deve ser oferecido nos primeiros dois anos de vida. d) INCORRETA. Como dito na alternativa B, a introdução alimentar deve ocorrer a partir do sexto mês. Aos 3 meses a criança ainda não apresenta nem coordenação para mastigar e deglutir alimentos sólidos. e) INCORRETA. Sempre devemos preferir alimentos preparados em casa, pelo menor teor de conservantes e temperos, evitando sempre que possível o consumo de comidas industrializadas. No entanto, em situações de exceção, em que a papa caseira não puder ser oferecida, é evidente que é melhor fornecer uma papa industrializada do que não dar comida para a criança. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250010.

Comentário: Temos uma puérpera que se queixa de baixa produção de leite. Logo, a primeira hipótese diagnóstica que temos que pensar é a hipogalactia. Agora sobre o tratamento, um detalhe importante A sulpirida, um antagonista dopaminérgico usado como antidepressivo e antipsicótico e que atua sobre receptores D2, D3 e D4 promovendo aumento dos níveis de prolactina sérica e um efeito galactagogo, vem sendo cada vez mais contraindicada pelos autores devido sua baixa eficácia. Além disso, é excretada no leite materno em dose alta. Deste modo, de acordo com a própria FEBRASGO, qualquer referência anterior sobre o uso de medicamentos contendo sulpirida como galactagogo deve ser atualizada e tal uso deve ser desconsiderado. Questão que deveria ter sido anulada, mas que teve como resposta a letra C.

218136.

Comentário: Analisando as assertivas 1 - verdadeira. Esses são os principais fatores a tentarem ser revertidos o mais precocemente possível para tentar evitar sequelas neurológicas. 2 - falsa. A ausência de testículos na bolsa escrotal define um quadro de genitália ambígua (atípica) e quando não há gônadas palpáveis, o diagnóstico mais provável é de pseudo-hermafroditismo feminino devido à hiperplasia congênita de supra-renal. A investigação deve ser voltada para tal entidade, clínica e laboratorialmente. 3 - falsa. A hérnia inguinal em bebês deve ser resolvida cirurgicamente o mais precocemente possível, pois o risco de encarceramento ou estrangulamento é grande. 4 - verdadeira. Sabemos que nas meninas o primeiro sinal de puberdade é a telarca (desenvolvimento da glândula mamária). Esse caracter sexual surge entre 8 e 13 anos. A puberdade precoce é definida quando o desenvolvimento das características sexuais secundários nas meninas ocorre antes de 8 anos de idade Resposta letra B.

218148.

Comentário: Os primeiros dois anos de vida são um período de crescimento intenso e, por isso, esta é a fase em que a criança está mais vulnerável a ocorrência de anemia por deficiência de ferro. De acordo com o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, a suplementação de ferro deve ser feita para as crianças de 6 a 24 meses, diariamente, com 1 mg kg de ferro,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

independentemente do volume de fórmula ingerido no dia. A suplementação também independe do resultado de exames complementares. Porém, desde 2018, a Sociedade Brasileira de Pediatria passou a recomendar que as crianças nascidas a termo e com peso superior a 2.500 g em aleitamento materno exclusivo começassem a receber a profilaxia a partir dos três meses. Estariam dispensadas desta profilaxia aquelas que continuassem recebendo pelo menos 500 ml dia de fórmula infantil. Resposta letra E.

218184.

Comentário: Vamos avaliar as afirmativas 1ª Falsa. Os sucos devem ser evitados e devemos dar preferência às frutas in natura, preferencialmente sob a forma de papa. A primeira papa principal (antigamente chamada de papa salgada) deve ser oferecida a partir do 6º mês. Não há restrições à introdução concomitante de alimentos diferentes, mas a refeição deve conter pelo menos um alimento de cada um dos seguintes grupos Cereais ou tubérculos, leguminosas, carne e hortaliças. A papa deve ser amassada, sem peneirar ou liquidificar, para que sejam aproveitadas as fibras dos alimentos e fique na consistência de purê. 2ª Falsa. Habitualmente, o recém-nascido mama com frequência, sem regularidade quanto a horários. É comum um bebê em aleitamento materno exclusivo sob livre demanda mamar de 8 a 12 vezes ao dia. Muitas mães, em especial as inseguras, costumam interpretar esse comportamento como sinal de fome do bebê, leite fraco ou insuficiente, culminando, quando não assistidas adequadamente, com a introdução de suplementos. Não está indicada alimentação hiperproteica para as mães, o uso de protetores de mamilos, nem ordenar o leite residual, ou aumentar a frequência das mamadas. 3ª Verdadeira. Pelos motivos citados, é que orienta-se o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Resposta letra C.

139745.

Comentário: Em relação aos métodos contraceptivos na adolescência, temos A) Os preservativos masculinos ou femininos (condoms) são ótimas opções contraceptivas, além de funcionarem como método preventivo contra doenças sexualmente transmissíveis. Quando associados a espermicidas, podem atingir uma eficácia de 98%. Os espermicidas atuam também na redução da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incidência de gonorreia, tricomoníase, vaginose bacteriana e infecção por clamídia (CORRETA). B) Os anticoncepcionais hormonais devem ser tomados de acordo com o ciclo menstrual, estando indicados apenas para mulheres com idade ginecológica acima de 2 anos, devendo-se evitar seu uso no período inicial pós-menarca (CORRETA). C) A ação anticoncepcional dos métodos de emergência se mantém até 72 horas após a relação sexual desprotegida, porém a sua eficácia é dependente do tempo decorrido entre a relação sexual e a tomada da medicação (CORRETA). D) CORRETA. Resposta letra D.

134787.

Comentário: A Puberdade Precoce pode ser definida como o aparecimento de qualquer caracter sexual secundário antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. O tratamento consiste no uso de análogos do GnRH com o objetivo de prevenir a perda de estatura final, minimizar as repercussões psicossociais na criança e na família e reduzir o risco de abuso sexual. A sua administração acarreta a diminuição da secreção corporal de gonadotrofinas e consequente parada ou involução dos caracteres sexuais. Todas as afirmativas estão corretas. Resposta letra D.

134790.

Comentário: A primeira característica do desenvolvimento puberal identificada no sexo masculino é o aumento do volume testicular. Diz-se que houve o aumento deste volume quando o testículo for maior ou igual a 4 ml ou maior do que 2,5 cm em seu maior diâmetro. Isto marca o estádio G2 do desenvolvimento puberal. Os limites etários para início da puberdade no sexo masculino são 9 e 14 anos. Logo, quando a puberdade masculina inicia-se antes dos nove anos há puberdade precoce quando a puberdade masculina não se inicia após os 14, há atraso puberal. O surgimento dos pêlos pubianos costuma suceder o aumento do volume testicular. Resposta letra D.

139783.

Comentário: Uma das contraindicações absolutas para o aleitamento materno é a infecção pelo vírus HIV. Nestes casos, ainda que a principal forma de transmissão seja periparto, a amamentação deve ser suspensa. As crianças deverão ser alimentadas com fórmula infantil apropriada, fornecida pelo governo nos primeiros meses de vida. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134673.

Comentário: Esta questão abordou aspectos da fisiologia da lactação. Logo após o nascimento, os dois hormônios que serão responsáveis pela manutenção da amamentação são a prolactina e a ocitocina. A ocitocina, liberada pela hipófise posterior, atua sobre as células mioepiteliais e é responsável pela ejeção do leite, enquanto a prolactina, produzida pela hipófise anterior, pela secreção láctea. Resposta letra B.

111934.

Comentário: Esta questão representa uma situação relativamente comum no ambulatório de pediatria e que pode causar bastante angústia para as nossas adolescentes, porém, trata-se de algo absolutamente fisiológico. É comum que os primeiros ciclos menstruais sejam irregulares, anovulatórios e mais prolongados, pelo inadequado desenvolvimento folicular. Os ciclos menstruais ovulatórios costumam surgir apenas após 12 a 18 meses de vida ginecológica resultando da maturação das interações do hipotálamo, hipófise, ovários e trato genital. Resposta letra A.

111851.

Comentário: A questão nos mostra um lactente com 6 meses de idade, eutrófico e com desenvolvimento neuropsicomotor satisfatório, sem queixas. A partir dos seis meses de vida, o leite materno passa a não ser capaz de suprir todas as necessidades nutricionais da criança, desta forma, devemos orientar a mãe a iniciar a alimentação complementar, através das papas doces e salgadas, gradativamente - lembrando que o leite materno pode e deve continuar a ser oferecido até, no mínimo, os dois anos de vida. Desta forma, melhor resposta letra B.

350821.

Comentário: Vamos relembrar as orientações do Ministério da Saúde para a adequada introdução alimentar, com base no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras , que descreve 12 passos para uma alimentação saudável 1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses 2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses 3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas 4. Oferecer a comida amassada quando a criança

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

começar a comer outros alimentos além do leite materno 5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade 6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança 7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família 8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família 9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição 10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família 11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa 12. Proteger a criança da publicidade de alimentos A partir disso, vamos avaliar cada afirmativa Letra A incorreta. Devemos desestimular a oferta de frutas na forma de sucos e orientar a oferta da fruta in natura, raspada ou amassada. Os sucos oferecem alto valor calórico e poucas fibras, por isso não são recomendados. Até 1 ano de idade, não devem ser oferecidos. Entre 1 e 3 anos, a oferta máxima deve ser de 120 mL por dia, desde que seja natural da fruta e sem adição de açúcar. Letra B incorreta. Na fase de introdução alimentar, o leite materno deve continuar sendo oferecido em livre demanda, já que ainda é a principal fonte de nutrição do bebê. Letra C incorreta. Os alimentos não devem ser liquidificados, mas sim amassados ou desfiados e oferecidos separadamente para a criança, para que ela conheça novas texturas e sabores. Letra D correta. A papa principal (antigamente chamada de papa salgada e atualmente chamada de papa de múltiplas misturas) deve conter alimentos diferentes grupos, a saber 1 cereal ou tubérculo, legumes e verduras, algum alimento do grupo dos feijões e 1 proteína (carne ou ovos). Resposta letra D.

350817.

Comentário: Questão sobre crises de birra, que fazem parte do desenvolvimento emocional de lactentes e pré-escolares. Neste período, a internalização do não faz parte da estruturação da vida psíquica, e pais e cuidadores tem papel fundamental nisto. O controle é uma questão central neste desenvolvimento as crianças pequenas não controlam a maior parte dos aspectos de sua vida, e são propensos a perder o controle interno causando as birras. Medo, cansaço, fome, expectativas inconsistentes e desconforto físico também podem causar estes episódios. Vamos analisar as opções quanto à faixa etária em que essas reações se reduzem. Letra A incorreta. As birras em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

geral se iniciam na faixa etária entre 1 e 2 anos. Letra B correta e gabarito liberado pela banca. De acordo com o Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, o comportamento de birra como tentativa de alcançar um objetivo revela que a criança compreende as regras e reluta em aceitá-las. De maneira geral, no terceiro ano de vida a criança já é capaz de utilizar adequadamente a linguagem, o que define o tempo das explicações e a redução das birras. Letra C correta. De acordo com o Nelson Textbook of Pediatrics, as birras tem seu pico de prevalência entre 2 e 4 anos, reduzindo após esta idade. Letra D incorreta. Como vimos acima, a redução da frequência das birras costuma ocorrer aos 3 ou 4 anos, dependendo da referência. Resposta da banca letra B. Pela equipe Medgrupo, a letra C também deveria ser considerada correta.

350816.

Comentário: O desenvolvimento da linguagem deve ser avaliado por meio de sons emitidos pela criança, desde a vocalização simples até palavras, frases e orações, como também a habilidade de compreensão e conversação. A aquisição destas habilidades pode ocorrer em períodos diferentes, mas devem sempre respeitar os limites de idade estabelecidos para os marcos de desenvolvimento. Vamos às alternativas. Letra A incorreta. Aos 12 meses, a criança deve falar outras palavras além de mama, dada aos 15 meses, obedecer a comandos simples e aos 18 meses, falar dez palavras e identificar uma ou mais partes do corpo. Letra B incorreta. Aos 24 meses, a criança deve formar frases (sujeito, verbo e predicado) aos 30 meses, referir-se a si mesmo com o pronome eu e aos 3 anos, conhecer seu nome completo, dizer sua idade e sexo e contar três objetos. Também se espera que por volta dos 2 anos a criança seja capaz de seguir instruções com duas etapas. Letra C correta. Aos 4 anos, a criança deve conta até quatro e contar histórias. Essa habilidade junto com o pensamento mágico característico do pré-escolar faz com que seja comum também a invenção de muitas histórias e o surgimento de várias perguntas. Aos 5 anos, deve identificar quatro cores e contar até dez. Letra D incorreta. Dos 5 aos 6 anos, espera-se que a criança já saiba usar o plural, os tempos verbais e os pronomes da forma correta. Resposta letra C.

321319.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos relembrar alguns conceitos sobre o período neonatal e analisar as informações do caso. Nos primeiros dias de vida, é esperada uma perda de até 10% do peso de nascimento em geral, o recém-nascido (RN) recupera este peso até dez a 14 dias de vida. Neste caso, temos um RN com seis dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, que perdeu 200g, correspondendo a 6% do peso de nascimento ou seja, dentro do esperado. O relato de sete fraldas com diurese e seis evacuações (de característica normal para um RN) diárias é um indicativo de ingestão adequada de leite materno. A icterícia até a zona II de Kramer é aquela que se estende até a cicatriz umbilical, correspondendo a valores estimados de bilirrubina entre 5-12 mg dl. A causa mais comum de icterícia no período neonatal é a icterícia fisiológica devemos suspeitar de causa patológica para a icterícia quando esta surge com menos de 24-36 horas de vida, persiste por mais de dez a 14 dias, apresenta aumento de bilirrubina direta ou quando os níveis séricos de bilirrubina aumentam numa taxa maior que cinco mg dl dia e ou atingem níveis maiores que 12mg dl perceba que não há nenhum indício destes sinais de alerta. A icterícia por isoimunização ABO ocorre em mães O e RN A ou B , e a isoimunização Rh em mães Rh negativo com RN Rh positivo como a mãe tem tipagem A , não devemos pensar nestas condições. Juntando todos estes dados, percebemos que estamos diante de um RN saudável com provável icterícia fisiológica, sem indicação de internação hospitalar ou exame complementar deve-se estimular o aleitamento materno e realizar acompanhamento de rotina de puericultura. Resposta letra B.

321321.

Comentário: A descida do leite (apojadura) ocorre, em geral, até o 3º ou 4º o dia após o parto, independentemente do estímulo de sucção. Nos primeiros três a cinco dias, é secretado o colostro, que pode não saciar o recém-nascido da mesma forma que o leite maduro fará por isso, mamadas frequentes e de curta duração são ideais, evitando a sucção ineficaz. Por esses motivos, essa sensação de leite insuficiente nos primeiros dias é muito comum o exame físico normal e a presença de diurese e evacuação são indicativos de que a amamentação está sendo suficiente, apesar dessa impressão materna. Assim, é importante acolher esta mãe e suas angústias relacionadas ao choro da criança, estimular o aleitamento materno em livre demanda e aumentar a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

frequência das mamadas. Não há indicação, portanto, de associar fórmula láctea, estabelecer horários ou aumentar o tempo de mamada, nem de solicitar exames complementares. Resposta letra A.

321330.

Comentário: Vamos relembrar alguns conceitos sobre o crescimento e o desenvolvimento nesta idade. Nos três primeiros meses de vida, espera-se que a criança ganhe 25-30g dia de peso, cresça 3,5 cm mês e aumente o perímetro cefálico em dois cm mês. Além disso, alguns dos marcos esperados até dois meses são o sorriso social e a vocalização, e, entre dois e quatro meses, o sustento da cabeça. A criança descrita no enunciado, portanto, apresenta crescimento e desenvolvimento adequados para a idade, além de diurese em boa quantidade e um padrão evacuatório normal lembre-se que lactentes em aleitamento materno exclusivo podem ficar vários dias sem evacuar. Tudo isso indica que o aleitamento materno está suprindo completamente suas necessidades, devendo ser mantido de forma exclusiva até seis meses, sem necessidade de introdução de fórmula infantil, novos alimentos ou mesmo ordenha. É importante esclarecer a mãe sobre os benefícios do aleitamento em livre demanda e orientá-la que a criança pode passar a ter mamadas mais eficazes e por isso mais curtas, mas que isso não indica um abuso do peito , e que esta criança está eutrófica e saudável. Resposta letra A.

321331.

Comentário: A questão aborda a alimentação de um pré-escolar, período que vai dos dois aos seis anos de idade. As principais orientações nessa idade são que a criança receba cinco ou seis refeições diárias (café da manhã, lanche colação, almoço, lanche, jantar e lanche ceia), que devem ser oferecidas em horários fixos e feitas junto com os outros membros da família. As sobremesas não devem ser recompensas os comportamentos de subornos, ameaças ou gratificações devem ser desencorajados. Assim, se for oferecida, a sobremesa deve ser parte da refeição e, preferencialmente, ser uma fruta (alternativa D correta) refrigerantes, balas, salgadinhos, sucos de caixinha, refrigerantes e doces devem ser evitados (alternativa A incorreta). A oferta de líquidos durante as refeições deve ser controlada deve ser oferecida preferencialmente água após as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

refeições (alternativa B incorreta). O consumo diário de sucos deve ser de 120 ml dia entre um e três anos e 175 ml dia entre quatro e seis anos a ingestão excessiva está associada à obesidade, pelo maior consumo de calorias (um suco, em geral, contém várias unidades da fruta) e perda das fibras, que contribuiriam para diminuir a absorção do açúcar. Nessa idade, o comportamento alimentar é variável e imprevisível, com uma grande oscilação na quantidade ingerida, e a criança possui mecanismos internos de controle de saciedade, que devem se respeitados. Assim, o tamanho das porções deve estar de acordo com o grau de aceitação da criança, ou seja, ela pode repetir, mas não deve ser obrigada a comer tudo que está no prato (alternativa C incorreta). Deve-se limitar também o consumo de excesso de gordura, sal e açúcar, e devem ser oferecidos alimentos ricos em cálcio, vitamina A, vitamina D, zinco e fibras. Resposta letra D.

321333.

Comentário: A erupção dentária é um processo natural, marcada por um período de aumento da produção de saliva e irritabilidade do bebê. O primeiro dente a surgir, é o incisivo central inferior, que aparece entre os 6 (seis) e 10 meses. Em seguida, o incisivo lateral inferior, entre os 7 (sete) e 16 meses. Perceba que esse período pode ser amplo, variando de criança para criança. Ainda que a questão tenha questionando o período de surgimento dos incisivos inferiores na maioria das vezes , esse período pode ser amplo e não é possível afirmar que na maioria das vezes será aos seis meses. Por tal motivo, a questão foi anulada.

321335.

Comentário: Em relação aos marcos do desenvolvimento de uma criança de 15 meses de idade, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. A demonstração de afeto por pessoas conhecidas, já se inicia por volta dos seis meses de idade. A letra B está incorreta. As emoções primárias de raiva, alegria, interesse, medo, nojo e surpresa aparecem, também, por volta dos seis meses de idade. A letra C está incorreta. Entre seis e nove meses, a criança já tem a capacidade de coordenar e compartilhar sua atenção e afeto para objeto e pessoa, ou seja, recebe, mostra ou oferece objetos, com sorrisos, sons e gestos, sempre mantendo a interação com contato visual (letra C incorreta). E por fim, a letra D está correta. A criança com 15 meses de idade,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apresenta um vínculo de segurança bem estabelecido com sua mãe ou seu pai, dessa forma, utilizam-se dessa segurança como uma base da qual começará a explorar de maneira independente o ambiente. Resposta letra D.

321362.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas relacionadas ao aleitamento materno. A prevenção da mastite se dá essencialmente pelo esvaziamento adequado da mama, pois o acúmulo de leite e a resposta inflamatória local favorecem a instalação de um processo infeccioso. Não há indicação, portanto, de desmame, hidratação vigorosa ou de corticoterapia tópica para prevenção dessa condição (alternativa B incorreta). O aciclovir e a sertralina são medicações consideradas compatíveis com a amamentação, que não deve ser descontinuada o aciclovir pode, no entanto, modificar o gosto do leite materno. A losartana é classificada como possivelmente compatível, ou seja, pode ser administrada se o benefício justificar um risco potencial para o bebê. Já o metotrexato é classificado pela Sociedade Brasileira de Pediatria como possivelmente perigoso, ou seja, existem evidências de risco para o lactente ou para a produção láctea, mas o seu uso pode ser aceitável após a avaliação da relação riscos versus benefícios (alternativa C incorreta). O aleitamento materno tem diversos benefícios para a criança, como uma composição nutricional ideal, prevenção de doenças respiratórias e diarreicas, diminuição de alergias e de doenças crônicas, melhor desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da cavidade oral e fortalecimento do vínculo afetivo mãe-bebê. No entanto, a redução do risco de estenose hipertrófica de piloro não está entre esses benefícios (alternativa D incorreta). Dentre as condições maternas que contraindicam a amamentação, destacam-se a infecção pelos vírus HIV e HTLV e o uso de algumas medicações, como antineoplásicos e imunossupressores. Na infecção perinatal por varicela, a amamentação não é permitida se a infecção for adquirida entre cinco dias antes e dois dias depois do parto. Na lactante com tuberculose ativa não tratada, o aleitamento deve ser suspenso temporariamente até o diagnóstico e início da terapia profilática na criança mesmo durante o início do tratamento, enquanto a mãe ainda for bacilífera, ela poderá amamentar. Além disso, enquanto não é instituído tratamento e é indicado isolamento, não há contra-indicação à

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ordenha do leite, que pode ser oferecido à criança em copo ou seringa. Por isso, apesar do gabarito inicial da banca ser a alternativa A, a questão foi anulada, pois essa afirmativa também pode ser considerada incorreta.

292831.

Comentário: As questões sobre desenvolvimento neuropsicomotor são geralmente classificadas como chatas , devido a decoreba dos marcos. No entanto, só pensar que existe uma sequência lógica, principalmente para os marcos motores o desenvolvimento tem sequência crânio-caudal e do centro para a periferia. Logo, espera-se que primeiramente a criança adquira o sustento cefálico (3-4 meses), para depois rolar no leito (6-7 meses), posteriormente sentar sem apoio (9-10) meses, aí sim conseguirá arrastar-se em prono (10 meses) e evoluir com a marcha sem apoio (15 meses). Com relação ao motor-adaptativo, a criança irá pegar objetos na linha média e levá-los a boca (4 meses), transferir objetos de uma mão para a outra (7 meses), evoluir com a pinça assistida (9-10 meses) e pinça completa (12 meses). Logo, somente com essas informações, você já saberia que a letra D é a alternativa correta da questão. Para finalizar, lembrar que a criança geralmente bate palmas e dá tchau em períodos bastante próximos,por volta dos 9 a 10 meses, quando começa a entender a comunicação gestual, evoluindo posteriormente com o ato de apontar. As primeiras palavras com repetição consonantal ocorre aos 10 meses, sendo que até os 12 meses já apresentam sentido claro, em especial de nomeação. Resposta letra D.

292835.

Comentário: Vejamos cada uma das alternativas sobre o tema alimentação na infância. A opção A está mais do que correta está corretíssima Existe uma crescente preocupação com o consumo de açúcar na infância. O consumo precoce do açúcar aumenta a chance de ganho de peso excessivo nos primeiros anos de vida e o risco de obesidade e outras doenças na vida adulta. A criança não deve receber açúcar e produtos que contenham este ingrediente nos primeiros dois anos de vida (a opção B está errada). A opção C está errada os alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos nos primeiros dois anos de vida são nutricionalmente desbalanceados e contêm muitos aditivos. E por fim, a opção D está errada as bebidas açucaradas não devem ser oferecidas e o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

consumo de sucos não é recomendado no primeiro ano de vida. A criança deve consumir apenas água em vez destes líquidos. Resposta letra A.

292841.

Comentário: Durante a consulta do adolescente, de fato, é importante que seja oferecida a possibilidade de que o adolescente converse com o profissional de saúde sem a companhia de seus pais. Diversos protocolos já foram desenvolvidos com o intuito de permitir um ampla avaliação das condições gerais de vida do adolescente. Em 1988, o método HEADSS foi descrito e cada letra corresponde a uma área a ser avaliada H (home lar, E (education employment educação), A (activities atividade com pares), D (drugs drogas), S (sexuality sexualidade) e S (suicide depression suicídio e depressão). Posteriormente, este protocolo foi atualizado acrescentando-se duas áreas representadas pelas letras E (eating disorders distúrbios alimentares) e S (safe representando segurança e violência), passando a ser reconhecido por HEEADSSS. A tabela em anexo foi extraída de um documento sobre a consulta do adolescente, publicado pela SBP, e traz exemplos de perguntas feitas sobre cada uma destas áreas. É fácil perceber que todas as perguntas citadas poderiam levar à avaliação das condições descritas em todas as alternativas. Por conta disso, a questão foi anulada.

292845.

Comentário: A questão aborda as orientações que habitualmente devem ser discutidas durante o acompanhamento de puericultura. A opção A está incorreta durante o período da amamentação deve ser estimulada uma alimentação adequada, mas sem restrição calórica. A opção B está correta tais orientações estão corretas e são dados que indicam de forma mais específica a adequação do suprimento lácteo que está sendo ofertado para a criança. A opção C está incorreta não há indicação de restrição calórica, mas também não há indicação de alimentos hipercalóricos. E, por fim, a opção D está incorreta não é obrigatório que a criança esvazie a mama por completo em cada mamada. A saciedade da criança deve ser respeitada. Resposta letra B.

259733.

Comentário: O estabelecimento do acolhimento e da empatia são fundamentais estratégias para a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

construção de uma boa relação médico-paciente. Vejamos casa uma das afirmativas. A opção A está incorreta embora vejamos isso sendo feito com frequência em nossa prática, isso não deve ser encorajado. Os responsáveis devem ser cordialmente chamados pelo próprio nome, garantindo a personalização do atendimento. A opção B está correta todas estas informações são importante para conhecimento das condições de vida da criança e adequado planejamento de acompanhamento e tratamento. A opção C está incorreta estes elementos também compõem a anamnese realizada pelo pediatra ou médico da equipe de saúde da família. E, por fim, a opção D está errada o conhecimento da composição do núcleo familiar bem como a compreensão acerca dos conflitos eventualmente existentes nos permitem ter um conhecimento mais aprofundado sobre o paciente. Resposta letra B.

259734.

Comentário: Até os seis de meses de idade devemos recomendar que a criança seja mantida em regime de aleitamento materno exclusivo como, felizmente, ocorreu neste caso. A partir desta idade é recomendado o aleitamento materno complementado, ou seja, o leite materno deve continuar sendo oferecido, mas, de forma gradual e progressiva, é indicada a introdução de alimentos sólidos ou semissólidos. Vejamos cada uma das opções. A opção A está incorreta mesmo alimentos considerados potencialmente alergênicos devem ser introduzidos a partir dos seis meses. Já houve época que a recomendação era de que essa introdução fosse postergada, mas observou-se que o retardo nessa introdução pode aumentar o risco do desenvolvimento de alergia. A opção B está completamente incorreta os açúcares de um modo em geral não devem ser oferecidos para menores de dois anos e o mel está completamente contraindicado no primeiro ano de vida pela associação com o maior risco de botulismo nesta faixa etária. A opção C também está incorreta o leite materno, como já dito, deve continuar sendo oferecido até a criança completar, no mínimo, dois anos de idade. E, por fim, a opção D está correta os alimentos inicialmente oferecidos devem ter consistência pastosa (não devendo nunca ser liquidificados) e esta consistência vai aumentando progressivamente. Resposta letra D.

259748.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Durante o processo de busca da identidade adulta, o adolescente passa por uma série de modificações de comportamento que constituem o que chamamos de síndrome da adolescência normal. Dentre essas modificações, observamos os seguintes comportamentos. busca de si mesmo e da identidade adulta separação progressiva dos pais tendência grupal necessidade de intelectualizar e fantasiar crises religiosas deslocação temporal contradições sucessivas nas manifestações de conduta atitude social reivindicatória constantes flutuações do humor e do estado de ânimo e evolução sexual. As características descritas no enunciado representam a separação progressiva dos pais, quando determinados comportamentos familiares são rejeitados pelos adolescentes. Não há qualquer razão para um acompanhamento específico, especialmente pela descrição do comportamento escolar. Resposta letra C.

259762.

Comentário: Você conhece bem as recomendações para uma alimentação saudável e já repetiu diversas vezes que o aleitamento materno exclusivo é o alimento ideal para todas as crianças e deve ser oferecido de forma exclusiva até seis meses de idade. Porém, eventualmente, isso não será possível. Na impossibilidade de mantermos acriança em aleitamento materno, o substituo ideal é uma fórmula infantil (nos primeiros seis meses de vida são oferecidas as fórmulas de partida e, a partir desta idade, as fórmulas de seguimento). De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria n (SBP), o leite de vaca na deve ser oferecido no primeiro ano de vida O Ministério da Saúde (MS) orienta que o leite de vaca na seja oferecido nos primeiros nove meses. Tanto o MS quanto a SBP orientam que a criança que recebe fórmula infantil receba apenas a fórmula até seis meses e, a partir desta idade, seja feita a introdução da alimentação complementar, do mesmo modo que orientado para as crianças em aleitamento materno. O MS cita que quando a criança recebe leite de vaca, a introdução dos alimentos complementares pode se dar a partir dos quatro meses, desde que o desenvolvimento neuropsicomotor da criança assim o permita. A grande limitação relacionada com o uso das fórmulas é o custo elevado pode representar até 30% do orçamento de uma família que recebe um salário mínimo. Feitas essas considerações, vejamos o que seria a melhor conduta dentre as expostas pela banca, sabendo que a conduta trazida não é algo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

padronizado nas referências citadas. A opção A não é aceitável as fórmulas devem ser rigorosamente diluídas como orientado na lata do fabricante, não devendo ser feita maior diluição para aumentar o rendimento ou acréscimo de outras farinhas à fórmula diluída. A opção B não parece cabível o ideal é que nos primeiros 9-12 meses de vida o leite de vaca não seja oferecido. A opção C foi o gabarito da banca e é algo possível... o enunciado foi categórico ao mostrar a limitação financeira da família. A oferta de outros alimentos diminuirá o consumo da fórmula. Fica o questionamento se a criança já está apta para isso, pois nada foi dito sobre seu desenvolvimento. E, por fim, a opção D também não parece cabível a composição das fórmulas de seguimento não é adequada para os menores de seis meses. Resposta letra C.

234045.

Comentário: Um hemograma feito por conta própria... . Não se espante com uma hemoglobina de 9,6 g dl. O que esta criança apresenta é, muito provavelmente, um quadro denominado anemia fisiológica da infância. Esta situação consiste em um declínio dos níveis de hemoglobina nas primeiras 8 12 semanas de vida até 9 11 g dl em função da diminuição fisiológica dos níveis de eritropoetina após o nascimento (uma consequência do aumento da oferta tecidual de oxigênio com o início da ventilação). Quando o nadir nos níveis de hemoglobina é alcançado, os sensores hepáticos e renais detectam essa redução, e a síntese de eritropoetina é recomeçada. Considerando o crescimento satisfatório e a ausência de qualquer outra alteração que pareça nos preocupar, vamos apenas tranquilizar a família e seguir o acompanhamento de puericultura. Resposta letra A.

234059.

Comentário: Podemos definir a Puberdade Precoce (PP) como sendo o início do desenvolvimento puberal abaixo dos oito anos em meninas e abaixo dos nove anos em meninos. Sendo assim, diante de uma menina menor de oito anos com desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, deve-se considerar a possibilidade de PP. A menina apresentada pela banca tem PP além do desenvolvimento da mama e da USG pélvica mostrando volume de útero e ovários acima do esperado para a idade, ela apresenta avanço da idade óssea, que é um dos grandes problemas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

da PP. A PP pode ser separada em dois grupos principais central ou verdadeira, que é dependente do GnRH, e periférica ou pseudopuberdade precoce, que independe do estímulo de GnRH. Na PP central, há ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, com aumento das gonadotrofinas, levando ao aumento dos esteroides sexuais. A sequência do desenvolvimento puberal é a mesma que a habitual, porém de forma mais precoce. A velocidade de crescimento está aumentada e a idade óssea está avançada em relação à cronológica. A criança apresentada tem aumento de LH, ou seja, de gonadotrofinas. O tratamento é feito com análogos de GnRH. Através da estimulação contínua, os análogos do GnRH dessensibilizam os gonadotrofos hipofisários, diminuindo a liberação de LH e FSH. Resposta letra A.

234079.

Comentário: Questão sobre alimentação na infância que apareceu na parte de preventiva Vamos lá Incorreta. O aleitamento materno ao seio em livre demanda pode ser dado até os 2 anos de idade. Incorreta. Como citado anteriormente. Incorreta. CORRETA. A criança já possui 8 meses, ou seja, já consegue ingerir alimentos sólidos e não precisamos introduzir sucos de frutas e sopas ralas (o que deveria ser feito a partir dos 6 meses). Resposta letra D.

199694.

Comentário: Esta é uma queixa comum a muitas mulheres que estão amamentando a crença de que estão produzindo leite em quantidade insuficiente para seus filhos ou de que seu leite seja fraco. É verdade que, em algumas situações, pode ocorrer uma diminuição na produção láctea, especialmente quando o aleitamento não se dá em regime de livre demanda e quando as mamas não são esvaziadas apropriadamente. Porém, não devemos supor que a criança esteja sendo amamentada de forma insuficiente apenas pelo choro este pode ser manifestação de várias condições, como o início de cólicas infantis. Para avaliar se o suprimento lácteo recebido pela criança está adequado, devemos nos basear em dados objetivos, sendo que o ganho ponderal é o mais importante destes. Foi dito que a criança tem ganho satisfatório e isto deve ser assegurado para dona Marta. O estímulo para o consumo de fórmulas infantis poderá diminuir a frequência das mamadas e, aí sim, diminuir a produção de leite. Não deve ser orientado horário fixo entre as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mamadas, sendo recomendado o regime de livre demanda. Resposta letra D.

199648.

Comentário: As questões sobre desenvolvimento frequentemente vão dar margem para dúvidas e, por isso, é importante tentar encontrar a melhor resposta. Estamos diante de uma criança de nove meses de idade e a banca quer saber quais são os padrões emergentes de comportamento nessa criança. Vamos analisar as alternativas. A opção A está incorreta uma criança de 9-10 meses ainda não fala as primeiras palavras, ela apenas duplica sílabas. Além disso, ela não dá os primeiros passos, que acontece aos 12 meses com apoio. A opção B também está incorreta aos nove meses a pinça completa (polpa a polpa) ainda não é realizada, sendo esperada aos 12 meses. A opção C está incorreta observar a própria mão e seguir com o olhar até 180 são características observadas no primeiro trimestre de vida. E, por fim, a letra D foi a opção correta pela banca. Transmitir objetos de uma mão para a outra já deveria ter sido observada na consulta anterior (é esperado em torno dos 6-7 meses). Entretanto, as demais descrições são encontradas na criança de nove meses. Logo, a melhor resposta é a letra D. Resposta letra D.

199665.

Comentário: O tema saúde bucal vem tornando-se cada vez mais recorrente nos concursos. Sabemos que a cárie nos dentes de leite pode causar dor, prejudicar a mastigação e até mesmo a fala. Para controle da placa bacteriana e prevenção da cárie e de outras doenças bucais, é fundamental que sejam dadas orientações periódicas para higiene bucal. Recomenda-se que a escovação dentária seja iniciada tão logo ocorra a erupção dos primeiros dentes. Isso deve ser feito, pelo menos, duas vezes ao dia e devem ser usados dentifrícios fluoretados (a prática de não se usar isso é algo desatualizado). A criança deve ser orientada a cuspir a pasta e para as crianças que ainda não conseguem cuspir, a recomendação é de que seja usada uma quantidade mínima do dentifrício. Conforme o espaço entre os dentes diminui após o surgimento dos molares, também trona-se importante a recomendação do uso de fio dental. Resposta letra B.

172983.

Comentário: Vamos recordar algumas regrinhas sobre o acompanhamento antropométrico no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

primeiro ano de vida. No primeiro trimestre de vida, o bebê ganha uma média de 700 g mês. Em três meses, portanto, espera-se que o lactente em questão tenha 700 g x 3 2.100 g a mais do que o nascimento, ou seja, 2.780 2.100 4.880 g. O bebê pesou 4.800 g, um valor bem próximo ao esperado em média. Quanto ao perímetro cefálico, sabemos que, no primeiro trimestre de vida, o bebê tem um crescimento de 2 cm por mês, seguindo no segundo trimestre com 1 cm por mês e, posteriormente, ao longo do segundo semestre de vida, apenas 0,5 cm por mês. Nosso bebê nasceu com um perímetro cefálico de 33 cm e, ao longo dos 3 meses, esperamos que tenha ganhado 6 cm (2 cm x 3 meses), totalizando 39 cm (33 6). Sua medida atual foi de 40 cm, bem próximo do esperado para a idade. Assim, podemos afirmar que suas medidas estão adequadas para a idade. Resposta letra D.

173028.

Comentário: Temos aqui um caso clássico de ingurgitamento mamário, o resultado de uma bola de neve que pode se estabelecer após a apojadura. Quando a produção láctea se estabelece, algumas mulheres produzem uma grande quantidade de leite e, nos primeiros dias de vida, a criança ainda não consegue mamar grandes volumes. Este quadro pode levar ao desenvolvimento de um ingurgitamento patológico a estase do leite compromete a drenagem linfática da mama, e a consequência disso são mamas edemaciadas, dolorosas, podendo estar difusamente avermelhadas... O caos Esta condição pode prejudicar muito a amamentação, dificultando a pega do bebê. Lembre-se de que a mastite é diferente do apresentado geralmente, a vermelhidão é mais localizada em um quadrante. A fim de se resolver o ingurgitamento, está indicado o estímulo à amamentação em regime de livre demanda, massagem das mamas, uso de analgésicos sistêmicos e ou anti-inflamatórios, suporte para as mamas (uso contínuo de sutiã de sustentação), crioterapia (aplicação de gelo) após as mamadas, para redução temporária da produção de leite, e esvaziamento completo da mama, por ordenha manual ou bomba. Resposta letra C.

150860.

Comentário: Ao avaliarmos a técnica da amamentação, iremos dizer que a mesma está correta quando são observados alguns pontos-chave relacionados com o posicionamento e a pega. Os

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pontos-chave do posicionamento adequado são 1. Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo 2. Corpo do bebê próximo ao da mãe 3. Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido) 4. Bebê bem apoiado. Já os pontos-chave da pega adequada são 1. Mais aréola visível acima da boca do bebê (opção D errada) 2. Boca bem aberta (a maior parte da aréola deve ser abocanhada, não apenas o mamilo opção C errada) 3. Lábio inferior virado para fora (opção B certa) 4. Queixo tocando a mama (opção A errada). Resposta letra B.

150873.

Comentário: Essa questão gerou, justificadamente, alguns questionamentos na ocasião do concurso. Vamos tentar entender o que está acontecendo neste caso. Temos uma criança que já se encontra no 15 o dia de vida e que ainda não recuperou o seu peso de nascimento. Sabemos que é esperado que ocorra uma perda ponderal de até 10% do peso de nascimento na primeira semana de vida, mas que isso costuma ter sido recuperado até o 10 o -14 o dia de vida criança. O fato de isso ainda não ter ocorrido é algo que deve nos alertar para algum problema subjacente, principalmente um problema relacionado com a amamentação (opção A errada). O primeiro passo é sempre avaliar a técnica da amamentação e verificar se existe algum problema que possa ser corrigido. Além disso, devemos avaliar se a amamentação está se estabelecendo em regime de livre demanda. A recomendação habitual é de que a criança seja mantida com amamentação em livre demanda, ou seja, sem restrições de horários e de tempo de permanência na mama. Em geral, um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de oito a 12 vezes ao dia, mas essa frequência pode ser maior ou menor. A resposta considerada correta pela banca foi letra B e podemos entender o que a banca quis indicar... Para que o ganho ponderal seja satisfatório, é importante que a criança esvazie cada uma das mamas, de modo a receber o leite posterior, mais rico em gordura e com maior densidade calórica. Crianças que permanecem pouco tempo em uma mama podem receber apenas o leite anterior e, deste modo, terem menos ganho ponderal. Muitos questionaram se estaria correta essa indicação, uma vez que não devemos estabelecer um tempo de permanência em cada mama... de fato, isso não deve ser uma regra, mas pode ser algo temporário até que a mulher consiga ter melhor percepção o esvaziamento de cada uma das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mamas. Além disso, as outras opções estão claramente incorretas. Se iniciarmos uma fórmula infantil, como sugerido na opção C, vamos reduzir o estimulo da sucção para produção láctea, o que pode contribuir para a interrupção da amamentação. Não haveria porque não amamentar a criança diretamente na mama e oferecer o leite ordenhado, o que também poderia diminuir o estímulo... assim, a melhor resposta fica sendo, de fato, a letra B.

150889.

Comentário: As principais habilidades na avaliação de uma criança de 15 meses, são as seguintes. Do ponto de vista motor, já é capaz de andar sozinha e engatinhar para subir uma escada. Do ponto de vista da motricidade fina, já faz torres de três cubos, faz um alinha com lápis de cera e coloca uma uva-passa em uma garrafa. Em relação à linguagem, é capaz de obedecer a comandos, nomear objetos familiares, responder ao seu nome. E, do ponto de vista social, indicam desejos ou necessidades apontando e abraça os pais. Assim, a opção D é a que melhor descreveria, ainda que já seja esperado que a criança fale palavras desde 12 meses. Na opção A temos a descrição de habilidades esperadas desde o segundo semestre de vida na opção B, temos habilidades mais tardias (só costuma ser esperado que a criança corra com 18 meses). E, na opção C, temos a descrição de construir frases, que só é esperada no final do segundo ano de vida. Resposta letra D.

150793.

Comentário: A grande pegadinha da questão é que ela começa apresentando o caso de uma indivíduo, mas termina com uma pergunta direcionada a estratégia que atue no coletivo. Todas as medidas dispostas podem produzir impacto na saúde bucal, mas a utilização de pastas com flúor e fio dental e a explanação de técnicas de escovação específicas têm atuação individual. De forma oposta, a fluoretação das águas de abastecimento e a realização de oficinas de promoção de saúde bucal nas UBS representam estratégias de impacto coletivo. No entanto, a primeira possui maior abrangência, visto que afeta toda uma população, enquanto a segunda somente os que frequentam as oficinas e aderem as informações recomendadas. Resposta letra A.

126979.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O primeiro passo para uma alimentação saudável nos primeiros dois anos de vida da criança é tentar garantir que nos primeiros seis meses a criança seja mantida em regime de aleitamento materno exclusivo. A partir dos seis meses, de forma gradual e progressiva, deve ser iniciada a introdução da alimentação complementar, mantendo-se o oferecimento de leite materno até dois anos de idade, no mínimo (regime chamado de aleitamento materno complementado). O Ministério da Saúde propõe algumas orientações para que a alimentação saudável seja mantida. Uma delas diz que a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher começar com consistência pastosa (papas purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família (opção D certa). Os alimentos não devem ser liquidificados e nem passados em peneiras (opções B e C erradas). Além disso, deve-se oferecer à criança diferentes alimentos todos os dias. Porém, tais alimentos não devem ser misturados, permitindo que a criança seja exposta a diferentes sabores e paladares (opção A errada). Resposta letra D.

126989.

Comentário: Sabemos que o desenvolvimento de uma criança é um processo sequencial e previsível e que, nas várias faixas etárias, espera-se que já tenha ocorrido o surgimento de algumas habilidades. As habilidades descritas nas opções B, C e D são habilidades características de crianças que já estão no quarto trimestre de vida e de modo algum seriam esperadas em uma criança de apenas cinco meses. Porém, a habilidade descrita na opção A já deveria estar presente neste lactente. Até essa idade, já é esperado que a criança seja capaz de ter uma resposta ativa ao contato social. O Ministério da Saúde recomenda que isso seja avaliado da seguinte forma fique à frente do bebê e converse com ele. Observe se ele responde com sorriso e emissão de sons como se estivesse conversando com você. Pode pedir que a mãe cuidador o faça. Resposta letra A.

126982.

Comentário: Questão relativamente simples, objetiva saber se o aluno conhece os intervalos de tempo em que o leite materno ordenhado pode ser armazenado. Mesmo após a nutriz retornar ao trabalho, é possível que a criança seja mantida em aleitamento materno exclusivo. Para isso, nos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

períodos em que a mãe estiver em casa, a amamentação será mantida da forma habitual. Porém nos períodos de ausência, a criança irá receber leite que tenha sido previamente ordenhado e armazenado. Para tanto, o médico deve orientá-la a ordenhar manualmente as mamas a intervalos regulares, com a mão em forma de C , sempre comprimindo a mama em direção à caixa torácica, sem atritar a pele do mamilo. O leite deverá ser armazenado em recipientes limpos, e idealmente armazenado em geladeira por 12 horas e em freezer ou congelador por 15 dias. Antes de oferecer o leite à criança, ele deverá ser reaquecido em banho-maria, fora do fogo. Resposta letra D.

102100.

Comentário: Quando fazemos a avaliação do controle postural de uma criança, temos que nos lembrar de que essa avaliação deve ser feita com a criança em diferentes posições decúbito dorsal, ventral, de pé, sentada e suspensão ventral. Em cada uma dessas posições iremos avaliar o tônus e a força dos diferentes grupamentos musculares. Aos quatro meses de idade, seria indicativo de atraso motor o fato de a criança não ser capaz de elevara sua cabeça. Nessa idade, já é esperado que mesmo em posição prona a criança já eleve e sustente bem a cabeça. Resposta letra A.

102107.

Comentário: Ao avaliar a história alimentar desse lactente você deve ser capaz de perceber que ele tem mais de um fator de risco para o desenvolvimento de um quadro de anemia ferropriva. Temos a descrição de introdução precoce de leite de vaca e a interrupção precoce do aleitamento materno. Além disso, não foi iniciada a profilaxia para anemia ferropriva. Nos lactentes com interrupção precoce de aleitamento e uso do leite de vaca, o Ministério da Saúde recomenda que a suplementação comece a ser feita já a partir dos quatro meses. Apenas por isso, já poderíamos pensar em marcar a letra B. Diga essa dieta oferece risco de sobrecarga renal Sim, principalmente nos primeiros quatro meses de vida. O leite de vaca tem excesso de proteína e de eletrólitos como sódio, o que impõe importante sobrecarga renal nos primeiros meses de vida, quando a capacidade de concentração urinária ainda é limitada. Em relação às outras alternativas, a criança parece ter um aporte de cálcio suficiente, e isso não seria um problema o risco maior seria de hipovitaminose A e D, não o contrário os alimentos recebidos não parecem ser ricos em glúten (não se sabe ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

certo qual o tipo de biscoito que vem sendo oferecido) e não há porque pensar em doença celíaca. Resposta letra B.

102175.

Comentário: Temos uma menina de 10 anos de idade que mede 128 cm. A primeira pergunta é ela tem baixa estatura Para respondermos esta pergunta, a banca nos forneceu um gráfico. Ao plotarmos a altura atual e a pregressa, observamos que essa paciente vem crescendo entre os percentis 3 e 15 e com velocidade de crescimento normal. Por qual razão foi solicitada uma radiografia para avaliação de idade óssea é um mistério. Será que ela está muito abaixo de seu alvo genético Além disso, essa menina é impúbere e ainda irá passar pela aceleração do crescimento puberal. Logo, iremos tão somente acompanhá-la clinicamente. Resposta letra D.

81323.

Comentário: Criança saudável, sem história de intercorrências na gestação ou durante os primeiros dois anos de vida. Em relação à queixa principal da mãe sobre a linguagem, podemos dizer que nessa idade a criança deve ser capaz de colocar 3 palavras em conjunto (sujeito, verbo e objeto). Portanto, percebemos que esta criança forma frases pequenas e consegue se comunicar, apesar da falta do verbo vamos . Em relação aos outros marcos do desenvolvimento, aos 24 meses, uma criança deve correr, pular, fazer torre de 7 cubos e ajudar a se despir. E pelo exame clínico, a criança apresenta desenvolvimento adequado para a idade. Dessa forma, devemos tranquilizar a mãe quanto à normalidade e orientar a estimulação para o uso da linguagem oral em seu dia a dia com a criança. Diante da benignidade do quadro, o retorno pode ser conforme a rotina para a idade. Resposta letra D.

65746.

Comentário: Vamos analisar cada uma das alternativas Opção A - Incorreta. Os estoques corporais de ferro são recompostos com o tratamento oral à base de sulfato ferroso em um período entre 1 a 3 meses. Opção B - Incorreta. O sulfato ferroso é melhor absorvido longe das refeições, especialmente em associação a sucos cítricos, pois o ácido ascórbico facilita a sua absorção ao nível intestinal. Opção C - Incorreta. Os fitatos (presentes em cereais como aveia, farelo de trigo e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

arroz e sementes de leguminosas), compostos fenólicos (presentes na cebola, achocolatados, chás, café, vinho e refrigerantes), fibras e sais de cálcio e fósforo (presentes na soja, leite e ovo) prejudicam a absorção de ferro. Opção D - Correta. Opção E - Incorreta. Dificilmente existe uma intolerância oral ao sulfato ferroso, e a transfusão de concentrado de hemácias é uma solução apenas para quadros mais graves de anemia.

65725.

Comentário: Questão que parece algo subjetivo na maior parte das assertivas, visto que a atenção ao adolescente remete para a questão da normatização dos costumes e condutas, tendo como referência uma variação entre o tradicional e o correto, não se pode pensá-la fora do âmbito da ética. Neste caso, a sociedade definida como um conjunto de indivíduos adultos donos de uma ordem vigente em cada cultura, leva ao adolescente sua ideologia de normas, atitudes e práticas que sem dúvida irão influenciar positiva ou negativamente sua formação. Nesse sentido, o acesso ao serviço de saúde é fundamental para que o adolescente busque tratamento em tempo hábil. Além disso, ele necessita de privacidade e confidencialidade na relação com os profissionais de saúde como expressão de seu processo de individualização. O sigilo da consulta deve ser assegurado por meio de um debate nos serviços visando a um consenso entre os profissionais sobre as situações onde deva ser violado. A confidencialidade apoia-se no artigo 103 do código de Ética Médica, que veda ao médico revelar segredo profissional referente à paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente . Dentre as opções descritas, fica evidente que o único comportamento que, de fato, corresponde a um nítido risco à saúde física e psicológica do paciente é o uso de bebida alcoólica as outras opções apenas refletem conceitos e situações inerentes à chamada adolescência normal . Gabarito letra B.

65740.

Comentário: Analisando as opções A- Errada. Sentar sem apoio é um marco do desenvolvimento esperado para crianças a partir do 6º mês, ou seja, no caso, essa criança estaria com um

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desenvolvimento até um pouco além do esperado na área motora. Na idade de 5 meses, ela já rola bem (letra C correta) e levanta o tronco se tiver apoio dos braços. B- Errada. Segundo a Escala de Desenvolvimento de Denver, a criança de 5 meses é capaz de rir alto, se virar para sons e para vozes (letra D correta), no que concerne à linguagem. E errada. Nessa idade, na área motora fina adaptativa , a criança é capaz de enxergar bem ao seu redor, inclusive podendo alcançar alguns objetos, segundo Denver. Gabarito letra D.

65719.

Comentário: A partir dos seis meses de idade, as necessidades nutricionais da criança não são mais supridas apenas pelo leite materno ou pela fórmula infantil, sendo necessária a introdução de alimentos complementares. Aos seis meses, preconiza-se a introdução de uma papa de frutas e de uma papa salgada (ou papa principal, usando uma nomenclatura mais atual). A criança do caso enunciado já está recebendo as frutas. Assim, o que devemos fazer neste momento é a introdução da papa salgada. Os alimentos que compõem essa papa salgada incluem cereais, tubérculos, leguminosas, legumes, verduras, carnes e ovo. Portanto, a resposta certa é a letra E .

65698.

Comentário: Esta é uma questão no estilo verdadeiro ou falso . O caso enunciado pouco influencia na forma como iremos avaliar cada uma das opções. Vejamos cada uma delas Opção A - Errada. As cefalosporinas não são contraindicadas durante o parto e, inclusive, são aceitas como forma de prevenção da transmissão do estreptococo do grupo B nas situações em que a gestante apresenta história de alergia não grave às penicilinas. Opção B - Errada. Um dos princípios fundamentais relacionados à amamentação é de que não devemos estabelecer um tempo de permanência em cada mama. O tempo necessário para o esvaziamento de uma mama varia de acordo com cada mãe e bebê na verdade, esse tempo pode variar de uma mamada para outra, de acordo com a fome da criança e o intervalo de tempo transcorrido entre duas mamadas. O importante é que a criança fique na mama o tempo necessário para esvaziá-la. Opção C - Errada. Nos casos de ingurgitamento mamário, pode-se realizar a ordenha da mama. O esvaziamento da mama é fundamental para dar alívio à lactante, diminuir a pressão dentro dos alvéolos, aumentar a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

drenagem da linfa e do edema e não comprometer a produção do leite, além de prevenir a ocorrência de mastite. Porém, o leite ordenhado não é necessariamente descartado, podendo ser oferecido à criança. Opção D - Errada. Esta é uma falsa contraindicação clássica à amamentação. Nos casos de mastite puerperal, ainda que a lactante esteja em uso de antimicrobianos, a amamentação não deve ser suspensa. O esvaziamento regular das mamas é o componente mais importante no manejo dessa situação e este esvaziamento deve ser feito, preferencialmente, pelo próprio recém-nascido. Isso não oferece riscos ao recém-nascido sadio. Opção E - Correta. O trauma mamilar representa a dificuldade mais frequente relacionada à amamentação no período pós-parto. A causa mais comum de dor e trauma é a técnica inadequada de amamentação. Com frequência, a nutriz termina por interromper ou reduzir o número de mamadas pela dor provocada pela lesão.

65697.

Comentário: Em primeiro lugar, a banca deseja saber como deve ser interpretado o crescimento dessa adolescente. São fornecidas duas medidas antropométricas peso e estatura. Já é de se estranhar que seja solicitada a avaliação do crescimento sem a informação do percentil ou escore-Z da estatura idade ou IMC idade que a paciente apresenta ou, no mínimo, dos gráficos para que possamos fazer essa avaliação. Não seja por isso. Se consultarmos os gráficos da Organização Mundial de Saúde, iremos descobrir que essa adolescente tem baixa estatura. A sua estatura por idade encontra-se abaixo de -2 desvios-padrão da média da população e isto, por definição, caracteriza um quadro de baixa estatura. Em relação ao seu IMC idade, o mesmo está logo abaixo de 1 desvio-padrão, classificando-a como eutrófica por esse parâmetro. Vamos em frente. A segunda parte da questão diz respeito à avaliação o desenvolvimento puberal. Nossa paciente já iniciou o seu desenvolvimento puberal. Já houve a telarca e a pubarca. O desenvolvimento puberal está associado, primordialmente, à ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Laboratorialmente, os marcadores desse processo são o LH, o FSH e os esteroides. Porém, a ativação do eixo é marcada por uma relação LH FSH maior que 1, não o contrário, como descrito no enunciado. Se quisermos avaliar mais a fundo essa questão, podemos mesmo questionar se

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uma idade óssea de 13 anos é compatível com o estádio M2 (lembre-se de que a idade óssea é um índice da maturação endócrina global e correlaciona-se mais com o estadiamento puberal do que a idade cronológica). De todo modo, isso já seria uma discussão mais aprofundada no âmbito da especialidade. Em função deste erro no enunciado, a banca conferiu a anulação da questão.

141618.

Comentário: Os pilares do tratamento da obesidade infantil consiste no planejamento dietético e estímulo a atividade física. Respeitar os horários das alimentações, melhorar a qualidade da dieta, mastigar bem os alimentos (sem necessitar de líquidos para a ingestão deglutição destes), fazer as principais refeições à mesa e não durante atividades que desviem a atenção do alimento como assistir TV são estratégias fundamentais para um hábito alimentar saudável. Desta forma, a única alternativa que apresenta orientações corretas é a letra A

141606.

Comentário: Questões sobre atraso do desenvolvimento neuropsicomotor são comumente cobrado em provas. Por mais que você não apresente os marcos relacionados a cada faixa etária em mente (o que é normal), associe com as crianças previamente hígidas que já tenha convivido anteriormente. Você espera que todo bebê de 4 meses já fale sílabas, sente sem apoio ou apresente controle esfincteriano Não Um bebê de 4 meses emite barulhos sonoros (ahh , ngah), ainda não senta com apoio (automaticamente não senta sem) e o controle esfincteriano ocorre normalmente entre os 2 a 5 anos de idade. No entanto, você espera que ele já apresente contato social, inclusive que expresse descontentamento, que dê gargalhadas, ou seja, já apresente um certo grau de interação social. Ao mesmo tempo, ela já consegue alcançar objetos e inclusive levá-los a boca. Ou seja, qual alternativa é um sinal de alerta com relação ao desenvolvimento de uma criança Resposta letra A.

45393.

Comentário: Vejamos cada opção Opção A Errada. O recém-nascido saudável perde aproximadamente 10% do seu peso de nascimento ao longo da primeira semana de vida. Uma perda ponderal superior a esse valor deve ser avaliada com cautela e pode estar associada a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dificuldades na amamentação. Opção B Errada. Na idade pré-escolar (2 e 6 anos incompletos) espera-se que a criança ganhe em média 2kg ano. Opção C Correta. Cuidado Encontramos mais comumente a descrição de um incremento de 9 cm no perímetro cefálico no primeiro semestre de vida. Porém, o aumento de 10 cm está correto também. Opção D Errada. Ao final do primeiro ano a criança cresce em média 25 cm, ou seja, 50% do seu comprimento ao nascimento (50 cm). Contudo, o pré-escolar ganha em média de 6 a 8 cm por ano (há diferenças de acordo com a referência utilizada). Opção E Errada. A relação segmento superior inferior varia com a idade. Ao nascimento é de 1,7, aos 3 anos é 1,3, entre 8 e 10 anos é de 1,0 e daí até o fim da puberdade é de 0,9 a 1,0.

45389.

Comentário: Questão bastante simples, mas que traduz uma queixa comum das mães no ambulatório de pediatria. O enunciado descreve um lactente de 40 dias de vida, nascido a termo, com peso adequado, e sem intercorrências. Atualmente, verificamos um ganho ponderal de 1950 g, o que corresponde aproximadamente à aquisição de 50 g dia, valor além do esperado (25-20 g dia). Portanto, a alimentação com leite materno está suprindo todas as necessidades energéticas e nutricionais do lactente. Nesta faixa etária, é absolutamente fisiológico um reflexo gastrocólico exacerbado, levando ao aumento da frequência de evacuações e redução da sua consistência, sem que isto tenha qualquer conotação patológica ou semelhança com uma síndrome diarreica. A conduta é a tranquilização da mãe, explicando que este comportamento gastrocólico é fisiológico no lactente e manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Resposta letra A.

45379.

Comentário: No laboratório de uma anemia ferropriva temos (1) ferritina baixa, (2) ferro sérico baixo, (3) saturação de transferrina baixa e (4) TIBIC - ou capacidade total de ligação do ferro - aumentado. As talassemias são o principal diagnóstico diferencial da anemia ferropriva nos quadros de anemia com microcitose (a grande diferença - além da cinética de ferro alterada na ferropriva - é que o RDW está normal nas talassemias e aumentado na anemia ferropriva). As sulfas e as quinolonas podem desencadear hemólise em crianças portadoras de deficiência de G6PD, um tipo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

específico de anemia hemolítica geneticamente herdada diferente das anemias esferocíticas. Nos quadros de ferropenia extrema e prolongada, as manifestações neuropsiquiátricas eventualmente observadas não respondem bem ao tratamento de reposição de ferro, ao contrário das manifestações hematológicas como a anemia. Por fim, sabemos que são fatores de risco para anemia carencial na infância (entidade que tem na anemia ferropriva seu principal fator contribuinte) baixo peso ao nascer, desmame precoce (antes de 6 meses de vida) e dieta pobre em fontes de ferro (ex. carne). Resposta certa D.

365639.

Comentário: O enunciado descreve um lactente de um ano de idade com alguns fatores de risco para anemia ferropriva, incluindo o desmame precoce, a ausência de suplementação profilática de ferro e a oferta precoce de leite de vaca. Lembre-se que é recomendado o aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida, e complementado até pelo menos dois anos a suplementação profilática de ferro é indicada para todos os lactentes até dois anos de vida (sendo o início e a dose definidos pela presença de fatores de risco, como prematuridade e baixo peso ao nascer). Apesar disso, este lactente não apresenta indícios de anemia ferropriva em exame laboratorial. Vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é que a suplementação de ferro oral profilática seja mantida até dois anos de vida em todos os lactentes logo, deve ser prescrita neste paciente, mesmo que não tenha sido iniciada antes. Letra B incorreta. Como vimos, há indicação de prescrição de ferro em dose profilática. Além disso, após um ano não há recomendação de substituição do leite de vaca por fórmulas infantis. Letra C correta. A família deve ser orientada quanto aos passos para a alimentação saudável e variada, e o ferro profilático deve ser iniciado na dose de 1 mg kg dia e mantido até dois anos de vida. Letra D incorreta. Não há indicação de administração de ferro em dose terapêutica na ausência de anemia ferropriva, que foi descartada pelos exames. Resposta letra C.

349726.

Comentário: A questão descreve um recém-nascido (RN) assintomático, com bom ganho de peso, em aleitamento materno exclusivo. O padrão das evacuações relatado é comum na faixa etária

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

neonatal e nos lactentes amamentados exclusivamente - mais de três episódios dia, consistência semilíquida e coloração amarelada. Dessa forma, estamos diante de um RN saudável Vamos às alternativas. Letra A correta. O padrão de evacuações apresentado é normal em RN e lactentes alimentados exclusivamente com leite materno. Como o RN está saudável e com bom ganho de peso, deve-se manter o aleitamento materno exclusivo. Letra B incorreta. A intolerância à lactose não é comum em lactentes em aleitamento materno exclusivo. Lembre-se que esta é uma afecção relacionada às lesões da mucosa do intestino delgado, secundárias às diarreias agudas virais, que determinam redução da concentração de lactase. É a principal causa de diarreia persistente (mais de 14 dias) no lactente acima dos 6 meses de idade. Letra C incorreta. A proctocolite alérgica é a manifestação não mediada por IgE mais comum da alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e cursa com sangramento nas fezes, não sendo este o quadro apresentado. Caso houvesse suspeita de APLV, a conduta no RN amamentado seria suspender a proteína do leite de vaca da dieta da mãe. Além disso, a prescrição de fórmula de soja nos casos de APLV é controverso, pois sabe-se que a soja não é hipoalergênica e o risco da criança desenvolver alergia à soja é alto, especialmente em lactentes menores de 6 meses. Letra D incorreta. Não há indicação de suspensão da dieta de um RN, a não ser que haja suspeita de quadro de abdome agudo, por exemplo, o que não é o caso relatado. Letra E incorreta. O Ministério da Saúde não recomenda a oferta de leite de vaca (LV) para lactentes menores de 6 meses de idade. Entretanto, quando não for possível o uso de fórmulas lácteas por seu maior custo, deve-se fazer a modificação caseira do leite de vaca sob orientação de profissional de saúde, com objetivo de diminuir as quantidades excessivas de proteínas, sendo recomendada a diluição do LV em água filtrada. É importante mencionar que leites desnatados ou semidesnatados não são indicados para crianças menores de 2 anos, pela menor quantidade de gordura, que é crucial para o desenvolvimento neurológico da criança. Resposta letra A.

365577.

Comentário: Questão objetiva sobre as condições maternas que contraindicam de forma absoluta a amamentação. Letra A incorreta. Apenas a hanseníase virchowiana não tratada, ou com tratamento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inferior a três meses com sulfona ou inferior a três semanas com rifampicina, ou aquela com lesões de pele na mama, indica a interrupção temporária do aleitamento até a instituição correta do tratamento por estes períodos indicados. Nas outras formas da doença, a amamentação pode ser mantida. Letra B incorreta. De forma geral, o Ministério da Saúde classifica os antidepressivos como drogas de uso criterioso quando em doses elevadas ou em uso prolongado . Feita esta ressalva, vários deles são de uso compatível com a amamentação, como amitriptilina, escitalopram e fluoxetina. Letra C incorreta. Na tuberculose pulmonar ativa, o aleitamento deve ser suspenso apenas temporariamente, até o diagnóstico e início do tratamento na lactante e da terapia profilática na criança neste período, pode ser ofertado o leite materno ordenhado. Mesmo durante o início do tratamento, a mãe poderá amamentar, com uso de máscara adequado, cobrindo nariz e boca, e buscando diminuir o contato mãe filho por pelo menos duas semanas após o início da terapia. Letra D correta. As infecções pelos vírus HIV e HTLV são contraindicações absolutas ao aleitamento materno esta é, inclusive, a principal forma de transmissão do HTLV da mãe para o bebê. Resposta letra D.

337545.

Comentário: Para analisar a afirmativa, o caso clínico introduzido é desnecessário. A síndrome de Marfan é uma condição genética que afeta o tecido conjuntivo, podendo cursar com alterações cardíacas e em vasos sanguíneos, como aneurisma de aorta oculares, como ectopia lentis, catarata e glaucoma e musculoesqueléticas. Esta síndrome cursa com estatura elevada, e não baixa, com membros e dedos desproporcionalmente compridos (aracnodactilia). Já a síndrome de Sotos é uma condição genética rara causada por mutação no gene NSD1 no cromossomo 5, caracterizada por crescimento excessivo nos primeiros anos de vida. Crianças com esta condição são mais altas, mais pesadas e com perímetro cefálico maior do que o esperado para a idade, podendo apresentar também uma cabeça desproporcionalmente larga e comprida, com fronte proeminente, hipertelorismo, mãos e pés grandes, hipotonia e comprometimento cognitivo leve. Portanto, nenhuma das condições cursa com baixa estatura (afirmativa incorreta). Resposta letra B.

337546.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A afirmativa está certa. A avaliação da estatura de um indivíduo pode ser feita com este na posição horizontal (habitualmente chamada de comprimento) ou na posição vertical (habitualmente chamada de altura, ainda que estes termos possam ser usados de formas distintas conforme a referência). Para a aferição do comprimento, o mais comum é a utilização da régua de madeira. Já para a aferição da altura, deve ser usado, preferencialmente, o antropômetro de parede. Esta padronização deve ser respeitada, pois os gráficos de crescimento seguem estas orientações e, como há diferença entre a estatura na posiçao horizontal e vertical, a comparação com os valores dos gráficos não estará adequada se isso não for feito. Resposta letra A.

337595.

Comentário: Questão direta. Diversos fatores podem influenciar o crescimento e desenvolvimento infantil, incluindo fatores genéticos e ambientais. Dentre estes últimos, a baixa escolaridade dos pais, principalmente materna, é um fator de risco para crescimento e desenvolvimento inadequados (afirmativa correta). Resposta letra A.

337596.

Comentário: A afirmativa está incorreta. Aos quatro meses de idade, é esperado que uma criança permaneça sentada com o apoio completo do tronco aos seis-sete meses, a criança permanece momentaneamente sentada sem apoio e logo precisa se apoiar sobre as próprias mãos apenas aos nove-dez meses é esperado que a criança permaneça sentada sem apoio de modo indefinido. Miguel tem apenas três meses e não há qualquer razão para a preocupação. Resposta letra B.

337598.

Comentário: A afirmativa está correta. Existe um padrão de crescimento esperado durante o primeiro ano de vida. Os recém-nascido a termo costumam crescer cerca de 25 cm ao longo deste primeiro ano. Lembre-se de que este crescimento ocorre de forma desacelerada. Com isso, há um incremento um pouco maior no primeiro semestre em relação ao que ocorre no segundo. No primeiro semestre pode ser descrito um ganho de 15 cm e, no segundo, de apenas 10 (alguns indicam um ganho ligeiramente maior no primeiro semestre). Resposta letra A.

337600.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A afirmativa está incorreta. Lembre-se de que existe uma estimativa de ganho ponderal médio durante os primeiros meses de vida, da seguinte forma primeiro trimestre 700 g mês segundo trimestre 600 g mês terceiro trimestre 500 g mês e quatro trimestre 400 g mês. O peso desta criança ao longo do primeiro trimestre já foi muito superior inclusive, ao que seria esperado. Isso em geral não denota qualquer problema, especialmente nas crianças em aleitamento materno exclusivo. Resposta letra B.

305307.

Comentário: O tema é comum na prática e, frequentemente, suscita dúvidas. O adolescente tem direito ao sigilo e à confidencialidade durante seu atendimento. Existem apenas algumas situações nas quais é dado ao médico o direito de romper este sigilo e a prescrição de métodos contraceptivos não é uma delas. Os adolescente podem e devem decidir pela escolha de métodos contraceptivos adequados para essa fase, para o exercício de uma vida sexual saudável e responsável preservativos masculino e feminino, anticoncepcionais hormonais orais, anticoncepcional injetável. A contracepção de emergência, se necessária, também deve ser prescrita. Cabe lembrar que, mesmo após a orientação para o uso do ACO, deve ser enfatizada a utilização de preservativos para a prevenção das IST. Resposta letra D.

298885.

Comentário: A questão foi considerada correta pela banca. Na verdade, esta questão teve seu gabarito modificado após o concurso e, talvez, o mais correto devesse ter sido a sua anulação. No Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, é indicado que Ao se aproximarem dos 2 anos já estão usando entre 50-200 palavras e formando frases com 1 substantivo e 1 verbo . O Nelson, Tratado de Pediatria, indica algo semelhante e acrescenta que aos 18 meses é esperado que a criança fale cerca de 10 palavras. Por estas fontes, o gabarito inicial que indicava que a questão estava errada seria coerente. Ainda, após recurso, a resposta final foi a letra A. VISÃO DA RÁDIO Radiografia de frente da porção distal do antebraço. A região do calo ósseo (MARCADO EM AZUL) se caracteriza por ser uma área esclerótica (mais branca) e com diâmetro aumentado, em relação ao osso normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298896.

Comentário: A afirmativa está completamente errada. Não é incomum que vejamos o que está indicado nesta afirmativa sendo repetido entre leigos e, até mesmo, entre profissionais de saúde. Todavia, seja no sexo feminino ou no sexo masculino, o atraso de linguagem deve ser valorizado e avaliado. A literatura que aborda o desenvolvimento da linguagem na infância traz algumas informações divergentes em relação ao que já seria esperado nesta idade. No Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, é indicado que Ao se aproximarem dos 2 anos já estão usando entre 50-200 palavras e formando frases com 1 substantivo e 1 verbo . Logo, ainda que existam variações, é preocupante o fato de uma criança não falar aos dois anos. Resposta letra B

298899.

Comentário: Independentemente do caso clínico, a questão só quer saber se aos dois anos a criança é capaz de realizar os marcos do desenvolvimento solicitados. Para não ficar somente na decoreba , vamos lembrar que o desenvolvimento motor tem sequência cranio-caudal e do centro para a periferia. Logo, para a criança usar a colher ou rabiscar, ela já tem que realizar movimento de pinça, que ocorre aos 12 meses. Logo, até os dois anos, com toda certeza ela já sabe manusear o instrumento, que ocorre, em média, aos 18 meses. O mesmo se aplica a subir degraus, visto que a criança inicia a marcha sem apoio aos 15 meses de idade e, ao longo dos 18 aos 24 meses, a criança aprende a desenvolver tal marco. No entanto, espera-se que a criança suba um degrau de cada vez, pois ela tem até os 30 meses para subir os degraus alternando os pés. Ao longo do segundo ano de vida a criança vai desenvolvendo a sua capacidade de imitação e de realizar comandos simples, o que seria plausível esperar que, ao completar 2 anos, seja capaz de imitar trabalhos caseiros. A grande dúvida fica com relação a nomear partes do corpo, mas lembre-se que no segundo ano a criança fala palavras avulsas, formando palavras-frase ao completar dois anos de idade e, na maioria das vezes, o seu discurso é com caráter de nomeação. Logo, a maioria das referências espera que aos 18 meses a criança seja capaz de identificar uma ou mais partes do corpo, mas desde que seja estimulada para tal. Da mesma forma como ela aponta para bola e fala

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o nome do objeto, ela também pode saber falar e identificar partes do corpo. Resposta item certo.

298931.

Comentário: A afirmativa está errada. Independentemente do caso descrito, a análise da afirmativa pode ser feita. Aos seis-sete meses de idade é esperado que uma criança sentesse com apoio pode permanecer sentada sem apoio por pouco tempo, mas logo inclina o tronco e se apoia sobre os braços. O atraso seria considerado caso a criança já tivesse 9-10 meses e ainda não se sentasse sem apoio. Resposta letra B.

298932.

Comentário: A afirmativa está correta. O aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses. Todavia, após esta idade, o leite materno isoladamente não é mais capaz de suprir todas as demandas nutricionais da criança e, deste modo, é feita a introdução da alimentação complementar. Ainda que a criança apresente queixas neste momento, observe que estamos em uma consulta de puericultura e, como a criança já tem seis meses, a família deve ser orientada sobre a introdução dos alimentos além do leite materno. Resposta letra A.

284298.

Comentário: Bem tranquila. Vamos relembrar a suplementação de ferro está recomendada pela SBP para todo lactente que nasceu a termo com 2500 g, a partir do terceiro mês de vida até os 2 anos, na dose de 1 mg kg dia. Para os que foram prematuros ou que nasceram com 2500 g, a suplementação inicia aos 30 dias de vida, com a dose variando em função do peso de nascimento. Os que nasceram com peso entre 1500 e 2499 g recebem 2 mg kg dia aqueles que nasceram com peso entre 1000 e 1499 g recebem 3 mg kg dia e para os que nasceram com 1000 g, recomendamos 4 mg kg dia. Esta dose é feita até os 12 meses, quando então passa para 1 mg kg dia, que deve ser mantida até os 24 meses. Afirmativa correta. Resposta letra A.

284299.

Comentário: Nem precisava de um enunciado tão grande Sabemos que todo lactente tem risco para deficiência de ferro, por isso está recomendada a suplementação desse micronutriente a partir dos 3 meses de vida para as crianças nascidas a termo e com peso 2500 g, independentemente da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dieta recebida, estando dispensados apenas aqueles pacientes que recebem 500 ml de fórmula infantil por dia. Os que recebem leite de vaca apresentam ainda mais risco, já que a biodisponibilidade do ferro é menor do que no leite humano. Além disso, crianças que recebem LV têm maior risco de desenvolver APLV - esta condição causa microsangramentos da mucosa intestinal, o que aumenta o risco de ferropenia. Afirmativa incorreta. Resposta letra B.

261252.

Comentário: A afirmativa está certa. Sabemos que, nos primeiros dias de vida, é esperada uma perda ponderal, considerada fisiológica. Todavia, no caso descrito esta perda excedeu o que é esperado, que costuma ser de até 10%. Um das principais condições que deve ser avaliada nestes casos é o baixo aporte lácteo, que pode estar relacionado com uma técnica de amamentação inadequada. A descrição de e dor extrema ao amamentar é uma informação que corrobora tal suspeita. A conduta nestes casos é a orientação da lactente quanto à técnica adequada, manutenção do aleitamento em regime de livre demanda, garantindo o esvaziamento adequado da mama. Resposta letra A.

261253.

Comentário: A afirmativa está errada (embora também poderia ser considerada certa...). A Organização Mundial de Saúde recomenda o regime de aleitamento materno exclusivo pelos primeiros seis meses de vida da criança. No aleitamento materno exclusivo, a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama ou ordenhado, ou leite humano de banco de leite, sem nenhum outro líquido ou tipo de leite. Dito isso, podemos concluir que afirmar que se recomenda o aleitamento exclusivo até quatro meses não está errado... Certamente a banca quis inferir que este não é recomendado apenas até quatro meses, mas sim até seis. Resposta letra B.

261254.

Comentário: A afirmativa está errada. Tome cuidado com esta questão De fato, a perda ponderal excessiva e o relato de dor extrema ao amamentar sinalizam a possibilidade de algum problema relacionado com a amamentação e baixo aporte lácteo para a criança. Porém, não interprete isso como sendo sinônimo de leite fraco . Nestes casos, não há qualquer alteração na composição do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

leite, mas sim alguma dificuldade relacionada com a amamentação que está levando a uma diminuição do volume de leite que a criança está recebendo. Devemos orientar o aleitamento exclusivo em regime de livre demanda e garantir o esvaziamento adequado da mama. Resposta letra B.

261255.

Comentário: A afirmativa está errada. O sorriso social é uma habilidade tipicamente esperada apenas aos dois meses de idade. Com um mês de vida, é esperado que a criança sorria espontaneamente. Apenas aos dois meses já é esperado que o sorriso represente uma forma de interação social. Para avaliarmos esta habilidade, devemos sorrir e conversar com a criança, sem lhe fazer cócegas ou tocar sua face. Esperamos, então, observar que ela responda com um sorriso. Resposta letra B.

274390.

Comentário: A única alternativa correta é a letra E, pois os fármacos com baixa biodisponibilidade são ideais para uso durante a lactação, pois mesmo quando presentes no leite, são pouco ou nada absorvidos pelo lactente (ex insulina, gentamicina, omeprazol, lansoprazol, heparina). Fármacos com baixo peso molecular atingem mais facilmente o leite materno que aqueles com peso molecular 10 daltons. Os poros das membranas permitem o movimento de moléculas com pesos moleculares 200 daltons (letra A errada). Fármacos com baixa afinidade a proteínas plasmáticas apresentam maior facilidade para atingir o compartimento lácteo, uma vez que os fármacos passam para o leite materno sob a forma livre, ou seja, não ligados às proteínas plasmática (ex diazepam - letra B errada). Fármacos lipossolúveis atravessam mais facilmente a barreira celular lipoproteica, atingindo mais facilmente o compartimento lácteo. Concentram-se mais no leite maduro em razão de seu maior coeficiente de solubilidade em lipídios (ex sulfonamidas e cloranfenicol - letra C errada). E, por fim, os fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno e, consequentemente, no leite materno (letra D errada). Resposta letra E.

274424.

Comentário: Vejamos as alternativas I) verdadeira. Nos últimos anos, o coeficiente de mordalidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

infantil no Brasil apresentou tendência de declínio, principalmente às custas da redução dos óbitos no período pós-neonatal, por fatores fundamentalmente ligados à melhoria das condições de saneamento básico. Em contrapartida, as taxas de mortalidade no período neonatal apresentaram tendência de declínio muito lento, em virtude da permanência dos elevados níveis de mortalidade por fatores ligados à gestação e ao parto. Esses problemas se refletem também na mortalidade perinatal. II) Verdadeira. Atualmente, a obesidade é mais frequente que a desnutrição (diferente do passado) III) Falsa. As primeiras consultas de puericultura devem ser feitas de preferência pelo médico de família e comunidade, mas crianças de risco habitual (não baixo), podem ser consultadas exclusivamente por enfermeiros IV) Falsa. A frequência das consultas de puericultura deve acompanhar os riscos para cada faixa etária. Devem ser observados os riscos nutricionais (obesidade) e sociais nas crianças das fases pré-escolar e escolar. Resposta letra C.

261303.

Comentário: Primeira pergunta Qual o diagnóstico mais provável da criança em questão Sarampo Ok, mas a questão queria saber disso, mas sim sobre o período que deve durar a amamentação. Para isso, vamos ao site oficial do Ministério da Saúde, que diz A amamentação reduz a mortalidade infantil e traz diversos benefícios para a mãe, para o bebê, para a sociedade e para todo o planeta. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais e, de forma exclusiva, nos primeiros 6 meses de vida. Resposta letra A. Para quem ainda ficou em dúvida, veja o que diz o Caderno de Atenção Básica nº 23, intitulado Saúde da Criança - Aleitamento Materno e Alimentação Complementar A OMS, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança.

250098.

Comentário: Existem duas situações em que existe uma contraindicação absoluta ao aleitamento materno mães infectadas pelo HIV e pelo HTLV. Em relação às hepatites virais, as hepatites A e B não contraindicam o aleitamento materno. Apesar do vírus da hepatite C ter sido detectado no leite

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de mães HCV-positivas, sua transmissão por essa via não foi comprovada. Por isso, a amamentação em mães HCV positivas não está contraindicada. Entretanto, a prevenção de fissuras mamilares é muito importante, pois ainda não foi determinado se o contato do bebê com o sangue materno pode favorecer a transmissão da doença. Sendo assim, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

250099.

Comentário: Nos dois primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. Também não devem ser oferecidas preparações que tenham açúcar como ingrediente, como bolos, biscoitos, doces e geleias. O açúcar também está presente em grande parte dos alimentos ultraprocessados. Esse é um dos motivos pelos quais eles não devem ser oferecidos para as crianças pequenas. Sendo assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

250100.

Comentário: Apesar de ser uma prática comum, não é recomendado adoçar as bebidas oferecidas às crianças, já que há maior risco de obesidade futura além de formação de cáries, a doença crônica mais comum da infância. Mesmo as formas alternativas ao açúcar devem ser desestimuladas, devendo o pediatra encorajar uma alimentação saudável variada baseada em alimentos in natura. Além disso, o mel é proibido em crianças menores de 1 anos, devido ao risco de botulismo em crianças pequenas. Afirmativa incorreta. Resposta letra B.

250101.

Comentário: O melhor alimento para uma criança é o leite materno. Na impossibilidade de aleitamento materno exclusivo, a criança deve receber uma fórmula infantil apropriada. O problema da fórmula é o custo financeiro, que pode comprometer o orçamento familiar. Por esse motivo, muitas famílias oferecem leite de vaca integral. O leite de vaca não fornece para a criança todos os nutrientes de que ela precisa. As quantidades excessivas de proteínas, sódio, potássio e cloro do leite de vaca podem sobrecarregar os rins da criança nos primeiros meses de vida. Nos primeiros quatro meses o leite de vaca integral, se for oferecido, tem que ser diluído. A partir dessa idade, o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

leite não deve mais ser diluído. O leite desnatado e o leite semidesnatado não são indicados para crianças menores de dois anos, porque possuem menor quantidade de gordura e ela é importante para o desenvolvimento neurológico da criança. Sendo assim, a afirmativa está errada, porque o não podemos utilizar fórmula de leite desnatado ou semidesnatado. Resposta letra B.

250107.

Comentário: Os dentes natais são aqueles presentes na cavidade oral no momento do nascimento. O mais comum é o dente incisivo lateral e podem estar associados a uma variedade de síndromes, como síndrome de Ellis-van Creveld, paquioníquia congênita, síndrome de Sotos e síndrome de Hallermann-Streiff. Em geral, a conduta é expectante, mas pode ser realizada a extração se o dente causar dificuldades na amamentação ou ulceração da boca ou língua. Antigamente, se acreditava que a mobilidade excessiva dos dentes natais poderia aumentar o risco de aspiração. No entanto, a aspiração raramente ocorre, portanto não é obrigatório que o dente seja extraído. Em relação à erupção dentária decídua (dentes de leite), sabemos que os primeiros dentes a surgir são os incisivos centrais inferiores, que podem nascer entre 6 e 10 meses de idade. Consideramos atraso na erupção quando há demora 6 meses além da faixa normal para aquele dente em particular. Ou seja, podemos aguardar até os 16 meses de vida para considerar que houve atraso na erupção dentária. A título de conhecimento, a falha completa da erupção dentária também está associada a uma variedade de condições, como por exemplo osteodistrofia hereditária de Albright, displasias ectodérmicas, síndrome de William, síndrome oto-palatal-digital e agenesia dentária seletiva. Como podemos perceber, a afirmativa da questão está incorreta. Apesar dos recursos, a banca não alterou o gabarito da questão. Gabarito da banca letra A. Gabarito MEDGRUPO letra B.

239311.

Comentário: A afirmativa está errada. A banca citou no enunciado a referencia bibliográfica que deveria ser usada e, na fonte citada, é indicado que o sorriso social é uma habilidade esperada a partir dos dois meses, não apenas após três meses. É fato que já é esperado que aos três meses a criança tenha esta habilidade, mas não apenas após essa idade. Resposta letra B.

239312.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A afirmativa está correta. A banca citou no enunciado a referencia bibliográfica que deveria ser usada e, na fonte citada, é indicado que as gargalhadas são esperadas aos quatro meses de idade. Resposta letra A.

239313.

Comentário: A afirmativa está errada. Sabemos que o desenvolvimento é um processo sequencial e previsível durante o qual a criança adquire a capacidade de realizar funções cada vez mais complexas. A habilidade de andar é mais complexa e, por isso, posterior a de engatinha. Por qual razão então a afirmativa está errada Porque nem todas as crianças engatinham. É uma habilidade que pode ser saltada sem que isso tenha qualquer conotação patológica. Resposta letra B.

239314.

Comentário: Afirmativa INCORRETA. O desenvolvimento das habilidades motoras manuais finas são estereotipados e previsíveis. A evolução dos marcos do desenvolvimento adaptativo é mais ou menos a seguinte Período neonatal fixa face humana na sua linha de visão, movimento de olhos de boneca durante a rotação do bebê de um lado para o outro 1 mês segue um objeto em movimento com os olhos 2 meses segue um objeto em movimento com os olhos por 180 4 meses alcança e agarra um objeto, levando-o à boca 7 meses vê grandes objetos e inclina-se para pegá-los transfere objetos de uma mão para a outra PEGA COM A PALMA RADIAL 10 meses pega objetos com o polegar e o indicador (pinça assistida) solta objetos em sua mão para outras pessoas 12 meses MOVIMENTO DE PINÇA entre polegar e indicador empurra objetos com o indicador entrega objetos por solicitação 15 meses faz torre de três cubos, faz uma linha com o lápis 18 meses faz torre de quatro cubos, imita rabiscos Esperamos o movimento de pinça completo ao final do primeiro ano de vida, não aos 6 meses. Resposta B.

239315.

Comentário: O reflexo cutâeno-plantar, que faz parte do exame neurológico em qualquer fase eda vida, pode ser pesquisado pelo estímulo do bordo externo da região plantar. A resposta esperada é a flexão dos dedos, acontece que no recém-nascido, podemos encontrar a resposta em extensão Essa apresentação pode persistir até 18 meses de vida sem significar ou denotar doença

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Posteriormente, a criança passa a ter a resposta semelhante ao adulto, isso é, com flexão dos dedos (é o famoso sinal de Babinski). Ora, depois do discutido, percebe-se que a afirmativa encontra-se INCORRETA. Resposta B.

255734.

Comentário: De acordo com os manuais do Ministério da Saúde, consideramos pré-escolar toda a criainça entre 2 e 6 anos (exclusive). Esse período do desenvolvimento é marcado pelo aprimoramento de habilidades adquiridas, em especial de comunicação, locomoção, manuseio de objetos e jogos simbólicos. O período neonatal é aquele até o vigésimo oitavo dia de vida e dos 29 dias até os 2 anos, temos a primeira infância (lactente) Resposta A.

255735.

Comentário: O crescimento e desenvolvimento infantil deve ser avaliado sob diversas esferas, como o cognitivo, motor, emocional e social. Sobre o desenvolvimento motor, desde os dois anos de idade esperamos que a criança pule sozinha e pedale. Aos quatro anos, é comum que ela já pule alternadamente com um e outro pé e vista-se sozinha. Afirmativa ERRADA.

255736.

Comentário: O crescimento e desenvolvimento infantil deve ser avaliado sob diversas esferas, como o cognitivo, motor, emocional e social. Sobre o controle esfincteriano, sabemos que a criança começa a desenvolvê-lo ao final do primeiro ano de vida, de forma que por volta do quarto ano espera-se que a criança comece a controlar a micção inclusive durante a noite. Afirmativa CERTA.

255737.

Comentário: O crescimento e desenvolvimento infantil deve ser avaliado sob diversas esferas, como o cognitivo, motor, emocional e social. Considerando as alterações individuais das crianças, é possível que determinados marcos atrasem o seu início, principalmente na faixa etária indicada, por ausência do estímulo adequado e não por doenças. Assim, é importante que o médico que realiza o atendimento seja um educador sobre a melhor forma de promover o desenvolvimento da criança, não deixando de estar atento quanto a possíveis patologias associadas e período para reavaliação. Afirmativa CERTA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239350.

Comentário: Apesar do enunciado enorme, a análise da afirmativa independe da história prévia. Em relação ao desenvolvimento puberal no sexo feminino, considera-se puberdade normal o início do desenvolvimento puberal que ocorre entre 8 e 13 anos. O primeiro sinal perceptível é o surgimento do broto mamário (telarca), que é seguido pelo surgimento de pelos púbicos (pubarca) e, posteriormente, pela primeira menstruação (menarca), que ocorre após 2 anos a 2 anos e meio após a telarca. A menarca ocorre após o pico do estirão já ter acontecido, quando a adolescente já está na fase de desaceleração do crescimento. O pico do estirão acontece em M2 M3 e a menarca em M4. Sendo assim, a afirmativa está errada, já que a menarca acontece depois do pico da velocidade de crescimento. Resposta letra B.

255780.

Comentário: O crescimento e desenvolvimento infantil deve ser avaliado sob diversas esferas, como o cognitivo, motor, emocional e social. Sobre o desenvolvimento motor, conforme consta na caderneta de saúde da criança, espera-se que a criança sente sem apoio a partir do sexto mês de vida, devendo esse marco ocorrer até o nono mês. Afirmativa CERTA.

196679.

Comentário: A afirmativa está errada. Sabemos que há mais de uma recomendação que pode ser usada para a recomendação do início da suplementação para a anemia ferropriva. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças nascidas a termo e com peso maior do que 2.500 g iniciem a profilaxia a partir dos seis meses já aquelas nascidas pré-termo e ou com peso inferior a 2.500 g, a partir dos 30 dias de vida. A partir de 2018, a Sociedade Brasileira de Pediatria passou a recomendar que as crianças nascidas a termo e com peso superior a 2.500 g em aleitamento materno exclusivo começassem a receber a profilaxia a partir dos três meses. Estariam dispensadas desta profilaxia aquelas que continuassem recebendo pelo menos 500 ml dia de fórmula infantil. Já para os nascidos a termo ou pré-termo com menos de 2.500 g, a recomendação é de que a profilaxia fosse iniciada a partir dos 30 dias. No caso descrito, temos um recém-nascido que foi pré-termo e não sabemos ao certo qual foi seu peso de nascimento, porém, isso não faz

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diferença por qualquer referência que fossemos optar por seguir, ainda que esta criança tivesse nascido a termo, como já tem mais de seis meses deveria receber a suplementação com ferro. Resposta letra B.

214399.

Comentário: Na avaliação do RN são encontrados os chamados reflexos primitivos, que são alguns movimentos que resultam de reações reflexas e involuntárias do bebê. Com o desenvolvimento, estes reflexos vão gradativamente desaparecendo e dando lugar a movimentos intencionais, cada vez mais coordenados e com propósito definido. É importante conhecer quais são estes reflexos e sua idade de desaparecimento, uma vez que sua permanência além do período normal ou o seu reaparecimento podem sugerir a presença de doença neurológica. No RN e nos primeiros meses de vida, o reflexo cutâneo plantar é encontrado em extensão. Em relação ao seu desaparecimento, temos divergências na literatura. Alguns autores consideram a extensão normal até 18 meses de vida, alguns consideram 24 meses de vida. Estamos diante de uma criança de 24 meses que apresenta o reflexo em extensão. Entretanto, não podemos afirmar que é normal para essa criança, já que ela tem fator de risco para ter alteração do neurodesenvolvimento foi um RN pré-termo, com sofrimento fetal agudo, necessitou de UTI neonatal. Essa criança tem fatores de risco para desenvolver, por exemplo, uma paralisia cerebral, que apresenta, comumente, manifestações de lesão de primeiro neurônio motor, justificando o achado de reflexo cutâneo plantar em extensão. Resposta letra B.

196689.

Comentário: Tenha o seguinte cuidado ao analisarmos o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança que foi prematura, não devemos usar a sua idade cronológica, mas sim a idade gestacional corrigida. A idade corrigida permite o ajuste da idade cronológica em função do grau de prematuridade (subtrair da idade cronológica as semanas que faltaram para a idade gestacional atingir 40 semanas no caso descrito, iríamos subtrair cinco semanas da idade atual). Não existe consenso em relação à idade máxima para o uso da idade corrigida, mas a maioria dos autores a utiliza nos primeiros dois anos de vida. Logo, esta criança tem uma idade corrigida de pouco mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de cinco meses. As habilidades descritas não são esperadas nesta idade entre seis e sete meses espera-se que a criança role no leito e sente-se com apoio só é esperado que a criança se sente sem apoio entre nove e 10 meses. Logo, não há razão para afirmarmos, com base no que foi descrito, que há qualquer atraso. Resposta letra B.

196694.

Comentário: O acompanhamento do crescimento dos recém-nascidos prematuros, em especial daqueles com muito baixo peso ao nascer, apresenta uma particularidade recomenda-se que seja usada a idade corrigida. Caso isso não seja feito, ao compararmos a criança que foi nascida prematura com aquela que nasceu a termo, sempre acreditaremos que existe uma alteração no seu crescimento. O padrão de crescimento pós-natal dessas crianças é um pouco distinto costuma-se observar que nos primeiros meses ocorre uma intensa velocidade de crescimento com recuperação inicial do perímetro cefálico, seguida do comprimento, e, finalmen te, o peso. A idade corrigida permite que seja feito um ajuste da idade cronológica em função do grau de prematuridade (devemos subtrair da idade cronológica as semanas que faltaram para a idade gestacional atingir 40 semanas no caso descrito, por exemplo, iríamos subtrair cinco semanas da idade atual). Alguns autores recomendam que seja utilizada a idade corrigida para a prematuridade até os 3 anos de idade deve utilizar, e, posteriormente, a idade cronológica. Resposta letra A.

196699.

Comentário: O acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança que foi prematura apresenta uma particularidade não devemos usar a sua idade cronológica, mas sim a idade gestacional corrigida. A idade corrigida permite o ajuste da idade cronológica em função do grau de prematuridade (subtrair da idade cronológica as semanas que faltaram para a idade gestacional atingir 40 semanas no caso descrito, iríamos subtrair cinco semanas da idade atual). Não existe consenso em relação à idade máxima para o uso da idade corrigida, mas a maioria dos autores a utiliza nos primeiros dois anos de vida. Logo, esta criança tem uma idade corrigida de pouco mais de cinco meses. Deste modo, todas as habilidades descritas neste enunciado deveriam estar presentes o sorriso social e a reação ao som estão presentes desde o primeiro trimestre a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

habilidade de agarrar um objeto é um marco esperado aos quatro meses. Resposta letra A.

196612.

Comentário: Passeando por qualquer loja que venda produtos infantis, você irá se deparar com andadores das mais variadas marcas e modelos, porém, não se engane o uso dos mesmos é formalmente desaconselhado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Os andadores estão associados com risco de quedas e aumentam a gravidade das mesmas, pois a projeção daqueda versus a velocidade do andador pode aumentar a forçado impacto sobre a boca e os dentes durante a queda. Há locais do país em que o uso dos mesmos já é proibido por lei em creches e escolas, reforçando a importância da orientação para que os mesmos não sejam usados. Resposta letra B.

196681.

Comentário: Esta questão é, no mínimo, controversa. Sabemos que existem poucas contraindicações verdadeiras para o aleitamento materno e uma delas é a infecção materna pelo HIV. Porém, devemos contraindicar a amamentação diante do diagnóstico da infecção, não pela possibilidade da mesma. Cabe aos serviços que atendem as parturientes o estabelecimento de uma logística capaz de permitir que os resultados dos testes estejam disponíveis em tempo hábil, permitindo que sejam adotadas as medidas de prevenção em tempo hábil. De todo modo, a resposta da banca foi indicar que o aleitamento deveria ser postergado até o resultado do teste. Resposta letra A.

214473.

Comentário: A criança com baixa estatura tem estatura por idade abaixo de -2 desvios-padrão da média populacional (escore Z) ou abaixo do percentil 3. Logo, a criança em tela não apresenta este diagnóstico, visto que a sua altura encontra-se no escore -1,75. Resposta item errado.

214482.

Comentário: A afirmativa está errada e aborda uma caraterística do desenvolvimento frequentemente observada na prática nem todas as crianças engatinham. Sabemos que o desenvolvimento motor é um processo previsível, ocorrendo sempre em uma sequencia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pré-determinada. Tal sequencia segue um sentido craniocaudal e as habilidades executadas pela criança tornam-se cada vez mais complexas, indicando a aquisição de maior controle, força e tônus da musculatura. As crianças que adquirem a habilidade de andar com apoio obrigatoriamente já desenvolveram controle do tronco e da cintura pélvica, bem como maior coordenação dos membros. Muitas dessas crianças engatinharão, mas nem todas farão isso. As crianças que ao engatinham apresentam outras habilidades que nos permitem verificar a normalidade de seu desenvolvimento, como apoiar-se em móveis e dar passos laterais. Resposta letra B.

214503.

Comentário: As recomendações das várias sociedades científicas no que diz respeito à triagem por meio de hemograma para identificação de anemia ferropriva não são consensuais. Em 2018, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento intitulado Consenso sobre anemia ferropriva Mais que uma doença, uma urgência médica . Nesta importante referência encontramos a recomendação haja uma triagem de exames já em crianças a partir dos 12 meses de vida. Os exames laboratoriais de rotina para diagnóstico e para a profilaxia da anemia são preferencialmente o hemograma completo (com parâmetros hematimétricos), contagem de reticulócitos e ferritina. Deste modo, a avaliação seria feita mesmo antes da suspensão da profilaxia, habitualmente feita aos 24 meses. Resposta letra B.

214507.

Comentário: O risco de transmissão de doenças da mãe para o filho durante a amamentação existe, porém deve ser avaliado de acordo com a doença acometida. Nas doenças virais como Hepatite, herpes vírus, caxumba, rubéola, sarampo, HIV, HTLV e entre outras, pode ocorrer a excreção de vírus no leite materno. A infecção pelo HIV é uma das poucas situações onde há contraindicação a amamentação. Na tuberculose e na hanseníase, a contaminação ocorre pelo trato aéreo superior, e a recomendação da amamentação depende da época em que foi feito o diagnóstico da doença, sendo que a amamentação em si não é contraindicação a amamentação. Resposta Errado.

196655.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos aproveitar essa questão para relembrar quais são as contraindicações, em relação a mãe, à amamentação ABSOLUTAS Infecção pelo HIV e HTLV. EVENTUAIS Infecção herpética com lesão ativa na mama (contraindica na mama acometida), varicela (se o quadro abrir 5 dias antes até 2 dias após o parto) e doença de Chagas na fase aguda ou quando há lasão mamilar sangrante. Resposta letra B.

179188.

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas. A opção A está errada lembre-se de que a quantidade de ferro encontrada no leite de vaca é semelhante à encontrada no leite humano, sendo que a diferença é que o ferro neste último apresenta maior biodisponibilidade. A opção B também está errada o ferro da dieta existe sob a forma de ferro heme (encontrado na hemoglobina, mioglobina e nas enzimas - ferro em alimentos de origem animal) e de ferro não heme, encontrado, principalmente, em alimentos de origem vegetal. Em geral, o ferro heme representa 10% e 15% do ferro ingerido, mas por sua melhor biodisponibilidade (15% a 35%), representa 40% do ferro absorvido. A opção C está errada existem fatores que aumentam e outros que inibem a absorção do ferro não heme. Os principais fatores dietéticos inibidores são os polifenóis, fitatos, cálcio, caseína e proteínas de legumes. Já o ácido ascórbico, estimula a absorção de ferro. A opção D está errada pelo contrário, a vitamina A pode aumentar a absorção do ferro. A vitamina A e o beta caroteno formam um complexo com o ferro, mantendo-o solúvel na luz intestinal, além de diminuir o efeito inibitório de substâncias como os fitatos e polifenóis. E, por fim, a opção E está certa, mas tome cuidado com o que foi afirmado. A suplementação de ferro é feita para as crianças entre seis meses e 24 meses, não apenas até 18 meses. Porém, afirmarmos que tal suplementação é feita entre seis e 18 meses não é um erro, embora isso tenha confundido muitos candidatos. Resposta letra E.

177649.

Comentário: Esta questão teve um problema, que foi não nos informar a idade gestacional desta criança. Sabemos que as crianças nascidas a termo e com mais de 2.500 g devem ser mantidas em aleitamento materno exclusivo e, após os seis meses, recomenda-se o aleitamento materno

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complementado. No momento em que é iniciada a introdução da alimentação complementar, também é feita a prescrição da profilaxia para anemia ferropriva com algum sal a base de ferro, que será mantido até a criança completar dois anos. Só estão dispensadas desta profilaxia as crianças que recebem pelo menos 500 ml ao dia de fórmula infantil. A banca certamente assumiu que esta criança nasceu a termo e, com base no consumo diário de fórmula que foi informado, não seria necessária a administração de ferro, tornando a afirmativa errada. Porém, cabe ressaltar que caso esta criança tivesse sido prematura ou nascido com menos de 2.500 g, tal profilaxia deveria ter sido iniciada desde os 30 dias de vida. Resposta letra B.

177658.

Comentário: O Ministério da Saúde apresenta, em um de seus cadernos de atenção básica, as recomendações para o acompanhamento de puericultura das crianças. São recomendadas sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês) duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. Esses momentos são selecionados porque representam momentos de oferta de imunizações e de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças. Logo, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

177662.

Comentário: Esta questão gerou muitos questionamentos na época do concurso, mas a resposta dada pela banca está correta a afirmativa está errada. O crescimento da criança é bastante intenso no primeiro ano de vida, porém, é um processo desacelerado. Basta nos lembrarmos do ganho ponderal e estatural médio ao longo dos trimestres que iremos perceber que a criança vai, progressivamente, ganhando menos peso e crescendo menos. A única fase em que o crescimento pós-natal será acelerado é durante a puberdade. Resposta letra B.

177613.

Comentário: Cuidado com a ideia errada passada nesta questão. Na verdade, o andador não previne quedas e, muito menos, auxilia no desenvolvimento da percepção corporal e do equilíbrio. Ele atrasa o desenvolvimento psicomotor e faz com que crianças que usem andador demoram mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a andar sozinhas. Resposta letra B.

177693.

Comentário: Questão difícil, pois abordou um tema que segue como sendo controverso entre pediatras e demais profissionais de saúde. Antes de qualquer coisa, é importante que você compreenda alguns termos. O treinamento resistido é aquele no qual o indivíduo é submetido a diferentes cargas, com o intuito de melhorar sua saúde rendimento físico. Os exercícios são feitos com pesos livres, elásticos, máquinas com polias ou o próprio peso corporal. Durante muito tempo houve grande preocupação em relação a essa prescrição de exercícios para crianças e adolescentes, pelo risco de lesões ortopédicas e nas placas de crescimento, porém, já há um grande número de publicações que mostram a segurança e eficiência deste tipo de treinamento nestas populações. Além disso, não há evidências de que o treinamento resistido promova alteração no crescimento linear, podendo ser indicado mesmo antes da puberdade, especialmente nas crianças com sobrepeso e obesidade. Assim, a afirmativa está incorreta. Resposta letra B.

289437.

Comentário: A puberdade precoce nas meninas é definida pela presença de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários antes dos oito anos de idade. Pode ter origem central, quando o aumento dos hormônios sexuais ocorre pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, ou periférica, quando não há estímulo central. As dosagens de gonadotrofinas auxiliam na distinção entre os quadros de puberdade precoce central e periférica. Uma elevação significativa nos níveis de LH (basal ou após estímulo com GnRH) caracteriza a puberdade como central. Visto isso, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

289439.

Comentário: A puberdade precoce é definida nas meninas como o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários antes de oito anos de idade. Ela pode ter origem central (quando depende do estímulo do GnRH) ou periférica (quando o aumento dos hormônios sexuais ocorre independente do estímulo central). As dosagens de gonadotrofinas auxiliam na distinção entre os quadros de puberdade precoce central e periférica. Uma elevação significativa nos níveis de LH (basal ou após

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estímulo com GnRH) caracteriza a puberdade como central. A presença de níveis basais de LH dentro da normalidade não exclui a possibilidade de ativação do eixo. Desta forma, o teste de estímulo com GnRH é o mais importante para a avaliação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Após o estímulo com o agonista do GnRH, as elevações muito marcadas de LH indicam a ativação do eixo. Portanto, a afirmativa está certa. Resposta letra A.

289441.

Comentário: A puberdade precoce é definida pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes de oito anos nas meninas. Quando isso ocorre devido a um estímulo central, dizemos que a puberdade precoce é central ou verdadeira. No sexo feminino, a principal causa desta condição é idiopática. Durante a investigação, os exames de imagem, em especial a ressonância magnética, podem estar indicados para identificação de alterações no sistema nervoso central. O exame sempre deve ser solicitado nos casos de puberdade precoce central no sexo masculino, nas meninas com rápido desenvolvimento das mamas, nas meninas com menos de seis anos e naquelas com níveis de estradiol muito elevados. Alguns endocrinologistas pediátricos dispensam a realização dessa avaliação em meninas maiores de seis anos devido a causa idiopática, mas não existe consenso em relação à idade mínima para a indicação do exame. Portanto, o tema pode ser controverso, mas é fato que a ressonância ajuda a identificar possíveis causas para a condição. A assertiva está, então, certa. Resposta letra A.

289443.

Comentário: A puberdade precoce periférica ocorre quando há produção de hormônios sexuais independente do estímulo central. Há desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, semelhante ao que ocorre na puberdade precoce de origem central, mas no caso das periféricas a sequência do desenvolvimento puberal poderá ser aberrante e não a habitual. Portanto, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

289445.

Comentário: Estamos diante de um caso de uma menina que iniciou desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes de oito anos de idade, ou seja, uma puberdade precoce. Percebam que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

há liberação de LH após um estímulo central, o que caracteriza uma puberdade precoce central ou verdadeira. Nela há ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, com o aumento das gonadotrofinas levando ao aumento dos esteroides sexuais. A sequência do desenvolvimento puberal é a mesma que a habitual, porém de forma mais precoce. A velocidade de crescimento está aumentada e a idade óssea está avançada em relação à cronológica. Portanto, a afirmativa está certa. Resposta letra A.

289473.

Comentário: A questão perguntou sobre a avaliação antropométrica de um lactente, mas não nos forneceu gráfico de peso, altura ou perímetro cefálico. Devemos, portanto, fazer a conta da média de ganho destas medidas para ter certeza de que o bebê apresentado está dentro da normalidade. É esperado que o lactente ganhe 700 g mês no primeiro trimestre (aumento de 2,1 kg em relação ao peso de nascimento com três meses de idade) e 600 g mês no segundo trimestre de vida (ganho de 1,8 kg de três a seis meses). Portanto, um bebê que nasceu com 2900 g, deve pesar cerca de 5 kg ao final do primeiro trimestre e 6,8 kg ao final do segundo trimestre. Em relação ao comprimento, espera-se que o lactente cresça 25 cm ano no primeiro ano (12,5 cm em seis meses). Então, o paciente que nasceu com 45 cm, deve crescer até cerca de 57,5 cm até seis meses. Já o perímetro cefálico, cresce 2 cm mês no primeiro trimestre (aumento de 6 cm até três meses) e 1 cm mês no segundo trimestre (aumento de 3 cm de três a seis meses). Portanto, um bebê de seis meses, deve ter aumentado o seu perímetro cefálico em 9 cm em relação ao nascimento. O paciente da questão, portanto, deveria estar com um PC de cerca de 43 cm. Assim, o peso e a estatura estão adequados para a idade, mas o perímetro cefálico está abaixo do esperado. A assertiva está errada. Resposta letra B.

289478.

Comentário: Questão sobre o desenvolvimento e os achados no exame físico esperados para um lactente de seis meses. Com exceção da sutura metópica, que tem seu fechamento iniciado no período pré-natal, as demais suturas apresentam a união fibrosa por volta dos seis meses de idade e a ossificação concluída na fase adulta. É importante que as suturas estejam abertas no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

recém-nascido para que o crânio seja capaz de expandir rapidamente para acomodar o cérebro em crescimento, em especial nos primeiros dois anos de vida. Com esse processo, ocorre o fechamento completo das fontanelas, sendo o da posterior (ou lambdóidea) por volta dos três aos seis meses de idade e o da anterior (ou bregmática) por volta dos 6 aos 24 meses. Portanto, a assertiva está errada. Resposta letra B.

289480.

Comentário: Para que a puberdade ocorra, é necessário que ocorra um evento conhecido como gonadarca. Este é o processo de ativação das gônadas que ocorre por estímulo das gonadotropinas (LH e FSH). Nos meninos, as células de Leydig dos testículos respondem ao LH produzindo 5 a 10 mg dia de testosterona, que inicialmente levará ao aumento testicular. Mais tarde, este hormônio será responsável pelas mudanças como aumento do pênis, engrossamento da voz, crescimento de pelos e aumento da massa muscular. Assim, a afirmativa está certa. Resposta letra B.

289482.

Comentário: Baixa estatura é definida por estatura por idade abaixo de -2 desvios-padrão ou abaixo do percentil 3 para idade e sexo. Não é dito no enunciado a altura do paciente e nem mesmo o percentil ou escore-Z em que ele se encontra, não sendo possível, então, definir o diagnóstico de baixa estatura. O simples fato de ele estar menor que a irmã não representa que há anormalidade com o crescimento. Devemos lembrar que as meninas entram na puberdade antes dos meninos e atingem, assim, o pico de velocidade de crescimento antes. Normalmente, as meninas apresentam velocidade de crescimento mais alta dois anos antes dos meninos. A afirmativa está, portanto, errada. Resposta letra B.

289484.

Comentário: Durante a puberdade, os homens adquirem massa magra a uma velocidade maior e por mais tempo do que as mulheres. No sexo feminino, a massa muscular relativa diminui do início ao final da puberdade (passa de 80% para 75% do peso corpóreo). Embora haja aumento absoluto da massa muscular, seu percentual sofre queda porque o tecido adiposo aumenta mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

rapidamente. No sexo masculino, a massa muscular aumenta de 80-85% do peso corpóreo para 90% após a puberdade. Esse aumento reflete a ação dos andrógenos circulantes. O ganho de tecido adiposo é mais acentuado no sexo feminino, sendo importante para que os ciclos menstruais se instalem e se mantenham regulares. Portanto, a afirmativa está certa. Resposta letra A.

289487.

Comentário: A ginecomastia representa o desenvolvimento de tecido glandular mamário no sexo masculino. A ginecomastia verdadeira é caracterizada pela identificação de tecido fibroglandular palpável, com pelo menos 0,5 cm de diâmetro localizado concentricamente sob o mamilo e região areolar. O desenvolvimento de ginecomastia durante a puberdade é um evento bastante comum e cerca de 70% dos adolescentes do sexo masculino terão algum grau de hiperplasia glandular mamária, com um pico de incidência nos estágio 3 4 de Tanner. O aumento pode ser uni ou bilateral, sendo esta última a apresentação mais frequente. Portanto, a assertiva está errada. Resposta letra B.

289489.

Comentário: A ginecomastia representa o desenvolvimento de tecido glandular mamário no sexo masculino. A ginecomastia verdadeira é caracterizada pela identificação de tecido fibroglandular palpável, com pelo menos 0,5 cm de diâmetro localizado concentricamente sob o mamilo e região areolar. O desenvolvimento de ginecomastia durante a puberdade é um evento bastante comum e ocorre involução espontânea geralmente em até dois anos. Quando o diâmetro da glândula ultrapassa mais que 5 cm, essa involução é menos provável. Visto isso, a assertiva está errada. Resposta letra B.

289491.

Comentário: O enunciado traz o quadro clínica de uma paciente que apresenta sinais de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Aos dez meses de idade, é esperado que o lactente seja capaz de se sentar sozinho, sem apoio, com a coluna ereta, por tempo indeterminado. Além disso, deve conseguir deambular com apoio quando colocado de pé. O reflexo de preensão palmar desaparece em torno dos quatro meses, enquanto o de preensão plantar pode estar presente até 12-15 meses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de idade. A lactente da questão não é prematura e apresenta idade cronológica de dez meses. Assim, ela não apresenta os marcos de desenvolvimento esperados para sua idade. A assertiva está,, portanto, errada. Resposta letra B.

289493.

Comentário: A questão traz o caso clínico de uma paciente que está com sinais de atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor. Quando estamos avaliando uma criança, além dos marcos do desenvolvimento, temos também que pesquisar os reflexos primitivos, visto que tanto a ausência como a permanência dos mesmos pode indicar alguma alteração patológica. O reflexo de preensão palmar ocorre quando o examinador coloca o dedo sobre a palma da mão do bebê e ele flexiona os dedos e fecha a mão de forma reflexa. É esperado até o quatro meses de idade. Já na preensão plantar, o examinador comprime o polegar sobre a face plantar do bebê. A resposta esperada é a flexão dos dedos do pé. O desaparecimento ocorre entre 12 e 15 meses de idade. Assim, em um lactente de dez meses, o reflexo de preensão plantar ainda é esperado. Portanto, a assertiva está errada. Resposta letra B.

289495.

Comentário: A lactente apresentada no enunciado apresenta sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. No entanto, com esta idade não é esperado que ela possua controle esfincteriano. A aquisição da continência urinária e fecal normalmente segue um padrão evolutivo. Inicialmente a criança adquire o controle fecal noturno, seguido pelo controle fecal diurno, posteriormente o urinário diurno e finalmente o urinário noturno. A maioria das crianças aprende a controlar voluntariamente a eliminação de urina e de fezes durante o dia entre dois anos e dois anos e meio. A criança inicialmente sinaliza este preparo, avisando que a fralda está molhada ou suja de fezes. Visto isso, a assertiva está errada. Resposta letra B.

289497.

Comentário: A questão traz o caso clínico de uma paciente que apresenta alguns sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A transferência de objetos de uma mão para outra é esperada até os sete meses de idade. Visto isso, a afirmativa está certa. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289500.

Comentário: A questão traz o caso clínico de uma paciente que está provavelmente com atraso em seus marcos de desenvolvimento. Espera-se que um lactente de dez meses de idade seja capaz de sentar-se sozinho sem apoio por tempo indefinido. Pode ou não engatinhar, mas deve ser capaz de deambular se apoiando quando colocada de pé. Portanto, o desenvolvimento da criança está de fato atrasado, mas não pelo o fato de ainda não andar sem apoio. Esse marco é esperado até os 15 meses. Visto isso, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

152093.

Comentário: A banca anulou esta questão por um detalhe o enunciado começa dizendo que está sendo um lactente de um mês, mas a afirmativa chama essa criança de recém-nascido . Talvez isso não impossibilitasse a compreensão da questão, mas foi a justificativa dada pela banca do concurso para anular a questão. De todo modo, vale lembra que quando a criança já tem um mês, todas as habilidades descritas já são de fato esperadas. Com um mês, além de fixar o olhar em um objeto, a criança já é capaz de acompanha-lo com o o olhar, ainda que me movimento.

Inicialmente, a banca tinha considerado a afirmativa como correta.

152112.

Comentário: A afirmativa está correta. A perda ponderal nos primeiros dias de vida é um evento que ocorre na quase totalidade dos recém-nascidos e relaciona-se com a redução de fluidos e também com o uso de tecido adiposo como fonte de energia. As crianças amamentadas costumam ter uma perda de 5% 7% do peso do nascimento, em média, sendo que é aceito que seja considerado normal ou aceitável a perda ponderal de até 10%. Resposta letra A.

152120.

Comentário: De acordo com o Ministério da Saúde, durante o primeiro ano de vida a criança deve passar por sete consultas, seguindo o seguinte esquema na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês. Após, são recomendadas de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir de então, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152128.

Comentário: A afirmativa está correta e é justamente por essa razão que valorizamos tanto as orientações relacionadas com a técnica de amamentação. Quando a técnica não é correta, os riscos de complicações, como a formação de fissuras ingurgitamento e mastite, aumentam. A ocorrência dessas complicações é sabidamente algo que contribui para a interrupção precoce do aleitamento materno. Resposta letra A.

152139.

Comentário: A afirmativa está corretíssima e traduz as principais recomendações para uma alimentação saudável nos primeiros dois anos de vida da criança. Sabemos que, nos primeiros seis meses de vida, o leite materno é capaz de atender a quase totalidade das demandas nutricionais da maioria das crianças, devendo ser o único alimento oferecido neste período. Após os seis meses, torna-se necessário complementar a alimentação. Porém o oferecimento do leite continua trazendo benefícios em função de seus fatores de proteção e da sua composição de proteínas e gorduras de alto valor biológico. Resposta letra A.

152145.

Comentário: A icterícia do aleitamento materno é uma condição clínica associada com uma inadequação da amamentação. Nessa situação, a criança está recebendo um aporte alimentar inadequado (provavelmente por algum problema relacionado ao aleitamento), o que leva a uma diminuição do transito intestinal e aumento da circulação êntero-hepática da bilirrubina. Isso não contraindica a amamentação, pelo contrario a técnica deve ser corrigida e o aleitamento estimulado. Existe uma outra forma de icterícia relacionada com a amamentação que eventualmente pode implicar na necessidade de uma suspensão temporária do aleitamento, que é a icterícia do leite materno. Nesta condição, a presença de algum fator no leite materno faz com que a criança evolua com níveis elevados de bilirrubina indireta de forma prolongada. Quando os valores forem muito altos, pode ser necessária uma suspensão temporária do aleitamento, com fornecimento de fórmula infantil neste período. Resposta letra B.

152076.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bem direta que aborda aspectos da técnica de amamentação. Para avaliar a técnica, deve-se avaliar o posicionamento e a pega. Os pontos-chave do posicionamento adequado são 1. Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo 2. Corpo do bebê próximo ao da mãe 3. Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido) 4. Bebê bem apoiado. Já os pontos-chave da pega adequada são 1. Mais aréola visível acima da boca do bebê 2. Boca bem aberta 3. Lábio inferior virado para fora 4. Queixo tocando a mama. Assim, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

152096.

Comentário: Sabemos que o leite humano e o leite de vaca possuem uma série de diferenças em relação as suas composições bioquímicas. Uma das principais diferenças diz respeito ao teor proteico. É aceito que o leite de vaca possui cerca do triplo de proteína que o leite humano. Além disso, a composição proteica também difere. A maior fração proteica do leite de vaca (80%) está na forma de caseína, enquanto a maior fração proteica do leite humano (60%) está na forma de proteínas do soro, sendo que algumas dessas têm funções de defesa. Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

131843.

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas. A opção A está incorreta a infecção pelo HIV é, de fato, uma contraindicação absoluta para o aleitamento materno, mas o quadro de tuberculose, não. Em relação às drogas antineoplásicas, a maioria não é compatível com a amamentação, mas há uma ou outra exceção em que o uso da medicação pode ser de uso criterioso. A opção B está incorreta o lábio inferior deve estar e vertido (pequeno detalhe para pegar um candidato que fizesse uma leitura mais rápida). A opção C está correta essas são as principais diferenças encontradas no colostro quando comparado ao leite maduro. Vale lembrar que a maior concentração da vitamina A confere ao colostro sua típica coloração mais amarelada. A opção D está incorreta a principal proteína do soro no leite humano é a alfalactoalbumina. A betalactoglobulina está presente em grande quantidade no leite de vaca. E, por fim, a opção E está incorreta esta é a definição de aleitamento complementado. Chamamos de aleitamento misto a oferta de leite humano e outros

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tipos de leite. Resposta letra C.

134984.

Comentário: A síndrome de Cushing é a resultante fenotípica da exposição crônica a concentrações elevadas de glicocorticoides, apresentando níveis sanguíneos elevados de cortisol e outros glicocorticoides. A iatrogenia é a causa mais comum da síndrome, resultado de terapêutica com glicocorticoides prolongada e especialmente em altas doses, usadas no tratamento das doenças proliferativas. A afirmativa está certa

134993.

Comentário: Ao avaliarmos a criança com hipotireoidismo, devemos nos lembrar de que, na infância, podemos ter o hipotireoidismo congênito ou o hipotireoidismo adquirido. A banca está, certamente, falando sobre o hipotireoidismo adquirido, que deve ser considerado no diagnóstico diferencial das crianças com baixa estatura. As manifestações clínicas são variadas, em função da intensidade da falta dos hormônios tireoidianos e do tempo de evolução da doença. Costuma ser encontrada, inicialmente, a presença de bócio. Com a diminuição da produção hormonal, há sonolência, hipoatividade, lentidão, palidez, pele seca, hipotermia, bradicardia, obstipação, mixedema e diminuição da velocidade de crescimento, levando à baixa estatura. Na avaliação da idade óssea, esta mostra-se bastante atrasada em relação à idade cronológica. Assim, a afirmativa está certa.

135001.

Comentário: Questão bem simples A afirmativa está, evidentemente, errada. A síndrome de Turner é causada pela monossomia do cromossomo X (cariótipo 45X). O fenótipo dos indivíduos acometidos é um fenótipo feminino. Por isto, este diagnóstico deve ser considerado quando avaliamos meninas com baixa estatura. Essas pacientes são candidatas à terapia com hormônio de crescimento e os resultados obtidos variam bastante, em função do momento em que o tratamento é iniciado e dada a presença de outras comorbidades. Porém, como regra geral, há uma melhora na previsão de estatura final. Afirmativa errada.

135006.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O termo baixa estatura idiopática é usado para caracterizar uma situação na qual o paciente tem baixa estatura mas não tem um diagnóstico etiológico preciso para o distúrbio. É, na verdade, um diagnóstico de exclusão Os seguintes critérios podem ser usados para seu diagnóstico altura 2 DP para a idade cronológica peso e altura de nascimento 2 DP para a idade gestacional proporções corporais normais sem evidência de qualquer doença crônica ausência de doença endócrina sem evidência de problema psicossocial ingestão alimentar adequada e velocidade de crescimento normal. Além disso, essas crianças devem ter sido submetidas a uma avaliação que mostre não haver deficiência de GH. Assim, a afirmativa está errada.

140755.

Comentário: Questão bastante direta. A osteomalacia é uma doença provocada pela deficiência na mineralização do osteoide (matriz óssea cartilaginosa) em um osso já formado, podendo acometer crianças e adultos. O raquitismo, por sua vez, é caracterizado pelo deficit de mineralização do osteoide de um osso em crescimento, especialmente no local da placa de crescimetno (antes do fechamento epifisário). Portanto, é um diagnóstico exclusivo da criança. A resultante principal deste mecanismo - enfraquecimento ósseo - é a deformidade esquelética, marca registrada do raquitismo. Ambas são consequência da deficiência de vitamina D. Resposta A.

105548.

Comentário: O enunciado nos traz uma informação verdadeira e que norteia boa parte do atendimento pediátrico a avaliação do crescimento é um indicador sensível do estado geral de saúde da criança. Como regra geral, é sabido que uma criança saudável é uma criança que tem um crescimento apropriado da mesma forma, uma criança que apresenta alguma alteração no seu crescimento, pode apresentar algum processo mórbido subjacente, o que justificaria essa alteração. As alterações no peso indicam alterações agudas, uma vez que o peso é o primeiro parâmetro a ser alterado porém, em processos crônicos, observa-se também o comprometimento estatural (opção C CERTA). Nos casos em que há apenas perda ponderal, costuma ocorrer recuperação quando há prejuízo do crescimento linear, isso nem sempre irá ocorrer (opção E ERRADA). Durante a avaliação nutricional, fazemos também a avaliação dos hábitos alimentares da criança.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Uma queixa comum no ambulatório de pediatria é de que a criança coma mal porém, há períodos em que há maior ou menor apetite e, se o crescimento estiver adequado, não há razões para achar que a criança esteja sendo mal alimentada (opção D ERRADA). Uma subpopulação que vem sendo cada vez mais estudada é a das crianças que tiveram restrição ao crescimento intrauterino e, por isso, tiveram baixo peso ao nascer ou foram pequenas para idade gestacional. É sabido que essas crianças possuem maior risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular no futuro. Ainda que os mecanismos exatos que elevem esse risco sejam alvo de estudos, a associação já está estabelecida (opção A ERRADA). A velocidade da recuperação nutricional correlaciona-se positivamente com esse risco assim, a velocidade elevada aumenta o risco de obesidade e de diabetes tipo II (não tipo I opção B ERRADA). Resposta letra C.

108238.

Comentário: Temos uma criança com desenvolvimento psicomotor normal, e com peso e altura adequados (escore Z 0), portanto, o leite materno foi capaz de manter a criança bem nutrida. Como a caderneta estava atualizada até o 3º mês e a criança já está com 4 meses, devemos atualizar as vacinas referentes ao 4º mês de vida, administrando a pentavalente, a vacina inativada contra poliomielite, a vacina oral contra o rotavírus e a pneumocócica decavalente. A orientação da SBP para evitar a hipovitaminose D é a exposição solar. Considera-se como adequada uma exposição solar de 30 minutos por semana com a criança totalmente despida, ou de duas horas por semana com a criança parcialmente vestida (e não 1h pela manhã, como relatado pelo enunciado). E ainda devemos orientar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Resposta correta letra B

.

108176.

Comentário: Questão muito específica, porém correta. O PROP-1 é um fator de transcrição expresso especificamente nas células embrionárias da hipófise. Está envolvido na ontogênese, diferenciação e função dos somatotrofos, lactotrofos, e tireotrofos e, provavelmente, dos gonadotrofos. Diferentes mutações, todas localizadas dentro do homeodomínio do gene PROP-1, foram identificadas em pacientes com pan-hipopituitarismo, todos com herança autossômica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

recessiva. A mutação no gene PROP-1 é a causa genética mais frequente de pan-hipopituitarismo. Resposta letra A.

79673.

Comentário: O enunciado nos traz uma criança de 4 anos de idade que apresentava crescimento adequado até os seus 2 anos de vida. No último ano, apresentou uma velocidade de crescimento de 3 cm ano. Nesta faixa etária (pré-escolar 2 aos 6 anos) a velocidade de crescimento esperada é de cerca de 7-8 cm ano. Desta forma, observamos que a criança da questão está bem abaixo do esperado. Um deficit na velocidade de crescimento é indicativo de possíveis patologias associadas à baixa estatura. Na realidade, a questão apresenta um enunciado pobre. Mas bastava saber que a velocidade de crescimento está diminuída, pois apenas uma alternativa é compatível com uma velocidade de crescimento diminuída, a letra B (deficit do hormônio de crescimento). Contudo, cabe relembrá-los que a principal causa endócrina de baixa estatura é o hipotireoidismo. Gabarito letra B.

79682.

Comentário: Vamos analisar cada uma das opções A Onfalocele - durante a formação embrionária o intestino sofre diversos mecanismos de rotação. Caso o intestino médio não retorne a cavidade abdominal, haverá rotação e fixação anormal. Desta forma haverá protrusão diretamente no umbigo. É comum haver uma membrana recobrindo o intestino e assim, protegendo-o do líquido amniótico circundante. B Gastrosquise defeito ao lado direito do umbigo, com cordão umbilical integro e sem membranas cobrindo as vísceras abdominais. C Será que o autor quis dizer Síndrome de Claude Bernard-Horner Esta é caracterizada por miose, ptose discreta, anidrose facial e enoftalmia, em conseqüência da interrupção da atividade simpática. Não é uma condição cirúrgica e passível de correção. D Atresia de esôfago - É a interrupção ou descontinuidade congênita do esôfago, que causa obstrução esofágica. Em 90% dos casos vem associada a fístula traqueoesofágica. E Hérnia umbilical infantil - Ocorre como resultado da persistência da abertura do anel umbilical. Provavelmente em função do erro gráfico da opção C a questão foi ANULADA pela banca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88630.

Comentário: Assertiva incorreta. O uso do GH como estimulador do crescimento linear em síndromes de baixa estatura está indicado nas seguintes etiologias 1) deficiência de GH 2) síndrome de Turner 3) síndrome de Prader-Willi 4) RCIU e 5) Baixa estatura idiopática (crianças com estatura mais de 2 desvio-padrão abaixo da média, mas sem nenhuma anormalidade endócrina ou pediátrica). Na síndrome de Turner o ganho estatural pode ser de até 5-6 cm, dependendo da época de início. Gabarito letra B.

88640.

Comentário: O raquitismo por resistência à vitamina D, também conhecido como raquitismo vitamina D dependente do tipo 2 é um distúrbio autossômico recessivo caracterizado por mutações no gene que codifica o receptor da vitamina D, impedindo uma resposta fisiológica normal ao 1,25-diidroxi-vitamina D. Neste caso, os níveis de 1,25-D são extremamente elevados. Já o raquitismo vitamina D dependente do tipo 1 apresenta mutações no gene que codifica a 1- alfa -hidroxilase renal, impedindo a conversão de 25-hidroxi-vitamina D em 1,25-diidroxi-vitamina D. Pacientes com este distúrbio apresentam níveis normais de 25-D, porém níveis baixos de 1,25-D. AFIRMATIVA ERRADA. Gabarito letra B.

88643.

Comentário: Ao nascer, a criança apresenta um comprimento relacionado ao aporte nutricional intrauterino e que não apresenta relação com a altura dos pais. Cerca de 10% das crianças que nascem pequenas para a idade gestacional não fazem uma recuperação do crescimento até o 2º ano de vida (catch-up). Além de um risco maior de baixa estatura, elas têm um risco maior de apresentar adrenarca precoce (produção de esteroides sexuais pela glândula suprarrenal) e, na vida adulta, a síndrome plurimetabólica. Desta forma, percebemos que 90% das crianças pequenas para a idade gestacional conseguem recuperar sua curva de crescimento até os dois anos de idade - AFIRMATIVA ERRADA. Gabarito letra B.

88649.

Comentário: Assertiva corretíssima. O Atraso Constitucional do Crescimento e da Puberdade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(ACCP), juntamente com a baixa estatura familiar (BEF) ou genética compõe as duas principais variantes da normalidade da síndrome da baixa estatura. São crianças que por definição apresentam baixa estatura, isto é, estatura abaixo do percentil 3 ou 2 ou mais desvios-padrão abaixo da média para idade e sexo, mas sem qualquer anormalidade endócrina ou sistêmica. Geralmente, a velocidade de crescimento é normal ou muito próxima do normal, não há desproporção entre o segmento superior inferior, não há obesidade, nem retardo mental ou qualquer estigma sindrômico. Na BEF, a idade óssea é compatível com a idade cronológica e a criança cresce dentro do canal determinado pelo seu alvo-genético, que é baixo. No ACCP, a idade óssea é atrasada em relação à idade cronológica, ratificando que existe potencial de crescimento linear. São crianças que crescerão e se desenvolverão mais lentamente que os seus pares, mas ao final da puberdade alcançarão o alvo genético dos pais. Geralmente, há casos similares na família. Gabarito letra A.

82075.

Comentário: O novo modelo da CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA (Ministério da Saúde, 2013), adiciona informações ao modelo antigo, e inclui folha de registro das medidas antropométricas da criança, gráfico de perímetro cefálico (0 a 2 anos) x idade, gráfico peso x idade (0 a 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos), gráfico comprimento x idade (0 a 2 anos), gráfico altura x idade (2 a 5 anos, 5 a 10 anos), IMC x idade (0 a 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos). Aparentemente, a afirmativa nos parece correta, à exceção da descrição dos termos corretos perímetro cefálico para idade e IMC para idade . Por isso, gabarito B.

82081.

Comentário: Segundo o Caderno de Atenção Básica 23, Saúde da Criança nutrição infantil (MS, 2009), nas seguintes condições maternas, o aleitamento materno não deve ser contra-indicado - Hepatite B a vacina e a administração de imunoglobulina específica (HBIG) após o nascimento praticamente eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno. AFIRMATIVA ERRADA.

64323.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Recomendações de PEGA adequada boca do bebê bem aberta, englobando a maior parte da aréola (mais 2 cm acima do mamilo) lábio inferior evertido queixo tocando a mama a língua do bebê fica sobre a gengiva inferior e com as bordas curvadas para cima deglutição visível e audível. Recomendações de POSICIONAMENTO adequado rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz encostado no mamilo cabeça e tronco do bebê alinhados no mesmo eixo axial (o pescoço não pode estar rodado ou lateralizado) corpo do bebê próximo ao da mãe, encostando barriga com barriga pescoço do bebê levemente extendido corpo do bebê bem apoiado pelas mãos da mãe. Vantagens do aleitamento materno composição nutricional ideal prevenção de doenças infecciosas respiratórias, diarreicas, doenças imunoalérgicas e doenças crônicas favorece o desenvolvimento da cavidade oral fortalece o vínculo afetivo entre mãe-bebê. Conduta frente ao ganho de peso insuficiente corrigir os erros de pega e posicionamento, orientar a mãe sobre as vantagens nutricionais e imunológicas do aleitamento materno, e reagendar nova consulta em 1 semana para verificar a adesão e ganho ponderal.

64646.

Comentário: Conforme avaliamos os marcos do desenvolvimento, podemos perceber que os itens I, II e III estão corretos. - Quanto ao desenvolvimento pessoal-social com 1 mês a criança olha a face das pessoas que a observam. Ainda nesse 1º mês, apresenta movimentos do corpo em resposta à voz ou ao contato. Em relação ao desenvolvimento adaptativo aos dois meses, é capaz de seguir com o olhar até mais do que a linha média. No entanto, somente a partir do terceiro mês a criança é capaz de elevar a cabeça e a manter a 45 . Apesar da elaboração de recurso por nossa equipe, a banca não concedeu a anulação da questão, e manteve o gabarito letra E.

343406.

Comentário: Considera-se Hipertensão Arterial na Infância e Adolescência, valores de pressão arterial sistólica e ou diastólica iguais ou superiores ao Percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura em três ou mais ocasiões diferentes. Resposta letra C.

334890.

Comentário: Acerca da síndrome de Down Alternativa A correta. O hipotireoidismo, congênito ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

adquirido, tem forte associação com a síndrome de Down. Por este motivo, o TSH deve ser dosado com 6 meses de idade, 1 ano de idade e, então, anualmente até a terceira idade. Alternativa B incorreta. Há associação com cardiopatias congênitas em até 50% das crianças com síndrome de Down, por este motivo, o ecocardiograma deve ser realizado de rotina no período neonatal e repetido a critério médico. Alternativa C incorreta. A protusão e micrognatia fazem parte das manifestações fenotípicas do paciente com síndrome de Down e apenas aumentam o risco durante um processo de intubação orotraqueal (como em todas as outras etiologias de micrognatia e protusão excessiva da língua). Não contraindicam qualquer atividade esportiva específica. Alternativa D incorreta. O calendário vacinal segue a idade cronológica como em qualquer outra criança, havendo apenas indicação de vacinas mais específicas como a influenza anual (independente da faixa etária) e a pneumo-23 (em casos selecionados). Alternativa E incorreta. Estimulação precoce com fonoaudiologia e fisioterapia está recomendada para todas as crianças com síndrome de Down, a fim de proporcionar o melhor desenvolvimento motor, da fala e da alimentação. Resposta alternativa A.

343423.

Comentário: Indivíduos com Síndrome de Down estão mais propensos a defeitos cardíacos congênitos (50%), como defeitos septais atrioventriculares, defeitos septais ventriculares, defeitos septais atriais isolados tipo ostium secundum , ducto arterioso patente e tetralogia de Fallot. Muito se discute sobre qual é a principal cardiopatia congênita vista na síndrome de Down e, em geral, aceita-se que o Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV) é a principal. Existe uma certa discussão a respeito disso, já que comunicação interventricular (CIV) é a cardiopatia congênita mais frequente de todas, enquanto DSAV é classicamente associada à síndrome de Down. Mas nesse caso, não há dúvidas, pois os achados clínicos são compatíveis com o DSAV. No exame físico, por causa das pressões equilibradas nos átrios e nos ventrículos, o sopro pode ser discreto ou até mesmo ausente. Na presença de regurgitação importante da valva atrioventricular, ausculta-se um sopro sistólico de regurgitação em borda esternal esquerda. A 2ª bulha é hiperfonética, algumas vezes com desdobramento fixo. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343424.

Comentário: Alguns recém-nascido podem manter uma posição de extensão de cabeça e tronco, como relatado no enunciado. Ainda que essa posição seja considerada normal, é fundamental que intervenções posturais sejam tomadas. É muito importante manter o bebê posicionado de maneira fletida, com flexão de pescoço (não exagerada para evitar os riscos de apneias, alterações do fluxo sanguíneo cerebral e protrusão de escápula), flexão de tronco, de quadril e de membros inferiores. Deve-se pensar sempre no padrão flexor e procurar manter o bebê da melhor forma possível e posicionado em flexão para promover uma sensação de segurança para ele, além de padrões de movimento mais organizados. Tanto o não posicionamento correto do bebê quanto a sua permanência na mesma posição podem acarretar uma série de deformidades como, por exemplo, o encurtamento da musculatura do pescoço, a retração escapular, a rotação e abdução dos membros inferiores, etc. Resposta letra A.

273319.

Comentário: Se você nunca ouviu essa queixa ou nunca leu sobre isso, aproveite para gravar este conceito agora lactentes jovens que mantém as mãos constantemente fechadas devem ser cuidadosamente avaliados Este é um sinal bem característico de espasticidade lesão cerebral e que deve ser valorizado, principalmente quando relatado por alguém que está constantemente próximo ao paciente. Sabemos que as avós costumam sim ter preocupações excessivas em relação à saúde dos netos, mas jamais devemos negligenciar uma queixa trazida por familiares, especialmente uma queixa pertinente como esta. A partir dos 3 meses, é esperado que o bebê mantenha as mãos abertas na maior parte do tempo. Portanto, devemos avaliar esta criança cuidadosamente e se necessário, encaminhá-lo ao neurologista. Resposta letra A.

268901.

Comentário: Vamos analisar cada afirmativa a) INCORRETA. O termo Caderneta de Saúde da Criança é muito inespecífico, já que a caderneta traz diversas informações sobre a criança. De qualquer modo, é evidente que a utilizamos para avaliação do crescimento - nela, devem ser anotados os dados antropométricos da criança e plotados nas curvas da OMS disponíveis neste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

documento. b) CORRETA. As curvas da OMS servem para avaliação e seguimento das crianças, já que utiliza o padrão de crescimento ideal. c) INCORRETA. Em toda consulta de puericultura, os dados antropométricos devem ser avaliados e as medidas devem ser plotadas nas curvas, para avaliação da adequação do desenvolvimento da criança. d) INCORRETA. APrenda em questão de prova, a orientação de suspender o aleitamento materno e substituir por fórmula infantil nunca estará correta, a não ser que haja contraindicação para amamentação. e) INCORRETA. A curva de peso deve ser avaliada em conjunto com a curva de estatura, IMC, perímetro cefálico além dos dados encontrados no exame físico geral da criança. Resposta letra B.

268905.

Comentário: Vamos analisar as alternativas referentes a mastite A) ERRADA A amamentação em livre demanda, iniciada o mais cedo possível, preferencialmente logo após o parto, e com técnica correta, e o não uso de complementos (água, chás e outros leites) são as medidas mais eficazes na prevenção. B) ERRADA Preferencialmente, a mama deve ser esvaziada pelo próprio lactente, pois, apesar da presença de bactérias no leite materno, quando há mastite, a manutenção da amamentação está indicada por não oferecer riscos ao recém-nascido a termo sadio. A retirada manual do leite após as mamadas pode ser necessária se não houver esvaziamento adequado. C) CORRETA O sabor do leite materno costuma alterar-se nas mastites, tornando-se mais salgado devido a aumento dos níveis de sódio e diminuição dos níveis de lactose. D) ERRADA Diante de uma lactante com mastite, a primeira conduta a ser feita é instituir o tratamento farmacológico com antibioticoterapia e analgésicos antitérmicos, pois quanto maior o tempo entre o aparecimento dos sintomas e a assistência médica, maior a chance de mastites recorrentes e ou abscessos mamários. No entanto, temos que dar apoio à mãe, orientando-a a manter a amamentação, mas a dor não deve fazer parte dela. E) ERRADA O esvaziamento adequado da mama, por meio da manutenção da amamentação, sempre iniciando pela mama não afetada, faz parte do tratamento da mastite, assim como a ordenha para retirada manual do excesso de leite produzido. Resposta letra C.

268909.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos analisar cada afirmativa a) INCORRETA. Pelos pubianos ralos caracterizam o estágio P2 e mama em fase de botão caracteriza o estágio M2. O estágio M3 é caracterizado pelo crescimento da mama e aréola sem separação dos seus contornos, enquanto P3 é caracterizado por pelos escuros, espessos e encaracolados na sínfise púbica. b) CORRETA. Consideramos como puberdade precoce aquela que ocorre antes dos 8 anos de idade em meninas e antes dos 9 anos em meninos. Se houvesse apenas o relato de telarca, poderíamos estar diante de uma telarca precoce, mas a descrição do desenvolvimento de pelos e da adrenarca configuram um quadro de puberdade precoce. c) INCORRETA. A menarca ocorre, em geral, 2 anos a 2 anos e meio após a telarca. d) INCORRETA. Na puberdade precoce central, o desenvolvimento segue a sequência habitual do desenvolvimento puberal, apenas mais precocemente que o habitual. e) INCORRETA. Não dá nem para saber o que o autor quer dizer com desreguladores endócrinos , mas certamente não reduzirão os casos de puberdade precoce. Resposta letra B.

274626.

Comentário: Questão bem específica e pouco relevante, já que se trata de uma síndrome muito rara. De qualquer forma, vamos aproveitar para aprender com a questão. A síndrome de Hutchinson-Gilford ocorre por uma mutação que leva à produção de uma proteína mutante chamada progerina, responsável pelo envelhecimento precoce típico desta síndrome. As principais manifestações clínicas são déficit de crescimento, anormalidades dermatológicas, musculoesqueléticas e neurológicas. A aparência característica inclui olhos proeminentes, nariz fino e pontudo, micrognatia, retrognatia, lábios finos, perda de sobrancelhas e veias proeminentes do couro cabeludo. A expectativa de vida é de aproximadamente 15 anos - esses pacientes desenvolvem aterosclerose acelerada e morrem geralmente por IAM ou AVC. A alternativa A descreve a síndrome de Tourette. A alternativa C descreve a síndrome de Highlander. A alternativa D descreve a osteogênese imperfeita. Resposta letra B.

266466.

Comentário: Estamos diante de uma escolar de 6 anos com quadro de puberdade precoce, denotado pelo surgimento da telarca antes dos 8 anos de idade. Repare que houve rápida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

progressão nos estágios puberais após o surgimento da telarca, avanço na idade óssea e Usg pélvico revelando linha endometrial e ovários aumentados de volume. Todas essas informações falam a favor de puberdade precoce CENTRAL. Na puberdade central, a sequência do desenvolvimento puberal é a mesma que a habitual, porém de forma mais precoce, como no caso. A velocidade de crescimento está aumentada e a idade óssea está avançada em relação à cronológica. Os casos de puber dade precoce central podem ser de origem idiopática (quando uma causa subjacente não é identificada) ou de origem neurogênica (quando há algum distúrbio levando à secreção precoce dos hormônios hipotalâmico-hipofisários). De qualquer forma, para todo caso suspeito de puberdade precoce central é recomendada a investigação por exame de imagem (no sexo masculino, a puber dade precoce central está associada a alguma anomalia no sistema nervoso central em até 75% das vezes. A maioria dos casos no sexo feminino (cerca de 90%) é de origem idiopática. Resposta letra B.

266467.

Comentário: Não há muito o que discutir nesssa questão. Provavelmente houve um erro de digitação e o enunciado ficou incompleto, sem possibilidade de afirmarmos nada, já que não sabemos qual seria a pergunta da banca. A questão foi anulada após recurso.

266468.

Comentário: O tratamento da sinéquia de pequenos lábios só está indicado em casos de aderência extensa, que provoque desconforto vulvar, leucorreia ou sintomas urinários. Na maior parte dos casos, a conduta pode ser expectante, já que grande parte se resolve no início puberal, pela ação dos estrogênios. Em caso de complicações ou ausência de melhora, o uso de estrogênio tópico estará indicado. A afirmativa está errada. A banca anulou a questão após formulação de recurso.

291519.

Comentário: Analisando os marcos do desenvolvimento presentes no enunciado, observamos que, ao que tudo indica, esta criança apresenta um desenvolvimento neuropsicomotor adequado para sua idade. Aos 12 meses de idade, é esperado que a criança ande ainda com apoio a habilidade de andar sem apoio é um marco esperado apenas aos 15 meses e sua ausência neste momento não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é razão para qualquer preocupação. A banca, todavia, tentou gerar dúvidas no candidato ao descrever os achados ultrassonográficos no período neonatal e trouxe uma classificação bastante específica. Na avaliação do recém-nascido, sempre devemos fazer o rastreamento para a displasia do desenvolvimento do quadril através da realização das manobras de Barlow e de Ortolani. A descrição de um estalido na manobra de Ortolani indica que esta manobra foi positiva, o que é compatível com a presença de uma luxação na articulação do quadril (o estalido pode representar a redução da articulação luxada suscitada pela manobra). A ultrassonografia pode ser realizada para a avaliação destas crianças e o método de Graf é um dos métodos empregados neste sentido. A classificação ecográfica do quadril avalia diversos parâmetros e divide os quadris em quatro tipos principais com seus subtipos. O tipo I indica um quadril normal e não demanda qualquer intervenção. Com isso, podemos tranquilizar a família e apenas seguir o acompanhamento de puericultura. Resposta letra A.

266469.

Comentário: Em meninas, a puberdade precoce é definida como surgimento de caracteres sexuais secundários antes dos oito anos de idade. A puberdade precoce verdadeira ou central é aquela que depende do estímulo de gonadotrofinas e por isso, a sequência de desenvolvimento puberal costuma ser a mesma do habitual, só que mais cedo. A causa mais comum em meninas (cerca de 90% dos casos) é idiopática, enquanto que em meninos o hamartoma hipotalâmico predomina. Na puberdade precoce periférica ou pseudopuberdade precoce, a sequência de desenvolvimento puberal tem comportamento aleatório, já que ocorre independente do estímulo das gonadotrofinas. Afirmativa correta. Resposta letra A.

266471.

Comentário: Nos casos de puberdade tardia, um importante diagnóstico é o hipogonadismo hipogonadotrópico do hipogonadismo hipergonadotrófico. Qual a diferença No hipogonadismo hipogonadotrófico, a origem do problema está na secreção das gonadotrofinas, ou seja, há um comprometimento hipotalâmico ou hipofisário, que resulta na deficiência das gonadotrofinas circulantes. Já no hipogonadismo hipergonadotrófico, há secreção de gonadotrofinas, mas alguma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alteração gonadal impede que ocorra resposta ao estímulo central. Observa-se uma concentração elevada de gonadotrofinas, em resposta à falência gonadal e ausência do feedback inibitório. Os pacientes apresentam ausência de desenvolvimento puberal com concentrações baixas de testosterona ou estrógenos, na presença de concentrações elevadas de LH e FSH. Assim, frente à um caso de puberdade tardia, deve-se realizar anamnese, curva de crescimento, exame físico, raio x de mãos e punhos, ultrassonografia pélvica, dosagens de FSH, LH, estradiol sérico, TSH, T4 livre e prolactina. Resposta Letra A.

263404.

Comentário: A descrição do exame das mamas nos permite identificar características clínicas compatíveis com o diagnóstico de mastite. Esta é uma das possíveis complicações que estabelecem durante a amamentação e consiste em um processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama (o mais comumente afetado é o quadrante superior esquerdo, exatamente como descrito), geralmente unilateral, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. A origem do problema é a estase do leite, que pode promover mudanças na arquitetura da mama, permitindo a passagem de alguns componentes do plasma para o leite e desse para o tecido intersticial da mama, causando uma resposta inflamatória. Este processo permite o estabelecimento de infecção bacteriana, sendo que o Staphylococcus aureus é a principal bactéria implicada a presença de fissuras pode ser a porta de entrada da bactéria. Um dos pontos fundamentais do tratamento da mastite é o esvaziamento adequado da mama, alcançado de forma eficaz pela própria amamentação, que pode ser mantida ao seio. Mesmo havendo infecção bacteriana e uso de antimicrobianos, o aleitamento pode ser mantido (são escolhidos antibióticos compatíveis com a amamentação). Resposta letra A.

266498.

Comentário: Sabemos que o sigilo ao adolescente na consulta é um dos direitos deve ser respeitado, desde que este tenha capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Qualquer exigência, como a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

serviço de saúde, que possa afastar ou impedir o exercício pleno pelo adolescente de seu direito fundamental à saúde e à liberdade, constitui lesão ao direito maior de uma vida saudável. Portanto, não há necessidade de assinatura do termo de consentimento para inserção do DIU na paciente por parte do seu responsável legal. Resposta letra B.

244485.

Comentário: Questão de Transtorno do Espectro Autista (TEA) boa para revisar o tema. A criança com TEA tem dificuldade de manter contato visual , de se expressar por meios não verbais, de desenvolver relacionamentos, de demonstrar afeto tem atraso no desenvolvimento da linguagem falada tem preferência por brincar sozinho com objetos, do que com pessoas é agitado, com padrões restritivos repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades (costuma empilhar blocos ou enfileirar carrinhos de forma sistemática). Resposta correta Letra C.

227411.

Comentário: A questão apresenta uma menina de 7 anos com quadro de puberdade precoce, pois o início do desenvolvimento puberal ocorreu antes dos oito anos de idade (aos 6 anos e 9 meses), inclusive com aparecimento de caracteres sexuais secundários. Durante o exame de estadiamento puberal, identificamos que a meninas encontra-se no estágio M2 (crescimento da aréola e da papila) e P2 (pelugem longa, fina e pouco escura na sínfise púbica), corroborando com a nossa hipótese inicial. De avaliação complementar, somente um dado foi fornecido e de extrema importância valor de pico do LH maior que 5 UI L, pois tal exame confirma o diagnóstico em ambos os sexos de puberdade precoce central ou verdadeira. O principal objetivo do tratamento da pupberdade precoce central é a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, da secreção de gonadotrofinas e dos esteroides gonadais. Para isso, os análogos GnRH estão indicados, mas somente nos casos de puberdade precoce central em que existe ativação das gonadotrofinas. Isto levará a desaceleração do ritmo de avanço de maturação óssea e a recuperação da velocidade de crescimento normal, visando ao melhor prognóstico de altura final. Sabemos que a maior parte das pacientes do sexo feminino com puberdade precoce central têm quadro idiopático. Mesmo assim, em meninas com PPC com menos de 6 anos de idade, devemos realizar exame de neuroimagem,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para afastar lesões em SNC. Acima dessa idade, não há consenso na literatura - alguns autores recomendam essa investigação mais completa, enquanto outros dispensam, indicando o tratamento e seguimento da criança. Pela falta de consenso na literatura, a questão acabou sendo anulada.

227412.

Comentário: Estamos diante de uma menina de 7 anos com uma provável puberdade precoce, visto que o início do desenvolvimento puberal ocorreu antes dos oito anos de idade (aos 6 anos e 9 meses), inclusive com o surgimento dos caracteres sexuais secundários (telarca e pubarca). Durante o exame de estadiamento puberal, identificamos que a meninas encontra-se no estágio M3 (crescimento da mama e da aréola, sem separação dos contornos) e P3 (pelos mais escuros alcançando a região da sínfise púbica), corroborando com a nossa hipótese inicial. De avaliação complementar, somente um dado foi fornecido e de extrema importância valor de pico do LH maior que 5 UI L, pois tal exame confirma o diagnóstico em ambos os sexos de puberdade precoce central ou verdadeira, pois sabemos que ela é dependente do estímulo de GnRH. Sabemos que o principal objetivo do tratamento da puberdade precoce central é a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, da secreção de gonadotrofinas e dos esteroides gonadais. Para isso, os análogos GnRH são usados, porém apenas nos casos de puberdade precoce central em que existe ativação das gonadotrofinas. Isto levará a desaceleração do ritmo de avanço de maturação óssea e a recuperação da velocidade de crescimento normal, visando ao melhor prognóstico de altura final. O grande problema é que não sabemos a etiologia do quadro desta criança, mas a banca manteve o gabarito como letra A. Resposta letra A.

227413.

Comentário: A questão apresenta uma menina de 7 anos com quadro de puberdade precoce, pois o início do desenvolvimento puberal ocorreu antes dos oito anos de idade (aos 6 anos e 9 meses), inclusive com aparecimento de caracteres sexuais secundários. Durante o exame de estadiamento puberal, identificamos que a meninas encontra-se no estágio M3 (crescimento da mama e da aréola, sem separação dos contornos) e P3 (pelos mais escuros e distribuindo-se na sínfise púbica), corroborando com a nossa hipótese inicial. Resposta item errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227414.

Comentário: A questão apresenta uma menina de 7 anos com quadro de puberdade precoce, pois o início do desenvolvimento puberal ocorreu antes dos oito anos de idade (aos 6 anos e 9 meses), inclusive com aparecimento de caracteres sexuais secundários. Durante o exame de estadiamento puberal, identificamos que a meninas encontra-se no estágio M3 (crescimento da aréola e da papila) e P2 (pelugem longa, fina e pouco escura na sínfise púbica), corroborando com a nossa hipótese inicial. De avaliação complementar, somente um dado foi fornecido e de extrema importância valor de pico do LH maior que 5 UI L, pois tal exame confirma o diagnóstico em ambos os sexos de puberdade precoce central ou verdadeira. O principal objetivo do tratamento da pupberdade precoce central é a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, da secreção de gonadotrofinas e dos esteroides gonadais. Para isso, os análogos GnRH estão indicados, mas somente nos casos de puberdade precoce central em que existe ativação das gonadotrofinas. Isto levará a desaceleração do ritmo de avanço de maturação óssea e a recuperação da velocidade de crescimento normal, visando ao melhor prognóstico de altura final. No entanto, não sabemos com certeza a etiologia do caso desta criança, embora a grande maioria seja idiopática, a investigação debe ser realizada antes do início do tratamento.

230599.

Comentário: A ginecomastia (aumento das mamas no sexo masculino) é uma condição benigna e muito comum. Na maioria dos casos, a ginecomastia será de até 4 cm e teM resolução espontânea. A classificação de Simon para ginecomastia leva em conta o tamanho da mama e presença ausência de excesso de pele. I) Pequena, sem excesso de pele IIa) Moderada, sem excesso de pele IIB) Moderada, com excesso de pele III) Grande, com excesso de pele (similar à ptose mamária feminina) A banca entendeu que por ter sido descrito como similar à mama feminina poderia ser considerado como a ptose mamária feminina descrita por Simon, por isso, considerou o gabarito letra C. Gabarito C

206173.

Comentário: Questão simples, direta e objetiva. Analisando as opções A) errada. A causa mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

comum, reponsável por pelo menos 80% dos casos, é idiopática. B) correta. Telarca é o marco inicial da puberdade precoce central. Nesse caso, há ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, o que faz com que haja a sequência esperada de eventos pubertários (telarca-pubarca-menarca) antes da idade esperada (para meninas, 8 anos, no mínimo). C) errada. Geralmente, não há alteração da idade óssea, pois é um quadro isolado. D) errada. No caso de PP central em meninos, devemos sempre lembrar de tumor de SNC. Resposta letra B.

203154.

Comentário: Espera-se de um bebê de 8 meses que seja capaz de brincar de esconde-achou, transferir objetos de uma mão para a outra, duplicar sílabas e sentar-se sem apoio (letra C correta). Contudo, produzir jargão é uma habilidade alcançada mais tarde, em torno dos 15 meses, assim como fazer pinça, marco atingido e torno dos 12 meses. Resposta letra C.

206164.

Comentário: O hipogonadismo hipogonadotrófico caracteriza-se pela falta completa ou parcial de desenvolvimento puberal em decorrência de defeitos na migração, síntese, secreção ou ação do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH). Baixas concentrações de esteroides sexuais e valores reduzidos ou inapropriadamente normais de gonadotrofinas hipofisárias (LH e FSH) definem, do ponto de vista laboratorial, essa condição clínica. A secreção dos demais hormônios hipofisários encontra-se normal, bem como a ressonância magnética de região hipotalâmica-hipofisária, demonstrando a ausência de uma causa anatômica. Alterações olfatórias, como anosmia ou hiposmia, podem estar associadas ao HHI, caracterizando a síndrome de Kallmann (não tem relação com Turner ou Klinefelter, a priori). Resposta letra C.

203075.

Comentário: Para começar, o que é herbiatria Bem, para quem não sabe, herbiatra é o médico especializado no tratamento de adolescentes. Mas isso pode Não é necessário que um responsável esteja presente na consulta De jeito nenhum Segundo o Código de Ética Médica (Resolução nº 2.217 do CFM) É vedado ao médico Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente . Melhor resposta, portanto letra B.

203063.

Comentário: O enunciado retrata o quadro de uma escolar de 9 anos apresentando boto mamário com mamas no estágio M2 de Tanner e pêlos pubianos em estágio P3 além de sua Estatura estar no percentil normal para idade. Vamos relembrar o desenvolvimento fisiológico puberal do sexo feminino O primeiro sinal de puberdade é o aparecimento do broto mamário (primeira alteração puberal reconhecida e notada), seguido pelo surgimento dos pelos pubianos, pico de crescimento e terminando com a menarca. Assim, a mãe da paciente deve ser orientada que o brotamento mamário e o surgimento de pêlos pubianos ocorre antes da menarca e representa alteração fisiológica. Não há necessidade de investigação e exames complementares. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.

212034.

Comentário: Questão mal feita. Sabemos que a telarca precoce é definida pelo aparecimento unilateral ou bilateral de mamas de modo ISOLADO, na AUSÊNCIA de outros sinais puberais, em meninas com menos de 8 anos de idade. Repare que Mariana, além de apresentar a telarca antes dos 8 anos, também tem o surgimento de pelos pubianos, o que sugere uma puberdade precoce, e não telarca precoce. Resposta Medgrupo letra B. Resposta da Banca letra A.

212124.

Comentário: Lembre-se do conceito no sexo feminino, a puberdade pode ter início entre 8 e 13 anos assim considera-se precoce o início do desenvolvimento puberal antes dos 8 anos e considera-se que há atraso quando uma menina já completou 13 anos e ainda não teve o início da puberdade. Já no sexo masculino, a puberdade ocorre entre 9 e 14 anos assim, o início antes dos 9 anos é considerado precoce e a ausência de desenvolvimento puberal em quem já completou 14 anos indica atraso puberal. João ainda tem 11 anos e, por isso, não podemos definir atraso puberal. Resposta letra B.

212127.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão conceitual O início da puberdade é definido nos meninos pelo aumento do volume testicular, que pode ser avaliado pelo volume 3 ml ou 4 ml. Este estágio corresponde a G2 dos critérios de Tanner. Resposta alternativa A.

212019.

Comentário: Questão tranquila. Sabemos que a menarca (primeira menstruação) é um evento tardio na puberdade feminina e costuma ocorrer cerca de dois a dois anos e meio após a telarca, quando as mamas estão no estágio M4. Resposta letra A.

212028.

Comentário: Questão bem direta sobre o momento do estirão de crescimento durante a puberdade. Nas meninas o pico da velocidade de crescimento ocorre no estágio III de Tanner (M3), e nos MENINOS no estágio IV de Tanner (G4). Logo, a afirmativa está errada. Gabarito letra B.

175101.

Comentário: A suplementação de vitamina D, atualmente, é feita para todos os recém-nascidos de forma universal, logo após o nascimento até 12 meses na dose de 400 UI dia e 600 UI dia dos 12 aos 24 meses. Já a suplementação com ferro elementar é feita para todos recém-nascido a termo a partir do 6 mês e para prematuros a partir do 1 mês de vida. É válido lembrar que crianças que fazem uso de pelo menos 500 ml dia de fórmula infantil não precisam da suplementação com ferro, e para as que fazem uso de 1.000 ml dia de fórmula estão dispensados da suplementação de vitamina D. Logo, gabarito letra C.

177225.

Comentário: O recém-nascido pode ser contaminado com herpes simples intraútero pela via hematogênica transplacentária, durante o parto (a via mais frequente) ou no período pós-natal. O risco de contaminação neonatal é maior para infecção primária ou não-primária se ocorrer no último mês da gestação. Porém, na última semana antes do parto, a transmissão é baixa para doença recorrente. O risco de transmissão do vírus pelo leite materno é muito baixo, não contraindicando o aleitamento ao seio. No acometimento da nutriz pelo herpes, o aleitamento materno deve ser mantido, exceto quando as vesículas herpéticas estiverem localizadas na mama. Lesões ativas em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

outras partes do corpo devem ser cobertas, recomendando-se rigorosa higiene da nutriz para que o aleitamento seja mantido. O tratamento com aciclovir deve ser iniciado o mais precocemente possível para a nutriz, sem interferir, por sua vez também, no aleitamento. A melhor resposta é a letra C, porém, a banca divulgou como gabarito a letra D. Resposta letra D.

175102.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) INCORRETA. No primeiro ano de vida a criança cresce em média 25 cm (15cm no 1º semestre e 10cm no 2º semestre). B) INCORRETA. No 1º trimestre 700g mês ou 25-30g dia 2º trimestre 600g mês ou 20g dia 1800g 3º trimestre 500g mês ou 15g dia 4º trimestre 400g mês ou 12g dia. C) INCORRETA. A criança duplica o seu peso de nascimento por volta do 4-5 mês de vida e triplica no final do primeiro ano. D) CORRETA. No primeiro trimestre de vida o perímetro cefálico cresce em média 2 cm mês (aproximadamente 0,5cm semana). Logo, gabarito letra D.

175103.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) INCORRETA. A maioria das crianças são capazes de andar com apoio a partir de 12 meses de idade. B) INCORRETA. Transferir objetos de uma mão para outra é uma habilidade esperada por volta do sexto sétimo mês de vida. C) CORRETA. É esperado que uma criança sente com apoio e também sem apoio por tempo limitado a partir do sexto mês de vida. D) INCORRETA. A criança segura objetos por volta do quarto mês de vida. Resposta correta letra C.

183877.

Comentário: Errado. Não vamos confundir o reflexo de Babinski com o reflexo cutaneoplantar. O reflexo cutaneoplantar é obtido ao se estimular a sola do pé com um objeto de ponta romba, fazendo-se um risco do calcanhar à base do quinto dedo. Até o 4º mês de vida, 100% dos lactentes fazem extensão do hálux com ou sem abertura dos dedos em leque, e isso é um achado normal. A partir do 12º mês, o reflexo passa a ser a flexão dos dedos, permanecendo desta maneira por toda a vida. Mas não podemos chamar tal reflexo de sinal de Babinski, visto que este é um achado patológico encontrado nas síndromes piramidais. Portanto, eis uma questão que mereceu recursos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183881.

Comentário: Questão relativamente simples. Quando aviliamos um gráfico por escore Z, o zero se refere a média de uma população. Assim, se o paciente apresenta-se em uma curva maior que ZERO, indica que o paciente está um desvio padrão acima da média (escore Z 1), duas curvas acima da média (escore Z 2), o paciente estaria 2 desvios padrão acima da média...

183884.

Comentário: A afirmativa em questão encontra-se incorreta, uma vez que o hormônio do crescimento (GH) não atua diretamente na síntese de condroblastos. Vamos rever um pouquinho da fisiologia do crescimento normal O principal fator de crescimento, tanto no período pré-natal como no período pós-natal, é a IGF-I, que age na epífise de crescimento. No período pós-natal, a IGF-I, sob a regulação direta do GH, é produzida no fígado e liberada na circulação e também produzida diretamente na epífise óssea. O GH, que é produzido na hipófise, também tem ação direta na placa de crescimento. Enquanto a IGF-I estimula expansão e a hipertrofia, o GH estimula a diferenciação celular. Os hormônios tireoidianos estimulam a produção e a secreção de GH e estimulam a síntese de IGF-I GH-dependente. Além disso, os hormônios tireoidianos têm um efeito direto na placa de crescimento, estimulando a diferenciação terminal dos condrócitos e a atividade dos osteoclastos. Os glicocorticoides apresentam um efeito agudo de estimular o crescimento, mas uma exposição crônica a níveis elevados de glicocorticoides causa uma diminuição da síntese e da sensibilidade ao GH e, consequentemente, diminui a síntese de IGF-I e a proliferação celular, comprometendo o crescimento. Afirmativa, portanto, incorreta. Resposta letra B.

183914.

Comentário: Mães portadoras de tuberculose pulmonar bacilífera devem ser encorajadas a amamentar . Basta que ela o faça usando máscara, em ambiente arejado e sob luz solar. Após 15 dias de tratamento com o esquema básico (RIPE), ela deixa de ser bacilífera, salvo em casos de resistência à terapêutica. Assertiva errada. Resposta B.

183919.

Comentário: Nas formas aguda e crônica da doença de Chagas, estudos mostram que o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Trypanosoma cruzi pode ser isolado no leite materno. A doença aguda no lactente tende a evoluir de forma benigna, embora sequelas tardias possam ocorrer. A raridade da transmissão da doença justifica a manutenção do aleitamento na doença crônica, exceto se houver sangramento ou fissura na papila. Na doença aguda a nutriz não deve amamentar. Logo, a afirmação está errada. Resposta letra B.

183925.

Comentário: O HbsAg tem sido detectado no leite materno de mulheres soropositivas para a hepatite B, e é possível que pequenas quantidades de sangue materno sejam ingeridos pelo recém-nascido durante a amamentação, a partir de lesões nos mamilos, mesmo que pequenas. A maior via de transmissão da mãe para o bebê é através do contato com o sangue materno durante o trabalho de parto e parto. A criança deve receber a primeira dose da vacina logo após o parto e a imunoglobulina hiperimune da hepatite B na dose de 0,5 ml IM nas primeiras 12 horas de vida, aplicadas concomitantementes, mas em locais diferentes. A eficácia dessa conduta é de 95% e elimina eventual risco de transmissão pelo leite materno. A realização de vacina e imunoglobulina à mãe não reduz o risco de transmissão da hepatite B ao recém-nascido. Resposta letra A.

183929.

Comentário: Toda atenção com afirmativas que dizem ser necessário suspender o aleitamento materno. Poucas são as contraindicações à amamentação relacionadas à mãe, e vamos aqui relembrar algumas drogas, como as antineoplásicas e imunossupressoras, substâncias radioativas, derivados do ergot em doses para enxaqueca. A hidroxiureia é droga que, quando usada, deve-se suspender o aleitamento materno por 24 horas. Casos graves de psicose puerperal, eclampsia ou choque lesões ativas na mama ou mamilo por herpes mães HIV, HTLV 1 e 2 positivas. Lembrar que a tuberculose ativa materna não contraindica a amamentação, devendo a mãe utilizar máscara e a criança receber quimioprofilaxia. Se a mãe estiver bem clinicamente para amamentar, a doença diarreica aguda e dengue materna não indicam a suspensão do aleitamento materno. Lembre-se de que a dengue não é transmitida pelo leite materno de mães infectadas. A afirmativa está, portanto, errada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183955.

Comentário: CERTO. O comportamento alimentar ocupa atualmente um papel central na prevenção e no tratamento de doenças. A alimentação durante a infância, ao mesmo tempo em que é importante para o crescimento e desenvolvimento, pode também representar um dos principais fatores de prevenção de algumas doenças na fase adulta. Sabemos que os hábitos alimentares na infância estao relacionados à diversas doenças na fase adulta como obesidade, diabetes e sobrepeso.

183959.

Comentário: Questão foi anulada pois o gabrito era Errado e a afirmativa está CORRETA. Vamos justificar a resposta tendo como base o Tratado de Pediatria da SBP, 4ª edição, temos Na faixa etária pediátrica, a alimentação saudável deve possibilitar crescimento e desenvolvimento adequados, otimizar o funcionamento de órgãos, sistemas e aparelhos e atuar na prevenção de doenças em curto e longo prazo. Essa faixa representa uma janela de oportunidades importante para a implementação de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis com repercussões até a fase adulta. Nos primeiros meses de vida, os sistemas digestório, nervoso, renal e imunológico são imaturos, o que requer ainda maior atenção nas orientações nutricionais fornecidas pelos profissionais de saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde periodicamente disponibilizam materiais atualizados sobre o tema alimentação saudável. Estudos em animais de experimentação e humanos enfatizam a importância dos fatores nutricionais e metabólicos, em fases iniciais do desenvolvimento humano, com efeito, em longo prazo, na programação (programming) da saúde futura. O programming é a indução, a deleção ou o prejuízo do desenvolvimento de uma estrutura somática permanente ou ajuste de um sistema fisiológico por um estímulo ou agressão que ocorre em um período suscetível (p.ex., fases precoces da vida), resultando em consequências em longo prazo para as funções fisiológicas. Um exemplo importante de programming em humanos é a relação entre a alimentação no primeiro ano de vida e o desenvolvimento de obesidade. O aleitamento materno tem efeito protetor e dose-dependente na redução do risco de obesidade até a idade adulta. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Durante o crescimento e a definição da composição corporal, os componentes da dieta e dos alimentos são os principais fatores ambientais a afetar o genoma humano. A epigenética representa o conjunto emergente de mecanismos que explicam de que forma o ambiente e a alimentação nutrição podem influenciar o genoma. Esse trecho é o suficiente para definirmos que o gabarito divulgado estava inapropriado e, com base nisso, a questao foi anulada pela banca.

157998.

Comentário: Questão conceitual. Calcularíamos o alvo genético da seguinte forma Para meninos Estatura do pai (estatura da mãe 13) 2. Para meninas Estatura da mãe (estatura do pai - 13) 2. Visto isso, vamos calcular 186cm (169 13) 2 184cm. A maioria das crianças atinge uma estatura, quando adultas, dentro de aproximadamente 5 cm para mais ou para menos equivalendo aos percentis 3 e 97 do alvo genético. Logo, gabarito letra C.

154482.

Comentário: Vamos analisar as alternativas. A) Errada A criança duplica de peso por volta dos 4 meses e o comprimento aumenta em 50% somente no primeiro ano de vida. B) Certa No segundo trimestre (3-6 meses), é esperado um ganho diário de 20 g e o peso duplica por volta dos 4 meses de idade. C) Errada A criança triplica o peso do nascimento no primeiro ano de vida e o Perímetro Cefálico (PC) aumenta em 12 cm comparado ao do nascimento. D) Errada A criança nasce com um PC entre 32-36 cm e cresce 12 cm no primeiro ano de vida, ou seja, tal crescimento corresponde a menos de 50% do PC do nascimento. E) Errada É esperado que o lactente recupere em até 15 dias o peso do nascimento. Resposta letra B.

154494.

Comentário: Dos marcos apresentados, o único esperado em um paciente de 7 meses é a transferência de objetos de uma mão para a outra. No que se refere a linguagem, é esperado a formação de polissílabos vocais, só sendo exigida a repetição de sons consonantais (mama, dada) e olhar quando chamado pelo nome a partir dos 10 meses de idade. O movimento de pinça

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

assistida (segura objetos entre o polegar e o indicador) também é esperado aos 10 meses e o pensamento simbólico ou faz-de-conta trata-se de um marco bem mais tardio, somente após os 2 anos de idade. Resposta letra A.

168444.

Comentário: Temos uma pré-escolar que apresenta o desenvolvimento precoce de caracteres sexuais secundários o aumento das mamas. O primeiro passo na abordagem dessa criança é tentarmos definir se isto está ocorrendo por uma puberdade precoce ou se há somente a presença do caracter isolado, ou seja, uma telarca precoce isolada (a banca reitera a informação de que a única alteração observada foi o aumento das mamas, sem outros sinais de puberdade). Para tal, a avaliação da velocidade de crescimento e a determinação da idade óssea são fundamentais. Lembre-se de que a puberdade precoce cursa com aceleração do crescimento e do fechamento epifisário e, por isso, é causa de baixa estatura na vida adulta. Assim, a avaliação inicial deve ser a solicitação da radiografia de mão e punho para verificação do início da puberdade (não acreditamos ser possível solicitar o recurso pelo fato da banca ter indicado o termo radiografia de punhos , no plural). O diagnóstico da causa do distúrbio é uma etapa posterior, que segue-se ao diagnóstico da puberdade precoce. Apenas após o diagnóstico de puberdade precoce é que a dosagem de gonadotrofinas poderá ser solicitada para a distinção entre um quadro de puberdade precoce e um quadro de puberdade periférica. Porém, após recurso, a questão acabou sendo anulada, mas fique o conceito de que a idade óssea é o exame inicial mais importante.

159536.

Comentário: A síndrome de Beckwith-Wiedemann é uma síndrome de hipercrescimento caracterizada por macrossomia, macroglossia, hemi-hipertrofia, onfalocele e anomalias renais. Há um aumento no risco para neoplasias, como tumor de Wilms, hepatoblastoma, rabdomiossarcoma, neuroblastoma e carcinoma adrenal cortical. Assim, recomenda-se um rastreamento periódico da forma indicada. Cabe lembrar que a dosagem de alfafetoproteína pode estar discretamente elevada na criança com síndrome de Beckwith-Wiedemann durante o primeiro ano de vida. Assim, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159593.

Comentário: O substituto ideal para o leite materno é a fórmula infantil. No entanto, por algum motivo, sobretudo financeiro, que impeça a família de realizar a alimentação da criança com a fórmula, o leite de vaca é o substituto indicado. Vale lembrar que, devido a alta quantidade de proteínas e eletrólitos (principalmente o sódio) que o leite de vaca integral apresenta, a sua forma in natura não pode ser oferecida para crianças abaixo de 4 meses de idade, sendo então necessário realizar a sua diluição. No entanto, como o leite perde calorias quando diluído, devemos complementar com o óleo vegetal, cuja quantidade é uma colher de sopa para cada 100 ml do leite de vaca diluído, que dá uma concentração de óleo em torno de 3% na solução final. Além disso, o volume a ser administrado é calculado de acordo com o peso. Porém, tratando-se de um lactente de 2 meses, mesmo considerando um peso elevado, não ultrapassaria uma quantidade de 180 ml para ser oferecida 5 a 6 vezes ao dia. Logo, a questão encontra-se incorreta por diversos motivos. Gabarito errado

159619.

Comentário: O Capítulo IX do Código de Ética Médica, Art. 74., discorre É vedado ao médico Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Devemos atender a demanda da paciente, que é legítima, respeitando o sigilo ético exigido da consulta. Resposta certa A

133991.

Comentário: Questão sobre crescimento. Temos uma criança nascida a termo, sem intercorrências, com peso, estatura e perímetro cefálicos adequados. Por volta dos 12 meses, a criança deve ter triplicado seu peso de nascimento, crescido cerca de 25 centímetros em estatura e 12 centímetros o perímetro cefálico. Desta forma, com 1 ano de idade, esta criança deve estar pesando em torno de 9 quilos, medindo cerca de 75 cm e com um perímetro cefálico próximo a 47 cm. Resposta letra C.

133941.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Temos um lactente de 2 anos com erros alimentares, queixa de palidez e uma hemoglobina diminuída (abaixo de 11 g dL). A deficiência de ferro constitui a principal causa de anemia na infância, podendo acometer cerca de 30-50% dos lactentes, causando alterações no crescimento e desenvolvimento dessas crianças. A primeira alteração a ocorrer é a diminuição da ferritina, a proteína responsável pelo armazenamento do ferro intracelular. Em seguida, se dá a diminuição do ferro sérico, o aumento da capacidade de ligação da transferrina e a diminuição da saturação da transferrina. Ao longo da sua instalação, os eritrócitos se tornam deformados e há diminuição do seu conteúdo de hemoglobina, apresentando caracteristicamente microcitose, hipocromia, poiquilocitose, aumento da amplitude de distribuição do tamanho dos eritrócitos (RDW) ou anisocitose e diminuição dos reticulócitos. Nestes casos, existe a indicação de iniciar sulfato ferroso em dose terapêutica, com o intuito de normalizar os níveis de hemoglobina, os outros indicadores hematimétricos e repor os estoques teciduais. A dose diária de ferro elementar recomendada é de 3 a 6 mg kg dia, por um período em média de três a quatro meses ou até oito semanas após a normalização da hemoglobina. A profilaxia contra a anemia ferropriva está indicada a partir dos 6 meses, na dose de 1 mg Kg dia de ferro elementar, até os dois anos. Resposta letra C.

129076.

Comentário: Vamos analisar as alternativas sobre o tema alimentação saudável . A CORRETA. Os ácidos graxos ou gorduras trans são um tipo de gordura formado pelo processo de hidrogenação natural, que ocorre quando o animal rumina, ou durante o processo industrial de hidrogenação parcial, que transforma os óleos líquidos em gorduras mais consistentes à temperatura ambiente. Gordura vegetal hidrogenada é aquela na qual são adicionadas moléculas de hidrogênio. Este processo, conhecido como hidrogenação, transforma os óleos vegetais líquidos em gorduras mais consistentes à temperatura ambiente. B INCORRETA. Alimentos que usam como conservante o sódio podem ser doces, como refrigerantes. C INCORRETA. Ervas aromáticas são amplamente utilizadas para a substituição do sal. D INCORRETA. A tabela apresenta uma forma de organização com início pelo valor energético, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sódio, outros minerais e vitaminas, nesta ordem. E INCORRETA. Existe diferença entre alimentos light e diet . Os termos diet e light podem, opcionalmente, ser utilizados nas embalagens de alimentos. No entanto, os critérios e as condições para o uso dessas duas expressões são diferentes. Enquanto o termo light é usado para indicar uma informação nutricional de menor concentração calórica, o termo diet é usado em alguns produtos para fins especiais, para indicar a substituição do açúcar por adoçante e nem sempre possui menor teor calórico. Gabarito letra A.

129061.

Comentário: Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente da natureza (plantas ou animais), que não sofreram qualquer alteração para o consumo (ovo, leite, folhas, frutas). Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas, como grãos secos e polidos, farinhas, tubérculos lavados, cortes de carne resfriados, leite pasteurizado. Os alimentos processados são produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado legumes em conserva, frutas em calda, queijos, pães. Os alimentos ultraprocessados tratam-se de produtos cuja fabricação envolve diversas etapas, ingredientes e técnicas de processamento, como refrigerantes, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e barrinhas de cereais. Resposta letra D.

104774.

Comentário: Lactentes que não são amamentados ao seio materno devem idealmente receber fórmula infantil. As fórmulas infantis disponíveis no Brasil possuem quantidades adequadas de vitaminas e oligoelementos, não sendo necessária a suplementação de vitamina D teoricamente (letra A INCORRETA). Vale lembrá-los que atualmente, a SBP recomenda a vitamina D profilática para todas as crianças menores de 2 anos, independente da cor, região do país e tipo de alimentação. Se fôssemos respondê-la hoje (e não na época do concurso) esta opção estaria CORRETA. Em regiões de alta prevalência de hipovitaminose A, deve-se administrar a vitamina A em megadoses por via oral a cada 4 a 6 meses, sem necessidade de comprovação laboratorial, uma vez que a concentração dessa vitamina no leite materno varia de acordo com a alimentação materna (letra E INCORRETA). A partir dos 6 meses, inicia-se a alimentação complementar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Embora com horários mais regulares que os da amamentação, ela deve permitir pequena liberdade inicial quanto a ofertas e horários, permitindo também a adaptação do mecanismo fisiológico de regulação da ingestão. Mantém-se, assim, a percepção correta das sensações de fome e saciedade, característica imprescindível para a nutrição adequada, sem excessos ou carências (letra D INCORRETA). Em crianças entre 1 e 2 anos de idade, a amamentação deve continuar. As refeições devem ser semelhantes às dos adultos, evitando-se alimentos industrializados ricos em açúcar, gordura e sal (letra C INCORRETA). Devem ser consumidos todos os tipos de carnes e afins, com estímulo ativo ao consumo de frutas e verduras. Deve ser incentivada a ingestão média de 600 ml de leite de vaca (preferencialmente fortificado com ferro e vitamina A), assim como de outros derivados (iogurtes caseiros, queijos), para garantir correta oferta de cálcio (letra B CORRETA).

111313.

Comentário: Embora não tenha sido indicado neste enunciado, fica claro que a banca está fazendo menção ao desenvolvimento puberal do sexo feminino. O primeiro sinal de desenvolvimento puberal identificado no sexo feminino costuma ser o desenvolvimento do broto mamário, a telarca. A telarca é resultante da secreção de estrógenos pelas gônadas femininas (gonadarca) e marca o estágio de Tanner M2. Após a telarca, ocorre a pubarca, que corresponde ao desenvolvimento da pilificação pubiana e decorre da presença dos androgênios adrenais (adrenarca). O pico do estirão do crescimento, época de crescimento mais intenso, costuma suceder a pubarca, quando as mamas estão em estágio M3. A menarca, primeira menstruação, acontece em uma época em que ainda há crescimento, mas de forma desacalerada. Habitualmente, a menarca irá ocorrer quando as meninas estiverem no estágio M4 e o intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser de 2 a 2,5 anos. A sequência correta está indicada na letra D. Resposta letra D.

111358.

Comentário: Temos uma criança apresentando uma anemia microcítica, sem reticulocitose, com história de prematuridade e aleitamento materno exclusivo somente até os 2 meses, com introdução do leite de vaca e sem suplementação de ferro. Logo, a hipótese diagnóstica mais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

provável é anemia ferropriva. Sabe-se que prematuros e crianças com baixo peso ao nascer devem receber suplementação de ferro a partir dos 30 dias de vida, até os 2 anos de idade. É importante lembrar também que o leite de vaca é um leite com muito baixa biodisponibilidade de ferro, já o leite materno apresenta alta biodisponibilidade deste nutriente. Então, diante da suspeita de anemia ferropriva, devemos dosar o ferro sérico e a ferritina. Resposta letra E .

111314.

Comentário: O primeiro sinal de desenvolvimento puberal identificado no sexo masculino é o aumento do volume testicular, resultante do estímulo gonadotrófico sobre as gônadas masculinas. O volume testicular pode ser medido com o orquidômetro de Prader, no qual valores superiores ou iguais a 4 mL indicam o início do desenvolvimento puberal. Também podemos dizer que há o aumento do testículo quando o maior diâmetro for superior a 2,5 cm. Este aumento do volume testicular marca o estágio G2 de Tanner no estágio G3 há o aumento do comprimento do pênis no estágio G4, ocorre o aumento do diâmetro. O início da pilificação pubiana sucede o aumento do volume testicular a pilificação facial e axilar são eventos mais tardios. O pico do estirão do crescimento, no sexo masculino, costuma ocorrer em estágios avançados do crescimento G4. Resposta letra D.

111325.

Comentário: A ginecomastia corresponde à presença de tecido glandular mamário no sexo masculino. Embora possa ser um marcador de algum processo mórbido, pode ser também um processo fisiológico e benigno em algumas fases da vida, como nos primeiros meses. No recém-nascido, e nos primeiros meses de vida, pode haver uma ginecomastia transitória. Esta condição é bastante comum e pode ser mesmo acompanhada de secreção láctea (popularmente conhecida com leite de bruxa). Este quadro é resultante da ação dos hormônios placentários e começa a desaparecer, espontaneamente, após a interrupção desta passagem hormonal. Não há necessidade de qualquer intervenção específica. Recomenda-se, apenas, que os familiares não manipulem a glândula, tentando drenar a secreção. Resposta letra A.

111336.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bem simples O principal cuidado era não errar na hora da conta. O cálculo do alvo genético no sexo masculino é feito da seguinte forma altura do pai (altura da mãe 13) 2. O alvo-genético permite que seja avaliada a herança (estatura dos pais) na determinação da faixa de estatura final. Lembre-se de que uma criança que cresce muito aquém do seu alvo-genético deve ser avaliada, ainda que não tenha baixa estatura. Fazendo as contas com os dados fornecidos, chegamos ao valor de 168 cm. Resposta letra D.

111284.

Comentário: A baixa estatura familiar é uma variante da normalidade, ou seja, não é considerada uma baixa estatura patológica. Nesses casos, a criança é baixa, mas cresce em um ritmo constante, dentro do alvo genético e apresenta idade óssea compatível com a idade cronológica. A idade estatural é menor que ambas. Resposta letra C.

97734.

Comentário: O enunciado nos traz um neonato de 5 dias e sua mãe, que apresenta um ingurgitamento mamário fisiológico, próprio do período pós-apojadura. A ansiedade materna quanto à quantidade e qualidade do leite materno é muito frequente, e pode colocar em risco a amamentação exclusiva. O pediatra deve orientá-la sobre a fisiologia do processo, garantir a suplência nutricional do leite materno, corrigir a técnica de pega posicionamento, e requer antes da pega, recomendar a ela que realize periodicamente expressão manual do leite, a fim de deixar as mamas menos túrgidas e dolorosas, tornando a aréola e bico mais macios para o bebê. Gabarito letra B.

80702.

Comentário: Sabemos que a forma ideal de acompanharmos o crescimento ponderal de uma criança é através da construção de sua curva de crescimento e da comparação dos dados obtidos com os referenciais populacionais. Mas, é útil conhecer alguns valores médios de ganho de peso ao longo da infância Vamos memorizar, então - Ao nascimento a média de peso é de 3,4 kg. Há uma perda de 10% do peso de nascimento na primeira semana, seguida de recuperação na segunda semana. -1º trimestre 700 g mês ou 25 a 30 g dia -2º trimestre 600 g mês ou 20 g dia -3º

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trimestre 500 g mês ou 15 g dia -4º trimestre 400 g mês ou 12 g dia -Pré-escolar 2 kg ano -Escolar 3 a 3,5 kg ano. De uma maneira geral, devemos lembrar que a criança costuma dobrar de peso de nascimento aos 4-5 meses, triplicar aos 12 meses e quadruplicar com 2 a 2 anos e meio. Portanto, esta criança com um ano deve ter 3 X 3,2 kg 9,6 kg. Resposta letra D.

80709.

Comentário: Da mesma maneira que acompanhamos o peso de uma criança, sabemos que a forma ideal de acompanharmos o seu crescimento é através da construção de sua curva de crescimento e da comparação dos dados obtidos com os referenciais populacionais. Mas, também devemos memorizar o incremento esperado na estatura de uma criança ao nascimento a média do RN a termo é 50 cm no 1º ano Cresce 25 cm (15 cm no 1º semestre e 10 cm no 2º semestre), 2º ano 12 cm ano 2-4 anos, 7 cm ano 4-6 anos, 6 cm ano 6 anos, puberdade 5 cm ano, meninas 8,3 cm ano (no pico do estirão) meninos 9,5 cm ano (no pico do estirão) Sendo assim, esta criança de 1 ano deve ter 50 cm 25 cm 75 cm. Resposta letra C.

75524.

Comentário: O quadro clínico da questão é compatível com ingurgitamento mamário, pois a paciente não está amamentando corretamente seu filho. O ingurgitamento mamário caracteriza-se por estase láctea repentina em puérperas em bom estado geral, acompanhada de desconforto e hiperdistensão mamária e hipertermia local e sistêmica. Isto geralmente ocorre por erro na pega, que deve ser corrigida, e a paciente ainda apresenta mamilos planos, dificultando ainda mais a amamentação. O mais importante para o caso é a manutenção do aleitamento, o apoio físico e psicológico à puérpera. Enquanto não há melhora da amamentação, é necessário esvaziar as mamas após a amamentação e utilizar sutiã para melhorar a sintomatologia. Não há sinais clínicos para pensarmos em mastite e justificar a antibioticoterapia. Não há indicação de suspender a amamentação, pelo contrário ela deve ser estimulada. Gabarito letra A.

75474.

Comentário: A simples leitura cuidadosa do enunciado permitiria que chegássemos a melhor resposta para essa questão. Percebam como fica caracterizado que as ditas alterações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

comportamentais deste escolar estão ocorrendo apenas em um ambiente, o ambiente escolar. Como regra geral, as dificuldades de aprendizagem podem ser relacionadas a problemas no âmbito familiar, no âmbito doméstico ou questões próprias da criança. Fica bem caracterizado que o escolar não possui alterações de comportamento doméstico e que suas indisciplinas são esperadas para alguém de sua idade. Nos transtornos de conduta, encontramos diversas características, como discussões com adultos e aborrecer propositalmente os outros essas características devem estar presentes por pelo menos seis meses para que o diagnóstico seja estabelecido. O TDHA é uma das causas de dificuldade de aprendizagem, mas tem manifestações que surgem em mais de um ambiente. Assim, a melhor resposta é a letra C.

75538.

Comentário: As questões que abordam o neurodesenvolvimento infantil frequentemente são alvo de controvérsia. Os diversos autores que estudam o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças ao longo dos primeiros anos de vida divergem em relação ao momento exato em que os reflexos arcaicos desaparecem ou que determinadas habilidades estão presentes. Assim, a melhor forma de chegarmos à resposta de uma questão como essa é através da exclusão das alternativas que trazem conceitos claramente equivocados. Em relação aos reflexos primitivos, ou arcaicos, um dos reflexos que as bancas mais gostam de abordar é o reflexo de Moro. Tradicionalmente, é aceito que o reflexo de Moro torna-se incompleto aos três meses e desaparece por completo aos seis meses. Deste modo, a presença deste reflexo em uma criança que já completou sete meses poderia ser indicativa de uma alteração. Com isso, excluímos as opções A e C. A opção B traz habilidades que representam padrões de comportamento emergentes observados na consulta de nove-dez meses. Seria impossível que uma criança de apenas sete meses já executasse algumas dessas funções De modo algum. Porém, isso seria muito pouco provável. Menos provável ainda para não usar o termo impossível - seria a execução das habilidades descritas na opção A, que traz padrões emergentes observados em uma criança com 12 meses de idade. Resta-nos a opção D. De fato, nesta opção encontramos a descrição de habilidades que seriam encontradas em uma criança dessa idade. Vale lembrar alguns pontos as crianças com sete meses permanecem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sentadas longos períodos com apoio e alguns períodos sem apoio o momento de desaparecimento do reflexo de preensão plantar varia bastante na literatura, mas em geral encontramos que seu desaparecimento ocorre entre seis e oito meses. Assim, a opção D é a melhor resposta.

351606.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre aleitamento materno, para determinar a sequência correta A primeira afirmativa é falsa. No aleitamento materno exclusivo, preconizado até os 6 meses, não é necessário ofertar qualquer líquido entre as mamadas. A segunda afirmativa é verdadeira. Quando comparado ao leite de vaca, o leite materno tem menor proporção de caseína (40% contra 80%), e uma melhor digestibilidade. A terceira afirmativa é falsa. A maioria dos fatores de proteção presentes do leite materno (IgA secretória, lisozima, etc) não estão presentes nas fórmulas, sejam elas parcialmente hidrolisadas ou não. Vale reforçar que esses fatores de proteção imunológica são, em sua maioria, inativados pelo processo de pasteurização, de modo que são exclusivos do leite biológico cru. A quarta afirmativa é falsa. A amamentação é considerada segura em casos de mães com hepatite B, contando que o recém-nascido receba a imunoglobulina e a vacina para hepatite B. Assim, chegamos à ordem F V F F. Resposta letra A.

351583.

Comentário: Vamos analisar as alternativas para determinar o que devemos esperar quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança de 2 anos De fato, aos 18 meses a criança já deve ser capaz de obedecer a ordens simples, reconhecer e apontar pessoas e partes do corpo. Nessa etapa, a criança apresente o sentimento de posse, repetindo com frequência as palavras meu e não no dia a dia. Ainda, aos 18 meses a criança já deve ser capaz de andar com segurança, dar pequenas corridas e subir e descer degraus baixos. Como dito anteriormente, uma criança de 2 anos já deve ser capaz de andar sozinha. Essa criança deve ser capaz de reconhecer o próprio nome, mas a capacidade de elaborar muitas perguntas e a criação de amigos imaginários são habilidades esperadas para crianças mais velhas, entre 4 e 5 anos. O vocabulário expandido, o uso correto do plural e a capacidade de saltar alternadamente são habilidades esperadas para uma criança de 5 anos, não dois. A capacidade de contar historinhas surge com a expansão do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vocabulário, entre 4 e 5 anos. A capacidade de comer sozinha com uma colher surge a partir dos 3 anos.

352159.

Comentário: Temos um recém-nascido cuja mãe está cheia de dúvidas a respeito do aleitamento materno, um fato recorrente da vida e na prova. Vamos analisar as alternativas acerca das orientações adequadas para esta mãe Letra A incorreta. Todas as sociedades, inclusive a Organização Mundial de Saúde, recomendam o regime de aleitamento materno sob livre demanda, ou seja, que a criança seja amamentada sem restrição de horários ou de tempo de permanência na mama. Especialmente nos primeiros meses, é comum que a criança mame em horários irregulares e com alta frequência. Letra B correta. Embora esta afirmação esteja cada vez mais sendo colocada em cheque. Alguns definem o leite anterior como os primeiros 30 ml de leite coletado, enquanto outros dizem que é aquele coletado durante os primeiros três minutos de fluxo lácteo, e o restante obtido até o esvaziamento completo da mama seria o leite posterior. Mas, nem sempre há um momento mágico em que o leite anterior se transforma em posterior. Em geral, à medida que o bebê mama, o aumento do teor de gordura é gradual, com o leite ficando cada vez mais gorduroso quando a mama é esvaziada mais completamente. Letra C incorreta. Ruídos da língua são considerados sinais de alerta para uma pega inadequada. Outros sinais de técnica de amamentação incorreta são bochechas encovadas, mama muito esticada ou deformada durante a mamada e dor à amamentação. Letra D incorreta. Na sua cartilha sobre amamentação, o Ministério da Saúde afirma não se recomenda que os dedos da mãe sejam colocados em forma de tesoura, pois dessa maneira podem servir de obstáculo entre a boca do bebê e a aréola . Caso seja necessário que a mãe apoie a mama, deve fazê-lo com os dedos em formato de C, utilizando o polegar na região superior da mama e os outros 4 dedos na região inferior, dando sustentação para a mama. Resposta letra B.

351602.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre os benefícios do aleitamento materno para a mãe, para determinar qual é a alternativa incorreta Letra A correta. A mulher que amamenta tem risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

reduzido de câncer de mama, ovário e endométrio. Letra B incorreta. A redução do risco de diabetes mellitus tipo 1 é um benefício que o aleitamento traz para a criança amamentada. Para a mãe, há redução na prevalência de diabetes do tipo 2. Letra C correta. A amamentação exclusiva parece reduzir o risco de recaída de esclerose múltipla no pós-parto, especialmente nos primeiros meses. Letra D correta. Como vimos, a mulher que amamenta tem risco reduzido de câncer de ovário. Resposta letra B.

337634.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre aleitamento materno. A letra A está incorreta o aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe somente o leite materno, direto da mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção das vitaminas e medicamentos. A letra B está incorreta as funções descritas para os hormônios são exatamente as opostas, ou seja, o que se descreve como ação de prolactina aqui tem como base o esperado para os progestágenos e vice-versa. A letra C está incorreta o colostro é secretado nos primeiros dias após o parto e, em relação ao leite maduro, possui mais proteínas (imunoglobulinas e outras proteínas com atividades anti-infecciosas). O leite maduro possui mais lactose e gordura que o colostro. E, por fim, a letra D está correta o que foi descrito é uma das bases fundamentais do sucesso na técnica da amamentação sob livre demanda. Resposta letra D.

321174.

Comentário: Chamamos de puberdade precoce quando o início do desenvolvimento puberal ocorre antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. A puberdade precoce pode ser central ou periférica. A central ocorre por ativação precoce do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, portanto, é dependente das gonadotrofinas, ao contrário da forma periférica (também chamada de pseudopuberdade precoce) (letra B incorreta). Dentre as caudas de puberdade precoce central, a principal é a idiopática e a origem genética da doença já está bem fundamentada (letra A incorreta). A investigação desses quadros deve ser feita com avaliação da idade óssea (radiografia de mão e punho não dominantes), ultrassonografia pélvica, dosagem de gonadotrofinas e de esteroides sexuais e imagem do SNC (letra C correta). No caso descrito, não temos como descartar nesse

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

primeiro momento a hipótese de puberdade precoce. A menarca costuma ocorrer concomitante à fase M4, cerca de 2 anos a 2 anos e meio após a telarca. Se a menina tem 10 anos em M4, pode ser que tenha apresentado telarca pouco antes de completar 8 anos (letra D incorreta). Então os exames complementares serão de grande auxílio diagnóstico neste caso. Portanto, a resposta da questão é a letra C.

320438.

Comentário: Vamos relembrar as recomendações para armazenamento do leite ordenhado o leite não pasteurizado pode ser conservado em geladeira por até 12 horas, e no freezer ou congelador por até 15 dias. O leite congelado deve ser descongelado em banho-maria em fogo desligado o leite descongelado que não for aquecido pode ser guardado na geladeira e consumido em até 12 horas após o descongelamento. O leite ordenhado deve ser oferecido para a criança em copo, xícara ou colher, de forma a reduzir a possibilidade de confusão de bicos e de desmame precoce, mais prováveis com a utilização de mamadeira. Resposta letra C.

320440.

Comentário: A dor ao amamentar é uma queixa frequente, e as fissuras mamilares são uma causa comum, muitas vezes causada pela técnica e pega inadequadas. Assim, a principal medida na abordagem das fissuras é avaliar a mamada e corrigir a técnica uma técnica adequada irá facilitar o esvaziamento da mama e evitar traumas mamilares futuros, que perpetuam o problema e dificultam a cicatrização. Amamentar em outras posições, para reduzir a pressão sobre os pontos dolorosos, é uma das estratégias usadas no manejo, mas não a mais importante (letra B incorreta). O uso do leite ordenhado nos mamilos é controverso, e não há comprovação da sua eficácia (letra C incorreta). O uso de cremes e pomadas pode deixar o mamilo úmido e gerar reações alérgicas, piorando as lesões (letra D incorreta) uma exceção seriam as pomadas à base de lanolina, discutidas há algum tempo e recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A exposição ao sol não é mais recomendada, pois desidrata as camadas da epiderme e pode piorar as lesões (letra E incorreta). Resposta letra A.

336279.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O paciente da questão é um menino que apresenta evolução puberal, tanto genital, quanto de pelos pubianos, de início antes dos 9 anos de idade, portanto, trata-se de puberdade precoce. Neste caso precisamos então diferenciar se trata-se de puberdade precoce central ou periférica. Analisando as alternativas Alternativa A incorreta. A puberdade precoce central idiopática é responsável por cerca de 90% das puberdades precoces centrais, principalmente no sexo feminino. Nestes caso há evolução natural dos caracteres sexuais e não surgem comemorativos sistêmicos adicionais. Alternativa B correta. A clínica deste paciente é de puberdade precoce central, provavelmente secundária a um tumor de sistema nervoso central. Os hamartomas são os tumores mais relacionados com surgimento de puberdade precoce central e cursam com secreção inapropriada de GnRH, podendo cursar com crises convulsivas. Alternativa C incorreta. A neurofibromatose tipo 1 pode cursar com puberdade precoce central, causada por gliomas de sistema nervoso central. Porém o surgimento dos neurofibromas é precoce e pode ser o único sintoma da doença. Alternativa D incorreta. A hiperplasia adrenal congênita é causa de puberdade precoce periférica que ocorre por deficiência enzimática (21-hidroxilase, 11-hidroxilase ou 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase) e, na sua forma clássica, o diagnóstico vem no período neonatal com desidratação. Resposta alternativa B.

334754.

Comentário: O crescimento pré e pós-natal sofre influências de diversos fatores. Alternativa A correta. O peso é o que é impactado mais imediatamente quando há qualquer fator prejudicial ao crescimento, enquanto a estatura necessita de prejuízo tempo mais prolongado para que seja afetada. Portanto, quando um bebê nasce apenas com comprometimento de peso é provável que o fator prejudicial tenha ocorrido nas fases finais da gestação. Alternativa B incorreta. É classificada como nascida com baixo peso a criança nascida com peso inferior a 2500g. Alternativa C incorreta. A primeira fase de crescimento mais intenso da criança inicia-se no período intrauterino e perdura até o final do segundo ano de vida e sofre maior influência de fatores extrínsecos, sendo o potencial genético e o hormônio do crescimento influências menos relevantes. Alternativa D incorreta. Conforme as regrinhas práticas, no final do primeiro ano de vida a criança triplicou seu

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

peso e cresceu cerca de 25cm. Resposta alternativa A.

334756.

Comentário: Vamos analisar as alternativas com relação às características do leite materno Alternativa A incorreta. Comparando o leite materno com o leite de vaca, observa-se que o valor calórico e de gordura é semelhante entre os dois, porém há maior concentração de carboidratos no leite humano, enquanto há maior concentração de proteína no leite de vaca. Com relação à caseína, um tipo de proteína, ela é encontrada em muito maior concentração no leite de vaca (2x mais), portanto, o leite de vaca é que promove um esvaziamento gástrico mais lento e não o contrário. Alternativa B incorreta. É exatamente o oposto O uso de agentes hiperosmolares, como as fórmulas infantis, aumenta o risco de enterocolite necrotizante. Alternativa C incorreta. Este é um aspecto bastante interessante pois a composição do leite humano é muito parecida ao redor do mundo, sendo que há grande variação na dieta e hábito das mães nas diferentes regiões. Alguns fatores mostram variação do leite de uma mesma mãe, como época da gestação, horário do dia e momento da mamada. Alternativa D correta. O leite materno é rico em fatores de proteção, como imunoglobulinas (IgA, IgM e IgG), leucócitos, lactoferrina, lisozima, fator bífido e lipase. Quando comparamos o colostro com o leite maduro, observamos que o colostro é mais rico em eletrólitos, proteínas, vitaminas lipossolúveis, minerais e concentração de imunoglobulinas (principalmente IgA e lactoferrina), enquanto o leite maduro é mais rico em lipídios. Resposta alternativa D.

334759.

Comentário: Com relação à anemia ferropriva Alternativa A incorreta. Justamente o oposto. Estão em maior risco para anemia ferropriva os bebês prematuros, com baixo peso ao nascer e pequenos para idade gestacional, além daquelas crianças em ritmo acelerado de crescimento (velocidade de crescimento p90). Alternativa B incorreta. O clampeamento tardio do cordão é considerada uma estratégia para reduzir a incidência de anemia fisiológica do lactente, porém aumenta o risco de icterícia neonatal. Alternativa C correta. Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, atualizadas em 2021, bebês sem fatores de risco devem iniciar a suplementação com ferro a partir de 180 dias de vida, e esta deve ser mantida até os 24 meses de idade. Alternativa D

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incorreta. Para prematuros (nascidos antes de 37 - e não 39 semanas) e recém-nascidos a termo com peso inferior a 2500g há variação da dose recomendada para profilaxia, porém esta deve ser iniciada com 30 dias de vida. Resposta alternativa C.

335110.

Comentário: Nas consultas de puericultura o pediatra deve estar sempre atento para a saúde emocional da criança, inclusive para a presença de indícios de maus tratos. Algumas situações devem servir de alerta para o pediatra indícios de maus tratos físicos e ou emocionais (assertiva II correta), negligência no cuidado com a criança (assertiva III correta) e alto nível de estresse dos pais (assertiva IV correta). A dificuldade de aprendizagem é uma queixa comum, mas frequentemente associada a outros fatores, como falta de interesse, perturbação emocional, inadequação metodológica ou mudança do padrão de exigência da escola. Portanto, na presença de dificuldade de aprendizagem, também é importante a investigação mais profunda daquela criança (assertiva I correta). Resposta letra D.

306705.

Comentário: A letra A está correta. A água contribui com quase 90% da composição do leite materno, o que garante o suprimento das necessidades hídricas de uma criança em aleitamento materno exclusivo (AME), mesmo em climas quentes e áridos. A letra B está incorreta. Nos primeiros dias, a secreção láctea é chamada de colostro, que contém mais proteínas e menos lipídios do que o leite maduro, e é rico em imunoglobulinas, em especial a IgA. A letra C está incorreta. A concentração de gordura no leite (e consequentemente o teor energético) aumenta no decorrer de uma mamada . Assim, o leite do final da mamada (leite posterior) é mais rico em energia e sacia melhor a criança daí a importância de a criança esvaziar bem a mama. E por fim, a letra D está incorreta. Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente inativados pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5 C por 30 minutos) não tem o mesmo valor biológico que o leite cru. Resposta letra A.

291930.

Comentário: A ginecomastia é caracterizada proliferação do tecido glandular mamário, podendo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ocorrer no período neonatal, na puberdade e na senilidade. A ginecomastia ocorre em até 70% dos adolescentes normais do sexo masculino e é causada pelo desequilíbrio transitório das concentrações de estrogênio e androgênio no tecido mamário. Isso significa que, na maioria dos casos, não se identifica uma causa orgânica para o problema, sendo assim chamada de idiopática (letra D errada). Mais raramente pode ser causada por outras doenças ou pelo uso de medicamentos (ex anabolizantes). Alguns medicamentos podem ser causas de ginecomastia, como antiandrógenos e outros hormônios exógenos, antirretrovirais e bloqueadores do receptor de histamina. Bloqueadores dos canais de cálcio, certos antipsicóticos e inibidores da bomba de prótons podem ser os causadores. Entre as drogas de abuso, o álcool e os esteróides anabolizantes podem estar associados à ginecomastia. A incidência da ginecomastia puberal atinge o pico aos 14 anos de idade, no estágio de Tanner 3-4, com um volume testicular de 5-10 mL. É uma condição fisiológica e que geralmente regride em 18 a 24 meses. O tratamento consiste em tranquilizar o menino e sua família sobre a natureza fisiológica e transitória do fenômeno. No entanto, quando o aumento é marcante e persistente e causa sérios distúrbios emocionais ao paciente, o tratamento específico pode ser justificado. Já o paciente que recebe hormonio antiandrogênico no tratamento de câncer de próstata pode ter ginecomastia como efeito colateral, por isso uma estratégia de prevenção é a radioterapia nas mamas, que será eficaz apenas quando não tiver ocorrido a hipertrofia do tecido mamário (letra C correta). Por fim, o estrogênio circulante no homem deriva principalmente da aromatização periférica e, realmente, não há diferenças na responsividade hormonal intrínseca ao tecido mamário do homem ou da mulher, a diferença está no o estímulo hormonal (letras A e B corretas). Resposta letra D.

291931.

Comentário: Vamos avaliar cada uma das alternativas e procurar a incorreta A letra A está correta a puber dade é caracterizada pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários, o aumento corporal até o tamanho adulto e o desenvolvimento da capacidade reprodutora. A letra B está correta segundo o estadiamento de Tanner, o estágio P1 é caracterizado pela ausência de pelos pubianos na área genital. A letra C está correta a puber dade tardia ou atrasada é marcada pela a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ausência de mamas em meninas após 13 anos e ausência de aumento de volume testicular em meninos após 14 anos. A ausência de progressão dos sinais puberais também deve ser considerada como atraso puberal. Por exemplo, quando o adolescente não apresenta evolução sexual em quatro ou cinco anos após o início dos primeiros caracteres secundários. Já o termo amenorreia primária é usado para descrever as situações em que não ocorre a menarca após os 14 anos na ausência de caracteres sexuais secundários ou após os 16 anos na presença de caracteres sexuais secundários. A letra D está incorreta sabemos que o início do desenvolvimento puberal varia de acordo com o sexo do indivíduo. No sexo feminino, por exemplo. o início da puberdade ocorre entre 8 e 13 anos. Já no sexo masculino, o início ocorre entre 9 e 14 anos. Resposta letra D.

291627.

Comentário: O leite humano ordenhado congelado pode ser estocado por um período máximo de 15 dias a partir da data da coleta, se for mantido em temperatura máxima de -3 C. Se o leite humano ordenhado for refrigerado, pode ser estocado por um período de até 12 horas, se guardado em temperatura máxima de 5 C. O uso de mamadeiras confundem o bebê porque a forma de sugar ao seio é completamente diferente da forma como se suga os bicos artificiais, correndo grande risco de desmame. O ideal é utilizar o copinho, que reduz a chance do desmame precoce. Resposta letra B.

291937.

Comentário: A puber dade é marcada pelas mudanças biológicas que ocorrem na adolescência, caracterizada pelo surgimento dos primeiros caracteres sexuais secundários, do aumento corporal até o tamanho adulto e do desenvolvimento da capacidade reprodutora. Nas meninas, a puberdade tem início dos 8 aos 13 anos de idade, e nos meninos dos 9 aos 14 anos. O estágio M2 é caracterizado pelo início da puberdade no sexo feminino, com o aparecimento do broto mamário (telarca). Aqui não há motivos de preocupação, pois para definir uma a puber dade precoce, o início do desenvolvimento puberal deve ser abaixo dos 8 anos em meninas e abaixo dos 9 anos em meninos. Como essa adolescente de 11 anos encontra-se no estágio M3, é bem provável que a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

telarca surgiu depois dos 8 anos de idade e a menarca ainda não ocorreu. Lembre-se que o intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser de 2-2,5 anos, quando as mamas estão em M3-M4 (mais comumente M4).) Portanto, nossa adolescente apresenta uma puberdade fisiológica, por isso não há necessidade de exames complementares e nem de tratamento específico (letras B, C e D erradas). Resposta letra A.

306721.

Comentário: Estamos diante de um lactente de nove meses, nascido com 28 semanas de idade gestacional. A idade corrigida pela prematuridade é de seis meses (três meses a menos que a idade cronológica). Avaliando os marcos do desenvolvimento atingidos até o momento, temos que brinca de esconde-achou (nove meses) rola no leito (seis meses) leva objetos à boca (seis meses) senta com apoio (seis meses). Considerando os marcos do desenvolvimento obtidos por uma criança de nove meses, cronologicamente este lactente está atrasado. Entretanto, pela idade gestacional corrigida, os marcos presentes estão de acordo com a idade encontrada. Resposta letra A.

291943.

Comentário: Vamos procurar a correta em relação à composição do leite A letra A está errada na realidade, além de ser rico em nutrientes, o leite materno tem cerca de 90% de água, por isso é recomendado apenas o leite materno até o sexto mês de vida, sem necessidade de outros fluidos (ex chás, água, suco) ou qualquer outro tipo de alimento. A letra B está correta realmente a composição do leite muda durante a mama. O leite do início da mamada, o chamado leite anterior, pelo seu alto teor de água, tem aspecto semelhante ao da água de coco. Porém, ele é muito rico em anticorpos. Já o leite do fim da mamada, o chamado leite posterior, tem maior concentração de gordura, garantindo mais energia e saciedade ao bebê. Também é mais mais amarelado devido à presença de betacaroteno, pigmento lipossolúvel presente na cenoura, abóbora e vegetais de cor laranja, provenientes da dieta da mãe. A letra C está errada o colostro contém mais proteínas, imunoglobulinas, eletrólitos e vitaminas lipossolúveis. Menor quantidade de gordura, lactose e vitaminas hidrossolúveis. A letra D está errada a suplementação de vitamina K para toda criança,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

após o nascimento, é feita essencialmente por três motvios 1) não há transferência de vitamina K livre para o feto de forma suficiente 2) o leite materno é pobre em vitamina K 3) o intestino do neonato é estéril, ou seja, não há flora bacteriana residente para sintetizar a vitamina K. Em relação a vitamina D, o leite materno também tem baixas concentrações de vitamina D, por isso todo bebê deve iniciar a suplementação ainda na primeira semana de vida. Resposta letra B.

304875.

Comentário: A puberdade fisiológica costuma ter início entre 8 e 13 anos no sexo feminino e entre 9 e 14 anos no sexo masculino. No sexo feminino, o primeiro sinal da puberdade é o desenvolvimento do broto mamário (telarca). Logo, ausência de telarca aos 14 anos indica um quadro de atraso puberal e a necessidade de avaliação (opção A correta). O primeiro sinal da puberdade no sexo masculino é o aumento do volume testicular, sendo que há aumento quando o volume é maior ou igual a 4 ml. Logo, a descrição de volume de 4mm3 (o mesmo que 4 ml) aos 9 anos não indica nada de anormal. A adernara corresponde ao início da secreção dos androgênicos pela adrenal. Isto pode ocorrer antes da telará, ainda que o surgimento da pilificação costuma ser posterior ao desenvolvimento do broto mamário. Resposta letra A.

304880.

Comentário: Mesmo após o retorno da mulher ao trabalho, é possível que a criança seja mantida em regime de aleitamento materno exclusivo. Para isso, recomenda-se que, nos períodos que a mulher estiver em casa, seja mantido o aleitamento em livre demanda diretamente no seio. Nos períodos de ausência materna, deve ser oferecido o leite materno previamente ordenhado e armazenado. O leite humano ordenhado congelado pode ser estocado por um período máximo de 15 dias (ou duas semanas) a partir da data da coleta na geladeira ou freezer , se for mantido em temperatura máxima de -3 C. Pode ser ordenhado e refrigerado na geladeira por um período de até 12 horas, se guardado em temperatura máxima de 5 C. Quando oferecido à criança, não devem ser usadas mamadeiras, dando-se preferência ao uso de copinhos ou colheres. Resposta letra B .

291963.

Comentário: Questão retirada na íntegra do documento do Ministério da Saúde intitulado SAÚDE

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

DA CRIANÇA Nutrição Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar . Vamos analisar as assertivas de acordo com esse documento A) Correta. A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior quanto menor é a criança. Assim, a mortalidade por doenças infecciosas é seis vezes maior em crianças menores de 2 meses não amamentadas, diminuindo à medida que a criança cresce, porém ainda é o dobro no segundo ano de vida. B) Correta. O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. C) Incorreta. Oferecer à criança amamentada água ou chás, prática considerada inofensiva até pouco tempo atrás, pode dobrar o risco de diarréia nos primeiros seis meses. D) Correta. Estudos mostram que a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes . Assim, retardar a introdução de outros alimentos na dieta da criança pode prevenir o aparecimento de alergias, principalmente naquelas com histórico familiar positivo para essas doenças. Portanto, a única correta é a letra C, nosso gabarito.

314074.

Comentário: Em relação à puberdade e suas definições, temos que 1. Atraso puberal considera-se como atraso puberal a falta de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários aos 13 anos de idade nas meninas e 14 anos nos meninos, ou seja, ausência de broto mamário e testículo menor que 4 mL, respectivamente. 2. Puberdade precoce por definição clássica, puberdade precoce ocorre quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários acontece antes dos oito anos em meninas e antes dos nove anos em meninos. 3. Puberdade normal é o período de transição entre a infância e a vida adulta, fase biológica de crescimento e desenvolvimento na qual ocorrem modificações marcantes, físicas e psicológicas, que culminam com maturidade sexual e capacidade de reprodução. Nos meninos ocorre entre os nove e 14 anos e nas meninas entre os oito e 13 anos de idade. Resposta letra B.

314075.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A gravidez ainda é o diagnóstico mais comum em adolescentes com amenorreia secundária e por isso, a negação da atividade sexual e irregularidade menstrual não devem excluir o diagnóstico. Durante a gestação, a adolescente ainda está se adaptando emocionalmente às suas próprias características e formatos, e o corpo, que ainda está em transformação, sofre novas mudanças de tamanho e forma. A gravidez na adolescência pode cursar com sintomas tradicionais de gravidez enjoo matinal, vômitos, mamas dolorosas, ganho de peso, estrias e amenorreia. Frequentemente as manifestações são vagas, como dor abdominal, cefaleia, fadiga e menstruação escassa. Portanto, a sentença está completamente correta. Reposta letra A.

314088.

Comentário: Diz-se que uma criança está em aleitamento materno quando ela recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de estar recebendo ou não outros alimentos. O padrão do aleitamento materno é classificado da seguinte maneira - Aleitamento materno exclusivo (AME) quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos - Aleitamento materno predominante quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões) e sucos de frutas - Aleitamento materno complementado quando a criança recebe, além do leite materno, alimentos complementares, definidos como qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementar o leite materno - Aleitamento materno misto ou parcial quando a criança recebe, além do leite materno, outros tipos de leite. Resposta letra C.

266359.

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas feitas sobre o acompanhamento do crescimento nas crianças. A opção A está incorreta as crianças nascidas com peso abaixo de 2.500 g são consideradas crianças de baixo peso (lembre-se de que as nascidas com menos de 1.000 g são classificadas como tendo extremo baixo peso e aquelas nascidas com peso entre 1.000 e 1.500 g são considerados com muito baixo peso). A opção B está correta em geral, é exatamente isso o que observamos. Contudo, cabe lembrar que não é dessa forma que fazemos o acompanhamento da criança, mas sim através da marcação dos dados antropométricos em gráficos e construção das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

curvas de crescimento. A opção C está incorreta o que ocorre é justamente o contrário. Quando há um comprometimento da estatura e do perímetro cefálico, acreditamos que o agravo ocorreu em fases mais iniciais da gestação quando há apenas um comprometimento do peso, isso indica um problema mais tardio. E, por fim, a opção E está incorreta o crescimento intrauterino é pouco influenciado por fatores genéticos, sendo determinado essencialmente por fatores nutricionais. Deste modo, mesmo crianças filhas de pais baixos terão comprimento normal ao nascer. Resposta letra B.

266360.

Comentário: Vejamos cada uma das afirmativas feitas sobre o tema aleitamento materno. A opção A está incorreta por incrível que pareça, a composição do leite materno é bastante homogênea. É claro que determinados fatores nutricionais podem interferir nesta composição, mas não é comum que isso seja relevante. A opção B também está incorreta o colostro e o leite maduro possuem algumas diferenças em sua composição. O colostro é mais rico em proteínas e eletrólitos, enquanto o leite maduro possui maior teor de lactose e de gorduras. A opção C está incorreta estes elementos são encontrados em pouca quantidade do leite materno e, justamente por isso, devem ser suplementados. E, por fim, a opção D está correta esta frase é encontrada em diversos manuais sobre o tema. O leite humano possui uma série de fatores de proteção, que podem ser parciais ou totalmente inativados pelo aquecimento. Resposta letra D.

257359.

Comentário: As contraindicações ABSOLUTAS ao aleitamento materno incluem doenças maternas, como a infecção pelo vísrus HIV e HTLV 1 e 2, como também doenças da criança, sendo a principal delas a galactosemia, condição que a criança não é capaz de metabolizar a galactose, que é um dos monossacarídeos que fazem parte da lactose, o que deixa a criança impossibilitada de receber o leite materno. No que se refere a Covid-19, a mãe pode amamentar o lactente, desde que realizado precaucações para gotículas, como lavagem das mãos e uso do álcool gel, uso da máscara durante as mamadas e evitar toques no rosto da mãe e do bebê. Já a mastite e o vírus Epstein-Barr não apresentam restrições para o aleitamento, inclusive a manutenção da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

amamentação faz parte do tratamento da mastite. Resposta letra C.

260690.

Comentário: De acordo com as recomendações mais recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2019, a profilaxia de anemia ferropriva com suplementação de ferro deve ser iniciada aos 3 meses para RNs a termo que estejam em aleitamento materno exclusivo, exatamente de acordo com o gabarito originalmente liberado pela banca. O problema é que nas referências deste concurso, a banca utilizou a segunda edição do tratado da SBP, no qual a recomendação ainda era de iniciar aos 6 meses. Apesar de a resposta mais atual e correta ser realmente a letra B, liberada pela banca como gabarito, a banca anulou a questão após recurso.

287350.

Comentário: O treinamento esfincteriano é um marco importante do desenvolvimento físico e psicológico em crianças, além de constituir um desafio para as famílias. A literatura pediátrica enfatiza a importância da criança apresentar os sinais de prontidão, ou seja, habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento, o que começa a ocorrer geralmente entre 24 e 36 meses de idade (alternativa A, B e D incorretas). O controle esfincteriano ocorre primeiro para as fezes e depois para a urina. Segundo documento científico da SBP, quando a criança se conscientiza sobre sua própria necessidade de eliminar urina e fezes ela já pode ser considerada treinada para o controle (alternativa C incorreta). Este mesmo documento traz a seguinte informação observa-se também maior prevalência de disfunção vesical em crianças que apresentam constipação intestinal funcional e que iniciam o TE precocemente, antes de 24 meses ou tardio, após 36 meses de idade , mas também que é importante ressaltar que toda criança tem um desenvolvimento individualizado e, portanto, somente a idade não é um bom critério para decidir o momento de iniciar o treinamento . Como podemos ver, nenhuma afirmativa está completamente correta, mas a banca liberou como gabarito a letra B.

260691.

Comentário: Questão recorrente em prova de residência. Sabemos que a tuberculose não é contraindicação à amamentação, porém, cabe a seguinte ressalva caso a mãe ainda esteja

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

bacilífera (geralmente torna-se não transmissora após 2 a 4 semanas do início da medicação) recomenda-se que ela amamente utilizando máscara. Além disso, a vacina BCG não deverá ser administrada e a criança deverá receber isoniazida até 3 meses. Perceba que a mãe está tratando há um mês, ou seja, não há mais transmissão. Assim, a amamentação ao seio está liberada sem restrições. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina